

LIBRO DE BANCOS DE PREGUNTAS

TOMO III

DR: GUILLERMO GUEVARA ALIAGA

ÍNDICE PRUEBAS DE CIRUGÍA, ESPECIALIDADES, PSIQUIATRÍA Y SALUD PÚBLICA

I) CIRUGÍA Y ANESTESIA

Prueba 1.....	Pág 03
Prueba 2.....	Pág 07
Prueba 3.....	Pág 10
Prueba 4.....	Pág 14
Prueba 5.....	Pág 17
Prueba 6.....	Pág 21
Prueba 7.....	Pág 25
Prueba 8.....	Pág 29
Prueba 9.....	Pág 33
Prueba 10.....	Pág 36
Prueba 11.....	Pág 44
Prueba 12.....	Pág 48
Respuestas.....	Pág 39

II) TRAUMATOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 40
Prueba 2.....	Pág 44
Prueba 3.....	Pág 48
Prueba 4.....	Pág 51
Prueba 5.....	Pág 55
Prueba 6.....	Pág 58
Prueba 7.....MED INT.....	Pág 196
Respuestas.....	Pág 61

III) UROLOGÍA

Prueba 1.....MED INT.....	Pág 112
Prueba 2.....MED INT.....	Pág 115
Prueba 3.....MED INT.....	Pág 121
Prueba 4.....MED INT.....	Pág 124
Prueba 5.....MED INT.....	Pág 128
Prueba 6.....MED INT.....	Pág 132
Prueba 7.....MED INT.....	Pág 135
Respuestas.....MED INT.....	Pág 142

IV) DERMATOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 64
Prueba 2.....	Pág 68
Prueba 3.....	Pág 71
Prueba 4.....	Pág 74
Prueba 5.....	Pág 78
Prueba 6.....	Pág 82
Prueba 7.....	Pág 85
Prueba 8.....	Pág 88
Respuestas.....	Pág 91

V) OTORRINOLARINGOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA

Prueba 1.....	Pág 92
Prueba 2.....	Pág 96
Prueba 3.....	Pág 100
Prueba 4.....	Pág 103
Prueba 5.....	Pág 106
Prueba 6.....	Pág 109
Prueba 7.....	Pág 51
Prueba 8.....	Pág 55
Respuestas.....	Pág 112

VI) PSIQUIATRÍA

Prueba 1.....	Pág 113
Prueba 2.....	Pág 117
Prueba 3.....	Pág 120
Prueba 4.....	Pág 123
Prueba 5.....	Pág 127
Prueba 6.....	Pág 130
Prueba 7.....	Pág 134
Prueba 8.....	Pág 137
Prueba 9.....GINE PED.....	Pág 18
Respuestas.....	Pág 141

VII) SALUD PÚBLICA

Prueba 1.....	Pág 142
Prueba 2.....	Pág 145
Prueba 3.....	Pág 149
Prueba 4.....	Pág 152
Prueba 5.....	Pág 157
Prueba 6.....	Pág 123
Prueba 7.....	Pág 127
Respuestas.....	Pág 161

VIII) PRUEBAS GRANDES CIRUGÍA, ESPECIALIDADES, SALUD PÚBLICA Y PSIQUIATRÍA

Prueba 1.....	Pág 162
Prueba 2.....	Pág 173
Prueba 3.....	Pág 184
Prueba 4.....	Pág 196
Prueba 5.....	Pág 208
Prueba 6.....	Pág 219
Respuestas.....	Pág 231

I) CIRUGÍA PRUEBAS Y ANESTESIA

Prueba 1

1) Una mujer de 47 años, asintomática, se realiza una mamografía, como parte de un chequeo médico. Es informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nueva mamografía en un año
- b) Solicitar ecografía mamaria
- c) Realizar nueva mamografía en 6 meses
- d) Derivar para biopsia
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear

2) Un paciente de 63 años se realiza neumonectomía del lóbulo medio derecho como parte del tratamiento de un adenocarcinoma bronquial. ¿A qué tipo de herida corresponde esta cirugía?

- a) Herida limpia
- b) Herida limpia contaminada
- c) Herida contaminada
- d) Herida sucia
- e) Herida infectada

3) Un paciente de 40 años, camionero, consulta por intenso dolor anal, de un día de evolución, de inicio rápido y que aumenta al sentarse y al defecar. Al examen se observa aumento de volumen azuloso en relación a la zona perianal posterior, muy doloroso. El diagnóstico más probable es:

- a) Fisura anal aguda
- b) Absceso perianal
- c) Hemorroide externo trombosado
- d) Hemorroide interno trombosado
- e) Plicoma

4) Un paciente de 65 años, hipertenso mal controlado consulta por dolor torácico intenso, irradiado a dorso, de 40 minutos de duración. Al examen físico se constata PA: 210/130 mmHg, FC: 120x' y auscultación cardíaca con ritmo regular en 2 tonos, y con soplo diastólico de regurgitación aórtica. La auscultación pulmonar es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Aneurisma aórtico roto
- b) Infarto agudo al miocardio
- c) Disección aórtica
- d) Úlcera péptica perforada
- e) Insuficiencia cardíaca descompensada por crisis hipertensiva

5) Una paciente de 67 años, colecistectomizada, consulta por dolor abdominal, tipo cólico, intenso, asociado a vómitos alimentarios y distensión abdominal. No ha presentado diarrea. Al examen físico destaca abdomen distendido, doloroso difuso, con ruidos hidroaéreos aumentados. Se solicita radiografía de abdomen simple de pie, que muestra múltiples niveles hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis y decidir manejo según hallazgos
- b) Iniciar hidratación y antibióticos endovenosos y observar evolución por 24 horas
- c) Derivar para colonoscopia de urgencia
- d) Iniciar hidratación oral fraccionada y antibióticos orales
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato, bajo cobertura antibiótica

6) La mejor imagen para evaluar un aumento de volumen de una extremidad, compatible con un sarcoma de partes blandas es:

- a) Ecografía de partes blandas
- b) Cintigrafía
- c) Tomografía axial computarizada
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Radiografías simples seriadas

7) La complicación más frecuente de la apendicectomía es:

- a) Pilohebitis
- b) Infección de la herida operatoria
- c) Dehiscencia de la herida operatoria
- d) Atelectasia
- e) Filtración de contenido intestinal

8) Un paciente de 65 años cae del tercer piso de un edificio en construcción y es traído al hospital, donde Ud. está de turno. Llega en la parte posterior de una camioneta 15 minutos después del accidente. Viene inconsciente, no responde a estímulos, sólo se palpa pulso carotídeo muy débil, frecuencia respiratoria 35 por minuto, tráquea desviada hacia la derecha. No se ausculta murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, el que se percute timpánico, además se palpan múltiples fracturas costales y enfisema subcutáneo. Está pálido y sudoroso, con abdomen distendido y tenso. Tiene una extensa herida en cráneo que sangra profusamente y una fractura expuesta en antebrazo derecho que también sangra activamente. ¿Cuál sería su primera acción sobre este paciente?

- a) Comprimir heridas sangrantes mientras le colocan 2 vías venosas gruesas y le administran suero fisiológico a chorro
- b) Puncionar hemitórax izquierdo para descomprimir neumotórax a tensión
- c) Proceder con intubación orotraqueal
- d) Colocar collar cervical
- e) Poner una cánula mayo y ventilar con ambú

9) Un lactante de 7 meses de edad es traído por su madre ya que presenta llanto y actitud de dolor 40 minutos de duración, seguidos de eliminación de deposiciones rojas, tipo mermelada de frutilla. Al examen físico se observa lactante adolorido, con flexión de las caderas y llanto al palpar el abdomen. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- b) Iniciar cristaloides y antibióticos endovenosos y observar evolución por 24 horas
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar colonoscopia

10) Un paciente de 33 años, sin antecedentes de importancia ni historia de cefaleas previas, presenta cefalea holocránea muy intensa, de inicio súbito, de 6 horas de evolución, asociada a vómitos y que no cede con analgésicos. Al examen físico está afebril y no hay signos neurológicos focales, pero se constata rigidez de nuca. Se solicita TAC de cerebro sin contraste, el que resulta normal. La actitud más adecuada es:

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
- b) Enviar a domicilio con analgésicos orales
- c) Realizar TAC de cerebro con contraste
- d) Realizar punción lumbar
- e) Hospitalizar y administrar AINEs y corticoides endovenosos

11) Una mujer de 57 años, consulta por nódulo tiroideo derecho de 3 cms, duro, que se moviliza con la deglución. No presenta adenopatías palpables ni ecográficas y la citología por aspiración con aguja fina resulta compatible con carcinoma papilar de tiroides. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar para tiroidectomía total
- b) Derivar para hemitiroidectomía derecha más linfadenectomía cervical ipsilateral
- c) Administrar yodo radiactivo
- d) Iniciar quimioterapia y radioterapia
- e) Administrar levotiroxina y observar evolución por un mes

12) En un paciente con antecedentes de tabaquismo y dislipidemia, debe sospecharse isquemia crítica de una extremidad inferior ante:

- a) Claudicación intermitente a distancia menor a 20 metros.
- b) Una angiografía con estenosis de arteria femoral superficial mayor a 90%.
- c) Ausencia de pulso femoral y poplíteo.
- d) Un índice tobillo/brazo de 0.6.
- e) Dolor isquémico en reposo de la extremidad.

13) En un paciente con colecistitis aguda es recomendable diferir la cirugía si:

- a) Han pasado menos de 48 horas desde el inicio de los síntomas
- b) Han pasado más de 10 días desde el inicio de los síntomas
- c) El paciente es mayor de 65 años
- d) Existe sospecha de coledocolitiasis concomitante
- e) El paciente se encuentra febril

14) En un paciente con cáncer de colon sigmoides, operado de urgencia por una obstrucción intestinal secundaria, la intervención quirúrgica más adecuada es:

- a) Resección segmentaria y anastomosis colo-colónica
- b) Colectomía izquierda, sutura de muñón rectal y colostomía proximal
- c) Hemicolectomía izquierda y anastomosis ileo-transverso
- d) Colostomía derivativa sin tocar el tumor
- e) Resección endoluminal del tumor, con asa

15) En cardiología, el concepto de “dominancia izquierda” significa que:

- a) El nodo sinusal se ubica en la aurícula izquierda
- b) El tabique interventricular está formado mayormente por fibras musculares del ventrículo izquierdo
- c) La arteria descendente anterior se origina de la coronaria izquierda
- d) La arteria descendente posterior se origina de la arteria circunfleja
- e) La presión arterial sistémica es mayor que la presión de la arteria pulmonar

16)Cuál de las siguientes opciones corresponde a una indicación de cirugía en el contexto de una pancreatitis aguda:

- a) Necrosis
- b) Pseudoquiste de 4 cm
- c) Abscesos
- d) Colecciones peripancreáticas
- e) Distress respiratorio

17) La causa más frecuente de fiebre, 24 horas luego de una cirugía es:

- a) Tromboflebitis
- b) Atelectasia
- c) Infección de la herida operatoria
- d) Hipertermia maligna
- e) Neumonía

18) Una mujer de 24 años, sufre accidente de tránsito, golpeándose el tórax y evolucionando con disnea. Al examen físico se aprecia paciente taquipneica, adolorida, con abolición del murmullo pulmonar y matidez en el hemitórax derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax a tensión
- b) Contusión pulmonar
- c) Hemotórax
- d) Tórax volante
- e) Neumotórax abierto

19) Una paciente de 67 años consulta por cuadro de dolor abdominal bajo, asociado a constipación y sensación febril. Al examen se constatan temperatura de 37,4°C, FC: 90 lpm, PA: 140/80 mmHg. Abdomen blando, depresible, sensible en fosa iliaca izquierda, con signo de Blumberg esbozado. El examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica es:

- a) Tomografía de abdomen y pelvis con contraste
- b) Radiografía de abdomen simple de pie y decúbito
- c) Colonoscopia
- d) Ecografía abdominal
- e) Enema baritado

20) Respecto al divertículo de Zenker es verdadero que:

- a) Rara vez produce síntomas
- b) Se produce por un mecanismo de tracción
- c) El tratamiento suele ser la resección quirúrgica
- d) Se produce en la unión gastroesofágica
- e) Se diagnostica mediante endoscopia digestiva alta

Prueba 2

CIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA y UROLOGÍA (Bancos de preguntas)

1) ¿Cuál de los siguientes fármacos debe suspenderse necesariamente antes de una cirugía electiva?

- a) Hipoglicemiantes
- b) Antihipertensivos
- c) Anticoagulantes
- d) Antidepresivos
- e) Anticonvulsivantes

2) Los síntomas y signos de la enfermedad arterioesclerótica de la bifurcación de la aorta abdominal (Síndrome de Leriche) incluyen:

- a) claudicación del glúteo y pierna
- b) dolor de la extremidad inferior
- c) eyaculación retrógrada
- d) gangrena del pie
- e) rubor del pie

3) Mujer de 19 años, en el quinto día de menstruación. Desde hace 24 horas está con dolor continuo en fosa iliaca derecha y ha tenido en cuatro oportunidades deposiciones líquidas sin sangre. En el examen hay resistencia muscular en la zona del dolor y esbozo de Blumberg. Examen ginecológico normal. Temperatura axilar es de 38C y rectal de 39.5C. El recuento de blancos es de 22.000/mm³. La primera posibilidad diagnóstica es:

- a) apendicitis aguda.
- b) colecistitis aguda
- c) proceso inflamatorio pelviano.
- d) salmonellosis intestinal.
- e) pielonefritis aguda.

4) Una ictericia fluctuante orienta al diagnóstico de:

- a) colangitis esclerosante
- b) hepatitis aguda
- c) litiasis coledociana
- d) hepatitis alcohólica
- e) tumores hepáticos

5) ¿Cuál es el diagnóstico más probable frente a un paciente que consulta por una masa perianal pequeña, dolorosa, de 2 días de evolución y sin sangrado rectal?

- a) Fisura anal
- b) Hemorroide interno grado 2
- c) Condilomas acuminados perianales
- d) Absceso perianal
- e) Absceso pelvirrectal

6) Niña de 3 meses, con antecedentes de parto en podálica y madre con displasia de cadera tratada. Al examen físico destaca limitación a la abducción de cadera derecha.

¿Cual es la conducta más adecuada?

- a) Solicitar radiografía de cadera derecha
- b) Solicitar radiografía de pelvis antero posterior
- c) Indicar uso de doble pañal
- d) Indicar uso de correas de Pavlik
- e) Observar y controlar en un mes

7) Paciente de 22 años, sufre caída sobre la mano con el codo en extensión. Presenta dolor, leve aumento de volumen e impotencia funcional del codo, con imposibilidad de pronosupinar en forma activa.

El diagnóstico más probable es una fractura:

- a) de epitroclea.
- b) marginal de capitelum.
- c) supracondílea
- d) de cúpula radial.
- e) de olécranon.

8) ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es indispensable descartar en un paciente con fractura de pelvis inestable y globo vesical, que no puede orinar espontáneamente?

- a) Rotura vesical
- b) Trauma renal
- c) Adenoma de próstata
- d) Estenosis uretral
- e) Rotura uretral posterior

9) De las complicaciones postoperatorias de la apendicitis aguda, la más frecuente es:

- a) Absceso apendicular
- b) Pileflebitis
- c) Plastrón apendicular
- d) Infección de herida operatoria
- e) Obstrucción intestinal

10) Son potenciales complicaciones de una Enfermedad Diverticular de larga data

- a) Fístula Colo – Vesical
- b) Absceso perianal
- c) Cáncer de sigmoides
- d) Incontinencia anal
- e) Colitis ulcerosa

11) ¿En qué pacientes sugeriría usted adelantar los controles de pesquisa de cáncer prostático?

- a) Antecedentes de prostatitis crónica
- b) Antecedente personal de cáncer testicular
- c) Antecedentes de padre con cáncer de próstata
- d) Antecedentes de tabaquismo
- e) Antecedentes de padre y hermano con hiperplasia prostática

12) Un paciente de 65 años portador de una masa inguinal que antes se reducía y desde hace 3 horas no puede reducir, consulta en policlínico. Al examen impresiona como una hernia inguinal, irreductible, sensible. La conducta más apropiada en ese momento es:

- a) Solicitar interconsulta con Urólogo
- b) Solicitar exámenes de sangre pre operatorios y programar cirugía electiva
- c) Hospitalizar y programar cirugía de urgencia
- d) Hospitalizar, iniciar antibióticos y analgésicos y reevaluar en 24 horas
- e) Hospitalizar y programar cirugía diferida

13) Paciente de 30 años ingresa con traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis estable y contusión pulmonar. Tres días después presenta una trombosis venosa profunda proximal a la rodilla. La conducta más apropiada es:

- a) instalar un filtro en la vena cava inferior
- b) indicar compresión neumática intermitente
- c) iniciar tratamiento anticoagulante con heparina fraccionada
- d) indicar vendas de compresión elástica graduada y deambulación precoz
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

14) Paciente con fractura de pierna inmovilizada con bota larga de yeso, recibiendo antiinflamatorios no esteroideos por vía oral. Horas después de la inmovilización presenta aumento del dolor y de volumen de la pierna que no cede al abrir el yeso. Presenta además dolor a la movilización de los dedos del pie. ¿Cuál es la causa más probable de este cuadro?

- a) Trombosis venosa profunda
- b) Distrofia simpático-refleja
- c) Síndrome compartamental
- d) Desplazamiento de la fractura
- e) Dosis y vía inadecuada de antiinflamatorios

15) ¿Cuál de las siguientes conductas es más adecuada frente al diagnóstico clínico y ecográfico de tumor testicular?

- a) Realizar orquectomía por vía inguinal
- b) Solicitar cintigrafía ósea
- c) Controlar con nueva ecografía en 30 días
- d) Realizar biopsia testicular por punción
- e) Realizar exploración quirúrgica testicular por vía escrotal

16) Respecto al síndrome de pellizcamiento humeral:

- a) Es un problema infrecuente de consulta médica
- b) Los pacientes frecuentemente acusan dolor nocturno
- c) Se produce por atrapamiento del tendón del músculo serrato anterior
- d) Los síntomas son atípicos cuando hay rotura del tendón involucrado
- e) Siempre tiene la misma etiología, independientemente del gupo etáreo al que afecta

17) Un hombre de 55 años sufre una caída desde un 3º piso, se le compromete la conciencia, frecuencia respiratoria de 37x', con fractura expuesta de antebrazo, con lesión sangrante en zona parietotemporal izquierda, la tráquea está desviada a la izquierda y el murmullo pulmonar derecho está abolido. La primera acción a tomar es:

- a) Poner collar cervical
- b) Puncionar segundo espacio intercostal derecho
- c) Solicitar TAC de cerebro
- d) Tomar set de radiografías de politraumatizado (AP pelvis, AP de tórax, Lat columna cervical)
- e) poner dos vías venosas e iniciar reposición de volumen.

18) Paciente de 60 años, muy fumador, con adenopatía de consistencia pétreas en región submandibular izquierda. Este hallazgo corresponde con mayor probabilidad a una adenopatía secundaria a:

- a) cáncer pulmonar
- b) cáncer de estómago
- c) cáncer diferenciado de tiroides
- d) cáncer hipofaríngeo
- e) cáncer de tráquea

19) Es contraindicación de la mastectomía parcial:

- a) Receptores hormonales negativos
- b) Tumor multifocal
- c) Cáncer ductal invasor
- d) Tumor de 5 cms
- e) Cáncer in situ

20) La tríada sintomática de la obstrucción intestinal es

- a) dolor abdominal, vómitos y fiebre
- b) dolor abdominal, fiebre e imposibilidad de eliminar gases
- c) vómitos, constipación y dolor abdominal
- d) dolor abdominal, distensión abdominal y vómitos
- e) vómitos, dolor abdominal y abolición de los ruidos hidroaéreos

Prueba 3 (CIRUGÍA)

1) Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con trombolisis endovenosa, permaneciendo sólo con una leve hemiparesia izquierda. Se realiza ECG que resulta normal, ecocardiografía sin alteraciones y ecografía-doppler carotídea con estenosis carotídea derecha de 60% y estenosis carotídea izquierda de 40%. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación oral y controlar los factores de riesgo cardiovascular
- b) Iniciar aspirina y controlar los factores de riesgo cardiovascular
- c) Realizar endarterectomía derecha
- d) Realizar endarterectomía bilateral
- e) Solicitar angiografía carotídea

2) Un paciente de 64 años consulta por dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos y distensión abdominal progresiva. Refiere haber presentado dolores similares en los meses anteriores, pero mucho menos intensos, también asociados a constipación, pero que cedían espontáneamente cuando lograba evacuar gases y deposiciones. El examen físico presenta distensión abdominal, con dolor a la palpación, hipertimpanidad abdominal y aumento de los ruidos hidroaéreos. La radiografía de abdomen simple muestra asas dilatadas de intestino delgado y de colon, hasta el sigmoides, con varios niveles hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Obstrucción intestinal por bridas
- b) Vólvulo de colon
- c) Diverticulitis aguda
- d) Cáncer de colon obstructivo
- e) Íleo paralítico

3) Un hombre de 45 años es mordido por el gato de su vecina, mientras le ayudaba a atraparlo, para llevarlo a control con su veterinario. Al examen físico se observan varios rasguños en los antebrazos y 4 lesiones puntiformes en el dorso de la mano y los dedos derechos sin signos de infección. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antitetánica, indicar amoxicilina más ácido clavulánico y observar al animal por 10 días
- b) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antirrábica e indicar cloxacilina
- c) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antitetánica y observar al animal por 10 días, sin necesidad de antibióticos
- d) Realizar aseo y curación de la herida, administrar la vacuna antirrábica e indicar amoxicilina más ácido clavulánico
- e) Realizar aseo y curación de la herida, administrar las vacunas antitetánica y antirrábica e indicar antibióticos de amplio espectro

4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Las quemaduras tipo B se caracterizan por ser muy dolorosas
- b) Las quemaduras faciales son de especial cuidado, por el compromiso de la vía aérea
- c) Las quemaduras por electricidad frecuentemente no se manifiestan en toda su gravedad en los primeros minutos, tras la electrocución
- d) Las quemaduras circulares de las extremidades deben ser tratadas con una escarotomía
- e) Las quemaduras tipo A requieren de mayor aporte de volumen que las tipo B

5) Es una herida limpia:

- a) Colectomía
- b) Lobectomía pulmonar
- c) Tiroidectomía total
- d) Amigdalectomía
- e) Hemicolectomía

6) El factor pronóstico más importante del cáncer de lengua es:

- a) El tamaño del tumor
- b) El tipo histológico del tumor
- c) El compromiso de los ganglios linfáticos del cuello
- d) Las metástasis a distancia
- e) La calidad de fumador

7) ¿Cuál de los siguientes casos clínicos debe realizarse un TAC de cerebro y cráneo?

- a) Niño de 5 años, con caída a nivel, golpe en la cabeza y formación de un hematoma en la zona frontal, de 4
- b) Hombre de 60 años se golpea con un poste en la cabeza, mientras caminaba, produciéndose una herida de cuero cabelludo de 5 cm, la que sangró profusamente, cediendo posteriormente
- c) Hombre de 24 años sufre un accidente de tránsito, golpeándose en la cabeza y evolucionando a la hora con cefalea intensa, holocránea y de intensidad en aumento
- d) Niño de 8 años sufre caída en bicicleta golpeándose la cabeza y presentando confusión transitoria de 5 minutos de duración
- e) Mujer de 39 años sufre un golpe en la cabeza, al caer de una silla, presentando 2 episodios de vómitos en la hora siguiente

8) Un hombre de 67 años, con antecedente de diabetes, hipertensión y arritmia cardíaca, presenta dolor abdominal de inicio súbito, muy intenso. Al examen físico se aprecia sudoroso, FC: 100x', presión arterial normal y con abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de abdomen, de pie
- b) Administrar analgésicos y antibióticos
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar colonoscopia de urgencia
- e) Anticoagular con heparina y solicitar angiografía mesentérica

9) Un paciente sufre una caída por una escalera, golpeándose la cara y resultando con fractura de ambas ramas mandibulares. La complicación más característica es:

- a) Hematoma del piso de la boca
- b) Pérdida de la vía aérea
- c) Compromiso del nervio hipogloso
- d) Osteomielitis
- e) Artrosis temporomandibular

10) Un paciente sufre un atropello, con golpe en el tórax y evolucionando con intensa disnea. Al examen físico se observa FC: 110x', PA: 110/70 mmHg, SatO₂: 83%. Destaca examen pulmonar con murmullo pulmonar conservado, simétrico y con crépitos difusos, mayores a izquierda. El examen cardíaco no presenta alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax
- b) Hemotórax
- c) Contusión pulmonar
- d) Tórax volante
- e) Parálisis frénica

11) Un paciente de 50 años, obeso, presenta dolor abdominal, en el hemiabdomen superior, asociado a vómitos alimentarios. El dolor inició hace 4 horas y se volvió cada vez más intenso, siendo actualmente 9/10 e irradiándose al dorso. Al examen físico destaca un abdomen blando, doloroso a la palpación, sin signos peritoneales, pero con disminución de los ruidos hidroaéreos. Se solicitan exámenes que muestran Hcto: 34%, blancos: 15.000, GOT: 250 UI/L, bilirrubina: 2,4 mg/dl, Ca⁺⁺: 8,4 mg/dl, albúmina: 3,0 mg/dl, PCR: elevada, LDH: 290 UI/L, amilasa 460 UI/L, Na⁺: 132 mEq/L, fosfatasas alcalinas: 203 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Colecistitis aguda
- c) Úlcera péptica perforada
- d) Embolia mesentérica
- e) Pancreatitis aguda

12) Un paciente de 18 años consulta por dolor epigástrico de 5 horas de evolución, que luego migra a la fosa ilíaca derecha, siendo muy intenso. Habría presentado deposiciones normales durante la mañana. Al examen físico se observa adolorido, febril hasta 38°C, con dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca derecha, donde además presenta resistencia muscular y signo de Blumberg. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de abdomen, de pie
- b) Administrar analgésicos y antibióticos
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar colonoscopia de urgencia
- e) Resolver inmediatamente, de manera quirúrgica

13) Un hombre de 40 años consulta por dolor anal, intenso, que inicio durante una defecación y que se asocia a escaso sangrado. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorroide externo trombosado
- b) Fisura anal aguda
- c) Hemorroides internos
- d) Absceso perianal
- e) Fístula perianal

14) Respecto al cáncer papilar de tiroides es cierto que:

- a) Su marcador tumoral es la calcitonina
- b) En general, tiene mal pronóstico
- c) Su tratamiento de elección es la tiroidectomía total
- d) Suele dar metástasis hematógenas
- e) No responde a yodo radiactivo

15) La causa más frecuente de fiebre en el postoperatorio es:

- a) Atelectasias
- b) Infección de la herida quirúrgica
- c) Neumonía
- d) Infección urinaria
- e) Farmacológica

16) el neumotórax a tensión se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Hipersonoridad en el hemitórax ipsilateral
- b) Desplazamiento de la tráquea hacia contralateral
- c) Hipertensión arterial
- d) Yugulares ingurgitadas
- e) Asimetría de la caja torácica

17) Una paciente de 46 años, presenta un aumento de volumen bajo la zona inguinal, que aumenta de tamaño cuando realiza esfuerzos o cuando tose. Al examen físico se aprecia aumento de volumen blando, indoloro, que protruye por debajo del ligamento inguinal y que aumenta con las maniobras de Valsalva. El diagnóstico más probable es:

- a) Hernia inguinal directa
- b) Hernia inguinal indirecta
- c) Hernia femoral
- d) Hernia incisional
- e) Hernia de Petit

18) Las 2 causas más frecuentes de obstrucción intestinal son:

- a) Bridas y hernias
- b) Bridas y cáncer
- c) Hernias y cáncer
- d) Hernias e íleo biliar
- e) Bridas e íleo biliar

19) Un lactante de 6 semanas de edad, presenta vómitos postprandiales, de gran volumen, que se iniciaron hace una semana. La madre refiere que toma leche ávidamente, pero que suele vomitar después de todas las tomas. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar fórmula láctea a la lactancia materna
- b) Iniciar un proquinético
- c) Solicitar radiografía de abdomen simple
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Resolver quirúrgicamente a la brevedad

20) En el cáncer de mama, el mayor beneficio del estudio de ganglio centinela, es que permite:

- a) Determinar el grado de diferenciación histológica del tumor
- b) Decidir la indicación de radioterapia
- c) Etapificar, sin necesidad de linfadenectomías extensas
- d) Identificar a aquellas pacientes que no son susceptibles de tratadas con hormonoterapia
- e) Prevenir la diseminación por vía linfática

Prueba 4

UROLOGÍA + CIRUGÍA GENERAL

1) Un hombre de 30 años refiere que su padre, de 55 años, fue diagnosticado de cáncer de próstata recientemente. El consejo más adecuado es:

- a) Realizarse control inmediatamente con tacto rectal más antígeno prostático
- b) Iniciar controles anuales con tacto rectal y antígeno prostático desde los 35 años
- c) Iniciar controles anuales con tacto rectal y antígeno prostático desde los 40 años
- d) Iniciar controles anuales con tacto rectal y antígeno prostático desde los 45 años
- e) Iniciar controles anuales con tacto rectal y antígeno prostático desde los 50 años

2) ¿A qué tipo de herida corresponde la prostatectomía radical?

- a) Limpia
- b) Limpia contaminada
- c) Contaminada
- d) Sucia
- e) Infectada

3) Una paciente de 25 años es diagnosticada de pielonefritis aguda, por E. coli multisensible. Se inicia tratamiento con ciprofloxacino, sin embargo persiste febril y muy decaída luego de 3 días de tratamiento antibiótico. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener el tratamiento antibiótico y reevaluar en 2 días
- b) Cambiar el tratamiento antibiótico a cefadroxilo
- c) Solicitar ecografía
- d) Solicitar TAC
- e) Solicitar nuevo urocultivo con antibiograma

4) ¿Cuál es la primera causa de obstrucción intestinal?

- a) Cáncer
- b) Hernias
- c) Adherencias
- d) Bezoares
- e) Vólvulos

5) Un paciente de 34 años se palpa un aumento de volumen testicular derecho. Al examen físico se palpa tumoración de 3 cm en relación al testículo derecho, sin dolor ni signos inflamatorios. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía testicular
- b) Solicitar alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana
- c) Solicitar biopsia testicular por punción
- d) Realizar tumorectomía y biopsia
- e) Realizar orquiectomía radical

6) La equimosis periumbilical es característica de:

- a) Colangitis aguda
- b) Pileflebitis
- c) Rotura de aneurisma abdominal
- d) Hepatitis por congestión
- e) Pancreatitis aguda

7) Un paciente de 50 años consulta por dolor abdominal, asociado a vómitos. El dolor es muy intenso y comenzó hace 24 horas, localizándose en el epigastrio. Ha presentado deposiciones normales y orinas oscuras. Al examen físico se observa icterico, con signos vitales normales y con abdomen blando, doloroso en el epigastrio, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Colecistitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Coledocolitiasis
- d) Pancreatitis aguda
- e) Hepatitis aguda

8) El principal riesgo de la fimosis en el adulto es:

- a) Impotencia sexual
- b) Cáncer de pene
- c) Parafimosis
- d) Infertilidad
- e) Infección urinaria

9) Una mujer de 48 años presenta escapes de orina, en gran cantidad. Refiere que siente ganas incontrolables de orinar y que no alcanza a llegar al baño, habiendo presentado escapes en varios lugares públicos, lo que afecta sus actividades laborales y sociales. Se descarta la presencia de infección urinaria y se inician ejercicios de Kegel y medidas conductuales, pero persiste con los síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos
- b) Iniciar anticolinérgicos
- c) Iniciar antagonistas alfa-adrenérgicos
- d) Resolver de manera quirúrgica
- e) Solicitar cistoscopia

10) ¿Qué tratamiento antibiótico indicaría a una paciente con infección de una herida operatoria, luego de una mastectomía parcial?

- a) Cefotaximo más metronidazol
- b) Ciprofloxacino
- c) Gentamicina más metronidazol
- d) Ceftriaxona
- e) Cefazolina

11) Un paciente de 50 años, con antecedente de una nefrectomía derecha por un trauma renal hace 5 años, se realiza una ecografía como parte del estudio de un dolor abdominal, de características funcionales, detectándose un tumor renal izquierdo sólido, de 2 cm de diámetro. El examen físico no aporta mayor información. Se realiza TAC con contraste que muestra la lesión compatible con un tumor de células renales, sin adenopatías. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía radical
- b) Realizar nefrectomía parcial
- c) Solicitar alfafetoproteína y Ca 19.9
- d) Iniciar radioterapia
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear

12) Un paciente de 45 años refiere que muchas veces presenta deposiciones con algunas estrías de sangre, sin otros síntomas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- a) Fisura anal
- b) Absceso perianal
- c) Hemorroides internos
- d) Hemorroides externos
- e) Poliposis intestinal

13) Respecto al cólico renal es verdadero que:

- a) El pielotac sólo detecta los cálculos cálcicos
- b) Suele ser bilateral
- c) Suele acompañarse de vómitos
- d) Rara vez el dolor se irradia a genitales
- e) Cede con la flexión lumbar, por lo que los pacientes suelen adoptar una "posición fetal"

14) Un paciente de 65 años consulta por disfagia, de 5 meses de evolución, que aparece al tragar alimentos sólidos, especialmente al no masticarlos bien. No presenta otros síntomas y el examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía abdominal
- b) Solicitar TAC de cuello, tórax y abdomen
- c) Solicitar radiografías baritadas
- d) Solicitar manometría esofágica
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

15) ¿Cuál de las siguientes situaciones requiere de exploración quirúrgica inmediata?

- a) Hombre de 18 años con dolor testicular izquierdo, de 24 horas de evolución, asociado a fiebre
- b) Adolescente de 15 años, con aumento de volumen escrotal, asociado a dolor leve intermitente, palpándose aumento de volumen en "bolsa de gusanos"
- c) Hombre de 60 años, con aumento de volumen escrotal, con prueba de transiluminación positiva
- d) Hombre de 24 años con dolor testicular derecho, de inicio súbito, intenso, asociado a aumento de volumen testicular
- e) Niño de 20 años con aumento de volumen testicular de lento crecimiento y consistencia sólida

16) Respecto a las hernias es verdadero que:

- a) Las hernias crurales son más frecuentes que las inguinales, en las mujeres
- b) La hernia encarcerada presenta compromiso vascular
- c) La hernia incisional no tiene saco peritoneal
- d) Su tratamiento de elección es la observación
- e) La hernia inguinal indirecta atraviesa el anillo inguinal interno

17) ¿Cuál de las siguientes NO es una indicación de tratamiento quirúrgico en un paciente con hiperplasia prostática benigna?

- a) Cálculos vesicales
- b) Elevación del antígeno prostático
- c) Síntomas que no responden al tratamiento médico
- d) Retención urinaria aguda
- e) Hidrouréteronefrosis

18) Un paciente de 60 años consulta por dolor abdominal de 8 horas, asociado a fiebre. El dolor es de carácter sordo y se localiza en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Al examen físico se constata un abdomen blando, depresible, doloroso, especialmente al palpar la fosa iliaca izquierda, sin signos de irritación peritoneal. Entre los exámenes destaca leucocitosis de 13.000 y se realiza TAC que muestra edema y reacción de la grasa pericólica a nivel del colon sigmoides. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con AINEs y antiespasmódicos
- b) Enviar a domicilio con régimen líquido e iniciar ciprofloxacino más metronidazol por vía oral
- c) Realizar colonoscopia
- d) Realizar cirugía de Hartmann
- e) Realizar hemicolectomía izquierda

19) Un paciente de 65 años consulta por hematuria indolora, sin otros síntomas, ni alteraciones en el examen físico. Se solicita sedimento de orina que muestra múltiples glóbulos rojos, sin dismorfia y urocultivo que resulta negativo. Se realiza ecografía renal y vesical que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar ácido tranexánico
- c) Solicitar cistoscopia
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste
- e) Solicitar pielotAC

20) Respecto a la pancreatitis crónica es FALSO que:

- a) Su etiología más frecuente es la patología litiasica biliar
- b) Su síntoma principal es el dolor
- c) En etapas avanzadas suele presentar esteatorrea y diabetes
- d) Se caracteriza por presentar calcificaciones pancreáticas en la radiografía o en la TAC
- e) El tratamiento de primera línea son los AINEs

Prueba 5

1) Un paciente presenta dolor anal, de 12 horas de evolución, muy intenso, especialmente al sentarse. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de color violáceo, en relación a la zona perianal derecha, muy doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar analgésicos y baños de asiento
- b) Iniciar anticoagulación y administrar analgésicos
- c) Iniciar antibióticos y administrar antibióticos
- d) Derivar para resolución quirúrgica
- e) Realizar drenaje por punción

2) La hemorragia subaracnoidea suele producirse en primer lugar por traumatismos craneoencefálicos y en segundo lugar por rotura de aneurismas. Estas últimas suelen presentarse como cefalea de inicio súbito, muy intensa, que habitualmente se describe como “la más intensa de la vida”. ¿Qué examen debe solicitarse en primer lugar ante un paciente en el que se sospecha una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma cerebral?

- a) Ecodoppler carotídeo
- b) Punción lumbar
- c) TAC de cerebro sin contraste
- d) Angiografía carotídea
- e) Resonancia magnética nuclear con medio de contraste

3) Un paciente presenta súbitamente dolor de la extremidad inferior izquierda, asociado a parestesias. Al examen físico se aprecia que desde la zona media del muslo en adelante existe palidez y se constata ausencia de los pulsos poplíteo, tibial posterior y pedio. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores
- b) Iniciar anticoagulación con heparina y realizar estudio de trombofilias
- c) Administrar heparina endovenosa y realizar angiografía de urgencia
- d) Solicitar pletismografía de volumen (PVR)
- e) Resolver quirúrgicamente

4) Un paciente de 35 años sufre una caída en bicicleta, golpeándose el tórax contra el pavimento. Evolucionan con disnea progresiva y desaturación arterial de oxígeno. Al examen físico se observa equimosis del sitio de impacto y se ausculta un murmullo pulmonar simétrico, con crepitaciones bilaterales, mayores en el pulmón derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax a tensión
- b) Neumotórax traumático
- c) Hemotórax
- d) Contusión pulmonar
- e) Tórax volante

5) Un paciente con hipertrigliceridemia de hasta 800 mg/dl, con tratamiento irregular con gemfibrozilo, consulta por dolor abdominal intenso, asociado a vómitos. El dolor es epigástrico y se irradia al dorso. Al examen físico presenta dolor a la palpación, muy intensa, con resistencia muscular en la zona. Se solicitan exámenes que muestran leucocitosis, hematocrito normal, glicemia de 197 mg/dl, protrombinemia de 86%, SGOT de 57 UI/l, bilirrubinemia de 2,3 mg/dl, calcemia de 9,1 mg/dl, natremia de 135 mEq/l, kalemia de 4,6 mEq/l, amilasemia de 546 UI/l, creatinina de 1,8 mg/dl y BUN de 41 mg/dl. La ecografía abdominal no es capaz de identificar alteraciones y es informada con presencia de asas intestinales con gas, que dificulta la visualización ecográfica. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar régimen cero, administrar cristaloides y analgésicos por vía endovenosa
- b) Resolver de manera quirúrgica de inmediato
- c) Solicitar radiografía de abdomen en posición de pie
- d) Iniciar cristaloides, analgésicos y antibióticos por vía endovenosa
- e) Indicar régimen hídrico e insistir en el adecuado uso del hipolipemiente

6) El mejor examen para iniciar el estudio de un nódulo tiroideo, con TSH normal, es:

- a) Tomografía axial computada de cuello
- b) Cintigrafía con yodo radiactivo
- c) Biopsia excisional
- d) Biopsia por punción con aguja gruesa
- e) Ecografía cervical

7) Un paciente de 20 años con historia de broncorrea crónica de predominio matinal, presenta hemoptisis masiva. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cáncer pulmonar de células pequeñas
- b) Adenocarcinoma bronquioloalveolar
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Bronquiectasias
- e) Tuberculosis

8) Un paciente de 63 años, con historia de constipación de 1 año de evolución, se realiza colonoscopia que demuestra una tumoración de 8 cm de diámetro en el colon descendente, la que se biopsia, siendo informada como un adenocarcinoma tubular de grado de diferenciación intermedio. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar para inicio de radioterapia preoperatoria
- b) Solicitar test de sangre oculta en deposiciones
- c) Solicitar antígeno carcinoembrionario
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Solicitar TAC de tórax y abdomen

9) ¿Qué aseveración es correcta?

- a) Las úlceras arteriales suelen ser indoloras
- b) Las úlceras arteriales se caracterizan por ubicarse en el maléolo interno
- c) Las úlceras venosas son un criterio diagnóstico de isquemia crítica crónica de extremidades inferiores
- d) Las úlceras venosas suelen tratarse con antibióticos y curaciones frecuentes
- e) Las úlceras venosas suelen asociarse a hiperpigmentación de la piel circundante

10) La etiología más frecuente de los aneurismas aórticos abdominales es:

- a) Enfermedad arterial ateromatosa
- b) Degeneración quística de la media
- c) Displasia fibromuscular
- d) Aneurisma micótico
- e) Hipertensión arterial

11) Un paciente con angina crónica se realiza un test de esfuerzo que resulta positivo para isquemia de la pared inferior. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía de provocación miocárdica con talio - dipiridamol
- b) Iniciar enalapril, furosemida y carvedilol
- c) Solicitar ecocardiograma
- d) Iniciar aspirina y acenocumarol
- e) Solicitar coronariografía

12) El tratamiento inicial del neumotórax a tensión es:

- a) Oxígeno al 100% por mascarilla de recirculación
- b) Ventilación a presión positiva con ambú
- c) Instalar un tubo pleural
- d) Punción del segundo espacio intercostal en la línea media clavicular
- e) Compresión torácica

13) El factor pronóstico más importante del cáncer de cavidad oral es:

- a) Tamaño del tumor
- b) Compromiso linfático
- c) Tipo histológico
- d) Presencia de metástasis a distancia
- e) Ubicación dentro de la cavidad oral

14) ¿Qué afirmación es FALSA?

- a) La mayoría de los pólipos de vesícula biliar son benignos, de tipo colesterolínico
- b) El mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula biliar es la presencia de cálculo biliares de gran tamaño
- c) La vesícula en porcelana rara vez evoluciona a cáncer de vesícula biliar
- d) El cáncer de vesícula biliar es la causa más frecuente de muerte por cáncer en la población femenina chilena
- e) El antígeno carcinoembrionario es un marcador de cáncer de vesícula biliar

15) Un paciente de 34 años, consulta por dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos explosivos y distensión abdominal progresiva. Al examen físico se observa abdomen distendido, timpánico, doloroso, con aumento de los ruidos hidroaéreos. Se aprecia una cicatriz subcostal derecha, producto de una colecistectomía, realizada 5 años atrás. Se solicita radiografía de abdomen que muestra asas intestinales dilatadas, con múltiples niveles hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- b) Solicitar ecografía abdominal
- c) Iniciar régimen cero y antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste
- e) Administrar volumen y antibióticos endovenosos y resolver quirúrgicamente de inmediato

16) Un paciente de 67 años presenta aumento de volumen en el antebrazo izquierdo, de un año de evolución, indoloro. Al examen físico se aprecia una masa de 15 cm x 9 cm en el tercio medio del antebrazo, de consistencia similar al resto del antebrazo, adherida a planos profundos. No se palpan adenopatías axilares. El diagnóstico más probable es:

- a) Tumor de Ewing
- b) Lipoma
- c) Linfoma
- d) Quiste de Baker
- e) Sarcoma

17) Un paciente de 67 años sufrió un infarto miocárdico transmural hace 4 meses, el que fue exitosamente tratado con estreptoquinasa. Evoluciona bien, sin embargo en su electrocardiograma de control se observa marcado supradesnivel del segmento ST en las derivaciones precordiales V2 a V5. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Holter de arritmias
- b) Solicitar test de esfuerzo
- c) Solicitar ecocardiograma
- d) Derivar al servicio de urgencia para manejo de síndrome coronario agudo
- e) Solicitar coronariografía

18) Un paciente sufre hemiparesia faciobraquiocrural izquierda, asociada a dificultad para hablar, que dura cerca de 15 minutos, cediendo espontáneamente. A la auscultación cardíaca se constata ritmo regular en 2 tonos, sin soplos, sin embargo se ausculta un soplo en la carótida derecha. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar angiografía carotídea
- b) Solicitar ecodoppler carotídeo
- c) Solicitar angio-TAC de tórax y cuello
- d) Iniciar aspirina y atorvastatina y controlar en 3 meses
- e) Iniciar anticoagulación a permanencia

19) Un paciente es diagnosticado de cáncer papilar de tiroides, sin adenopatías, con los exámenes pertinentes. Su TSH es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar levotiroxina oral
- b) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- c) Solicitar calcitonina plasmática
- d) Solicitar tiroglobulina plasmática
- e) Realizar tiroidectomía total

20) Un paciente recibe una puñalada en el tórax. Se encuentra en buenas condiciones, con signos vitales normales y sin sangrado activo. La herida es de 2 cm de largo en relación a la parrilla costal izquierda y el examen cardiopulmonar es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar pericardiocentesis
- b) Instalar tubo pleural
- c) Suturar la herida
- d) Solicitar radiografía de tórax
- e) Realizar exploración digital bajo anestesia local

Prueba 6

1) Ante un cuadro clínico de edema global del miembro inferior desde la raíz del muslo, en una paciente encamada por postoperatorio traumatológico, ¿qué prueba, de las siguientes, solicitaría en primer lugar?:

- a) Angioresonancia.
- b) Flebografía ascendente y/o cavografía retrógrada.
- c) Eco-Doppler venoso.
- d) Estudio con fibrinógeno marcado I125.
- e) Pletismografía venosa por aire o anillos de mercurio.

2) Una mujer de 45 años de edad comienza a padecer hace dos semanas dolor, frialdad e impotencia funcional en extremidad inferior derecha. La sintomatología cede espontáneamente a las pocas horas y acude dos semanas más tarde con claudicación intermitente a los 150 m (pierna derecha). El índice tobillo/brazo es: 0,4 (derecho) y 1 (izquierdo). ¿Cuál será, de los siguientes, el tratamiento de elección?:

- a) Antiagregación plaquetaria.
- b) Fibrinólisis.
- c) Anticoagulación.
- d) Embolectomía.
- e) Simpatectomía lumbar.

3) La práctica de una radiografía posteroanterior de tórax en espiración máxima es de gran utilidad para el diagnóstico de:

- a) Un derrame pleural.
- b) Un neumotórax mínimo.
- c) Un hemotórax.
- d) Una atelectasia pulmonar.
- e) Una atelectasia lobar

4) Un ejecutivo de una gran empresa, de 40 años y sin antecedentes de interés, acude al servicio de urgencias por presentar un dolor brusco y de gran intensidad, localizado en el epigastrio que ha comenzado una hora antes y no cede. A la exploración, el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración superficial; el abdomen contracturado es muy doloroso a la palpación superficial, mostrando desaparición de la matidez hepática a la percusión. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

- a) Apendicitis aguda.
- b) Pancreatitis aguda.
- c) Perforación gástrica.
- d) Colecistitis aguda.
- e) Isquemia mesentérica.

5) Una paciente de 83 años, con antecedentes de hipertensión arterial, es diagnosticada en el Servicio de Urgencias de un primer episodio de diverticulitis aguda, sin síntomas ni signos de peritonitis generalizada, y con un estudio de imagen que demuestra la presencia de una absceso en la pelvis en contacto con la pared abdominal, de 5 cm. de diámetro. La mejor actitud ante esta paciente será:

- a) Alta a domicilio con tratamiento antibiótico por vía oral (ciprofloxacino y metronidazol).
- b) Ingreso para realizar una proctocolectomía urgente.
- c) Ingreso para drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico intravenoso.
- d) Ingreso, dieta absoluta, líquidos i.v., cefalosporina de tercera generación i.v.
- e) Ingreso, colostomía de descarga y drenaje quirúrgico del absceso.

6) En la valoración en el servicio de urgencias hospitalario de un paciente con dolor abdominal agudo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:

- a) El inicio, la localización y severidad de dolor son útiles en el diagnóstico diferencial.
- b) La palpación es el aspecto más importante de la exploración física.
- c) El recuento de leucocitos puede ser normal en procesos inflamatorios abdominales como la apendicitis.
- d) La ecografía es una prueba de imagen útil y cada vez más utilizada en la valoración del dolor abdominal.
- e) No debe administrarse medicación analgésica hasta que el cirujano valore al paciente porque puede oscurecer el diagnóstico.

7) Paciente de 72 años, que como único tratamiento toma antidiabéticos orales, presenta anemia ferropénica crónica, con hemorragias ocultas positivas. ¿Cual es el método diagnóstico más indicado para localizar la lesión sangrante?:

- a) Tránsito gastroduodenal.
- b) Gammagrafía con hematíes marcados.
- c) Tránsito intestinal.
- d) Colonoscopia total.
- e) Panendoscopia oral.

8) A un paciente de 70 años, colecistectomizado, con ictericia de 48 horas de evolución, Bilirrubina total de 8 mg/dl y Bilirrubina directa de 6 mg/dl, fosfatasa alcalina 620 UI/L, fiebre de 39°C y leucocitosis mayor de 20.000 con desviación izda., se le realiza ecografía abdominal siendo informada como coledocolitiasis. El tratamiento inicial debe ser:

- a) Reposición hidroelectrolítica y antibioterapia únicamente, posponiendo cualquier otro proceder a la desaparición de los síntomas y signos de la infección.
- b) Reposición hidroelectrolítica, antibioterapia y laparotomía urgente.
- c) Reposición hidroelectrolítica, antibioterapia y corticosteroides.
- d) Reposición hidroelectrolítica, antibioterapia y litotricia.
- e) Reposición hidroelectrolítica, antibioterapia y esfinterotomía + drenaje biliar mediante colangiografía retrógrada endoscópica.

9) Enferma de 62 años con diabetes mellitus tipo II ingresa por dolor en hemiabdomen superior e hiperamilasemia siendo diagnosticada de pancreatitis aguda. El estudio realizado no demuestra etiología de la misma. A las 3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrándose asintomática, la ecografía abdominal evidencia una colección líquida, bien delimitada, de unos 35 x 30 mm de diámetro, con características inequívocas de pseudoquistes pancreáticos. ¿Qué conducta de las siguientes es más adecuada?:

- a) Intervención quirúrgica.
- b) Drenaje percutáneo de la colección líquida.
- c) Actitud expectante y seguir la evolución clínica en espera de la resolución espontánea.
- d) Punción-aspiración percutánea dirigida por ecografía para el análisis del líquido de la colección.
- e) Drenaje endoscópico del pseudoquiste.

10) Un paciente presenta un cuadro compatible con abdomen agudo quirúrgico. Se le practica una laparotomía exploradora con carácter urgente, sin encontrar nada patológico. Desde el punto de vista del riesgo de infección, esta intervención se considera:

- a) Limpia.
- b) Limpia-contaminada.
- c) Contaminada.
- d) Sucia.
- e) Infectada.

11) Varón de 24 años que ha ingresado en urgencias 3 horas antes por haber sufrido un grave traumatismo en el hemitórax derecho. En las radiografías se aprecian fracturas costales múltiples en este hemitórax, y es evidente el movimiento paradójico de la pared costal derecha a la inspiración; la situación hemodinámica es aceptable. En la gasometría arterial hay hipoxia e hipercapnia acusadas, que han empeorado desde el ingreso, a pesar de estarse aplicando oxigenoterapia con mascarilla, con una FiO₂ de 0,5. ¿Cuál de estas medidas terapéuticas indicaría inmediatamente?:

- a) Toracotomía exploradora, para determinar si hay lesiones pulmonares asociadas.
- b) Colocar 2 tubos de aspiración en el hemitórax derecho.
- c) Intubación endotraqueal y ventilación mecánica con presión positiva.
- d) Vendaje compresivo, que inmovilice el hemitórax derecho.
- e) Aumentar la FiO₂ a 0,7.

12) La causas más frecuentes de hemorragia subaracnoidea es:

- a) Traumática
- b) Aneurismática
- c) Por ruptura MAV
- d) Por tratamiento anticoagulante oral
- e) Tumoral

13) ¿Qué pacientes con prótesis valvular mitral mecánica tienen indicación de tratamiento anticoagulante oral permanente, con derivados cumarínicos?

- a) Aquellos con fibrilación auricular crónica
- b) Aquellos con antecedentes de cuadros embólicos
- c) Todos, aún cuando tengan ritmo sinusal
- d) Aquellos que presentan crecimiento auricular
- e) Aquellos mayores de 65 años

14) La vía de propagación más frecuente en el cáncer de colon es:

- a) linfática
- b) vascular
- c) diseminación peritoneal
- d) endoluminal
- e) Invasión local

15) Un paciente de 65 años portador de una masa inguinal que antes se reducía y desde hace 3 horas no puede reducir, consulta en policlínico. Al examen impresiona como una hernia inguinal, irreductible, sensible. La conducta más apropiada en ese momento es:

- a) Hospitalizar y programar cirugía de urgencia
- b) Solicitar interconsulta con Urólogo
- c) Solicitar exámenes de sangre pre operatorios y programar cirugía electiva
- d) Hospitalizar y programar cirugía diferida
- e) Solicitar ecografía de pared abdominal

16) Respecto de la fisura anal crónica, es cierto que:

- a) La etiología se debe a un traumatismo crónico del canal anal
- b) El mecanismo etiológico es Inflamatorio-Infeccioso por una infección de la musculatura perianal
- c) La hipertensión esfinteriana causaría isquemia de los tejidos rectoanales
- d) La mayor frecuencia de localización es en el rafe anterior
- e) Suele ser asintomática

17) En un paciente de 60 años de edad, hombre y fumador, que se le encuentra una masa cervical del grupo II y cuya biopsia por aguja informa un carcinoma escamoso, lo más probable es que sea una metástasis de un cáncer:

- a) del epitelio aereodigestivo superior
- b) de tiroides
- c) de pulmón
- d) gástrico
- e) de glándula salival

18) La presencia de microcalcificaciones mamográficas BIRADS 4 en una mujer de 50 años de edad, requiere de la siguiente conducta:

- a) Una ecotomografía de alta resolución
- b) Una mamografía en seis meses y reevaluar el caso
- c) Una biopsia estereotáxica
- d) Sólo seguir en control anual mamográfico
- e) Mastectomía parcial con radioterapia postquirúrgica

19) La causa más frecuente de obstrucción de colon es:

- a) Hernias
- b) Bidas
- c) Cáncer
- d) Diverticulitis
- e) Vólvulo

20) Un paciente será sometido a una neumonectomía, debido a broquiectasias localizadas. ¿Durante qué periodo debe administrarse la profilaxis antibiótica?

- a) Desde 3 días antes hasta 3 días después de la cirugía
- b) Desde 3 días antes hasta el día de la cirugía
- c) Desde la cirugía hasta 3 días después de la cirugía
- d) Desde 3 días antes hasta 7 días después de la cirugía
- e) Sólo el día de la cirugía

Prueba 7

1) Un paciente consulta por dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, de 2 horas de evolución, intenso y asociado a vómitos alimentarios, en varias ocasiones. Al examen físico se encuentra adolorido, en buenas condiciones, con PA: 120/80 mmHg, FC: 89x', FR: 18x', t°: 36,4°C. El abdomen es blando depresible, sensible en hipocondrio derecho, con RHA normales, sin signos de irritación peritoneal. El hemograma, pruebas hepáticas y lipasa son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con antiespasmódicos y dieta liviana
- b) Iniciar antibióticos y analgésicos
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Realizar laparotomía

2) Un paciente de 65 años sufre una caída de altura golpeándose el tórax contra el suelo. Evoluciona con cierto grado de dificultad respiratoria y al examen se constata abolición del murmullo pulmonar de la mitad inferior del campo pulmonar derecho y matidez en dicha zona. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Contusión pulmonar
- c) Neumotórax
- d) Hemotórax
- e) Derrame pericárdico

3) Un paciente de 23 años acude a control por aumento de volumen cervical. AL examen físico se palpa un nódulo de 2,5 cm en la zona supraesternal, de consistencia dura, que asciende con la deglución. Se solicita TSH que resulta normal y ecografía cervical que confirma un nódulo sólido, de ecogenicidad homogénea, sin presencia de adenopatías cervicales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar seguimiento ecográfico
- b) Solicitar anticuerpos anti-TPO
- c) Solicitar biopsia por punción
- d) Realizar tumorectomía y biopsia
- e) Derivar para tiroidectomía total

4) Un paciente de 67 años sufre pérdida de la visión del ojo izquierdo hace 3 días, de inicio súbito y 10 minutos de duración, que se recuperó espontáneamente. No presentó otros síntomas. Al examen físico destaca un soplo carotídeo izquierdo. La conducta diagnóstica más adecuada es:

- a) Realizar un ecocardiograma
- b) Realizar una angiografía carotídea
- c) Realizar un angioTAC de tórax y cuello
- d) Realizar un Ecodoppler carotídeo
- e) Solicitar un perfil lipídico y dímero D

5) Respecto a los hemorroides externos es verdadero que:

- a) Son causa frecuente de hemorragia de origen proctológico
- b) La complicación más grave es la fluxión hemorroidal
- c) Se producen por infecciones perianales recurrentes
- d) Son intensamente dolorosos cuando se trombosan
- e) Su diagnóstico requiere de una ecografía doppler

6) Un paciente de 33 años presenta sintomatología de un síndrome de Sjörgren, por lo que se realiza una biopsia quirúrgica de glándula salival menor de labio inferior. ¿A qué tipo de herida corresponde este procedimiento?

- a) Limpia
- b) Limpia contaminada
- c) Contaminada
- d) Sucia
- e) Infectada

7) Un hombre de 42 años, trabajador de una empresa forestal, sufre herida de gran tamaño en el muslo derecho, al enterrarse una estaca de pino. Al examen físico tiene una herida de 8 cm de largo y cerca de 4 cm de profundidad, con abundantes restos vegetales. El paciente habría recibido un esquema completo de vacunación antitetánica hace 30 años y una dosis de refuerzo hace 4 años, debido a un accidente similar, pero con una herida de tamaño mucho menor. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar esquema completo de toxoide tetánico e inmunoglobulina hiperinmune
- b) Administrar una nueva dosis de toxoide antitetánico y además inmunoglobulina hiperinmune
- c) Administrar inmunoglobulina hiperinmune, sin necesidad de nuevas dosis de toxoide
- d) Administrar una dosis de toxoide tetánico, de refuerzo, sin necesidad de inmunoglobulina
- e) No administrar vacuna ni inmunoglobulina antitetánica

8) Respecto a las úlceras venosas, es cierto que:

- a) Se localizan frecuentemente en el maléolo externo
- b) Suelen ser muy dolorosas
- c) Su tratamiento incluye antibióticos de amplio espectro
- d) Se producen por hipertensión capilar hipostática
- e) Rara vez presentan alteraciones de la piel circundante

9) Las causas más frecuentes de obstrucción de colon son:

- a) Divertículos y angiodisplasias
- b) Bridas y hernias
- c) Hernias y vólvulos
- d) Cáncer y diverticulitis
- e) Bridas y cáncer

10) ¿Cuál de las siguientes opciones NO representa un riesgo mayor de presentar náuseas y vómitos en el postoperatorio?

- a) Paciente fumador
- b) Sexo femenino
- c) Uso de morfina durante la cirugía
- d) Historia de náuseas fáciles de desencadenar
- e) Historia de náuseas en cirugías anteriores

11) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las hernias es falsa?

- a) La hernia encarcerada es dolorosa e imposible de reducir
- b) La hernia crural es más frecuente en las mujeres, que en los hombres
- c) La hernia inguinal indirecta es la más frecuente en ambos sexos
- d) La hernia estrangulada presenta compromiso vascular del contenido herniario
- e) La hernia crural, contiene un saco herniario que protruye por sobre el ligamento inguinal

12) Respecto al cáncer gástrico es falso que:

- a) Es la primera causa de muerte por cáncer en la población masculina chilena
- b) El único tratamiento con intención curativa es la cirugía
- c) Su etiología se asocia a la presencia de *Helicobacter pylori*
- d) Se diagnostica y etapifica mediante biopsia endoscópica y tomografía computarizada, respectivamente
- e) Su factor pronóstico más importante es la presencia de adenopatías comprometidas

13) Una paciente presenta dolor abdominal tipo cólico, asociado a vómitos y distensión abdominal con bazuqueo y aumento de los ruidos hidroaéreos. La ecografía abdominal demuestra neumobilia. La sospecha diagnóstica es:

- a) Intususcepción
- b) Colecistitis aguda
- c) Obstrucción intestinal por bridas
- d) Íleo biliar
- e) Vólvulo intestinal

14) Una paciente de 39 años se palpa varios nódulos mamarios de pequeño tamaño, algunos de ellos sensibles. Se realiza una mamografía que es informada como Birrads 2. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nueva mamografía en un año
- b) Realizar nueva mamografía en 6 meses
- c) Solicitar ecografía mamaria
- d) Solicitar biopsia por aguja fina
- e) Solicitar biopsia con mamótomo

15) Un paciente ingresa por un cuadro de colecistitis aguda, comprobada por ecografía y exámenes de sangre. La conducta anestésica más adecuada, para el manejo de la vía aérea es:

- a) Ocupar máscara laríngea
- b) Realizar intubación en secuencia rápida
- c) Inducir, administrar relajantes musculares, ventilar con ambú y realizar intubación orotraqueal una vez lograda una buena relajación
- d) Instalar una cánula Mayo
- e) Realizar anestesia superficial con dosis bajas de gases halogenados, sin necesidad de utilizar dispositivos de manejo de la vía aérea

16) La complicación más importante del aneurisma aórtico abdominal operado, es:

- a) Rotura del aneurisma
- b) Infección de la herida operatoria
- c) Embolias arteriales
- d) Infección de la prótesis aórtica
- e) Infarto agudo al miocardio

17) La conducta inicial, más adecuada, ante un paciente con dolor abdominal intenso, vómitos y elevación marcada de la lipasa, es:

- a) Indicar régimen cero, reponer volumen con cristaloides e iniciar analgésicos endovenosos
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis y si se encuentra alterado, resolver quirúrgicamente
- c) Iniciar antibióticos de amplio espectro, antiespasmódicos y AINEs por vía oral
- d) Iniciar régimen liviano, sin grasas y solicitar ecografía abdominal
- e) Realizar colangiografía retrógrada endoscópica de inmediato

18) ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una indicación de cirugía en un paciente con endocarditis bacteriana?

- a) Endocarditis sobre válvula aórtica bicúspide
- b) Abscesos perivalvulares
- c) Embolias sépticas a repetición
- d) Fracaso del tratamiento médico
- e) Insuficiencia cardíaca secundaria a rotura valvular

19) Una paciente es operada con resección de un lipoma de 5 cm, en el muslo derecho. Durante la cirugía recibió anestesia regional. Inicialmente bien, sin embargo evoluciona con eritema de la herida quirúrgica, que se extiende a la piel circundante, con un halo eritematoso de 5 cm y escaso exudado purulento. El antibiótico de elección para el tratamiento de esta complicación es:

- a) Ceftriaxona
- b) Cefazolina
- c) Gentamicina
- d) Cirpofloxacino
- e) Azitromicina

20) Un paciente con historia de epigastralgia urente y recurrente, de larga data, presenta un esguince de tobillo, por lo que inicia analgesia con ketorolaco oral. El dolor epigástrico se hace muy intenso y se irradia al dorso. Al examen presenta un abdomen muy doloroso, de forma difusa, con signos de irritación peritoneal marcados y abolición de los ruidos hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar omeprazol endovenoso y antibióticos de amplio espectro, reevaluando periódicamente
- b) Realizar endoscopia digestiva alta de urgencia
- c) Suspender el ketorolaco e iniciar tramadol y omeprazol oral
- d) Administrar suero fisiológico endovenoso y solicitar radiografía de abdomen y tórax de pie
- e) Realizar apendicectomía de inmediato

Prueba 8

1) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con golpe en el pecho. Evoluciona con dolor y dificultad respiratoria. Al examen físico destaca matidez y disminución del murmullo pulmonar en la base izquierda, asociado a FR: 22x' y SatO₂: 94%. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar Radiografía de tórax
- b) Realizar punción del segundo espacio intercostal
- c) Instalar un tubo pleural
- d) Administrar oxígeno en altas concentraciones por mascarilla de recirculación
- e) Iniciar ventilación a presión positiva

2) Una paciente de 55 años, consulta por vómitos y dolor abdominal intenso, que iniciaron al día siguiente de una abundante ingesta alimentaria y alcohólica. El dolor es de carácter sordo, localizado en el epigastrio e irradiado al dorso. Al examen físico destaca dolor a la palpación abdominal, mayor en el epigastrio, con disminución de los ruidos intestinales. Se solicitan exámenes de sangre que muestran, hematocrito: 32%, blancos: 15.600 por mm³, plaquetas: 160.000 por mm³, Na: 130 mEq/l, Cl: 90 mEq/l, K: 5,8 mEq/l, Ca: 8,0 mg/dl, creatinina: 3,4 mEq/l, GOT: 250 UI/l, GPT: 180 UI/l, GGT: 110 UI/l, FA: 201 UI/l, bilirrubina: 3,2 mg/dl, amilasa: 280 UI/l, glicemia: 240 mg/dl. La ecografía abdominal no muestra alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Colédocolitiasis
- b) Colangitis aguda
- c) Hepatitis aguda
- d) Pancreatitis aguda
- e) Úlcera gastroduodenal perforada

3) Qué examen es el más adecuado ante la sospecha de una úlcera péptica perforada:

- a) Ecografía abdominal
- b) Resonancia magnética nuclear
- c) TAC de abdomen y pelvis
- d) Radiografía de tórax de pie
- e) Cintigrafía

4) Un paciente de 60 años, consulta por dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos alimentarios y que no ha cedido con el uso de espasmolíticos. Al examen físico se aprecia distensión abdominal marcada, se auscultan ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad, con timbre metálico y bazuqueo intestinal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Obstrucción intestinal
- c) Cólico biliar
- d) Síndrome de intestino irritable
- e) Diverticulitis aguda

5) ¿Qué situación define una mayor gravedad en un paciente con claudicación intermitente?

- a) Dolor de reposo
- b) Disminución del pulso pedio
- c) Pérdida de fanéreos
- d) Disminución de la sensibilidad vibratoria y táctil
- e) Impotencia sexual asociada

6) Un paciente de 65 años consulta por dolor torácico intenso, de inicio súbito, asociado a disfonía de inicio súbito. El dolor inició hace una hora y ha ido aumentando con el tiempo. Al examen físico presenta PA: 210/130 mmHg y se oye una voz bitonal, compatible con una parálisis de un nervio laríngeo recurrente. El diagnóstico más probable es:

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Tromboembolismo pulmonar
- c) Mixoma auricular complicado
- d) Rotura diafragmática
- e) Disección aórtica

7) Un paciente de 18 años, delgado, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio y disnea. Al examen se ausculta asimetría del murmullo pulmonar. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumotórax espontáneo
- b) Derrame pleural
- c) Cuerpo extraño bronquial
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Pericarditis aguda

8) Un paciente de 80 años sufre una caída por una escalera, resultando con un golpe en la cabeza. Al examen físico se aprecia una pequeña erosión de cuero cabelludo, sin focalidad neurológica, ni otras alteraciones. Se solicita un TAC de cerebro que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, indicando control en caso de aparición de signos de alarma
- b) Hospitalizar para observación por 24 horas
- c) Solicitar TAC de cerebro seriados
- d) Solicitar RMN de cerebro
- e) Realizar punción lumbar

9) Un paciente de 65 años consulta por un cuadro de epigastralgia crónica, asociada a baja de peso de 6 kg en los últimos 2 meses. El examen físico resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar ecografía de abdomen
- c) Solicitar endoscopia digestiva alta
- d) Solicitar lipasa y pruebas hepáticas
- e) Tranquilizar al paciente, indicar dieta y observar evolución

10) Una paciente de 54 años consulta porque se autopalpó un nódulo mamario izquierdo. Al examen físico se palpa un nódulo de cerca de 2 cm de diámetro, de consistencia dura. La mamografía demuestra un nódulo mamario en forma de "Y" con varias microcalcificaciones agrupadas en disposición lineal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de mama
- b) Fibroadenoma
- c) Tuberculosis mamaria
- d) Mastitis crónica
- e) Mastopatía fibroquística

11) Un paciente de 42 años consulta por aumento de volumen cervical, sin otros síntomas. Al examen físico se palpa un nódulo cervical anterior, ubicado en la línea media, que asciende al deglutir. Se solicita TSH que resulta 8 UI/l y una ecografía que revela un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, de consistencia sólida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar levotiroxina, sin necesidad de estudios adicionales
- b) Solicitar T4 libre y anticuerpos anti-TPO
- c) Resolver de manera quirúrgica
- d) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- e) Solicitar biopsia por punción con aguja fina

12) Un paciente de 35 años presenta dolor anal muy intenso, que inició luego de defecar y que fue seguido de escasa rectorragia. El diagnóstico más probable y el tratamiento más adecuado, son respectivamente:

- a) Absceso perianal y resolver quirúrgicamente
- b) Hemorroide externo trombosado e indicar baños de asiento
- c) Fisura anal aguda e indicar baños de asiento
- d) Fisura anal aguda y resolver quirúrgicamente
- e) Hemorroide externo trombosado y resolver quirúrgicamente

13) Una paciente de 70 años consulta por dolor abdominal, en la fosa ilíaca izquierda, asociado a fiebre y malestar general. Al examen físico se palpa abdomen doloroso, con Blumberg esbozado en la zona. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis que muestra zona de edema y signos de diverticulitis aguda en el colon sigmoidees, sin evidencias de complicación. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar régimen hídrico y tratamiento antibiótico oral
- b) Hospitalizar, indicar régimen cero y administrar antibióticos y suero fisiológico, por vía endovenosa
- c) Solicitar colonoscopia de urgencia
- d) Observar evolución
- e) Realizar cirugía de urgencia

14) Un paciente es operado de apendicitis aguda. Al tercer día evoluciona con malestar general, fiebre y tos con abundante expectoración mucopurulenta. Al examen físico se ausculta crepitaciones en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Atelectasia
- b) Neumonía
- c) Derrame pleural
- d) Cuerpo extraño bronquial
- e) Tromboembolismo pulmonar

15) Un paciente consulta por aumento de volumen inguinal izquierdo, indoloro y sin otros síntomas. Al examen físico se constata aumento de volumen no doloroso, reductible, que se reproduce con la maniobra de Valsalva, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución clínica
- b) Realizar seguimiento ecográfico
- c) Indicar cirugía electiva
- d) Indicar cirugía de urgencia
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis y decidir conducta según los hallazgos

16) Un lactante de 9 meses de edad presenta crisis de llanto, asociada a deposiciones rojo intensa. El diagnóstico más probable es:

- a) Divertículo de Meckel
- b) Enterocolitis necrotizante
- c) Shigellosis
- d) Intususcepción intestinal
- e) Pólipo intestinal

17) Un paciente cursando un infarto agudo al miocardio anteroseptal, de 12 horas de evolución, presenta rápido deterioro de su estado hemodinámico. Al examen físico se ausculta un soplo holosistólico, que antes no tenía. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de la pared libre
- b) Rotura del músculo papilar
- c) Disección aórtica
- d) Aneurisma diverticular
- e) Endocarditis aguda

18) Un paciente asintomático, se realiza una ecografía abdominal, que muestra la presencia de un cálculo biliar de 3,4 cm de diámetro. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar seguimiento ecográfico
- b) Enviar a domicilio e indicar control en caso de síntomas
- c) Programar cirugía electiva
- d) Realizar cirugía de urgencia
- e) Solicitar colangiografía magnética nuclear

19) Un paciente se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de un cuadro de dolor abdominal de 6 meses de evolución, que evidencia 3 lesiones hepáticas de aspecto sólido, hipoecogénicas, redondeadas de 8, 14 y 20 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Quistes simples
- b) Quistes hidatídicos
- c) Hemangiomas
- d) Adenomas
- e) Metástasis

20) Un paciente de 75 años se realiza palpa una masa pulsátil en el abdomen. Se solicita un TAC que muestra un aneurisma aórtico infrarrenal de 7 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar angiografía
- b) Solicitar ecografía
- c) Iniciar anticoagulación a permanencia
- d) Solicitar angioTAC de abdomen
- e) Resolver quirúrgicamente

Prueba 9

1) Un paciente de 60 años se realiza una ecografía abdominal que identifica un aneurisma aórtico infrarrenal, de 5,5 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar seguimiento ecográfico y mejorar los factores de riesgo cardiovascular
- b) Solicitar angioresonancia
- c) Solicitar angiografía de urgencia
- d) Resolver quirúrgicamente, mediante endoprótesis
- e) Solicitar TAC de abdomen

2) Un paciente de 35 años presenta aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia un nódulo cervical anterior, ubicado en la línea media, que asciende con la deglución, de cerca de 2,5 cm de diámetro. Se solicita TSH que resulta normal y ecografía cervical que muestra un nódulo tiroideo de 2,6 cm de diámetro mayor, de aspecto sólido quístico, con pequeñas calcificaciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia excisional
- b) Solicitar biopsia por punción con aguja fina
- c) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- d) Solicitar calcitonina plasmática
- e) Iniciar levotiroxina oral y controlar en 3 meses

3) Un paciente de 66 años, hipertenso, consulta por dolor torácico intenso, irradiado al dorso. Al examen físico está taquicárdico, con PA: 200/120 y un soplo cardíaco diastólico III/VI que antes no tenía. Se solicita electrocardiograma que muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecocardiografía transtorácica y administrar antihipertensivos
- b) Solicitar angioTAC de tórax de urgencia y administrar antihipertensivos
- c) Iniciar aspirina, nitroglicerina, oxígeno y morfina y solicitar troponinas plasmáticas
- d) Iniciar anticoagulación con heparina y administrar antihipertensivos
- e) Administrar captopril sublingual y solicitar test de esfuerzo una vez solucionado el cuadro

4) Los abscesos de cabeza y cuello, deben ser tratados a tiempo, ya que en caso contrario, con frecuencia se complican con:

- a) Hipotiroidismo
- b) Hipoparatiroidismo e hipocalcemia severa
- c) Mediastinitis aguda
- d) Parálisis frénica
- e) Flegmón de cuello

5) Un paciente sufre un atropello, con golpe en el tórax. Evoluciona con disnea. Al examen físico se aprecian crepitaciones difusas, sin otras alteraciones pulmonares. Se solicita radiografía de tórax que muestra un patrón de relleno alveolar bilateral, mayor en el lóbulo superior izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión pulmonar
- b) Distrés respiratorio
- c) Hemotórax
- d) Lesión traqueobronquial
- e) Neumonía aspirativa

6) Un paciente sufre una puñalada en el abdomen. Al examen físico está en buenas condiciones y se aprecia una herida de 2 cm de largo, con escaso sangrado. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparotomía de urgencia
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar radiografía de abdomen y pelvis
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Realizar exploración digital con anestesia local

7) ¿Qué alteración es MENOS probable de encontrar en un paciente con neumotórax a tensión?

- a) Yugulares colapsadas
- b) Asimetría torácica
- c) Abolición del murmullo pulmonar en un hemitórax
- d) Hipotensión arterial
- e) Taquipnea

8) Un paciente de 60 años, cursando un infarto agudo al miocardio, de 24 horas de evolución, presenta marcado deterioro de su estado cardiorespiratorio. Al examen físico se ausculta un soplo holosistólico, que antes no tenía. El examen diagnóstico más adecuado es:

- a) Electrocardiograma
- b) Test de esfuerzo
- c) Ecocardiograma
- d) AngioTAC de tórax
- e) Radiografía de tórax

9) El principal factor pronóstico del cáncer gástrico es:

- a) El tamaño del tumor
- b) La localización del tumor
- c) El grado de diferenciación histológica
- d) La presencia de adenopatías
- e) El grado de invasión transmural

10) Un paciente de 69 años sufre una caída por la escalera, resultando con un golpe en la cabeza y un pequeño hematoma de cuero cabelludo. Evoluciona con cefalea intensa. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar una radiografía de cráneo
- b) Solicitar un TAC de cerebro sin contraste
- c) Solicitar una resonancia magnética nuclear
- d) Observar evolución sin indicar analgésicos, para evitar enmascaramiento de los síntomas
- e) Indicar analgésicos orales y reevaluar

11) Un paciente de 18 años presenta cefalea muy intensa, de inicio súbito, asociada a vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia rigidez de nuca esbozada. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar punción lumbar
- b) Solicitar hemograma, PCR e iniciar antibióticos endovenosos
- c) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- d) Administrar analgésicos endovenosos y reevaluar
- e) Indicar analgésicos orales y enviar a domicilio, indicando consulta en caso de aparición de signos de alarma

12) La asociación de dolor abdominal postprandial, esteatorrea y diabetes es característica de:

- a) Cáncer de páncreas
- b) Enfermedad celíaca
- c) Cáncer de vesícula biliar
- d) Cáncer de estómago
- e) Pancreatitis crónica

13) Un hombre de 60 años consulta por dolor abdominal tipo cólico, intenso, asociado a vómitos, distensión abdominal e imposibilidad de eliminar gases. Al examen físico presenta además dolor a la palpación abdominal, bazuqueo y aumento de los ruidos intestinales. Se solicita una radiografía de abdomen que muestra dilatación de asas de intestino delgado y de colon, con niveles hidroaéreos y una imagen en “grano de café” en el cuadrante inferior izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Obstrucción intestinal por bridas
- b) Cáncer de colon
- c) Vólvulo de sigmoide
- d) Obstrucción intestinal por bezoares
- e) Pseudoobstrucción intestinal

14) Un paciente de 67 años, en tratamiento con ibuprofeno por una artrosis de rodilla, presenta un cuadro de dolor abdominal epigástrico, urente, que aumenta con el ayuno. En las últimas horas el dolor se hace mucho más intenso, irradiado al dorso. Al examen físico se aprecian marcados signos de irritación abdominal difusos. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Embolia mesentérica
- d) Úlcera gastroduodenal perforada
- e) Cáncer gástrico complicado

15) El diagnóstico de la apendicitis aguda se basa en:

- a) La clínica
- b) La clínica + ecografía abdominal
- c) La clínica + TAC de abdomen
- d) La clínica + radiografía abdominal
- e) La clínica + exámenes de sangre

16) Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal intenso, de un día de evolución, constante, asociado a vómitos y sensación febril. Al examen físico se constata dolor a la palpación epigástrica y fiebre, sin signos de irritación peritoneal. Se solicita hemograma que muestra leucocitosis, pruebas hepáticas y lipasa que resultan normales y una ecografía abdominal que muestra dilatación de la vesícula biliar, con presencia de un cálculo impactado en el bacinete, edema de la pared y presencia de barro biliar. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Administrar analgésicos y cristaloides por vía endovenosa e indicar régimen cero
- d) Resolver quirúrgicamente de inmediato
- e) Administrar analgésicos y antibióticos y realizar cirugía diferida

17) Un paciente ingresa para una endarterectomía carotídea electiva, ¿Qué medicamento administraría como profilaxis antibiótica y durante cuánto tiempo?

- a) Ninguno
- b) Cloxacilina durante 3 días
- c) Ceftriaxona sólo en día de la cirugía
- d) Ceftriaxona + metronidazol durante 3 días
- e) Cloxacilina + gentamicina sólo el día de la cirugía

18) La primera causa de fiebre postquirúrgica es:

- a) Neumonía
- b) Atelectasias
- c) Flebitis y trombosis venosas
- d) Infección de la herida operatoria
- e) Iatrogénica

19) La complicación más frecuente de cesárea es

- a) Dehiscencia de la herida
- b) Trombosis venosa profunda
- c) Infección de herida operatoria
- d) Hernia incisional
- e) Embolia de líquido amniótico

20) Un paciente de 68 años, muy fumado consulta por disfagia lórica y baja de peso. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis
- b) Solicitar videodeglución
- c) Solicitar endoscopia digestiva
- d) Solicitar radiografías baritadas
- e) Solicitar TAC de tórax y abdomen

Prueba 10

1) Un paciente de 70 años consulta por dolor abdominal muy intenso, de inicio rápido, que inició hace 1 hora y se asoció a vómitos alimentarios. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca a 130x', irregular, PA: 160/100 mmHg, abdomen blando depresible, sin signos de irritación peritoneal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Úlcera perforada
- c) Obstrucción intestinal
- d) Gastroenteritis aguda
- e) Accidente vascular mesentérico

2) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por constipación de un mes de evolución, que en las últimas horas se ha hecho mucho más marcada, siendo imposible eliminar gases ni deposiciones y presentando dolor abdominal tipo cólico y vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia distensión abdominal, con dolor a la palpación y aumento de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Íleo biliar
- b) Vólvulo de sigmoides
- c) Cáncer de colon
- d) Obstrucción intestinal por bridas
- e) Enfermedad diverticular complicada

3) Una paciente de 66 años, asintomática, presenta un soplo carotídeo izquierdo. Se solicita ecografía doppler, que visualiza estenosis carotídea izquierda del 80% y derecha del 30%. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver mediante endarterectomía carotídea izquierda
- b) Resolver mediante endarterectomía carotídea bilateral
- c) Resolver mediante endarterectomía carotídea derecha
- d) Iniciar anticoagulación oral
- e) Iniciar aspirina y atorvastatina y controlar periódicamente, sin necesidad de cirugía

4) Un paciente, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, ambas bien controladas, usuario de aspirina y atorvastatina, se realiza un TAC abdominal, como parte del estudio de un cuadro de dolor abdominal inespecífico, que no visualiza alteraciones, excepto por un aneurisma de la aorta abdominal de 3,6 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar seguimiento ecográfico
- b) Realizar seguimiento con TAC
- c) Realizar resección del aneurisma y remplazo por prótesis aórtica
- d) Iniciar anticoagulación oral
- e) Solicitar angiografía aórtica

5) Un paciente sufre una caída de altura, cayendo sobre el tórax derecho y evolucionando con dificultad respiratoria. Al examen físico se aprecia equimosis torácica, abolición del murmullo pulmonar derecho, con matidez a la percusión. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión pulmonar
- b) Neumotórax
- c) Atelectasia masiva
- d) Laceración bronquial
- e) Hemotórax

6) Un paciente de 25 años, operado de apendicitis hace 24 horas, consulta por fiebre. Al examen físico se aprecia eritema de la herida quirúrgica, con un halo de 1 cm, con exudado seropurulento escaso. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar retiro de puntos y aseo peritoneal e iniciar antibióticos endovenosos
- b) Iniciar cloxacilina endovenosa
- c) Iniciar ceftriaxona + metronidazol por vía endovenosa
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Realizar curaciones periódicas y observar evolución

7) El problema más frecuente del propofol, en la práctica anestésica, es:

- a) Depresión respiratoria
- b) Hipotensión
- c) Convulsiones
- d) Alergias
- e) Hipertermia maligna

8) Identifique la asociación INCORRECTA entre la condición y el manejo de la vía aérea:

- a) Estómago lleno – máscara laríngea
- b) Vía aérea difícil – intubación vigil
- c) Estómago lleno – intubación en secuencia rápida
- d) Trauma cervical – No hiperextender la columna
- e) Vía aérea difícil – Intubación con guía (boogie)

9) Un paciente de 40 años presenta una endocarditis bacteriana aguda por Staphylococcus aureus, sobre la válvula mitral, con rotura valvular e insuficiencia cardíaca aguda severa. La conducta más adecuada es:

- a) Mantener tratamiento con cloxacilina + gentamicina endovenosa e iniciar vasodilatadores
- b) Mantener tratamiento con cloxacilina + gentamicina endovenosa e iniciar vasopresores
- c) Mantener tratamiento con cloxacilina + gentamicina endovenosa y realizar remplazo valvular con prótesis mecánica
- d) Mantener tratamiento con cloxacilina + gentamicina endovenosa y realizar remplazo valvular con prótesis biológica
- e) Mantener tratamiento con cloxacilina + gentamicina endovenosa e instalar balón de contrapulsación aórtica

10) ¿Qué examen es más adecuado para el diagnóstico de una pancreatitis crónica?

- a) Lipasa plasmática
- b) Amilasa plasmática
- c) Colecistoquinina fecal
- d) Ecografía abdominal
- e) TAC abdominal

11) Una paciente de 65 años presenta un cuadro de dolor abdominal, fiebre alta e ictericia de piel y mucosas de algunas horas de evolución. Al examen físico está taquicárdica, con PA: 100/60 mmHg, . La ecografía muestra dilatación biliar intra y extrahepática. Se instala una vía venosa, se toman exámenes generales y se inicia administración de suero fisiológico. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos de amplio espectro y realizar colecistectomía laparoscópica
- b) Iniciar antibióticos orales de amplio espectro e indicar régimen hídrico amplio
- c) Iniciar antibióticos de amplio espectro y realizar drenaje de la vía biliar por vía endoscópica
- d) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso
- e) Indicar régimen cero e iniciar AINES

12) Una paciente de 28 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea muy intensa, que inició de manera súbita, hace 30 minutos, presentando además vómitos. Al examen físico no presenta signos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos
- b) Administrar AINES y antieméticos endovenosos y reevaluar en 4 horas
- c) Indicar AINES orales y controlar en 24 horas
- d) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- e) Solicitar RMN de cerebro

13) Un paciente de 60 años, fumador e hipertenso, consulta por dolor en la pantorrilla izquierda, que aparece al caminar una cuadra y que cede con el reposo. Al examen físico tiene debilidad de los pulsos femorales y poplíteos y ausencia de pulso pedio y tibial posterior izquierdo. La conducta más adecuada, además de mejorar sus factores de riesgo cardiovascular, es:

- a) Indicar un programa de ejercicios
- b) Iniciar anticoagulación oral
- c) Realizar un bypass femoro-tibial
- d) Solicitar angiografía femoral
- e) Solicitar pletismografía de volumen

14) Una paciente de 36 años consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo en la línea media, en la zona supraesternal, que asciende con la deglución. Se solicita TSH que resulta normal. La ecografía visualiza un nódulo tiroideo sólido-quístico, de 2 cm de diámetro, con microcalcificaciones. Se realiza biopsia con aguja fina, que muestra carcinoma folicular de tiroides. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- b) Realizar tiroidectomía total
- c) Iniciar levotiroxina en dosis altas
- d) Observar evolución
- e) Iniciar radioterapia con yodo radiactivo oral

15) Un adulto mayor de 80 años presenta una caída por la escalera, golpeándose la cabeza. Al examen físico se aprecia un hematoma pequeño en el cuero cabelludo de la zona parietal izquierda, sin otras alteraciones y con normalidad del examen neurológico. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio con AINES
- b) Enviar a domicilio con paracetamol
- c) Solicitar TAC de cerebro y cráneo, sin contraste
- d) Solicitar RMN de cerebro
- e) Solicitar radiografía de cráneo

16) Un paciente de 40 años consulta por dolor anal intenso, mayor al sentarse y al defecar, que inició de manera súbita hace 6 horas. Al examen físico se observa aumento de volumen de color violáceo, en la zona perianal izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Fluxión hemorroidal
- b) Absceso perianal
- c) Hemorroide externo trombosado
- d) Fisura anal
- e) Fístula perianal

17) Un paciente de 54 años consulta por vómitos explosivos, frecuentes, que suceden algunos minutos después de cada comida. Refiere además haber bajado 7 Kg de peso en los últimos 2 meses. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar manometría esofágica
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste

18) Se solicita una ecografía abdominal a un paciente, como parte del estudio de una insuficiencia renal crónica, que visualiza como hallazgo, la presencia de 2 lesiones hepáticas redondas, anecogénicas, de 3 y 4 cm de diámetro respectivamente, con presencia de una pared hiperecogénica de 2 mm de grosor y refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Quistes simples
- b) Quistes hidatídicos
- c) Metástasis
- d) Hemangiomas
- e) Hiperplasia nodular

19) El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es:

- a) Adenopatías axilares comprometidas
- b) Aspecto mamográfico
- c) Diferenciación histológica
- d) Presencia de receptores de estrógeno y progesterona
- e) Tamaño del tumor

20) El tratamiento del divertículo de Zenker es:

- a) Observación
- b) Reparación endoscópica
- c) Resección quirúrgica y esfinterotomía
- d) Marsupialización quirúrgica
- e) Proquinéticos orales

Prueba 11
VER PREGUNTAS TRAUMATOLOGÍA, Prueba 2

Prueba 12
VER PREGUNTAS TRAUMATOLOGÍA, Prueba 3

CIRUGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	15 A	8 C	1 C	16 E	9 E
1 A	16 B	9 B	2 D	17 A	10 B
2 B	17 B	10 E	3 B	18 A	11 C
3 C	18 D	11 B	4 C	19 B	12 E
4 C	19 B	12 C	5 C	20 D	13 C
5 E	20 D	13 C	6 E		14 D
6 D		14 E	7 D	Prueba 8	15 A
7 B	Prueba 3	15 D	8 E	1 A	16 D
8 B	1 C	16 E	9 C	2 D	17 A
9 C	2 D	17 B	10 A	3 D	18 B
10 D	3 A	18 B	11 C	4 B	19 C
11 A	4 A	19 C	12 A	5 A	20 C
12 E	5 C	20 A	13 C	6 E	
13 B	6 C		14 A	7 A	Prueba 10
14 B	7 C	Prueba 5	15 A	8 A	1 E
15 D	8 C	1 A	16 B	9 C	2 C
16 C	9 B	2 C	17 A	10 A	3 A
17 B	10 C	3 C	18 C	11 E	4 A
18 C	11 E	4 D	19 C	12 C	5 E
19 A	12 E	5 A	20 E	13 A	6 C
20 C	13 B	6 E		14 B	7 B
	14 C	7 D	Prueba 7	15 C	8 A
Prueba 2	15 A	8 E	1 C	16 D	9 C
1 C	16 C	9 E	2 D	17 B	10 E
2 A	17 C	10 A	3 C	18 C	11 C
3 A	18 A	11 E	4 D	19 E	12 D
4 C	19 D	12 D	5 D	20 E	13 A
5 D	20 C	13 B	6 B		14 B
6 A		14 C	7 E	Prueba 9	15 C
7 D	Prueba 4	15 E	8 D	1 D	16 C
8 E	1 C	16 E	9 D	2 B	17 B
9 D	2 B	17 C	10 A	3 B	18 B
10 A	3 C	18 B	11 E	4 C	19 A
11 C	4 C	19 E	12 E	5 A	20 C
12 C	5 A	20 D	13 D	6 E	
13 A	6 E		14 A	7 A	
14 C	7 C	Prueba 6	15 B	8 C	

II) TRAUMATOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Una mujer de 47 años consulta por dolor en el hombro derecho, de origen insidioso a lo largo de semanas. Es más intenso durante la noche y aparece con algunos movimientos de la extremidad superior, especialmente cuando limpia y cuando maneja. Al examen físico, el hombro presenta movilidad pasiva completa e indolora, pero aqueja dolor a la abducción contra resistencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de atrapamiento subacromial (manguito rotador)
- b) Luxación crónica de hombro
- c) Capsulitis adhesiva
- d) Artrosis
- e) Fibromialgia

2) La primera medida a realizar en un paciente politraumatizado es:

- a) Asegurar la vía aérea
- b) Poner una tabla espinal
- c) Detener hemorragias activas
- d) Administrar cristaloides endovenosos
- e) Apoyar la ventilación y administrar oxígeno

3) La fractura de Colles presenta:

- a) Radialización, impactación y desplazamiento a dorsal del extremo distal del radio
- b) Cubitalización, impactación y desplazamiento a palmar del extremo distal del radio
- c) Cubitalización, rotación interna y desplazamiento a dorsal del extremo distal del radio
- d) Radialización, impactación y desplazamiento a palmar del extremo distal del radio
- e) Radialización, rotación interna y desplazamiento a palmar del extremo distal del radio

4) Una paciente sufre accidente de tránsito, resultando con una fractura de pelvis desplazada e inestable. No tiene lesiones torácicas ni faciales y respira adecuadamente. Inicialmente se encuentra en buenas condiciones, pero adolorido. Veinte minutos después, evoluciona con taquicardia, palidez, frialdad e hipotensión. La conducta más adecuada es:

- a) Reponer volumen y realizar angiografía urgente con embolización de los vasos sangrantes
- b) Administrar cristaloides endovenosos y estabilizar la fractura con un tutor externo
- c) Reponer volumen con suero fisiológico y realizar laparotomía exploradora, de modo de ligar los vasos sangrantes
- d) Administrar cristaloides, coloides y glóbulos rojos hasta lograr estabilizar la volemia
- e) Realizar osteosíntesis de cadera y transfundir glóbulos rojos

5) El dolor en la tabaquera anatómica es un signo típico de:

- a) Tendinitis de Quervein
- b) Dedo en gatillo o resorte
- c) Atrapamiento del nervio cubital
- d) Fractura del escafoides
- e) Artrosis carpometacarpiana del primer dedo (rizartrosis)

6) Los síntomas característicos del síndrome de túnel carpiano consisten en:

- a) Parestesias y debilidad a la flexión de los 1°, 2° y 3° dedos
- b) Parestesias y debilidad a la flexión de los 4° y 5° dedos
- c) Parestesias y debilidad a la extensión de los 1°, 2° y 3° dedos
- d) Parestesias y debilidad a la extensión de los 4° y 5° dedos
- e) Parestesias y debilidad a la flexión de todos los dedos

7) Un niño de 6 años, con una talla más corta que la que debería corresponder a su edad, aqueja dolores moderados de su cadera derecha y claudicación al correr. A la exploración se aprecia una discreta atrofia del muslo y existe una limitación de los movimientos de rotación interna y abducción. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Sinovitis transitoria de la cadera
- b) Artritis séptica
- c) Displasia de cadera
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Epifisiolisis de la cabeza femoral

8) Un paciente de 30 años sufre caída a nivel, golpeándose la cara lateral del hombro derecho y evolucionando con dolor. Al examen, presenta dolor a la palpación de la zona de contusión, con movibilidades pasiva y activa completas, moderadamente dolorosas. La palpación clavicular y acromial no produce dolor. Se solicitan radiografías de hombro y de articulaciones acromioclaviculares que resultan normales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía de partes blandas y decidir conducta según hallazgos
- b) Indicar uso de cabestrillo y analgésicos orales, mientras persista el dolor
- c) Indicar yeso braquial y analgesia oral
- d) Indicar analgésicos orales y reposo, sin necesidad de inmovilizaciones
- e) Derivar para resolución quirúrgica

9) ¿Cuál de las siguientes NO corresponde a una fractura osteoporótica?

- a) Aplastamientos vertebrales toracolumbares
- b) Fractura del extremo proximal del fémur
- c) Fractura del extremo distal del radio
- d) Fracturas costales
- e) Fractura subcapital de húmero

10) El factor que más incide en la severidad de una fractura expuesta es:

- a) El sitio de fractura
- b) El daño a las partes blandas
- c) El grado de desplazamiento
- d) El grado de conminución
- e) El mecanismo de fractura

11) Paciente con dolor lumbar irradiado desde la cara lateral del muslo y la pierna hasta el dorso del pie. Al examen físico presenta reflejos osteotendinosos normales, signo de Lasegue positivo y claudicación al caminar sobre los talones. ¿Cuál es la raíz nerviosa comprometida?

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

12) Un niño de 5 años, asintomático, es traído por su madre, ya que tiene pie plano. A la exploración no se observa el arco plantar, sin embargo éste aparece al hiperextender el primerortejo. Camina sin problemas. La conducta más correcta es:

- a) Tranquilizar a la madre y explicarle que la condición de su hijo no le traerá consecuencia alguna
- b) Explicarle a la madre que su cuadro es causado por un calzado inadecuado y que debe cambiarlo
- c) Solicitar radiografías de ambos pies y decidir conducta según hallazgos
- d) Indicar uso de plantillas y controlar cada 3 meses
- e) Derivar para corrección quirúrgica

13) Un paciente de 48 años sufre atropello, resultando con fractura de la tibia y fémur derechos. Ingresa a pabellón en buenas condiciones, con hemodinamia estable. Se realiza reducción y osteosíntesis con clavo endomedular, con buen resultado. En el postoperatorio evoluciona con compromiso de conciencia y dificultad respiratoria. Al examen físico se aprecia en Glasgow 10, con frecuencia cardíaca de 130x', presión arterial de 100/50 mmHg, frecuencia respiratoria de 33 rpm. El examen pulmonar demuestra crépitos difusos y la saturación arterial por pulsometría es 83%. Se observan petequias en el tórax. El diagnóstico más probable es:

- a) Tromboembolismo pulmonar
- b) Rabdomiolisis aguda
- c) Endocarditis bacteriana aguda
- d) Embolia grasa
- e) Shock anafiláctico

14) La conducta más adecuada ante una paciente de 80 años, quien sufre una fractura de la cadera derecha, de tipo intertrocanterica y desplazada, es:

- a) Inmovilizar con yeso pelvipedio y administrar analgesia endovenosa
- b) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar inmovilización con yeso pelvipedio
- c) Iniciar analgesia y antibióticos endovenosos y luego realizar cirugía de resección de la cabeza femoral (Cirugía de Girdestone))
- d) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar osteosíntesis con tornillo dinámico de cadera (DHS)
- e) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina e instalar prótesis parcial de cadera

15) Las radiografías mínimas que deben solicitarse a un paciente politraumatizado son:

- a) Cráneo AP, tórax AP y pelvis AP
- b) Columna cervical lateral, tórax AP y pelvis AP
- c) Cráneo AP, tórax AP y abdomen AP
- d) Tórax lateral, abdomen AP en posición de pie y caderas AP
- e) Cráneo AP y lateral, tórax AP y lateral y pelvis AP

16) Un paciente de 57 años sufre accidente laboral, sufriendo hiperextensión de la rodilla derecha, evolucionando con dolor y aumento de volumen de dicha rodilla. Al examen se aprecia derrame articular, movilidad completa, pero dolorosa. Los bostezos y el cajón posterior son negativos. El signo de cajón anterior es positivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura del menisco medial
- b) Rotura del menisco lateral
- c) Rotura del ligamento cruzado anterior
- d) Rotura del ligamento cruzado posterior
- e) Rotura del ligamento colateral medial

17) Un paciente de 34 años sufre fractura cerrada de pierna, por lo que se inmoviliza provisoriamente con una bota corta de yeso, en espera de cirugía. Evoluciona con intenso dolor. Al examen físico destaca dolor intenso a la movilización pasiva de los ortijos. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar nueva radiografía de pierna
- b) Solicitar radiografías de tobillo y pie
- c) Administrar analgesia endovenosa y observar evolución
- d) Retirar la bota de yeso y elevar la pierna
- e) Resolver la fractura quirúrgicamente, de inmediato

18) El mejor examen para la pesquisa precoz de la displasia de cadera en un niño de un mes de edad es:

- a) Radiografía
- b) Ecografía
- c) Tomografía axial computada
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) El examen físico

19) Una paciente de 67 años tropieza en un escalera, sufriendo inversión forzada del tobillo izquierdo. Evoluciona con aumento de volumen, dolor que le impide la marcha y equimosis importante de la zona inframaleolar externa y el dorso del pie izquierdo. Al examen presenta dolor a la palpación de la zona indicada y a la movilización del tobillo. Los pulsos, la movilidad y la sensibilidad distales son normales. El examen más adecuado para evaluar la gravedad de la lesión es:

- a) Radiografías de tobillo
- b) Ecografía de partes blandas
- c) Tomografía axial computada
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Cintigrafía

20) Una paciente de 27 años sufre caída sobre hombro derecho, resultando en luxación anterior de dicha articulación, la que se reduce bajo analgesia profunda. Evoluciona con imposibilidad para abducir el hombro y en el examen físico destaca hipoestesia de la zona deltoidea. ¿Qué estructura resultó dañada con mayor probabilidad?

- a) Nervio mediano
- b) Nervio radial
- c) Nervio cubital
- d) Nervio axilar
- e) Nervio musculocutáneo

Pregunta recuperativa Cirugía:

21) Los antibióticos usados como profilaxis de infecciones de las heridas operatorias, deben administrarse:

- a) Durante los tres días previos a la cirugía
- b) Durante los tres días siguientes a la cirugía
- c) Durante la cirugía
- d) Durante la cirugía y los tres días siguientes
- e) Durante los tres días previos a la cirugía y durante la cirugía misma

Prueba 2 (TRAUMATOLOGÍA Y ANESTESIA)

1) Un paciente es ingresado para una colecistectomía de urgencia, debido a una colecistitis aguda. Se decide manejarlo con anestesia general. La conducta más adecuada, para el manejo de la vía aérea, es:

- a) Administrar un inductor, realizar maniobra de Sellick, ventilar con ambú, provocar relajación pulmonar con succinilcolina y realizar intubación orotraqueal
- b) Preoxigenar, administrar un inductor, realizar maniobra de Sellick, provocar relajación pulmonar con succinilcolina y realizar intubación orotraqueal
- c) Administrar un inductor, ventilar con ambú, provocar relajación pulmonar con rocuronio, realizar maniobra de Sellick y realizar intubación orotraqueal
- d) Preoxigenar, provocar relajación pulmonar con rocuronio, administrar un inductor y realizar intubación orotraqueal
- e) Preoxigenar, provocar relajación pulmonar con succinilcolina, ventilar con ambú, administrar un inductor y realizar intubación orotraqueal

2) El principal riesgo asociado a las fracturas expuestas, en relación a las cerradas, es:

- a) No unión
- b) Trombosis venosa
- c) Infección
- d) Retraso en la consolidación
- e) Lesión neurovascular

3) ¿Cuál de los siguientes, es un signo de alarma para un paciente con lumbago?

- a) Inicio súbito
- b) Dolor intenso
- c) Irradiación a extremidad inferior
- d) Contractura muscular
- e) Antecedente de trauma

4) Un paciente de 79 años sufre caída a nivel, quedando con imposibilidad para caminar y mucho dolor. Al examen presenta acortamiento, leve abducción y rotación externa del muslo derecho, con pulsos y sensibilidad distales conservados. Se solicita radiografía de caderas que demuestra fractura de cuello femoral derecho, desplazada (Garden IV). La conducta más adecuada es:

- a) Inmovilizar con yeso pelvipedio y administrar analgesia endovenosa
- b) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar inmovilización con yeso pelvipedio
- c) Iniciar analgesia y antibióticos endovenosos y luego realizar cirugía de resección de la cabeza femoral (Cirugía de Girdlestone)
- d) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina y realizar osteosíntesis con tornillo dinámico de cadera (DHS)
- e) Estabilizar, administrar analgésicos, solicitar exámenes de sangre y orina e instalar prótesis parcial de cadera

5) Un paciente de 34 años presenta dolor cervical, luego de levantar muebles, que se irradia por la cara lateral del brazo y antebrazo, hasta el pulgar. Al examen destaca disminución del reflejo bicipital. La raíz nerviosa comprometida es:

- a) C5
- b) C6
- c) C7
- d) C8
- e) T1

6) ¿Cuál de las siguientes es una buena alternativa para el manejo anestésico de la vía aérea en un paciente con estómago lleno?

- a) Máscara laríngea
- b) Intubación vigil
- c) Intubación retrógrada
- d) Cánula Mayo
- e) Intubación a seis manos

7) ¿Cuál de las siguientes condiciones presenta un mayor riesgo de complicaciones respiratorias durante una cirugía o en el postoperatorio?

- a) Tabaquismo
- b) Espirometría alterada
- c) Cirugía torácica
- d) Cirugía abdominal
- e) Antecedente de VIH

8) El agente causal y la vía de llegada más frecuentes, de las osteomielitis agudas, son respectivamente:

- a) Staphylococcus aureus y hematógena
- b) Staphylococcus aureus y por contigüidad
- c) Staphylococcus aureus e inoculación directa
- d) Streptococcus pyogenes y por contigüidad
- e) Streptococcus pyogenes y hematógena

9) Un paciente sufre una caída en bicicleta, golpeándose el hombro derecho. Al examen se aprecia hombro derecho en charretera, con imposibilidad de abducirlo, asociado a anestesia de la zona deltoidea. El diagnóstico más probable es:

- a) Disyunción acromioclavicular con compromiso del nervio radial
- b) Disyunción acromioclavicular con compromiso del nervio axilar o circunflejo
- c) Luxación anterior de hombro con compromiso del nervio radial
- d) Luxación anterior de hombro con compromiso del nervio axilar o circunflejo
- e) Luxación anterior de hombro con compromiso del nervio musculocutáneo

10) Un paciente de 25 años cae de un tercer piso, golpeándose contra el suelo. Al examen se observa muy adolorido, consciente, orientado y respira espontáneamente, sin apremio respiratorio. Al examen presenta frecuencia cardíaca de 124 lpm, presión arterial: 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria: 20 rpm. Presenta una fractura en la pierna derecha, con una herida de 4 cm, con exposición ósea y sangrado profuso. También se observan varias heridas abrasivas en la extremidad superior izquierda y en la cara, sin sangrado activo. Se instala collar cervical. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Aplicar torniquete en el muslo derecho y reponer volumen con suero glucosalino endovenoso
- b) Realizar compresión sobre la herida de la pierna y administrar suero fisiológico por vía venosa periférica
- c) Realizar examen físico y neurológico completo
- d) Realizar intubación orotraqueal y administrar oxígeno
- e) Instalar un catéter venoso central

11) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA?

- a) Fractura de escafoides – Dolor en la tabaquera anatómica
- b) Fractura de cúpula radial – Imposibilidad de pronosupinar la muñeca
- c) Fractura de Colles – Radialización, impactación y desviación dorsal
- d) Fractura de húmero proximal – Equimosis en la cara medial del brazo
- e) Fractura de la tuberosidad del olecranon – Imposibilidad de flexar el codo

12) La no unión hipertrófica se debe a:

- a) Isquemia
- b) Inadecuada analgesia
- c) Inmovilización insuficiente
- d) Interposición de partes blandas
- e) Mal alineamiento

13) Una mujer de 32 años, ingresa para histerectomía. Recibe anestesia epidural, sin embargo se punciona la duramadre, administrando el anestésico directamente en el espacio raquídeo, evolucionando con compromiso de conciencia. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar soporte circulatorio y respiratorio, administrando anticonvulsivantes SOS
- b) Administrar amiodarona y realizar soporte circulatorio y respiratorio
- c) Conectar a ventilación mecánica, dar soporte circulatorio y administrar bicarbonato endovenoso
- d) Administrar adrenalina endovenosa y realizar monitoreo cardio-respiratorio continuo
- e) Realizar intubación orotraqueal, para proteger la vía aérea e instalar marcapasos externo transitorio

14) Los ejercicios que se indican como parte del tratamiento de la disfunción patelo-femoral, están dirigidos principalmente a:

- a) Fortalecer el músculo vasto medial
- b) Fortalecer el músculo vasto lateral
- c) Fortalecer el músculo recto femoral
- d) Fortalecer los músculos aductores
- e) Fortalecer el músculo bíceps femoral

15) Las fracturas de tobillo, se producen mayormente por:

- a) Caídas de altura
- b) Golpe directo
- c) Inversión o rotaciones forzadas
- d) Fracturas sobre hueso patológico
- e) Accidentes de tránsito

16) Identifique la asociación correcta

- a) Rotura del ligamento cruzado posterior – Signo de bostezo
- b) Esguince de ligamento colateral lateral – Alto riesgo de lesión meniscal
- c) Rotura de ligamento cruzado anterior – Signo de cajón posterior
- d) Lesión de menisco medial – Dolor a la compresión axial, con rotación externa de la pierna
- e) Esguince de ligamento colateral lateral – Hemartrosis

17) Un recién nacido, de 14 días de vida, presenta signo de Ortolani bilateral. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de pelvis antero-posterior, inmediatamente
- b) Solicitar ecografía de caderas, inmediatamente
- c) Solicitar radiografía de pelvis antero-posterior, al cumplir tres meses de vida
- d) Solicitar radiografía de pelvis antero-posterior, al cumplir seis meses de vida
- e) Solicitar ecografía de caderas, al cumplir tres meses de vida

18) Un hombre de 30 años consulta por dolor en la rodilla izquierda, de 5 días de evolución, que aparece al caminar y que se inició durante una expedición, en la que caminó largas distancias. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la cara interna de la zona tibial proximal de la pierna izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Tendinitis rotuliana
- b) Tendinitis ansarina
- c) Disfunción patelofemoral
- d) Bursitis
- e) Síndrome de Osgood Schlater (entesitis rotuliana)

19) ¿Cuál de las opciones siguientes es una contraindicación absoluta de la anestesia raquídea?

- a) Coagulopatía
- b) Infección del sitio de punción
- c) Embarazo inicial
- d) Antecedente de síndrome neuroléptico maligno
- e) Cirugía de urgencia

20) Un paciente de 45 años sufre una fractura de fémur, por arma de fuego, la que es manejada quirúrgicamente con un tutor externo y con antibioterapia. Presenta importante dolor, el que es manejado con AINES, con escasa respuesta. Algunos días después, presenta intenso dolor de toda la extremidad y al examen físico se constata dolor a la movilización de los dedos, con disminución de los vellos y adelgazamiento de la piel del pie. Presenta pulsos, movilidad y sensibilidad distal conservados. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome compartimental
- b) Trombosis venosa profunda
- c) Lesión de la arteria femoral
- d) Distrofia simpática refleja
- e) Retracción isquémica de Volkman

Prueba 3 (TRAUMATOLOGÍA + ANESTESIA)

1) Representa un mayor riesgo de náuseas postoperatorias, todos los siguientes, EXCEPTO:

- a) Sexo masculino
- b) No fumador
- c) Uso de opiáceos en la cirugía
- d) Historia de náuseas en cirugías previas
- e) Historia de náuseas ante olores desagradables o en carreteras con muchas curvas

2) Un paciente de 45 años sufre caída de altura, cayendo sobre la extremidad superior derecha y resultando con fractura del tercio medio de la diáfisis humeral. ¿Qué estructura se afectará con mayor probabilidad?

- a) Nervio axilar
- b) Nervio mediano
- c) Nervio radial
- d) Nervio cubital
- e) Nervio musculocutáneo

3) ¿Por qué mecanismo se produce la mayor parte de las fracturas de cadera?

- a) Caídas a nivel
- b) Caídas de altura
- c) Rotación forzada
- d) Fractura espontánea durante la marcha normal
- e) Accidentes de tránsito

4) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta?

- a) Distrofia simpático refleja – Disminución de los pulsos distales
- b) Embolia grasa – Rash petequial
- c) Embolia grasa – Edema pulmonar no cardiogénico
- d) Distrofia simpático refleja – Cambios en la piel y vellos distales
- e) Síndrome compartimental – Dolor a la movilización distal

5) ¿Cuál de las siguientes historias clínicas es MÁS sugerente de una cefalea postpunción?

- a) Cefalea intensa, de inicio súbito, luego de una endarterectomía carotídea, que fue realizada bajo anestesia general, con drogas endovenosas
- b) Cefalea intensa, mayor con el decúbito, asociada a vómitos, que inicia luego de una histerectomía radical, realizada bajo anestesia epidural
- c) Cefalea intensa, que aumenta al sentarse o al pararse, que inicia a 24 horas después de una osteosíntesis de tibia, realizada bajo anestesia raquídea
- d) Cefalea intensa, que aumenta con el decúbito y que está asociada a dificultades para ver y desorientación, que aparece luego de una cistoscopia, realizada bajo anestesia espinal
- e) Cefalea intensa, que aumenta al sentarse o al pararse y que inicia algunas horas después de un parto vaginal, realizado bajo anestesia peridural

6) ¿Cuál de las siguientes es un signo de mayor gravedad ante un traumatismo craneal?

- a) Herida de cuero cabelludo
- b) Salida de líquido transparente por un oído
- c) Hematoma de cuero cabelludo en la frente
- d) Convulsión de 30 segundos inmediatamente después del golpe
- e) Desorientación de 4 minutos de duración, después del golpe, seguido de amnesia de esos momentos

7) Un paciente de 35 años consulta en el consultorio de Futaleufú (zona rural), donde usted es el médico de turno. Sufrió una caída a caballo hace 30 minutos, resultando con una fractura expuesta del antebrazo de 30 minutos de evolución. No presenta sangramiento importante y sus signos vitales son normales. ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS adecuada para el manejo de este paciente?

- a) Derivación inmediata a un centro de mayor complejidad
- b) Aseo con abundante suero fisiológico
- c) Antibióticos endovenosos de amplio espectro
- d) Vacunación antitetánica
- e) AINES endovenosos

8) Respecto a la displasia de cadera es FALSO que:

- a) Es más frecuente en mujeres y en niños con antecedente de presentación podálica
- b) Uno cada 1.000 niños la presentan
- c) El signo de Barlow se caracteriza por la posibilidad de luxar la cadera del recién nacido, mientras que el de Ortolani reposiciona la cadera que está luxada
- d) La radiografía es el examen de elección para el diagnóstico en el recién nacido
- e) Los niños que se diagnostican después de los 18 meses de edad suelen ser tratados de manera quirúrgica

9) ¿Qué alternativas son más adecuadas para el manejo de la vía aérea en un paciente operado de urgencia por una obstrucción intestinal?

- a) Máscara laríngea e intubación retrógrada
- b) Intubación retrógrada e intubación en secuencia rápida
- c) Intubación en secuencia rápida e intubación vigil
- d) Intubación vigil e intubación con guía
- e) Intubación con guía y máscara laríngea

10) Un paciente de 40 años presenta aumento de volumen en relación a la rodilla derecha que ha crecido lentamente a los largo del último año y que presenta dolor en algunas ocasiones. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de consistencia ósea. Se realiza una radiografía, que muestra un tumor óseo de 12 cm de diámetro, multiloculado, de aspecto irregular, que compromete la arquitectura de la epífisis distal del fémur. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteocondroma
- b) Osteoma osteoide
- c) Tumor de células gigantes
- d) Tumor de Ewing
- e) Osteosarcoma

11) ¿Qué fractura supone una mayor gravedad?

- a) Fractura expuesta de fémur, con herida de 5 cm, debida a caída de altura
- b) Fractura expuesta de fémur, con pequeña herida, debida a impacto de bala
- c) Fractura expuesta de tobillo, de 2 horas de evolución, por golpe directo
- d) Fractura expuesta de pierna, con herida de gran tamaño y mínima cobertura de partes blandas, debida a accidente de tránsito
- e) Fractura expuesta de antebrazo, con restos de tierra en la herida, por caída en bicicleta

12) Una niña de 12 años, asintomática, presenta un test de Adams que muestra cierto grado de asimetría en el troco y se visualiza una giba costal leve. Se solicitan radiografías de columna que muestran una escoliosis con desviación de 10%. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar ejercicios posturales y observar evolución
- b) Solicitar TAC de columna
- c) Indicar uso de corsé dorsolumbar
- d) Indicar vendaje en ocho
- e) Resolución quirúrgica

13) Los efectos adversos más frecuentes de los inductores endovenosos clásicos, como el propofol y el tiopental, son:

- a) Hipertermia maligna
- b) Hipotensión
- c) Náuseas y vómitos
- d) Respiratorios
- e) Alergias

14) Un paciente presenta dolor lumbar de inicio súbito, que inició al movilizar unos muebles y que se irradia por la cara anterior del muslo y la cara medial de la pierna, hasta el maléolo medial. Al examen físico destaca disminución del reflejo rotuliano. La raíz comprometida es:

- a) L1
- b) S1
- c) L2
- d) L4
- e) L5

15) Respecto a la epitrocleítis es verdadero que:

- a) Se le llama codo del tenista
- b) Se caracteriza por dolor a la palpación de la inserción proximal de los músculos flexores del antebrazo
- c) Su tratamiento suele ser quirúrgico
- d) Frecuentemente se asocia a síndrome de atrapamiento del nervio cubital
- e) Es más frecuente que la epicondilitis

16) ¿Cuál es la presentación clínica más habitual de las fracturas de cadera?

- a) Acortamiento, rotación interna y aducción del muslo, con imposibilidad de caminar
- b) Acortamiento, rotación externa y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
- c) Acortamiento, rotación interna y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
- d) Posición púdica, equimosis, crujido articular y dolor intenso durante la marcha
- e) Posición impúdica, aumento de volumen y dolor intenso durante la marcha

17) ¿Qué medicamento se usa como relajante muscular en la técnica de inducción-intubación en secuencia rápida?

- a) Etomidato
- b) Ketamina
- c) Atracurio
- d) Rocuronio
- e) Succinilcolina

18) Un paciente sufre un golpe directo sobre la pierna derecha, al ser barrido mientras jugaba fútbol. Evoluciona con dolor intenso de la rodilla derecha, que le impide caminar. Al examen físico se aprecia derrame articular y destaca signo de cajón posterior. Las radiografías no muestran lesiones óseas. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión del menisco medial
- b) Rotura del ligamento cruzado anterior
- c) Rotura del ligamento cruzado posterior
- d) Rotura del ligamento colateral medial
- e) Rotura del ligamento colateral lateral

19) ¿Cuál de las siguientes fracturas suele producirse secundaria a osteoporosis?

- a) Fractura de cúpula radial
- b) Fractura de diáfisis femoral
- c) Fracturas costales
- d) Fractura de extremo distal del radio
- e) Fractura de tobillo

20) Un paciente sufre hiperextensión forzada del dedo índice derecho, evolucionando con dolor, aumento de volumen y equimosis, que limita los movimientos del dedo, especialmente la flexión de la articulación interfalángica proximal. Se solicita radiografía anteroposterior y lateral, que no detecta lesiones óseas. El diagnóstico más probable es:

- a) Esguince de dedo
- b) Fractura avulsiva de la base de la falange media
- c) Fractura avulsiva del extremo distal de la falange proximal
- d) Luxación interfalángica proximal
- e) Dedo en gatillo

Prueba 4 (OTORRINOLARINGOLOGÍA + OFTALMOLOGÍA + TRAUMATOLOGÍA)

1) La queratitis aguda se caracteriza por todo lo siguiente excepto:

- a) Fotofobia
- b) Epífora
- c) Miosis
- d) Ojo rojo periquerático
- e) Blefarospasmo

2) Un paciente presenta diplopía e imposibilidad de mirar hacia abajo y medial con el ojo izquierdo. El resto de los movimientos oculares es normal, al igual que el reflejo fortomotor. ¿Qué estructura está comprometida?

- a) Tercer nervio craneal izquierdo
- b) Cuarto nervio craneal izquierdo
- c) Sexto nervio craneal izquierdo
- d) Fascículo longitudinal medial
- e) Ganglio estrellado (Simpático)

3) Un paciente de 67 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina, pierde súbitamente la visión del ojo izquierdo y al examen físico destaca ausencia del rojo pupilar ipsilateral. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de la vena central de la retina
- b) Neuritis óptica
- c) Oclusión de la arteria central de la retina
- d) Hemorragia vítrea
- e) Desprendimiento de retina

4) Una paciente de 45 años presenta vértigo de inicio súbito, asociado a caídas frecuentes. Al examen físico destaca nistagmos vertical, que no disminuye al pedirle que fije la mirada sobre un punto. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Parálisis vestibular
- d) Neurinoma del acústico
- e) Vértigo central

5) Un adulto consulta por sensación de oído izquierdo tapado. Se solicita audiometría que muestra una hipoacusia de conducción izquierda y una impedanciometría, que muestra una curva B (plana). La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nasofibroscopía
- b) Iniciar antibióticos
- c) Iniciar corticoides
- d) Indicar uso de audífonos
- e) Instalar tubos de ventilación (colleras)

6) Un paciente de 55 años consulta por epistaxis de 20 minutos de duración, profusa. Refiere tener epistaxis con frecuencia, sin otros síntomas hemorrágicos y sus estudios previos han sido normales. Se realiza compresión manual por 20 minutos, sin conseguir detener la epistaxis y en la espeuloscopía nasal es imposible visualizar el sitio de sangrado. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar ácido tranexánico
- b) Realizar aseo con suero fisiológico
- c) Realizar cauterización a ciegas del tabique nasal anterior
- d) Realizar taponamiento anterior e indicar antibióticos
- e) Realizar taponamiento posterior e indicar antibióticos

7) ¿Qué condición le confiere un peor pronóstico a una fractura expuesta?

- a) Herida mayor a 5 cm
- b) Presencia de restos vegetales
- c) Mala cobertura de partes blandas
- d) Conminución del foco de fractura
- e) Ocurrencia en sitio agrícola

8) Una mujer de 66 años sufre caída de altura, golpeándole la cadera y la extremidad inferior izquierda, evolucionando con imposibilidad de ponerse de pie y gran dolor. Al examen físico destaca extremidad inferior izquierda en rotación interna y aducción, con algún grado de acortamiento. Los movimientos de la cadera están limitados por intenso dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de cadera intertrocanterica
- b) Fractura de cuello femoral
- c) Luxación posterior de cadera
- d) Fractura de pelvis
- e) Necrosis avascular de la cabeza femoral

9) Un hombre de 26 años sufre caída mientras esquiaba, torciéndose la rodilla derecha y evolucionando con importante dolor, especialmente al caminar. El examen físico se aprecia pequeño derrame articular y dolor a la rotación externa de la pierna, a la compresión de la rodilla y a la palpación de la interlínea posteromedial. Las radiografías de rodilla descartan lesiones óseas. ¿Qué estructura se daña con mayor probabilidad?

- a) Menisco medial
- b) Menisco lateral
- c) Ligamento cruzado anterior
- d) Ligamento cruzado posterior
- e) Ligamento colateral medial

10) La etiología de la distrofia simpático refleja es:

- a) Isquemia de la vasa nervorum
- b) Analgesia insuficiente
- c) Inmovilización deficiente
- d) Inmovilización prolongada
- e) Compresión nerviosa

11) Es característico de la miopía que:

- a) El diámetro anteroposterior del globo ocular es mayor al normal.
- b) El diámetro anteroposterior de globo ocular es menor al normal.
- c) El defecto reside en la refractividad del humor vítreo.
- d) La imagen del punto próximo se forma detrás de la retina.
- e) El defecto reside en la córnea.

12) Acude a Urgencias un paciente con intenso picor y lagrimeo en ambos ojos, hiperemia conjuntival, fotofobia, exudado más o menos viscoso y formación papilar en la conjuntiva tarsal. ¿Cuál es el diagnóstico probable?:

- a) Chalación.
- b) Conjuntivitis vírica.
- c) Conjuntivitis bacteriana.
- d) Queratoconjuntivitis seca.
- e) Conjuntivitis alérgica.

13) Una mujer de 64 años, hipermetrope y con cataratas en ambos ojos, acude a su consulta con dolor intenso en ojo izquierdo, de unas horas de evolución. La exploración de ese ojo pone de manifiesto una tensión ocular de 40 mmHg, reacción hiperémica cilio-conjuntival, midriasis y edema corneal. ¿Cuál sería la actitud inmediata más correcta de las que se enumeran a continuación?:

- a) Manitol intravenoso asociado a tratamiento miótico y corticoides tópicos.
- b) Practicar una trabeculectomía.
- c) Corticoides tópicos asociados a tratamiento midriático.
- d) Operar con urgencia la catarata de ese ojo, desencadenante del cuadro.
- e) Dilatar bien el ojo para explorar la retina y descartar un tumor intraocular.

14) Mujer de 34 años, madre de 3 hijos, que acude a su consulta presentando una hipoacusia derecha, con Rinne negativo derecho y positivo izquierdo y Weber con lateralización al lado derecho. La otoscopia es normal en ambos oídos. Su sospecha inicial será:

- a) Otitis serosa.
- b) Timpanoesclerosis.
- c) Hipoacusia súbita.
- d) Otosclerosis.
- e) Neuronitis vestibular

15) El aumento unilateral de tamaño de la amígdala palatina en el adulto, debe hacernos sospechar siempre:

- a) Un absceso látero-faríngeo.
- b) Un tumor maligno de la amígdala.
- c) Un flemón peridentario en relación con el tercer molar superior (muela del juicio).
- d) Una atrofia amigdalal contralateral.
- e) Un tumor maligno del seno esfenoidal ipsilateral.

16) ¿Cuál de los siguientes supuestos DESCARTARIA como causa de una parálisis recurrencial unilateral?:

- a) Aneurisma aórtico.
- b) Carcinoma de esófago.
- c) Absceso periamigdalino.
- d) Cirugía de la glándula tiroides.
- e) Carcinoma bronquial.

17) Al servicio de urgencias es traído un niño de 5 años por dolor inguinal de 48 horas de evolución. Tres semanas antes ha presentado una infección de vías respiratorias altas tratada con antibióticos. La exploración abdominal es normal y no se palpan hernias. La cadera presenta limitación dolorosa en todos sus movimientos, y el paciente cojea. La analítica y la radiología son normales y la ecografía indica un pequeño derrame articular de cadera probablemente seroso. El primer diagnóstico de sospecha debe ser:

- a) Artritis séptica de cadera.
- b) Artritis reumatoide juvenil.
- c) Sinovitis transitoria de cadera.
- d) Enfermedad de Perthes.
- e) Osteomielitis hematógena proximal de fémur.

18) Un paciente de 21 años, que ha sufrido una caída vertical sobre la pierna manteniendo el tobillo en varo y rotación interna, ha sido diagnosticado de esguince externo del tobillo derecho. ¿Cuál sería la técnica exploratoria más adecuada de las que se relacionan, para evaluar la gravedad del cuadro?:

- a) Una Tomografía Axial de la pinza bimaleolar.
- b) Una Resonancia Nuclear del tobillo.
- c) Radiografías dinámicas del tobillo previa anestesia local o regional.
- d) Repetir la radiografía estandar pasados 7 días.
- e) Una cintigrafía con TC 99.

19) De los signos siguientes, ¿cuál es el más precoz en un síndrome compartimental de los miembros?:

- a) La isquemia cutánea.
- b) La hipoestesia en el trayecto del nervio afectado.
- c) El dolor intenso al estiramiento pasivo muscular.
- d) La ausencia de pulso.
- e) La debilidad muscular

20) Paciente de 40 años con fractura del cuello del astrágalo, con desplazamiento posterior del cuerpo astragalino. Señale, de las complicaciones posibles que se relacionan, cuál es la más característica:

- a) Pie cavo-valgo postraumático.
- b) Necrosis isquémica del cuerpo del astrágalo.
- c) Pie plano postraumático.
- d) Pie cavo-varo postraumático.
- e) Síndrome compartimental.

Prueba 5

1) Un paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral, por un golpe directo. ¿Qué estructura estará lesionada con mayor posibilidad?

- a) Nervio cubital
- b) Arteria braquial
- c) Nervio mediano
- d) Vena basilíca
- e) Nervio radial

2) Una paciente de 27 años cae de una bicicleta, golpeándose el hombro derecho. Evoluciona con dolor, aunque mantiene gran parte de la movilidad. Al examen físico se observa equimosis de la zona del golpe y se observa el signo de la tecla de piano. La imagen más adecuada para evaluar a esta paciente es:

- a) TAC de hombro derecho
- b) Ecografía de hombro derecho
- c) Radiografía lateral de hombro derecho
- d) Radiografía AP bilateral comparativa de hombros
- e) Radiografía axial de hombro derecho

3) Una paciente de 68 años, alcohólica, consulta por dolor en la ingle izquierda, que inició el día de ayer y que le dificulta la marcha. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y presenta importante dolor a la movilización del muslo izquierdo, especialmente ante la abducción con rotación externa. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Artrosis
- c) Síndrome de pellizcamiento acetabular
- d) Pelvispondiloartropatía
- e) Necrosis avascular de la cabeza femoral

4) ¿Qué sería MENOS probable de hallar en una fractura de cadera clásica?

- a) Imposibilidad de levantar el talón del suelo
- b) Abducción del muslo
- c) Acortamiento del muslo
- d) Rotación externa del muslo
- e) Equimosis en la cara externa del muslo

5) Un paciente sufre un accidente de tránsito con luxofractura de la rodilla izquierda. Evoluciona a los 5 minutos con dolor importante en la pierna y pie izquierdos. Al examen físico se constata palidez, llene capilar muy enlentecido y ausencia de pulso pedio y tibial posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome compartimental
- b) Lesión de la arteria poplítea
- c) Trombosis venosa profunda
- d) Distrofia simpático refleja
- e) Rotura de quiste de Baker

6) ¿Qué elemento le da una mayor gravedad a una fractura expuesta?

- a) Herida de 5 cm de diámetro
- b) Fractura conminuta
- c) Mala cobertura de partes blandas
- d) Fractura con rasgo intraarticular
- e) Tiempo de evolución de 5 horas antes de atención médica

7) ¿Qué fracturas son frecuentes y deben buscarse dirigidamente en las caídas de pie desde altura?

- a) Cadera y fémur
- b) Tibia y fémur
- c) Columna y calcáneo
- d) Calcáneo y fémur
- e) Tibia y calcáneo

8) ¿Qué fractura puede ser considerada osteoporótica?

- a) Fractura de cráneo
- b) Fractura subcapital de húmero
- c) Fractura de falange
- d) Fractura de diáfisis femoral
- e) Fractura de escápula

9) Un paciente refiere dolor lumbar irradiado a la pierna izquierda. El dolor recorre la cara anterior y medial del muslo y al examen físico se constata debilidad a la extensión de la rodilla y disminución en la intensidad del reflejo rotuliano. La raíz nerviosa afectada es:

- a) L1
- b) L3
- c) L5
- d) S1
- e) S3

10) Un paciente de 40 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor muy intenso en la zona dorsal alta, de 4 horas de evolución, que inició de manera súbita luego de levantar una caja. Al examen físico presenta signos vitales normales y se constata dolor importante a la flexión y rotación lateral a derecha de la columna dorsal, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de columna dorsal
- b) Solicitar ecografía de partes blandas
- c) Solicitar TAC de columna dorsal
- d) Solicitar RMN de columna
- e) Indicar AINES y reposo relativo

11) El tratamiento del síndrome compartimental, secundario a una fractura, suele ser:

- a) Analgesia
- b) Anticoagulación
- c) Vendaje compresivo
- d) Inmovilización adecuada
- e) Fasciotomía amplia

12) ¿Qué fractura es característica de la edad pediátrica?

- a) Fracturas en tallo verde
- b) Fractura conminuta
- c) Fractura de escafoides
- d) Fractura de muñeca
- e) Fractura de Garden

13) Un joven de 17 años cae del tercer piso de su colegio, mientras se encontraba en estado de ebriedad. Usted llega en una ambulancia y constata que respira y realiza algunos movimientos, sin responder cuando se le habla. Además, se aprecia una fractura expuesta de la pierna izquierda, que sangra activamente y una herida en el cuero cabelludo. La primera medida a realizar es:

- a) Instalar una vía venosa
- b) Realizar compresión de las heridas para detener la hemorragia
- c) Inmovilizar la columna cervical
- d) Realizar intubación orotraqueal
- e) Retirar la ropa para poder evaluar la totalidad de las lesiones

14) Las fracturas con rasgo intraarticular habitualmente se manejan con cirugía, debido a que en caso contrario:

- a) Desarrollan necrosis avascular
- b) Desarrollan artrosis
- c) Desarrollan pseudoartrosis o no unión
- d) Desarrollan hemartrosis y dolor persistente
- e) Desarrollan artritis séptica

15) Un paciente de 34 años sufre una caída mientras jugaba fútbol, en la que sufrió una torsión en la rodilla izquierda. Al examen físico presenta signos de derrame articular y es posible luxar la rodilla movilizándolo la tibia hacia anterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de tendón rotuliano
- b) Rotura de ligamento cruzado anterior
- c) Rotura de ligamento cruzado posterior
- d) Rotura de ligamento colateral medial
- e) Rotura de ligamento colateral lateral

16) Un paciente de 72 años presenta una fractura de cadera de cuello femoral desplazada, tipo Garden IV. La conducta más adecuada es:

- a) Estabilizar al paciente, administrar analgésicos y derivar para resolución quirúrgica con prótesis parcial de cadera
- b) Estabilizar al paciente, administrar analgésicos y derivar para resolución quirúrgica con tornillo canulado
- c) Estabilizar al paciente, administrar analgésicos y derivar para resolución quirúrgica tutor externo
- d) Estabilizar al paciente, administrar analgésicos y derivar para inmovilización con bota larga de yeso
- e) Estabilizar al paciente, administrar analgésicos y derivar para inmovilización con yeso pelvipedio

17) Un paciente de 56 años consulta por dolor en el talón izquierdo, que aparece al caminar y que le dificulta la marcha, cuando es mayor a 3 cuerdas. Se solicita una radiografía de retropié que visualiza un espolón calcáneo de 1 cm. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar uso de calzado cómodo o taloneras
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Realizar resección quirúrgica
- d) Solicitar TAC de retropié
- e) Solicitar ecografía del retropié

18) Identifique la asociación incorrecta entre el tumor óseo y su característica:

- a) Osteocondroma – Reacción perióstica en sol naciente
- b) Osteosarcoma – Discontinuidad de la cortical ósea
- c) Osteoma osteoide – Dolor mayor en la noche
- d) Sarcoma de células gigantes – Rápido crecimiento y destrucción ósea local
- e) Sarcoma de Ewing – Rápido crecimiento en ubicación diafisaria

19) En paciente presenta inversión forzada del pie izquierdo mientras bajaba una escalera, evolucionando con intenso dolor. Al examen físico se aprecia equimosis y aumento de volumen en la zona inframaleolar externa. Se solicitan radiografías de tobillo y pierna, que no visualizan lesiones óseas. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar analgesia e inmovilizar con bota larga de yeso por al menos 3 meses y controlar con radiografías periódicas cada 2 semanas
- b) Indicar analgesia, reposo relativo e indicar el uso de una bota ortopédica removible
- c) Indicar analgesia y prohibir el apoyo de la extremidad por al menos 30 días
- d) Indicar analgesia y ejercicios de rotación e inversión del tobillo y controlar en 7 días
- e) Solicitar TAC de tobillo

20) Un paciente de 23 años presenta una caída a nivel, cayendo sobre la extremidad superior izquierda, en extensión. Al examen físico presenta dolor a la presión de la tabaquera anatómica. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de trapecio
- b) Fractura de cúpula radial
- c) Fractura de la apófisis estiloides
- d) Fractura de escafoides
- e) Fractura de extremo distal del radio

Prueba 6

1) Un hombre sufre un accidente laboral, resultando con múltiples fracturas en la extremidad superior izquierda. Al examen presenta imposibilidad de extender el codo y la muñeca. ¿Qué estructura está presuntamente dañada?

- a) Nervio mediano
- b) Nervio cubital
- c) Nervio musculocutáneo
- d) Nervio radial
- e) Nervio axilar

2) Un paciente sufre una caída mientras jugaba fútbol, con un golpe en la rodilla izquierda. Al examen físico se aprecian signos de derrame articular, el que se punciona, dando salida a sangre con gotas de grasa. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura meniscal
- b) Rotura de ligamento cruzado
- c) Rotura de ligamento colateral
- d) Rotura del cartílago articular
- e) Fractura de rodilla

3) Un paciente de 80 años sufre una caída a nivel, resultando con imposibilidad de ponerse de pie y dolor. Al examen físico se aprecia posición impúdica de la extremidad inferior izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de la cadera
- b) Luxación posterior de la cadera
- c) Fractura de cadera
- d) Fractura de acetábulo
- e) Lesión del nervio ciático

4) Un paciente de 19 años cae a nivel, con apoyo sobre la mano derecha, evolucionando con intenso dolor e impotencia funcional en el codo. Al examen físico presenta dolor en el codo, especialmente con los movimientos de pronosupinación. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Fractura de cúpula radial
- b) Fractura de olécranon
- c) Luxación de codo
- d) Lesión del nervio cubital
- e) Fractura de antebrazo

5) Un paciente de 45 años presenta un fractura de pierna, la que es reducida y fijada quirúrgicamente, con instalación de un clavo endomedular. Al día siguiente evoluciona con dolor y edema de la extremidad. Al examen físico presenta dolor marcado a la palpación muscular de la pantorrilla, con normalidad de los pulsos, sensibilidad y movilidad distal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome compartimental
- b) Lesión de arteria poplítea
- c) Distrofia simpático-refleja
- d) Trombosis venosa profunda
- e) Evolución postquirúrgica normal

6) Un paciente sufre una caída mientras andaba en bicicleta, golpeándose el hombro izquierdo. Al examen presenta “hombro en charretera” e impotencia funcional. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de clavícula
- b) Disyunción acromioclavicular
- c) Luxación anterior de hombro
- d) Luxación posterior de hombro
- e) Fractura subcapital de hombro

7) Un hombre presenta dolor lumbar irradiado a la extremidad inferior izquierda, por la cara lateral de la rodilla y anterior de la pierna, hasta los ortejos. Al examen tiene debilidad para abducir el muslo y extender el primer ortejo. Los reflejos son normales. ¿Qué raíz está afectada?

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

8) Los agentes etiológicos más frecuentes de las osteomielitis agudas y de las artritis sépticas son, respectivamente:

- a) Estafilococo aureo y estafilococo aureo
- b) Estafilococo aureo y gonococo
- c) Estreptococo beta hemolítico y gonococo
- d) Estreptococo beta hemolítico y estafilococo aureo
- e) Estreptococo beta hemolítico y estreptococo beta hemolítico

9) Un paciente de 50 años consulta por dolor en la pierna izquierda. Al examen se aprecia aumento de volumen en relación a la tibia. Se solicita radiografía de pierna que visualiza un tumor óseo de 5 cm de diámetro, con compromiso de la arquitectura, reacción perióstica en tela de cebolla y disrupción de la cortical. El diagnóstico más probable es:

- a) Osteosarcoma
- b) Osteoma osteoide
- c) Osteocondroma
- d) Adantimoma
- e) Enfermedad de Paget

10) Un adolescente de 14 años, con sobrepeso, consulta por dolor inguinal izquierdo intenso, que le impide la marcha. Al examen físico presenta dolor y limitación a la movilización de la cadera izquierda, especialmente a la abducción y rotación interna. El diagnóstico más probable es:

- a) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- b) Artrosis
- c) Sinovitis transitoria
- d) Enfermedad de Perthes
- e) Luxación congénita de la cadera (displasia de cadera)

11) Un paciente de 67 años consulta por dolor en la ingle izquierda, que aparece al caminar y que en ocasiones se presenta en el reposo, exacerbándose en los días en que realiza actividad física. Al examen físico presenta movilidad completa de la rodilla y cadera izquierdas, pero presenta dolor a la abducción completa de la cadera. Se solicita una radiografía que muestra disminución del espacio articular, con presencia de osteofitos acetabulares. La conducta más adecuada es:

- a) Resolver quirúrgicamente
- b) Iniciar paracetamol
- c) Realizar infiltración articular con corticoides
- d) Solicitar TAC de cadera
- e) Iniciar Ibuprofeno

12) ¿Qué antibiótico indicaría en un paciente con una fractura expuesta traumática, con mala cobertura de partes blandas y presencia de restos vegetales en la herida?

- a) Cloxacilina
- b) Imipenem
- c) Clindamicina + cloxacilina
- d) Cefazolina + gentamicina + metronidazol
- e) Ceftriaxona + gentamicina + metronidazol

13) Un adulto mayor de 80 años consulta por dolor lumbar de larga data, irradiado a ambas piernas que se presenta al caminar y que lo obliga a detenerse luego de andar una cuadra. Refiere que cede al sentarse y que es menos intenso cuando camina inclinado hacia delante. El diagnóstico más probable es:

- a) Espodilosis lumbar
- b) Espondilolistesis lumbar
- c) Raquiestenosis
- d) Lumbago tumoral
- e) Espondilitis anquiosante

14) Un paciente de 8 años, con sus vacunas al día, sufre una fractura expuesta de tibia, de gran tamaño, luego de caer de un caballo. ¿Qué conducta es la más adecuada en relación a la vacunación antitetánica?

- a) La vacunación antitetánica no es necesaria en este caso
- b) Debe administrarse una dosis de vacuna DT
- c) Debe administrarse una dosis de vacuna DT más suero antitetánico
- d) Deben administrarse 3 dosis de vacuna DT
- e) Deben administrarse 3 dosis de vacuna DT más suero antitetánico

15) Un paciente de 45 años sufre un accidente de tránsito, de alta energía. Al examen físico está consciente, respira normalmente y se aprecia una fractura expuesta en la pierna izquierda, que sangra activamente. Se instala collar cervical y vía venosa periférica con administración de suero fisiológico. ¿Qué conducta es la más adecuada para el manejo de la hemorragia?

- a) Realizar compresión con apósitos
- b) Realizar un torniquete con una banda elástica removible
- c) Realizar aseo con suero fisiológico, sin tocar la herida
- d) Realizar ligadura arterial
- e) Realizar reducción de la fractura y estabilización con una férula neumática

16) Un paciente sufre una fractura del cello del astrágalo, ¿cuál es la complicación típica de este tipo de lesiones?

- a) Necrosis avascular
- b) Infección
- c) Distrofia simpático-refleja
- d) Síndrome compartimental
- e) Artrosis

17) Un paciente sufre una “torsión de rodilla” mientras jugaba básquetbol, evolucionando con dolor en la cada lateral de la rodilla, sin impedimento de la marcha. Al examen físico se aprecia dolor a la palpación de la cara lateral de la rodilla y al varo forzado, sin signos de inestabilidad ni de derrame articular. La maniobra de Appleby es negativa. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión del menisco medial
- b) Lesión del ligamento cruzado anterior
- c) Lesión del ligamento cruzado posterior
- d) Lesión del ligamento colateral lateral
- e) Lesión del tendón de la pata de ganso

18) El concepto de “pseudoartrosis” se refiere a:

- a) Dolor articular crónico, no inflamatorio, sin cambios en la radiología
- b) La movilidad anormal de un segmento óseo por interposición de partes blandas durante el proceso de consolidación de una fractura
- c) La pérdida de la funcionalidad de una articulación con imposibilidad de realizar ninguno de los movimientos habituales de dicha articulación
- d) La consolidación de una fractura en la cual hay un mal alineamiento de los ejes, ya sea por desplazamientos antero-posteriores, laterales o rotación del segmento óseo distal
- e) El compromiso articular inflamatorio, con compromiso asimétrico del cartílago articular y presencia de lesiones óseas en “sacabocado”

19) Un niño de 30 días de vida presenta signo de Ortolani positivo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografías de cadera de inmediato
- b) Solicitar ecografía de cadera de inmediato
- c) Observar evolución, controlando periódicamente
- d) Solicitar radiografías de cadera al cumplir los 3 meses de edad
- e) Iniciar tratamiento con correas de Pavlik

20) Un paciente de 54 años consulta por dolor en la extremidad inferior izquierda y fiebre alta. Al examen físico se aprecia una gran placa eritematosa, con áreas violáceas y negruzcas, muy dolorosa en el muslo izquierdo, asociada a flictenas cutáneas. El agente más probable es:

- a) *Streptococcus* betahemolítico grupo A
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Pseudomonas aeruginosa*
- d) *Clostridium perfringens*
- e) *Meningococcus*

Prueba 7
VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA PREGUNTAS ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y NUTRICIÓN,
(Prueba 8)

TRAUMATOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	11 E	1 C	12 A
1 A	12 C	2 B	13 C
2 A	13 A	3 D	14 B
3 A	14 A	4 E	15 B
4 B	15 C	5 A	16 A
5 D	16 D	6 D	17 A
6 A	17 B	7 C	18 A
7 D	18 B	8 C	19 B
8 D	19 B	9 A	20 D
9 D	20 D	10 B	
10 B		11 A	Prueba 6
11 C	Prueba 3	12 E	1 D
12 A	1 A	13 A	2 E
13 D	2 C	14 D	3 C
14 D	3 A	15 B	4 A
15 B	4 A	16 C	5 D
16 C	5 C	17 C	6 C
17 D	6 B	18 C	7 C
18 B	7 A	19 C	8 A
19 A	8 D	20 B	9 A
20 D	9 C		10 A
	10 C	Prueba 5	11 B
Prueba 2	11 D	1 E	12 D
1 B	12 A	2 D	13 C
2 C	13 B	3 E	14 A
3 E	14 D	4 E	15 A
4 E	15 B	5 B	16 A
5 B	16 B	6 C	17 D
6 B	17 E	7 C	18 B
7 B	18 C	8 B	19 B
8 A	19 D	9 B	20 A
9 D	20 A	10 E	
10 B	Prueba 4	11 E	

III) UROLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 1

Prueba 2

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 2

Prueba 3

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 4

Prueba 4

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 5

Prueba 5

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 6

Prueba 6

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 7

Prueba 7

VER MANUAL DE MEDICINA INTERNA, PREGUNTAS NEFROLOGÍA, Prueba 8

IV) DERMATOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Lactante de 8 meses, con eritema, pápulas y algunas costras pequeñas en ambas mejillas, codos y en otras superficies extensoras, de 1 mes de evolución, que se han hecho más intensas en los últimos días. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Impétigo
- c) Dermatitis atópica
- d) Escabiosis
- e) Eritema infeccioso

2) Hombre de 19 años, con múltiples lesiones maculares en el pecho y la espalda, algunas de ellas, levemente pruriginosas. Al examen se aprecian varias máculas de 1 a 3 cms, hipopigmentadas, con signo del uñetazo positivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Vitiligo
- b) Pityriasis versicolor
- c) Pityriasis rosada
- d) Pityriasis alba
- e) Eccema numular

3) Recién nacido con una lesión macular de 2 cm, eritematosa, de color homogéneo y bordes bien definidos, en relación a la zona occipital media. Al examen físico no se aprecian signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Nevus flameus
- b) Erisipela
- c) Celulitis
- d) Hemangioma
- e) Mancha salmón

4) Un paciente de 19 años, consulta por aparición de múltiples placas eritematosas, descamativas en el tórax, abdomen y extremidades, sin compromiso de palmas ni plantas. Las lesiones son de color rosado claro, con descamación fina abundante y de tamaño entre 4 y 12 mm. Refiere haber sido tratado con penicilina hace 2 semanas, por amigdalitis. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema multiforme
- b) Pityriasis rosada
- c) Exantema eritematoso secundario a penicilina
- d) Psoriasis guttata
- e) Eritema nodoso

5) ¿Cuál de las siguientes patologías es producida por un mecanismo de autoinmunidad tipo dos, es decir, mediada por anticuerpos NO IgE?

- a) Penfigoide
- b) Liquen simple
- c) Urticaria
- d) Psoriasis
- e) Liquen plano

6) ¿Cuál de las siguientes patologías produce manifestaciones oculares con mayor frecuencia?

- a) Rosácea
- b) Lupus cutáneo subagudo
- c) Acné
- d) Vitiligo
- e) Psoriasis

7) La medida más importante para evitar la progresión de la rosácea es:

- a) Evitar la exposición a la luz solar
- b) Evitar los condimentos y el alcohol
- c) El tratamiento con antibióticos
- d) El tratamiento con inmunomoduladores
- e) Abandonar el hábito tabáquico

8) Un hombre de 44 años, fue diagnosticado de sífilis secundaria hace 2 años, siendo tratado con penicilina benzatina. Presenta actualmente un cuadro febril, por lo que decide tomar nuevos VDRL y FTA-ABS, los que resultan negativo y positivo, respectivamente. La conducta más adecuada es:

- a) Explicarle que con alta probabilidad ha sufrido una reinfección luética, por lo que deben realizarse exámenes a su pareja y tratarse ambos con penicilina benzatina
- b) Explicarle que lo más probable es que existió resistencia a la penicilina en su infección anterior, por lo que debe tratarse con eritromicina en esta ocasión
- c) Explicarle que lo más probable es que presentó una sífilis terciaria y que la dosis previa de penicilina fue insuficiente, por lo que debe tratarse con 2 dosis de 2.400.000 UI de penicilina benzatina
- d) Explicarle que el resultado de los exámenes es no concluyente, por lo que deben repetirse para poder decidir el manejo
- e) Explicarle que lo más probable es que su cuadro febril se deba a una causa distinta a la sífilis, ya que sus exámenes demuestran que está curado

9) El signo de Nikolsky se caracteriza porque al ejercer una presión tangencial sobre la piel sana, se produce un desprendimiento de la epidermis. Las tres patologías, que característicamente presentan este signo, son:

- a) Pénfigo, pénfigoide y síndrome de piel escaldada
- b) Prúrigo, impétigo buloso y necrosis epidermotóxica
- c) Pénfigoide, síndrome de piel escaldada y síndrome de Steven Johnson
- d) Síndrome de piel escaldada, necrosis epidermotóxica y síndrome de Steven Johnson
- e) Necrosis epidermotóxica, síndrome de piel escaldada y pénfigo

10) Un niño de 9 años, sin antecedentes de importancia, es traído por su madre, ya que luego de una excursión presenta pápulas, vesículas y placas eritematosas lineales en las manos, antebrazos, cara y cuello. El resto del examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto fotoalérgica
- b) Dermatitis atópica
- c) Dermatitis de contacto irritativa
- d) Dermatitis de contacto alérgica subaguda
- e) Prúrigo insectario

11) ¿Cuál de las siguientes opciones se correlaciona mejor con el cuadro clínico de una dermatitis de contacto alérgica crónica?

- a) Eritema, microvesículas y rezumación
- b) Eritema, descamación y dolor
- c) Liquenificación, prurito e hiperpigmentación
- d) Liquenificación, dolor y eritema
- e) Hipopigmentación, pápulas, pústulas y luego costras

12) ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una variante normal de la lengua?

- a) Leucoplaquia vellosa
- b) Glositis romboidal media
- c) Lengua vellosa negra
- d) Áreas depiladas
- e) Lengua fisurada

13) ¿Cuál de las siguientes lesiones tiene el peor pronóstico?

- a) Carcinoma basocelular
- b) Carcinoma espinocelular
- c) Queratosis actínica
- d) Enfermedad de Bowen
- e) Queratosis seborreica

14) Una mujer de 45 años, consulta por una lesión oscura, de color y forma irregular en la pierna derecha, que ha crecido en el último tiempo. Se decide realizar biopsia excisional que demuestra un melanoma de extensión superficial, con un índice de Breslow de 2,3 mm. La conducta más adecuada es:

- a) Ampliar los márgenes en 1 cm y realizar radioterapia local
- b) Ampliar los márgenes en 2 cm e iniciar quimioterapia
- c) Ampliar los márgenes en 2 cm, y solicitar radiografía de tórax y TAC de cerebro
- d) Ampliar los márgenes en 2 cm y realizar biopsia de ganglio centinela
- e) Ampliar los márgenes en 1 cm y solicitar radiografía de tórax y TAC de cerebro

15) Un adolescente de 16 años, consulta porque ha notado aparición de una lesión poliposa de rápido crecimiento en el cuero cabelludo, que en ocasiones le duele al peinarse. Al examen físico se observa una tumoración similar a una coliflor, multilobulada, irregular, pediculada, de color amarillo, de 3,8 cm. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma maligno
- b) Nevo sebáceo de Jadassohn
- c) Queratosis seborreica
- d) Condiloma de cuero cabelludo
- e) Carcinoma basocelular

16) La lesión elemental de la urticaria es:

- a) Comedón
- b) Pápula
- c) Mácula
- d) Placa
- e) Pseudopápula

17) Una mujer de 43 años, inicia tratamiento con ketoprofeno por un esguince de tobillo, sin embargo evoluciona con múltiples lesiones eritematosas generalizadas, que abarcan el 20% de la superficie corporal, algunas de las cuales evolucionan a vesículas y bulas. También presenta conjuntivitis, disuria y afectación de la mucosa oral, con múltiples lesiones vesiculares, que evolucionan a úlceras. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema multiforme menor
- b) Síndrome de Steven Johnson
- c) Necrosis epidérmica
- d) Síndrome de Sweet
- e) Reacción a fármacos, tipo penfigoide

18) Mujer de 35 años, con lesiones eritematosas, recidivantes, intensamente pruriginosas en muñecas, antebrazos y tobillos. Al examen se aprecian múltiples lesiones papulares, brillantes, de 3 a 5 mm, de forma poligonal. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen plano
- b) Liquen simple
- c) Dermatitis atópica
- d) Dermatitis de contacto alérgica
- e) Prurigo

19) Una mujer de 33 años, inmunodeprimida, presenta varias lesiones solevantadas, de menos de 5 mm de diámetro, con una umbilicación central, en tronco, cabeza y extremidades, no dolorosas, ni pruriginosas. El resto del examen físico sólo demuestra candidiasis oral. El diagnóstico más probable es:

- a) Condiloma
- b) Candidiasis cutánea
- c) Prurigo
- d) Molusco contagioso
- e) Angiomatosis basilar (*Bartonella henselae*)

20) La principal diferencia clínica, entre la candidiasis del pañal y la dermatitis del pañal, es:

- a) La presencia de exudado blanquecino
- b) La severidad de los signos inflamatorios
- c) La presencia de ulceraciones y costras
- d) El compromiso de pliegues y la presencia de lesiones satélites
- e) El compromiso concomitante de mucosas

Prueba 2

1) Un paciente de 20 años consulta por múltiples lesiones maculares, hipopigmentadas, que se distribuyen en la zona media de la espalda y del pecho. Las lesiones aparecieron hace cerca de un mes y no presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Vitíligo
- b) Pitiriasis alba
- c) Pitiriasis rosada
- d) Psoriasis gutatta
- e) Pitiriasis versicolor

2) La lesión elemental de la urticaria es:

- a) Mácula
- b) Pápula
- c) Vesícula
- d) Pseudopápula
- e) Placa

3) Un paciente de 50 años presenta desde hace varios meses eritema facial, asociado a pápulas y pústulas que comprometen las mejillas y la nariz, sin identificarse otro tipo de lesiones. Al examen además de aprecia eritema y fina descamación de los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Lupus sistémico
- b) Dermatomiositis
- c) Rosácea
- d) Acné
- e) Dermatitis atópica

4) Una mujer de 50 años presenta lesiones vesiculares y ampollares, recurrentes, especialmente en las zonas de roce. Es frecuente que forme bulas ante mínimos golpes y éstas se rompen fácilmente. Al examen físico destaca signo de Nikolski. ¿Qué afirmación es VERDADERA, respecto a la patología descrita?

- a) Se trata de un caso de penfigoide
- b) Su tratamiento de elección son los corticoides tópicos
- c) La inmunofluorescencia demostrará inmunoglobulinas en las uniones entre queratinocitos
- d) La exposición solar es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad
- e) Suele ser una enfermedad autolimitada

5) Un hombre de 68 años presenta una lesión en la espalda derecha, solevantada, de un centímetro de diámetro, con borde elevado, brillante, asociado a una telangiectasia adyacente. El diagnóstico más probable es:

- a) Quiste sebáceo
- b) Carcinoma basocelular
- c) Carcinoma espinocelular
- d) Queratosis actínica
- e) Melanoma nodular

6) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, respecto a las reacciones cutáneas a medicamentos?

- a) La necrosis epidérmica presenta signo de Nikolski
- b) El síndrome de Steven-Johnson se caracteriza por el compromiso de mucosas
- c) El eritema multiforme menor suele ser producido por causas infecciosas con mayor frecuencia que por medicamentos
- d) Los exantemas eritematosos inespecíficos son la reacción cutánea más frecuente ante el uso de fármacos
- e) Las reacciones acneiformes presentan abundantes comedones

7) La medida más importante para detener la progresión de la rosácea es:

- a) Corticoides tópicos
- b) Dieta
- c) Protección solar
- d) Inmunomoduladores
- e) Antibióticos

8) Un paciente de 56 años consulta por una lesión oscura, de 8 mm, ubicada en el hombro derecho, tiene bordes irregulares y pigmentación heterogénea. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Aplicar corticoides tópicos
- c) Realizar biopsia por punción
- d) Realizar biopsia excisional
- e) Solicitar biopsia de ganglio centinela

9) Un paciente de 24 años presenta desde hace algunos meses una placa hiperpigmentada, de 7 cm de diámetro y bordes difusos, con signos de liquenificación en la zona infraumbilical, la cual es pruriginosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma
- b) Impétigo
- c) Eccema numular
- d) Dermatitis de contacto alérgica
- e) Liquen simple crónico

10) Un hombre de 18 años nota múltiples cabellos en su almohada desde hace un tiempo y al revisar su cuero cabelludo nota una zona alopecica. Al examen se aprecia un área de 3 cm de diámetro sin presencia de ningún pelo en la zona occipital del cuero cabelludo, sin signos inflamatorios ni lesiones en otras áreas. El diagnóstico más probable es:

- a) Alopecia varonil
- b) Alopecia areata
- c) Tiña capitis
- d) Dermatitis seborreica
- e) Liquen simple crónico

11) Un paciente de 30 años consulta por lesiones eritematosas y descamativas de un año de evolución, recidivantes. Al examen se observan placas eritematodescamativas de distintos tamaños, entre algunos milímetros, hasta 5 cm, ubicadas en rodillas, codos y espalda. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen simple crónico
- b) Liquen plano
- c) Psoriasis
- d) Dermatitis seborreica
- e) Dermatitis de contacto

12) ¿En qué sitios anatómicos se presentan los melanomas con más frecuencia?

- a) En el tronco en las mujeres y en las extremidades inferiores en los hombres
- b) En las extremidades inferiores en las mujeres y en la cara en los hombres
- c) En la cara en las mujeres y en las extremidades inferiores en los hombres
- d) En las extremidades inferiores en las mujeres y en el tronco en los hombres
- e) En el tronco en las mujeres y en la cara en los hombres

13) Un niño de 5 años presenta lesiones recidivantes, de tipo papular y a veces microvesiculares en las mejillas, fosas cubitales y fosas poplíteas. El diagnóstico más probable es:

- a) Urticaria
- b) Dermatitis atópica
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Prurigo insectario
- e) Sarna

14) Un hombre de 67 años presenta una lesión en la cara derecha de la lengua, consistente en una placa eritematosa, no dolorosa, de lento crecimiento en varios meses, que actualmente es de 2 cm de largo por 1 cm de ancho. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio
- b) Administrar corticoides tópicos
- c) Aplicar antimicóticos tópicos
- d) Iniciar antibióticos orales
- e) Derivar para biopsia de la lesión

15) Un paciente de 34 años consulta por lesiones pruriginosas en los tobillos. Al examen se aprecian pápulas eritematosas, brillantes, de 2 a 6 mm de diámetro. En la cara inferior de la lengua se observa una placa reticulada, blanquecina. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer epidermoide
- b) Linfoma de células T
- c) Liquen plano
- d) Liquen simple
- e) Enfermedad de Behcet

16) Respecto al vitíligo es FALSO que:

- a) Se asocia a hipotiroidismo
- b) Se caracteriza por máculas acrómicas
- c) Su principal factor de riesgo es la exposición solar
- d) Las lesiones pequeñas se benefician del uso de corticoides tópicos
- e) Las lesiones no duelen ni presentan prurito

17) Un recién nacido presenta una mácula eritematoviolácea que compromete la frente, mejilla y zona periocular izquierdas, sin sobrepasar la línea media. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemangioma
- b) Nevus flameus
- c) Mancha salmón
- d) Nevo de Ito
- e) Nevo de Ota

18) Un lactante de 2 meses de edad presenta eritema marcado en la zona del pañal, que respetan los pliegues. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis atópica
- b) Dermatitis de contacto irritativa
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Dermatitis del pañal
- e) Candidiasis del pañal

19) Una mujer de 23 años consulta por lesiones vesiculares, recidivantes, muy pruriginosas, con tendencia a confluir y que aparecen en el dorso de las manos y de los dedos, especialmente cuando presenta sobrecarga emocional o laboral. El diagnóstico más probable es:

- a) Urticaria
- b) Dermatitis atópica
- c) Pofólix
- d) Demodectiosis
- e) Dermatitis de contacto

20) Un adolescente de 16 años, consulta porque ha notado aparición de una lesión poliposa de rápido crecimiento en el cuero cabelludo, que en ocasiones le duele al peinarse. Al examen físico se observa una tumoración similar a una coliflor, multilobulada, irregular, pediculada, de color amarillo, de 3,8 cm. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma maligno
- b) Nevo sebáceo de Jadassohn
- c) Queratosis seborreica
- d) Condiloma de cuero cabelludo
- e) Carcinoma basocelular

Prueba 3

1) Un paciente de 8 años, con antecedente de rinitis alérgica, consulta por aparición de una mácula hipopigmentada en la cara, de 15 mm de diámetro, bordes difusos y fina descamación. El diagnóstico más probable es:

- a) Vitíligo
- b) Pitiriasis alba
- c) Pitiriasis versicolor
- d) Demodectidiosis
- e) Tiña

2) Una mujer de 60 años presenta lesiones solevantadas, de 2 a 5 mm de diámetro, de larga evolución, ásperas, con fina descamación, ubicadas en la frente y en el dorso de las manos, sin dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis actínica
- b) Dermatitis seborreica
- c) Psoriasis
- d) Queratosis seborreica
- e) Léntigos solares

3) Una mujer de 32 años presenta lesiones en las uñas, consistentes en depresiones puntiformes, similares a picotazos. El diagnóstico más probable es:

- a) Onicomycosis
- b) Onicogriposis
- c) Liquen plano
- d) Psoriasis
- e) Onicocriptosis

4) Un paciente de 30 años presenta placas eritematosas y descamativas, recidivantes, en la zona lumbar y en las extremidades, especialmente en las rodillas y los codos. Las lesiones son de 2 a 5 cm de diámetro y no presentan otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen simple crónico
- b) Dermatitis de contacto
- c) Psoriasis
- d) Pitiriasis rosada
- e) Liquen plano

5) Un niño de 4 años presenta desde hace 5 días, pápulas eritematosas en las mejillas y alrededor de la boca, con costras amarillentas brillantes. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Impétigo
- c) Ectima
- d) Pénfigo
- e) Prúrigo

6) Una mujer de 37 años presenta varias máculas hipopigmentadas en la zona media del pecho y de la espalda. No presentan dolor, prurito ni signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Vitíligo
- b) Penfigoide
- c) Psoriasis guttata
- d) Pitiriasis versicolor
- e) Pitiriasis alba

7) Una mujer de 23 años presenta lesiones eritematosas, poligonales, pruriginosas en la cara palmar de las muñecas y en los tobillos. Además presenta una placa blanca reticulada en la cara lateral de la lengua. El diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Pénfigo
- c) Penfigoide
- d) Liquen simple
- e) Liquen plano

8) Un paciente de 30 años consulta por una lesión en el pene, consistente en una úlcera de un centímetro de diámetro, indurada, de fondo limpio, no dolorosa y sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis primaria
- b) Chancroide
- c) Herpes genital
- d) Donovanosis
- e) Linfogranuloma venéreo

9) Un hombre de 50 años presenta pápulas y pústulas en la cara, con una base eritematosa con algunas telangiectasias. Además presenta chalaziones con cierta frecuencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Acné
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Dermatitis atópica
- d) Dermatitis de contacto fototóxicológica
- e) Rosácea

10) Un hombre de 65 años presenta una mácula hiperpigmentada, de color irregular, de lento crecimiento en la mejilla izquierda. Actualmente tiene 24 mm. El diagnóstico más probable es:

- a) Nevo de Spilus
- b) Nevo de Sutton
- c) Nevo de Ota
- d) Lentigo maligno
- e) Lentigo solar

11) Un adulto mayor presenta una lesión solevantada en el hombro derecho, con borde perlado y una telangiectasia adyacente. El diagnóstico más probable es:

- a) Granuloma piógeno
- b) Queratosis actínica
- c) queratosis seborreica
- d) Cáncer basocelular
- e) Cáncer espinocelular

12) Un niño presenta una lesión macular azulosa que compromete el hombro y la zona pectoral derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Nevo gigante congénito
- b) Nevo de Spilus
- c) Nevo de Ito
- d) Nevo de Ota
- e) Mancha mongólica

13) Un hombre de 26 años presenta lesiones eritematosas y descamativas en las cejas y las alas nasales. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto
- b) Dermatitis seborreica
- c) Dermatitis atópica
- d) Psoriasis
- e) Queratosis seborreica

14) Un hombre de 45 años presenta una placa eritematosa en la cara medial de la zona proximal del muslo izquierdo. Su diámetro es de 6 cm, de bordes papulosos y arciformes, con fina descamación y tendencia a la curación central. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña cruris
- b) Liquen simple
- c) Liquen plano
- d) Lupus discoide
- e) Psoriasis

15) Un hombre de 50 años presenta enrojecimiento del muslo derecho, asociado a fiebre. Al examen físico se observa una placa eritematosa, brillante, de bordes definidos, con temperatura aumentada y dolor a la palpación. Además se palpan varias adenopatías inguinales. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritrasma
- b) Erisipela
- c) Celulitis
- d) Fasceítis necrotizante
- e) Loxocelismo cutáneo

16) Una mujer de 18 años presenta aparición de una placa eritematosa en la espalda, de 3 cm de diámetro, evolucionando luego de algunos días con aparición de varias lesiones similares en el dorso, en el pecho y en la zona proximal de las extremidades, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis guttata
- b) Sífilis secundaria
- c) Eritema multiforme
- d) Pityriasis rosada
- e) Eritema infeccioso

17) Un hombre de 67 años, fumador, hipotiroideo, diabético e hipertenso, presenta una lesión de lento crecimiento en la mucosa de la mejilla izquierda, sin dolor ni prurito. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa, de bordes irregulares de 2,5 cm de diámetro mayor. EL diagnóstico más probable es:

- a) Candidiasis
- b) Liquef plano
- c) Línea alba
- d) Penfigoide
- e) Eritroplaquia

18) Una paciente presenta prurito, eritema y liquenificación de ambos lóbulos de las orejas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto alérgica aguda
- b) Dermatitis de contacto alérgica subaguda
- c) Dermatitis de contacto irritativa aguda
- d) Dermatitis de contacto irritativa crónica
- e) Urticaria crónica

19) Un lactante de 1 mes de edad presenta una lesión roja, solevantada en el labio superior, la cual crece aceleradamente en los 2 meses siguientes, alcanzando un tamaño de 3 cm. El diagnóstico más probable es:

- a) Mancha salmón
- b) Nevus flameus
- c) Hemangioma
- d) Malformación vascular
- e) Punto rubí

20) Un hombre de 21 años inicia un tratamiento antibiótico, presentando varias lesiones cutáneas, consistentes en placas de 1 a 4 centímetros de diámetro, eritematosas, en disposición en tiro al blanco. No presenta otros síntomas y se observa en buenas condiciones generales. El diagnóstico más probable es:

- a) Necrosis epidérmica
- b) Síndrome de Steven Johnson
- c) Penfigoide
- d) Eritema multiforme menor
- e) Reacción acneiforme

Prueba 4 (DERMATOLOGÍA + INFECTOLOGÍA)

1) Por intertrigo se denomina en dermatología a:

- a) Una dermatopatía que afecta exclusivamente al tronco.
- b) Una lesión elemental circinada.
- c) La localización de lesiones en pliegues.
- d) Toda lesión más eritematosa en su interior.
- e) Cualquier lesión dermatológica que tiene mucho exudado.

2) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas suele acompañar a la atopia?:

- a) Piel seca.
- b) Congestión facial.
- c) Onicodistrofia.
- d) Perniosis.
- e) Alopecia.

3) Un paciente de 52 años, presenta por primera vez una erupción de lesiones pruriginosas, habonosas, diseminadas por toda la superficie corporal, de evolución fugaz y una amplia placa edematosa en hemicara. ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es el más probable?:

- a) Urticaria aguda.
- b) Angioedema hereditario.
- c) Erisipela.
- d) Carbunco
- e) Vasculitis.

4) Cuando se observa una inmunofluorescencia directa positiva en la piel lesional y perilesional afectando a la sustancia intercelular de la epidermis, podemos hacer el diagnóstico de:

- a) Penfigoide ampollar.
- b) Dermatitis herpetiforme.
- c) Epidermólisis ampollar.
- d) Enfermedad injerto contra huésped.
- e) Pénfigo vulgar.

5) El lugar más frecuente de metástasis de melanoma maligno es:

- a) Pulmón.
- b) Hígado.
- c) Piel y ganglios linfáticos.
- d) Cerebro.
- e) Hueso.

6) Mujer de 17 años sin hábitos tóxicos, que cinco días antes de su ingreso, comienza con fiebre, odinofagia, cansancio extremo y dolorimiento sordo en hipocondrio izquierdo. Su médico ha indicado tratamiento con amoxicilina dos días antes del ingreso. Examen físico: febril y deshidratada; rash macular con componente petequeial discreto en brazos, abdomen y piernas; linfadenopatía cérvico-axilar; fauces edematosas con exudados blanquecinos; hepatoesplenomegalia moderada, petequias en paladar. Laboratorio: fórmula leucocitaria, 70% linfocitos, 18% monocitos, 3% neutrófilos; plaquetas 70.000/mm³; GOT y GPT tres veces su valor máximo normal. Sangre periférica: células mononucleares atípicas. ASLO <100 U Todd. Con toda probabilidad el diagnóstico de esta paciente será:

- a) Infección por citomegalovirus.
- b) Púrpura trombopénica idiopática.
- c) Infección por virus de Epstein-Barr.
- d) Infección por virus de la hepatitis A.
- e) Infección por estreptococo hemolítico del grupo A.

7) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la neumonía por *Pneumocystis carinii* en pacientes con SIDA es FALSA?:

- a) El tratamiento profiláctico con cotrimoxazol sólo debe de iniciarse tras el primer episodio de neumonía.
- b) La radiografía de tórax puede ser normal.
- c) Los esteroides forman parte del tratamiento a considerar en esta infección.
- d) El cuadro clínico puede ser indolente, de semanas de evolución.
- e) El tiempo medio de mejoría clínica con tratamiento correcto es de 7 días.

8) Un paciente de 35 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar fiebre elevada de hasta 39°C, junto con confusión mental. En la exploración física destaca la existencia de lesiones cutáneas en pie izquierdo a nivel distal, maculares, de milímetros de diámetro, de aspecto isquémico hemorrágico y la auscultación cardiopulmonar es normal. A los pocos días se obtiene crecimiento de *Staphylococcus aureus* meticilina sensible en tres hemocultivos de tres obtenidos. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud correcta a seguir en ese momento?:

- a) Considerar el resultado de los hemocultivos como probable contaminación.
- b) Pautar de inmediato tratamiento antibiótico con penicilina y gentamicina durante 10 días.
- c) Comenzar tratamiento con cloxacilina y gentamicina y realizar estudio ecocardiográfico por la existencia probable de endocarditis aguda.
- d) Descartar la existencia de endocarditis por la ausencia de soplos en la auscultación cardíaca y buscar focos de posible osteomielitis.
- e) Realizar TAC abdominal urgente por probable absceso abdominal.

9) Hombre de 62 años diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 4 años que presenta un cuadro agudo febril (38,5°C), dolor de costado, esputo purulento y una radiografía de tórax donde existe una imagen de condensación con broncograma aéreo en lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico, de entre los siguientes, que debe utilizarse inicialmente de forma empírica?:

- a) Amoxicilina.
- b) Penicilina endovenosa.
- c) Amoxicilina-clavulánico.
- d) Ciprofloxacino.
- e) Eritromicina asociada a amoxicilina.

10) Señale, de entre las que a continuación se relacionan, cuál es la causa más común del absceso pulmonar:

- a) El hematoma intrapulmonar traumático.
- b) La aspiración de secreciones.
- c) El tromboembolismo séptico.
- d) La obstrucción bronquial por cuerpos extraños.
- e) La diseminación hematógena de un proceso séptico extratorácico.

11) Una mujer de 20 años presenta aparición de una placa eritematosa, levemente sollevada, no dolorosa ni pruriginosa, en el pecho, de 3 cm de diámetro, evolucionando algunos días después con aparición de múltiples lesiones similares en el pecho y espalda.

- a) Pitiriasis alba
- b) Pitiriasis rosada
- c) Dermatitis seborreica
- d) Pitiriasis versicolor
- e) Psoriasis

12) Un hombre de 34 años presenta múltiples lesiones papulares eritematosas, de forma poligonal, ubicadas en la cara flexora de las muñecas y zona distal de los antebrazos, con algunas lesiones similares en los tobillos. Son intensamente pruriginosas y no duelen. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis atópica
- b) Liquen plano
- c) Liquen simple crónico
- d) Sarna
- e) Urticaria

13) Una paciente de 50 años presenta una lesión oscura de lento crecimiento en relación a la uña del segundo dedo derecho, que en ocasiones se ulcera y sangra. El diagnóstico diferencial debe incluir 2 patologías. Estas son:

- a) Carcinoma espinocelular y Melanoma nodular
- b) Melanoma acral y granuloma telangiectásico
- c) Granuloma piógeno y leucoma maligno
- d) Carcinoma basocelular y tiña tricofítica
- e) Melanoma de extensión superficial y tiña microspórica

14) ¿Cuál de las siguientes patologías NO presenta como lesión elemental a una mácula?

- a) Psoriasis
- b) Vitiligo
- c) Cloasma
- d) Pityriasis versicolor
- e) Nevus flammeus

15) El eritema multiforme menor se caracteriza clínicamente por:

- a) Pápulas, vesículas y pústulas sobre una base eritematosa, que comprometen el tronco
- b) Placas en el tronco y zona proximal de las extremidades con disposición en “tiro al blanco”
- c) Pápulas y pústulas pruriginosas que afecta la cabeza y posteriormente se generalizan al tronco y las extremidades.
- d) Pápulas, placas y bulas que se rompen fácilmente, asociado a compromiso de mucosas
- e) Placas eritematosas que evolucionan a vesículas, confluentes, con gran extensión cutánea y presencia de signo de Nikolski

16) ¿Cuál de las asociaciones es FALSA entre el microorganismo oportunista y la manifestación clínica en un paciente VIH?

- a) Citomegalovirus – Coriorretinitis
- b) Criptococo – Diarrea
- c) Pneumocystis jirovecii – Neumonía
- d) Toxoplasma – Encefalitis
- e) Mycobacterium avium complex – Fiebre de origen no precisado

17) El tratamiento de la meningitis bacteriana aguda, cuyo agente etiológico aún no ha sido precisado, en una mujer embarazada debe incluir:

- a) Ceftriaxona + Dexametasona
- b) Ceftriaxona + Vancomicina + Dexametasona
- c) Ceftriaxona + Ampicilina + Dexametasona
- d) Ceftriaxona + Metronidazol + Dexametasona
- e) Ceftriaxona + Gentamicina + Dexametasona

18) El agente etiológico y la vía de infección, más frecuentes de la osteomielitis aguda son respectivamente:

- a) Staphylococcus aureus y vía hematógena
- b) Streptococcus pyogenes y vía hematógena
- c) Staphylococcus aureus e infección por continuidad
- d) Streptococcus pyogenes y vía directa
- e) Staphylococcus aureus y vía directa

19) ¿En cuál de las siguientes asociaciones NO existe una buena cobertura antibiótica?

- a) Cefoperazona – Pseudomona
- b) Ceftriaxona – Enterococo
- c) Penicilina – Treponema pallidum
- d) Clindamicina – Anaerobios
- e) Cefadroxilo – Escherichia coli

20) Un niño de 6 años presenta malestar general, fiebre y odinofagia, a lo que se agrega un rash macular eritematoso en las mejillas, que luego se extiende al tronco y a las extremidades, con una disposición reticular. El agente causal más probable es:

- a) Virus herpes 6
- b) Enterovirus
- c) Parvovirus B19
- d) Virus de Epstein Baar
- e) Virus de la rubéola

Prueba 5 (DERMATOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA)

1) ¿Qué espera encontrar en la campimetría de un paciente con una lesión a nivel de la cintilla óptica derecha?

- a) Hemianopsia heterónima bitemporal sin congruencia
- b) Hemianopsia homónima derecha con escasa congruencia
- c) Cuadrantopsia homónima izquierda, con escasa congruencia
- d) Cuadrantopsia homónima izquierda, con alta congruencia
- e) Cuadrantopsia heterónima binasal, con alta congruencia

2) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS probable de encontrar en un paciente con catarata senil?

- a) Leucocoria
- b) Empeoramiento de la visión en lugares con mucha luz
- c) Defecto pupilar aferente
- d) Disminución de la agudeza visual mayor en un ojo que en el otro
- e) Pupilas isocóricas

3) Un paciente de 16 años inicia tratamiento con indometacina por estar cursando con una pericarditis aguda, evolucionando con aparición de lesiones cutáneas eritematosas, dolorosas, consistentes en placas y algunas vesículas, que comprometen el 20% de la superficie cutánea. También presenta aparición de vesículas y úlceras en la mucosa oral y presenta hematuria en algunas oportunidades. El signo de Nikolsky es negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema multiforme
- b) Penfigoide secundario a fármacos
- c) Síndrome de Steven Johnson
- d) Necrosis epidermotóxica
- e) Síndrome de pie mano boca

4) Un niño de 4 años ronca, presenta apneas durante el sueño y habla con “voz de papa caliente”. Al examen físico se aprecia hipertrofia amigdalina, con amígdalas simétricas, que se juntan en la línea media de la faringe. No ha presentado amigdalitis ni otro tipo de infecciones recurrentes. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución hasta que cumpla 6 años
- b) Iniciar corticoides en spray nasal y reevaluar en un mes
- c) Iniciar corticoides orales y decidir conducta según respuesta
- d) Solicitar polisomnografía y decidir conducta según los resultados
- e) Derivar para amigdalectomía bilateral

5) La pérdida de la visión de un ojo, producida por una falta de desarrollo de los centros de procesamiento a nivel del sistema nervioso central, producto de una inadecuada estimulación durante los primeros años del desarrollo, se denomina:

- a) Presbicia
- b) Estrabismo
- c) Ambliopía
- d) Discoria
- e) Hipopión

6) La visión tubular es característica de:

- a) Glaucoma agudo
- b) Degeneración macular relacionada con la edad
- c) Hemorragia vítrea
- d) Neuritis óptica
- e) Glaucoma de ángulo abierto

7) Una paciente de 55 años consulta por hipoacusia derecha de instalación progresiva. Se realiza test de diapasones que muestra Rinne positivo a izquierda y negativo a derecha y Weber que lateraliza a derecha. La otoscopia es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Presbiacusia
- b) Otoesclerosis
- c) Miringoesclerosis
- d) Otitis media crónica
- e) Trauma acústico

8) Un obrero de la construcción estuvo soldando unas vigas metálicas, sin uso de protección adecuada, evolucionando algunas horas más tarde con ardor ocular, fotofobia, ojo rojo profundo y blefarospasmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Úlcera corneal
- b) Cuerpo extraño corneal
- c) Queratitis actínica
- d) Conjuntivitis química
- e) Queratitis punctata

9) Un niño de 5 años presenta lesiones papulares, eritematosas y recidivantes en la cara, fosas poplíteas y pliegues cubitales, que en algunas ocasiones se exacerban y rezuman. Al examen se observa además pitiriasis alba en la cara y doble ojera en cada ojo. El diagnóstico es:

- a) Dermatitis seborreica
- b) Dermatitis de contacto irritativa
- c) Dermatitis atópica
- d) Dermatitis inespecífica
- e) Dermatitis de contacto alérgica

10) Un paciente presenta vértigo de 5 horas de evolución, de inicio súbito, muy intenso, asociado a vómitos, con lateropulsiones a derecha y un nistagmo de reposo, horizontal, con fase rápida a izquierda, muy marcado. No tiene signos cerebelosos, compromiso de otros pares craneales ni alteraciones sensitivas o motoras. No presenta síntomas auditivos. El nistagmo disminuye al pedirle que fije la mirada sobre un punto. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Accidente vascular encefálico cerebeloso
- d) Parálisis vestibular
- e) Infarto de troncoencéfalo

11) Una paciente de 22 años consulta por fiebre, malestar general y disuria intensa. Al examen se observan varias vesículas de pequeño tamaño en el cuerpo del pene y glande, algunas de las cuales están ulceradas y son muy dolorosas. Se palpan varias adenopatías inguinales, sensibles. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antipiréticos y aciclovir por vía oral
- b) Iniciar AINEs y ciprofloxacino
- c) Iniciar azitromicina 2 gramos por una vez
- d) Solicitar cultivo de secreción uretral
- e) Solicitar VDRL

12) Un paciente de 46 años presenta otorrea e hipoacusia derechas, de dos meses de evolución, asociadas a otalgia ocasional. A la otoscopia se observa otorrea en el conducto auditivo externo y una perforación timpánica redondeada, de un diámetro equivalente a la cuarta parte del diámetro timpánico, a través de la cual pasa la secreción. El diagnóstico más probable es:

- a) Otitis media crónica
- b) Miringitis
- c) Mastoiditis
- d) Otitis externa complicada
- e) Perforación timpánica traumática

13) El tratamiento de elección de la onicomicosis es:

- a) Clotrimazol tópico
- b) Ketoconazol oral
- c) Terbinafina tópica
- d) Terbinafina oral
- e) Griseofulvina oral

14) ¿Cuál de las siguientes lesiones oculares no requieren manejo estricto por especialista?

- a) Trauma ocular con discoria
- b) Trauma ocular con hemorragia subconjuntival
- c) Trauma ocular con herida palpebral, que compromete el borde libre
- d) Trauma ocular con herida palpebral transfixiante
- e) Trauma ocular con amaurosis

15) Una paciente de 31 años presenta lesiones eritematosas, muy pruriginosas en los tobillos y antebrazos, de larga data, recidivantes, consistentes en pápulas eritematosas brillantes, de 2-5 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen plano
- b) Liquen simple
- c) Eccema numular
- d) Dermatitis atópica
- e) Urticaria crónica

16) Un niño de 6 años presenta rinorrea serosa, estornudos frecuentes y prurito nasal que inicia en septiembre y cede en diciembre, presentándose desde hace 3 años. En algunas ocasiones presenta además prurito ocular. Al examen físico destaca mucosa nasal pálida. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar prick test y decidir manejo según hallazgos
- b) Iniciar antihistamínicos tópicos y corticoides orales durante todo el año
- c) Iniciar antihistamínicos de segunda generación durante los meses sintomáticos
- d) Iniciar corticoides tópicos durante todo el año
- e) Iniciar tratamiento con antihistamínicos de segunda generación y corticoides orales durante los meses de síntomas

17) Una dueña de casa consulta por lesiones eritematosas, pruriginosas y descamativas en las manos. Desde hace un mes comenzó con aparición de pequeñas pápulas o placas eritematosas y pruriginosas, que han ido evolucionando hasta presentar grandes placas eritematosas en los dedos y palmas, agrietadas, con fina descamación y dolor en algunas oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Dermatitis de contacto irritativa
- c) Tiña
- d) Esclerodermia
- e) Eccema dishidrótico (ponfólix)

18) Un lactante de 3 meses de edad presenta epifora, opacidad corneal y ojos de mayor tamaño del normal. El diagnóstico de sospecha es:

- a) TORCH
- b) Atresia lagrimal
- c) Pseudotumor orbitario
- d) Retinoblastoma
- e) Glaucoma congénito

19) Respecto a la sinusitis crónica es cierto que:

- a) El germen más habitualmente aislado es el estafilococo aureo
- b) La imagen de elección para iniciar su estudio es la radiografía de cavidades paranasales
- c) Habitualmente se acompaña de obstrucción del meato medio
- d) El tratamiento de elección es la amoxicilina
- e) Se define como aquella sinusitis que dura más de 2 semanas

20) Un lactante de 3 meses presenta desde hace un mes una lesión roja en el labio superior que ha ido creciendo rápidamente hasta ser de 2 cm, solevantada, de color rojo intenso, sin signos inflamatorios.

El diagnóstico más probable es:

- a) Nevus flameus
- b) Mancha salmón
- c) Hemangioma
- d) Malformación vascular
- e) Hemangiosarcoma

Prueba 6

1) Una mujer de 26 años consulta por aparición de lesiones cutáneas en las rodillas. Al examen se aprecian algunas placas eritematosas de hasta 3 cm de diámetro, con descamación de la piel sobre ambas rótulas. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen simple
- b) Dermatitis de contacto
- c) Dermatitis atópica
- d) Psoriasis
- e) Liquen plano

2) Una paciente de 34 años, hospitalizada por una neumonía adquirida en la comunidad, en tratamiento con ceftriaxona, comienza con un cuadro de fiebre y aparición de lesiones cutáneas, que inician como pequeñas máculas, que luego evolucionan a placas eritematosas, con algunas vesículas, que se extienden por el tronco, cabeza y extremidades. Además presenta gran compromiso de los labios y la boca y también de los ojos. El signo de Nicolski es negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Pénfigo
- b) Penfigoide
- c) Necrosis epidérmotóxica
- d) Síndrome de Steven Johnson
- e) Eritema multiforme menor

3) Una mujer de 67 años presenta lesiones ásperas e hiperqueratósicas, de hasta 4 mm de diámetro en el dorso de las manos y en la zona frontal. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer basocelular
- b) Queratosis seborreicas
- c) Dermatitis seborreica
- d) Queratosis actínicas
- e) Lentigos solares

4) Un paciente presenta eritema y descamación en la zona interiliar y sobre el puente nasal, con lesiones similares en el cuero cabelludo. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis vulgar
- b) Psoriasis gutatta
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Dermatitis de contacto irritativa
- e) Dermatitis seborreica

5) Una mujer de 45 años, con antecedente de rinitis alérgica y asma, presenta desde hace varias semanas, lesiones redondeadas en los brazos y antebrazos, de hasta 3 cm diámetro, con costras en su superficie, que son levemente pruriginosas. El diagnóstico más probable es:

- a) Eccema numular
- b) Psoriasis
- c) Pitiriasis rosada
- d) Micosis fungoide
- e) Liquen plano

6) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un melanoma de extensión superficial, de 1 cm de diámetro, con índice de Breslow de 3 mm?

- a) Realizar biopsia de ganglio centinela y ampliar los márgenes en 2 cm
- b) Ampliar los márgenes en 1 cm
- c) Iniciar inmunoterapia
- d) Iniciar radioterapia generalizada
- e) Iniciar quimioterapia

7) ¿Cuál es la medida más importante para evitar la progresión de la rosácea?

- a) Evitar el consumo de alcohol
- b) Evitar el tabaco
- c) Evitar la exposición solar
- d) Utilizar inmunomoduladores tópicos
- e) Mantener la piel humectada

8) Los efectos adversos de la permetrina durante el embarazo, aún no están totalmente esclarecidos, aunque pareciera ser un medicamento seguro para el embarazo y la lactancia. Por eso el tratamiento de elección de la sarna durante el embarazo aún es:

- a) Lindano
- b) Ivermectina
- c) Vaselina azufrada
- d) Crotamitón
- e) Insecticidas piretroides

9) Una paciente presenta eritema y pápulas faciales, asociadas a blefaritis y chalaziones a repetición. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Lupus sistémico
- c) Rosácea
- d) Demodectidiosis
- e) Dermatitis atópica

10) Un niño de 4 años de edad presenta, desde el nacimiento, cerca de 10 máculas levemente hiperpigmentadas, de cerca de 3 cm de diámetro, ubicadas en el tronco y en las zonas proximales de las extremidades, que no presentan dolor ni prurito. Presenta un mayor riesgo de desarrollar:

- a) Melanoma
- b) Cáncer espinocelular
- c) Pénfigo
- d) Tumores del sistema nervioso
- e) Infertilidad

11) Una paciente de 30 años consulta por una lesión de larga data, muy pruriginosa, en el tobillo izquierdo. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa de cerca de 8 cm de diámetro, con algunas pápulas y costras en su superficie, con aumento del dibujo cutáneo, signos de grataje y leve descamación. El diagnóstico más probable es:

- a) Psoriasis
- b) Dermatitis de contacto alérgica crónica
- c) Liquen plano
- d) Liquen simple crónico
- e) Lipodermatoesclerosis

12) ¿Cuál de los siguientes hallazgos es NORMAL?

- a) Glositis romboidal media
- b) Vesículas en el paladar blando
- c) Leucoplaquia
- d) Úlceras orales no dolorosas
- e) Macroglosia

13) Una paciente de 30 años consulta por una lesión cutánea hiperpigmentada en la pierna derecha, de 8 mm de diámetro, que ha crecido lentamente desde hace 2 años. Presenta color heterogéneo y bordes irregulares. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Aplicar corticoides tópicos
- c) Derivar a dermatólogo para eventual resección
- d) Indicar uso de crema humectante
- e) Evitar la exposición solar de la lesión

14) Una paciente de 12 años presenta una lesión solevantada en el segundo dedo de la mano izquierda, de larga evolución de color rojo, de 0,7 cm de diámetro, que se ulcera fácilmente y sangra. Al examen se aprecia húmedo, con eritema y descamación de la piel circundante. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma acral
- b) Verruga
- c) Punto rubí
- d) Granuloma piógeno
- e) Dishidrosis

15) Un paciente de 70 años, fumador, presenta una placa eritematosa indolora en la mucosa yugal, de lento crecimiento, a lo largo de 5 años, con 2x3 cm de diámetro. Al examen es imposible removerla. La conducta más adecuada es:

- a) Aplicar corticoides tópicos
- b) Realizar biopsia de la lesión
- c) Aplicar antimicóticos tópicos
- d) Indicar antimicóticos orales
- e) Observar evolución

16) Las vesículas localizadas, que se rompen fácilmente al tocarlas, son características de:

- a) Impétigo buloso
- b) Quemaduras solares
- c) Prúrigo
- d) Penfigoide
- e) Herpes zóster

17) Una mujer consulta por lesiones pruriginosas y liquenificadas en ambas orejas, de larga data. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen plano
- b) Liquen simple
- c) Dermatitis atópica
- d) Dermatitis de contacto alérgica
- e) Urticaria

18) El tratamiento de la urticaria crónica suele ser:

- a) Corticoides tópicos
- b) Corticoides orales
- c) Adrenalina intramuscular SOS
- d) Antihistamínicos orales
- e) Salmeterol inhalado

19) Un paciente presenta caída del cabello en la zona parietal derecha, en un área de cerca de 5 cm de diámetro. Al examen físico se aprecia dicha zona, sin ningún cabello, ni signos inflamatorios del cuero cabelludo. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña capitis
- b) Pitiriasis alba
- c) Dermatitis seborreica
- d) Alopecia areata
- e) Granuloma anular

20) Un adolescente de 17 años consulta por lesiones maculares hipopigmentadas en la espalda, que no presentan otros síntomas. Al examen físico presenta ligera descamación al raspado. El diagnóstico más probable es:

- a) Vitiligo
- b) Pitiriasis versicolor
- c) Psoriasis guttata
- d) Pitiriasis rosada
- e) Psoriasis vulgar

Prueba 7

1) Una mujer de 40 años consulta por aparición de lesiones cutáneas en la espalda, en las piernas y en los codos. Al examen se aprecian algunas placas eritematosas de hasta 3 cm de diámetro, con descamación gruesa. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen simple
- b) Dermatitis de contacto
- c) Dermatitis atópica
- d) Psoriasis
- e) Liquen plano

2) Una paciente de 34 años, hospitalizada por una neumonía adquirida en la comunidad, en tratamiento con ceftriaxona, presenta aparición de placas eritematosas en tiro al blanco en el tronco y la zona proximal de las extremidades, de hasta 5 cm de diámetro. El signo de Nicolski es negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de Sweet
- b) Penfigoide
- c) Necrosis epidérmica tóxica
- d) Síndrome de Steven Johnson
- e) Eritema multiforme menor

3) Una mujer de 67 años presenta lesiones maculares hiperpigmentadas, de color homogéneo y bordes regulares, de hasta 4 mm de diámetro en el dorso de las manos y en la zona frontal. El diagnóstico más probable es:

- a) Nevos melanocíticos
- b) Queratosis seborreicas
- c) Léntigos malignos
- d) Queratosis actínicas
- e) Lentigos solares

4) Un paciente de 45 años, dueña de casa, consulta por lesiones en ambas manos, consistentes en placas eritematosas, hiperqueratósicas en los dedos en las palmas de ambas manos, asociadas a grietas, que en ocasiones presentan prurito y dolor. El diagnóstico más probable es:

- a) Eccema dishidrotico
- b) Tiña
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Dermatitis de contacto irritativa
- e) Esclerodermia

5) Una mujer de 40 años consulta por lesiones cutáneas, que iniciaron hace 12 años como maculas hiperpigmentadas en las piernas y que han ido creciendo lentamente. En los últimos años han comenzado a presentar relieve, transformándose en placas de hasta 6 cm de diámetro con bordes más elevados y aparición de algunas lesiones similares de menor tamaño en las piernas y también en el tronco. No presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Eccema numular
- b) Psoriasis
- c) Liquen simple
- d) Micosis fungoide
- e) Liquen plano

6) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un melanoma de extensión superficial, de 6 mm de diámetro, con índice de Breslow de 0,5 mm?

- a) Realizar biopsia de ganglio centinela y ampliar los márgenes en 2 cm
- b) Ampliar los márgenes en 1 cm
- c) Iniciar inmunoterapia
- d) Iniciar radioterapia generalizada
- e) Iniciar quimioterapia

7) ¿Cuál es la medida más importante para evitar la progresión de la rosácea?

- a) Evitar el consumo de alcohol
- b) Evitar el tabaco
- c) Evitar la exposición solar
- d) Utilizar inmunomoduladores tópicos
- e) Mantener la piel humectada

8) El tratamiento de elección de la sarna en los escolares es:

- a) Lindano
- b) Ivermectina
- c) Vaselina azufrada
- d) Crodamitón
- e) Permetrina

9) Una paciente presenta pápulas faciales, asociadas a “nariz de frutilla”. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Lupus sistémico
- c) Rosácea
- d) Demodicidiosis
- e) Dermatitis atópica

10) Un niño de 4 años de edad presenta, desde el nacimiento, una mácula hiperpigmentada, de color azulado en el hombro izquierdo, de 10 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma
- b) Nevo congénito gigante
- c) Nevo de Ito
- d) Nevo de Ota
- e) Nevo de Sutton

11) Una paciente de 30 años consulta por una lesión de larga data, muy pruriginosa, en la zona posterior del cuello. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa de cerca de 8 cm de diámetro, con algunas pápulas y costras en su superficie, con aumento del dibujo cutáneo, signos de grataje y leve descamación. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar biopsia de la lesión
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Iniciar antibióticos orales
- d) Iniciar corticoides tópicos y prohibir el rasquido de la lesión
- e) Iniciar PUVA-terapia

12) ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO es normal?

- a) Lengua geográfica
- b) Lengua vellosa negra
- c) Lengua fisurada
- d) Glositis romboidal media
- e) Eritroplaquia

13) Una paciente de 30 años consulta por una lesión cutánea hiperpigmentada en el primer ortojo izquierdo, que ha crecido lentamente en los últimos 3 años, alcanzando un diámetro de 1,5 cm actualmente y que se ha ulcerado en 2 oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Granuloma piógeno
- b) Melanoma acral
- c) Queratosis seborreica
- d) Carcinoma espinocelular
- e) Enfermedad de Bowen

14) Una paciente de 17 años consulta por aparición de múltiples placas eritematosas descamativas de 5 a 10 mm de diámetro, indoloras, que iniciaron hace una semana y que se extienden por la cara, tronco y extremidades, respetando sólo las palmas y las plantas. Refiere haber presentado una amigdalitis algunas semanas atrás. El diagnóstico más probable es:

- a) Pitiriasis rosada
- b) Psoriasis gutatta
- c) Sífilis secundaria
- d) Lupus cutáneo subagudo
- e) Púrpura de Shoenlein Henoch

15) Un paciente de 70 años, fumador, presenta una placa blanquecina indolora en la cara lateral de la lengua, de lento crecimiento, a lo largo de 5 años, con 2x3 cm de diámetro. Al examen es imposible removerla. La conducta más adecuada es:

- a) Aplicar corticoides tópicos
- b) Realizar biopsia de la lesión
- c) Aplicar antimicóticos tópicos
- d) Indicar antimicóticos orales
- e) Observar evolución

16) Las vesículas y bulas generalizadas, tensas, difíciles de romper, son características de:

- a) Impétigo buloso
- b) Síndrome de piel escaldada
- c) Prúrigo
- d) Penfigoide
- e) Necrosis epidermotóxica

17) Una mujer consulta por lesiones pruriginosas en ambas fosas cubitales, de larga data. Al examen físico se aprecian pápulas en las zonas descritas, asociadas a queratosis pilar en ambos brazos. El diagnóstico más probable es:

- a) Liquen plano
- b) Liquen simple
- c) Dermatitis atópica
- d) Dermatitis de contacto alérgica
- e) Urticaria

18) El tratamiento de la urticaria crónica suele ser:

- a) Corticoides tópicos
- b) Corticoides orales
- c) Adrenalina intramuscular SOS
- d) Antihistamínicos orales
- e) Salmeterol inhalado

19) Un paciente presenta caída del cabello en la zona parietal derecha, en un área de cerca de 5 cm de diámetro. Al examen físico se aprecia dicha zona, con escaso eritema y descamación y presencia de algunos cabellos quebrados y cortos. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña capitis
- b) Pitiriasis alba
- c) Dermatitis seborreica
- d) Alopecia areata
- e) Granuloma anular

20) Un adolescente de 17 años consulta por lesiones maculares hipopigmentadas en la espalda, que no presentan otros síntomas. Al examen físico presenta ligera descamación al raspado. La etiología más probable es:

- a) Por autoinmunidad tipo 2 (mediada por anticuerpos)
- b) Fúngica
- c) Por autoinmunidad tipo 3 (mediada por complejos inmune)
- d) Bacteriana
- e) Por autoinmunidad tipo 4 (mediada por linfocitos T)

Prueba 8

1) ¿Cuál de las siguientes lesiones tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer?

- a) Queratosis seborreica
- b) Nevo congénito gigante
- c) Nevus flameus
- d) Granuloma piógeno
- e) Nevo sebáceo de Jadassohn

2) Un paciente de 59 años, agricultor, presenta lesiones cutáneas ásperas, de hasta 4 mm de diámetro, localizadas en el dorso de ambas manos, en la frente y la nariz, que han crecido lentamente a lo largo de años y que no presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis seborreica
- b) Léntigos solares
- c) Carcinomas basocelulares
- d) Queratosis actínicas
- e) Rosácea

3) Una paciente obesa, de 55 años, consulta por lesiones maculares hipopigmentadas en el pecho, especialmente en la región intermamaria, que no presentan otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

- a) Pitiriasis rosada
- b) Vitiligo
- c) Pitiriasis versicolor
- d) Nevo de Sutton
- e) Tiña corporis

4) Un paciente presenta placas eritematosas en ambas extremidades inferiores, descamativas, no dolorosas ni pruriginosas, asociadas a lesiones ungueales como pequeños hundimientos. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña
- b) Psoriasis
- c) Dermatomiositis
- d) Liquen plano
- e) Dermatitis de contacto

5) Un paciente de 60 años presenta una lesión en la mucosa yugal, caracterizada por una placa de 3 cm de diámetro, adherente, indolora, que ha crecido lentamente en los últimos dos años. El diagnóstico más probable es:

- a) Línea alba
- b) Liquen plano
- c) Leucoplaquia
- d) Candidiasis oral
- e) Penfigoide

6) Un paciente de 67 años presenta una lesión facial oscura de lento crecimiento, a lo largo de años, caracterizada por una mácula hiperpigmentada de color heterogéneo y bordes irregulares, que actualmente presenta 2 cm de diámetro mayor. El diagnóstico más probable es:

- a) Melanoma lentigo maligno
- b) Carcinoma basocelular
- c) Melanoma acral
- d) Nevo melanocítico
- e) Queratosis seborreica

7) Un hombre de 20 años presenta lesiones papulares y pustulares en la cara, pecho y espalda, asociadas a comedones. El diagnóstico más probable es:

- a) Acné
- b) Rosácea
- c) Dermatitis atópica
- d) Varicela
- e) Prurigo

8) ¿Qué examen es útil para la confirmación diagnóstica de la dermatitis de contacto alérgica?

- a) Biopsia cutánea
- b) Prick test
- c) Test de parche
- d) Prueba de respuesta a corticoides
- e) Niveles plasmáticos de IgE específica

9) Un niño de un año presenta una mácula eritematosa congénita, que compromete la mejilla izquierda, la zona periocular izquierda y la mitad izquierda de la frente. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemangioma
- b) Nevo de Ito
- c) Nevo de Ota
- d) Nevus flammeus
- e) Mancha salmón

10) Respecto a la tiña capitis es VERDADERO que:

- a) Es causada por el hongo Pityrosporum ovale
- b) Su tratamiento suele ser la terbinafina tópica
- c) Suele presentarse en la edad pediátrica
- d) Habitualmente no presenta ningún signo inflamatorio en el cuero cabelludo
- e) Clínicamente es indistinguible de la alopecia areata

11) Un paciente de 16 años presenta lesiones papulares en los antebrazos y las fosas cubitales, que en ocasiones son pruriginosas. Al examen físico se aprecia queratosis pilar en ambos brazos y una lesión macular hipopigmentada, descamativa y de bordes difusos en la cara. El diagnóstico más probable es:

- a) Pityriasis versicolor
- b) Infección por el virus papiloma humano
- c) Liquen plano
- d) Dermatitis atópica
- e) Dermatitis herpetiforme

12) Las pseudopápulas son características de:

- a) Penfigoide
- b) Eritema multiforme menor
- c) Urticaria
- d) Liquen plano
- e) Dermatitis de contacto

13) Un paciente consulta por aparición de varias vesículas pruriginosas y tensas en la cara lateral del pulgar y en la palma de la mano derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Prurigo
- b) Impétigo buloso
- c) Pénfigo
- d) Pénfigoide
- e) Pónfolix

14) Un hombre de 50 años presenta fiebre de 24 horas de evolución y aparición de una placa inflamatoria, dolorosa y eritematosa en la pierna izquierda, de 15 cm de diámetro mayor, ligeramente dolorosa a la palpación y con bordes difusos. El tratamiento de elección es:

- a) Penicilina
- b) Cloxacilina
- c) Gentamicina
- d) Ciprofloxacino
- e) Vancomicina

15) Una paciente presenta lesiones eritematosas descamativas generalizadas, con compromiso de las palmas y plantas, asociadas a fiebre. Su esposo presenta lesiones similares. El diagnóstico más probable es:

- a) Pitiriasis rosada de Gibert
- b) Psoriasis guttata
- c) Sífilis
- d) Liquen simple
- e) Pitiriasis versicolor

16) Una mujer consulta por eritema facial, que compromete el dorso de la nariz y ambas zonas malares, respetando el surco nasolabial. No presenta otras lesiones y refiere astenia. El diagnóstico más probable es:

- a) Rosácea
- b) Dermatomiositis
- c) Lupus
- d) Nevus flammeus
- e) Erisipela

17) Respecto al eritema multiforme menor es FALSO que:

- a) Se debe en primer lugar a infecciones herpéticas
- b) Se caracteriza por lesiones en “tiro al blanco”
- c) Suele ser autolimitado
- d) El signo de Nikolski suele estar positivo
- e) La afectación de mucosas es poco frecuente

18) Un paciente de 60 años presenta una lesión solevantada en el ala nasal, de 6 mm de diámetro, con una ulceración central y una telangiectasia adyacente. El diagnóstico más probable es:

- a) Granuloma telangiectásico
- b) Carcinoma espinocelular
- c) Queratosis actínica
- d) Rosácea fimatosa
- e) Carcinoma basocelular

19) Un paciente de 30 años consulta por aparición de una lesión de un día de evolución caracterizada por una placa de 6 cm de diámetro, ubicada en la pierna derecha, dolorosa, bien delimitada, eritematosa, que en su centro se ha vuelto violácea, con zonas negruzcas. El diagnóstico más probable es:

- a) Eritema multiforme
- b) Ectima gangrenoso
- c) Eritema nodoso
- d) Loxocelismo cutáneo
- e) Pioderma gangrenoso

20) El tratamiento de elección de la sarna es:

- a) Vaselina azufrada
- b) Lindano
- c) Permetrina
- d) Ivermectiva
- e) Crotamitón

DERMATOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	8 D	16 D	2 C	10 D	18 D
1 C	9 D	17 E	3 C	11 D	19 A
2 B	10 B	18 B	4 E	12 A	20 B
3 E	11 C	19 C	5 C	13 C	
4 D	12 D	20 D	6 E	14 D	Prueba 8
5 A	13 B		7 B	15 B	1 B
6 A	14 E	Prueba 4	8 C	16 A	2 D
7 A	15 C	1 C	9 C	17 D	3 C
8 E	16 C	2 A	10 D	18 D	4 B
9 E	17 B	3 A	11 A	19 D	5 C
10 A	18 D	4 E	12 A	20 B	6 A
11 C	19 C	5 C	13 D		7 A
12 A	20 B	6 C	14 B	Prueba 7	8 C
13 B		7 A	15 B	1 D	9 D
14 D	Prueba 3	8 C	16 C	2 E	10 C
15 B	1 B	9 C	17 A	3 E	11 D
16 E	2 A	10 B	18 E	4 C	12 C
17 B	3 D	11 B	19 C	5 D	13 E
18 A	4 C	12 B	20 C	6 B	14 B
19 D	5 B	13 B		7 C	15 C
20 D	6 D	14 A	Prueba 6	8 E	16 C
	7 E	15 B	1 D	9 C	17 D
Prueba 2	8 A	16 B	2 D	10 C	18 E
1 E	9 E	17 C	3 D	11 D	19 D
2 D	10 D	18 A	4 E	12 E	20 C
3 C	11 D	19 B	5 A	13 B	
4 C	12 C	20 C	6 A	14 B	
5 B	13 B		7 C	15 B	
6 E	14 A	Prueba 5	8 C	16 D	
7 C	15 B	1 C	9 C	17 C	

V) OTORRINOLARINGOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Niño de 3 años, ha presentado 3 episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses. Consulta por nuevo episodio de otalgia y otorrea escasa a derecha. A la otoscopia se observa tímpano derecho eritematoso y abombado, con salida de pus. El tratamiento antibiótico para este nuevo episodio de otitis media aguda es:

- a) Amoxicilina
- b) Cefadroxilo
- c) Amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Azitromicina
- e) Ciprofloxacino

2) Paciente hombre de 75 años, sufre accidente vascular encefálico, secundario a embolia cardíaca por fibrilación auricular. Al segundo día de evolución, se encuentra en buenas condiciones, con hemiparesia braquial moderada a derecha. Se reinicia alimentación, produciéndose tos inmediatamente después de tagar. La conducta más adecuada es:

- a) Reiniciar alimentación exclusivamente con líquidos
- b) Derivar a cirujano para construcción de gastrostomía
- c) Indicar régimen cero y solicitar videodeglución
- d) Indicar nutrición parenteral total
- e) Instalar sonda nasoyeyunal e iniciar alimentación enteral con bomba de infusión continua

3) Hombre de 33 años, diagnosticado de neurinoma del acústico derecho, con compromiso de la audición de dicho oído. ¿Cómo espera encontrar las pruebas con diapazones, es este paciente?:

- a) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- b) Rinne (+) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- c) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- d) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- e) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda

4) Un niño de 6 años, consulta por rinorrea seromucosa de 2 meses de evolución, asociados a obstrucción nasal. Refiere además estornudos frecuentes. Al examen físico sólo destaca mucosa nasal pálida. El diagnóstico más probable es:

- a) Rinitis alérgica
- b) Rinosinusitis crónica
- c) Poliposis nasal
- d) Hipertrofia adenoidea
- e) Rinitis vasomotora

5) Paciente de 55 años, consulta por cuadro de vértigo intenso, de instalación progresiva en 24 horas, asociado a vómitos. Previo al vértigo presentó sensación de oído tapado y tinnitus a derecha, síntomas que persisten. Refiere haber presentado 3 cuadros similares en los últimos 5 años. El examen físico muestra nistagmo con fase rápida a izquierda y lateropulsiones a derecha, sin adiadococinesia ni dismetría. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Infarto de tronco cerebral
- c) Enfermedad de Meniere
- d) Tumor cerebeloso
- e) Neuronitis vestibular

6) Un paciente sufre trauma nasal, resultando con un hematoma en el tabique nasal. El tratamiento más adecuado es:

- a) Realizar incisión y drenaje completo del hematoma, dejando con un apósito compresivo e iniciar antibióticos sistémicos y analgésicos
- b) Realizar punción y aspiración del hematoma, dejando con analgesia oral
- c) Iniciar analgesia oral y reevaluar en 24 horas
- d) Realizar taponamiento nasal bilateral, asociado a antibióticos y analgésicos
- e) Realizar septoplastia entre 7 y 14 días luego del trauma

7) Paciente sin antecedentes mórbidos, consulta en un hospital rural por fiebre, odinofagia, voz empastada, trismus. Al examen presenta abombamiento del pilar faríngeo anterior derecho y adenopatías cervicales ipsilaterales. El agente etiológico más frecuentemente aislado, en esta patología, es:

- a) Neumococo
- b) Anaerobios
- c) Estreptococo beta hemolítico, grupo A
- d) Virus Epstein Barr
- e) Estafilococo áureo

8) Paciente de 44 años, consulta por sensación de presión facial, rinorrea purulenta, descarga posterior, obstrucción nasal e hiposmia, de 2 meses de evolución, de intensidad fluctuante. Al examen físico destaca visualización de descarga posterior y dolor a la percusión maxilar bilateral. El examen radiológico y el tratamiento antibiótico más adecuados, para el manejo de esta patología, son respectivamente:

- a) TAC de cavidades perinasales y amoxicilina más ácido clavulánico
- b) Radiografía de cavidades perinasales y amoxicilina
- c) Radiografía de cavidades perinasales y clindamicina
- d) TAC de cavidades perinasales y ampicilina
- e) Resonancia magnética de cavidades perinasales y cefuroximo

9) Paciente de 8 años, consulta por otalgia derecha intensa. Refiere haber estado bañándose en su piscina los días previos. A la otoscopia se aprecia conducto auditivo derecho con eritema difuso y secreción seropurulenta. El agente etiológico más probable es:

- a) Pseudomona aureginosa
- b) Streptococcus pneumoniae
- c) Staphylococcus aureus
- d) Streptococcus pyogenes
- e) Anaerobios

10) El factor pronóstico más importante en el cáncer de laringe es:

- a) El tamaño del tumor
- b) El tipo histológico
- c) La presencia de adenopatías cervicales comprometidas
- d) El grado de disfonía y estridor
- e) La persistencia del hábito tabáquico

Preguntas Oftalmología

11) La primera causa de ceguera en Chile es:

- a) Retinopatía diabética
- b) Glaucoma crónico
- c) Catarata
- d) Vicios de refracción
- e) Retinopatía hipertensiva

12) Mujer de 33 años, consulta por ardor ocular y ojo rojo derecho. Al examen físico destaca ojo rojo superficial, con importante compromiso de la conjuntiva tarsal, la que además presenta una reacción folicular. Es posible palpar una adenopatía pequeña preauricular derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis bacteriana aguda
- b) Conjuntivitis viral
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Úlcera corneal
- e) Orzuelo

13) Paciente de 42 años, consulta por dolor ocular derecho intenso, de 2 horas de evolución, asociado a vómitos. Al examen destaca ojo rojo profundo a derecha, con pupila en semimidriasis, que no responde a la iluminación con linterna. El diagnóstico más probable es:

- a) Uveítis aguda
- b) Úlcera corneal
- c) Glaucoma de ángulo estrecho
- d) Trombosis de la arteria central de la retina
- e) Neuritis óptica

14) Paciente de 65 años, consulta por disminución de la agudeza visual de 1 año de evolución, mayor a derecha y que empeora en lugares de mucha luz. No ha presentado dolor, ni otros síntomas. La causa más probable de su cuadro actual es:

- a) Glaucoma de ángulo abierto
- b) Degeneración macular relacionada con la edad
- c) Presbicia
- d) Catarata
- e) Déficit de vitamina A

15) Paciente de 33 años sufre accidente laboral, con entrada de soda cáustica en ojo izquierdo. El manejo inicial de este paciente es:

- a) Aplicar ácido débil en ojo izquierdo
- b) Retirar soda cáustica del ojo, con un paño seco
- c) Realizar lavado ocular con agua a chorro, por 30 minutos
- d) Aplicar ungüento antibiótico y realizar sello ocular con gasa
- e) Aplicar sello ocular y derivar a oftalmólogo de manera urgente

16) Paciente de 35 años, consulta por dolor y disminución de la agudeza visual izquierda. Al examen se aprecia ojo rojo izquierdo, de tipo profundo, asociado a miosis y disminución del tono ocular ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Síndrome de Claude Bernard Horner
- c) Parálisis del tercer nervio craneal izquierdo
- d) Uveítis aguda
- e) Infección intraocular (endoftalmitis)

17) Lactante de 4 meses de edad presenta estrabismo divergente, fluctuante. En algunas ocasiones fija la mirada con ambos ojos en el mismo punto y en otras se aprecia leve estrabismo por desplazamiento a lateral del ojo derecho. El rojo pupilar es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Derivar a oftalmología para corrección quirúrgica
- b) Derivar a oftalmología para iniciar sello ocular alternado y evitar ambliopía
- c) Observar y controlar en 1 mes, sin necesidad de realizar exámenes ni tratamientos
- d) Solicitar potenciales evocados visuales y decidir manejo según resultados
- e) Solicitar resonancia magnética de órbitas y cerebro y decidir manejo según hallazgos

18) Un paciente presenta disminución de la agudeza visual de larga data con los siguientes valores: OD: 10/20 y OI: 15/20. Al repetir la medición a través de un agujero estenopeico se obtienen los siguientes valores: OD: 15/20 y OI: 20/20. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinopatía diabética
- b) Glaucoma de ángulo abierto
- c) Degeneración macular relacionada con la edad
- d) Ambliopía
- e) Vicio de refracción

19) Mujer de 64 años, diabética, que consulta por cuadro de 7 días de visión de luces en zona temporal superior derecha. En algunas ocasiones también ve puntos negros en la misma zona. No presenta otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada con esta paciente es:

- a) Enviar a domicilio y controlar en 3 meses
- b) Derivar a realización de fondo de ojo, de manera urgente
- c) Solicitar resonancia magnética de silla turca
- d) Solicitar hemoglobina glicosilada y mejorar control glicémico
- e) Iniciar midriáticos y corticoides tópicos

20) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una causa de leucocoria en el lactante?

- a) Glaucoma congénito
- b) Catarata congénita
- c) Persistencia del vítreo primario hiperplásico
- d) Retinoblastoma
- e) Retinopatía del prematuro

Prueba 2

1) Un paciente de 34 años sufre una caída en bicicleta, golpeándose la cara. Al examen físico se aprecia deformidad del dorso nasal, con equimosis en la zona periocular y malar derechas. Además se constata la presencia de un hematoma del tabique nasal y se observan restos de sangre en las fosas nasales, sin epistaxis activa. Se solicita radiografía de huesos nasales que demuestran una fractura nasal con ligero desplazamiento. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar analgésicos y antibióticos, y realizar reducción quirúrgica inmediata de la fractura nasal
- b) Administrar analgésicos, realizar punción del hematoma septal y realizar taponamiento nasal anterior
- c) Administrar analgésicos, realizar taponamiento posterior e iniciar antibióticos orales
- d) Administrar analgésicos, drenar completamente el hematoma del tabique nasal, dejando un apósito nasal compresivo e iniciar antibióticos orales de amplio espectro
- e) Administrar analgésicos, reducir la fractura nasal de inmediato y realizar cauterización del tabique anterior

2) Un paciente de 20 años consulta por un cuadro de años de evolución de obstrucción nasal marcada, estornudos, escasa rinorrea serosa, asociada a estornudos frecuentes y prurito nasal. Los síntomas suelen ser mucho más frecuentes durante los meses de primavera y tienden a ceder durante los meses de otoño e invierno. Al examen físico sólo destaca palidez de la mucosa nasal. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada, son respectivamente:

- a) Rinitis alérgica y solicitar test cutáneo para alérgenos respiratorios
- b) Rinitis alérgica e iniciar antihistamínicos orales, solicitando IgE específica plasmática
- c) Rinitis alérgica e iniciar corticoides tópicos nasales
- d) Rinitis vasomotora y solicitar rinomanometría
- e) Rinitis vasomotora e iniciar vasoconstrictores

3) El síntoma de presentación más frecuente del cáncer glótico es:

- a) Disnea
- b) Tos
- c) Disfonía
- d) Expectoración hemoptoica
- e) Masa cervical

4) Un paciente de 58 años, fumadora, consulta por disfonía de 2 meses de evolución. No ha presentado otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía cervical
- b) Solicitar nasofibroscopía
- c) Solicitar TAC de cabeza y cuello e iniciar salbutamol inhalado
- d) Suspender el tabaco, solicitar TSH e iniciar AINEs y omeprazol
- e) Indicar suspensión del tabaco e iniciar terapia fonoaudiológica

5) Un paciente de 10 años consulta por odinofagia, asociado a coriza y escasa tos seca. Al examen físico se observa faringe eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño. Se visualizan 3 pequeñas vesículas en el paladar blando y se palpan varias adenopatías cervicales. El agente etiológico más probable es:

- a) Virus
- b) Neumococo
- c) Estreptococo betahemolítico, grupo A
- d) Moraxella catarralis
- e) Bacterias anaerobias

6) Un paciente de 56 años presenta sordera súbita en el oído derecho, manteniendo algún grado de audición en dicho oído y sin afectación del oído izquierdo. ¿Cómo espera encontrar los test de diapasones?

- a) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- b) Rinne (+) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- c) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- d) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- e) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda

7) Un niño de 4 años ingiere una moneda accidentalmente, evoluciona con dolor cervical y sialorrea importante. Se solicita una radiografía de cuello y tórax que demuestra presencia de la moneda a la altura del esófago. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, indicando revisión periódica de las heces del niño, sin necesidad de realizar mayor estudio
- b) Controlar nueva radiografía de cuello, tórax y abdomen en 24 horas
- c) Retirar la moneda por vía endoscópica, de inmediato
- d) Derivar al policlínico de cirugía
- e) Derivar a cirugía para resolución quirúrgica inmediata

8) Un hombre de 65 años, diabético, hipertenso, fumador y dislipidémico, consulta por obstrucción nasal derecha, de 6 meses de evolución, asociado a rinorrea serosanguinolenta. Al examen físico no se aprecian mayores alteraciones. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Rinitis alérgica
- b) Rinitis vasomotora
- c) Pólipos nasales
- d) Rinofibroangima
- e) Cáncer de nariz

9) Un paciente de 65 años, consulta por vértigo, asociado a vómitos y dificultades para caminar, ya que se cae hacia la derecha. No presenta síntomas auditivos. Al examen físico se aprecia nistagmo horizontal hacia izquierda y lateropulsiones a derecha. No presenta adiadococinesia ni dismetría. Los síntomas se instalaron relativamente rápida y perduraron cerca de 3 semanas, disminuyendo progresivamente hasta desaparecer. Respondían parcialmente al tratamiento con conarizina oral. El diagnóstico más probable es:

- a) AVE cerebeloso
- b) Vértigo postural paroxístico benigno
- c) Neurinoma del acústico
- d) Parálisis vestibular
- e) Enfermedad de Meniere

10) Una paciente de 24 años consulta por un cuadro de 12 días de evolución, que inició con tos y odinofagia, las que estuvieron presentes por 3 días, cediendo luego. Sin embargo evoluciona con sensación de descarga posterior, hiposmia, obstrucción nasal, mayor a izquierda, cefalea, sensación de presión facial y rinorrea purulenta. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antihistamínicos orales y corticoides tópicos
- b) Solicitar TAC de cavidades paranasales y decidir según hallazgos
- c) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico, asociada a AINEs
- d) Iniciar cefadroxilo, asociada a AINEs
- e) Iniciar amoxicilina oral, asociada a AINEs

11) Un paciente de 34 años, trabajador de la construcción, recibe golpe con una tabla en el ojo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes alteraciones supone una MENOR gravedad?

- a) Hifema
- b) Hemorragia subconjuntival
- c) Disminución de la agudeza visual
- d) Hipotonía del globo ocular
- e) Alteración del reflejo fotomotor

12) ¿Cuál de las siguientes asociaciones, entre patología y presentación clínica, es INCORRECTA?

- a) Escleritis – Ojo rojo profundo, con hipopión y pérdida del reflejo de acomodación
- b) Glaucoma agudo – Ojo rojo profundo, doloroso, con midriasis que no responde a la luz
- c) Uveítis aguda – Ojo rojo profundo, con miosis e hipotonía ocular
- d) Queratitis – Ojo rojo profundo, asociado a fotofobia y blefarospasmo
- e) Queratitis herpética – Ojo rojo profundo, con ulceración dendrítica en la córnea

13) El estrabismo de los niños debe ser tratado a tiempo, ya que en caso contrario se complica con:

- a) Mioipía
- b) Hemianopsia
- c) Diplopía
- d) Glaucoma
- e) Ambliopía

14) Un paciente de 45 años, hipertenso, consulta por cuadro de 3 días de evolución de visión de luces y puntos negros en el campo temporal superior derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Coriorretinitis
- c) Trombosis venosa retiniana
- d) Glaucoma
- e) Accidente vascular encefálico

15) Una paciente presenta ojo rojo bilateral, asociada a ardor, reacción tarsal folicular y presencia de una adenopatía preauricular derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Queratitis aguda
- e) Glaucoma agudo

16) Un paciente de 40 años presenta pérdida marcada de la agudeza visual del ojo izquierdo, asociada a ligero dolor del mismo ojo. Al examen se aprecian pupilas isocóricas, que se contraen normalmente al iluminar el ojo derecho, pero que vuelven a su posición dilatada, al iluminar el ojo izquierdo. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Pupila de Addie
- b) Lesión del quiasma óptica
- c) Lesión de la cintilla óptica
- d) Lesión del nervio óptico
- e) Accidente vascular encefálico, con compromiso del lóbulo occipital derecho

17) El glaucoma crónico, se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Disminución de la agudeza visual en etapas avanzadas
- b) Afectación del campo visual
- c) Ojo rojo profundo
- d) Aumento de la excavación papilar del nervio óptico
- e) Oculomotilidad normal

18) La causa más frecuente de ceguera en Chile es:

- a) Vicios de refracción
- b) Catarata
- c) Glaucoma
- d) Retinopatía diabética
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

19) Un paciente de 58 años, diabético tipo dos, en tratamiento irregular con glibenclamida y metformina, presenta amaurosis izquierda de rápida instalación, sin dolor ni compromiso de la oculomotilidad. ¿Qué otra alteración esperaría encontrar?

- a) Alteración del rojo pupilar
- b) Alteración del reflejo corneal
- c) Escape pupilar
- d) Alteración del reflejo de acomodación
- e) Ojo rojo

20) Un paciente presenta estrabismo convergente y diplop. Al examen físico se constata mirada a derecha conservada, pero al mirar a la izquierda el ojo derecho lo hace normalmente, mientras que el ojo izquierdo se queda fijo en la línea media. La estructura más probablemente comprometida es:

- a) Tercer nervio craneal izquierdo
- b) Cuarto nervio craneal izquierdo
- c) Sexto nervio craneal izquierdo
- d) Tercer nervio craneal derecho
- e) Fascículo longitudinal medial

Prueba 3

1) Un hombre de 60 años consulta por “visión de luces” y de “puntos negros” en la zona temporal superior del campo visual derecho. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio
- b) Solicitar campimetría ocular
- c) Realizar un fondo de ojo, de manera urgente
- d) Solicitar tonometría ocular
- e) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

2) El tratamiento de elección de la sinusitis bacteriana aguda es:

- a) Amoxicilina
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico
- c) Clindamicina
- d) Cefazolina
- e) Ceftriaxona

3) ¿Cuál de las siguientes opciones representa una MENOR gravedad en contexto de un trauma ocular?

- a) Equimosis del párpado superior
- b) Disminución de la agudeza visual
- c) Discoria
- d) Hifema
- e) Enoftalmo

4) Un paciente de 20 años presenta odinofagia, asociada a fiebre, rinorrea, tos y disfonía. Al examen físico se observa faringe eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño. El agente causal más probable es:

- a) Virus
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Staphylococcus aureus
- d) Bacterias anaerobias
- e) Haemophilus influenzae

5) Un paciente de 70 años ha presentado una lenta caída de la agudeza visual a lo largo de los últimos años, lo que le dificulta la lectura. Además refiere que su visión empeora en ambientes muy iluminados. En base a la patología descrita, ¿qué alteración encontrará con MENOR probabilidad?

- a) Leucocoria
- b) Alteración del rojo pupilar
- c) Defecto pupilar aferente
- d) Oculomotilidad normal
- e) Disminución asimétrica de la agudeza visual

6) ¿Cuál de las siguientes opciones supone una mayor gravedad en una amigdalitis pultácea?

- a) Fiebre
- b) Trismus
- c) Petequias palatinas
- d) Exudado
- e) Úlcera amigdalina

7) El glaucoma agudo se presenta clínicamente como:

- a) Dolor ocular, asociado a ojo rojo profundo y midriasis que no responde a la luz
- b) Disminución súbita de la agudeza visual, sin dolor ocular y midriasis fija
- c) Ojo rojo profundo y doloroso, con miosis que no responde a la luz
- d) Dolor periocular súbito, sin enrojecimiento ocular (ojo blanco) y miosis fija
- e) Dolor ocular, asociado a ojo rojo profundo y efecto Tyndall en la cámara anterior, sin compromiso pupilar

8) Una paciente de 45 años presenta una hipoacusia progresiva de 5 años de evolución, mayor al lado izquierdo. Su madre presentó un cuadro similar. La otoscopia es normal y se solicita una audiometría que es compatible con una hipoacusia de conducción. El diagnóstico más probable es:

- a) Otitis media crónica
- b) Presbiacusia
- c) Otoesclerosis
- d) Neurinoma del acústico
- e) Colesteatoma

9) Un paciente de 67 años acude a control oftalmológico de rutina, detectándose defectos asimétricos en el campo visual. El fondo de ojo revela aumento del tamaño de la excavación de la papila del nervio óptico en ambos ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Coriorretinitis
- c) Degeneración macular relacionada con la edad
- d) Glaucoma crónico
- e) Retinopatía hipertensiva

10) El síntoma más frecuente de la otitis media con efusión es:

- a) Hipoacusia
- b) Otagia
- c) Otorrea
- d) Fiebre
- e) Vértigo

11) Una paciente presenta ojo rojo derecho, asociada a abundante secreción purulenta y escaso ardor, sin reacción tarsal. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis alérgica
- d) Queratitis aguda
- e) Glaucoma agudo

12) Un paciente de 50 años, diabético y fumador, presenta disfonía desde hace 8 meses, la que ha ido en aumento. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar nasofibroscopia
- b) Derivar a terapia fonoaudiológica
- c) Solicitar radiografía de cuello
- d) Solicitar radiografía de tórax
- e) Solicitar tomografía axial computada de cuello

13) ¿Qué síntomas produce habitualmente la retinopatía diabética proliferativa que NO ha presentado hemorragias vítreas?

- a) Ninguno
- b) Disminución de la agudeza visual
- c) Entopsias
- d) Escotomas
- e) Dolor ocular

14) ¿Qué alteración es compatible con un vértigo periférico?

- a) Disartria
- b) Ataxia
- c) Nistagmo multidireccional
- d) Prueba calórica alterada
- e) Adiadococinesia

15) Un paciente hipertenso, presenta súbitamente marcada disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo sin otros síntomas. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar campimetría ocular
- b) Solicitar eco-doppler carotídeo
- c) Iniciar antihipertensivos endovenosos
- d) Realizar fondo de ojo
- e) Iniciar heparina endovenosa

16) Un niño de 5 años consulta por rinorrea crónica, asociada a estornudos frecuentes y prurito nasal. Al examen físico se aprecia ojeroso, con mucosa nasal pálida. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertrofia adenoidea
- b) Rinitis isquémica
- c) Rinitis alérgica
- d) Poliposis nasal
- e) Sinusitis crónica

17) Un niño de 3 meses presenta epifora, opacidad corneal e imposibilidad de cerrar bien uno de sus ojos, debido a un aumento del tamaño ocular. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Retinoblastoma
- b) Glaucoma congénito
- c) Persistencia del humor vítreo hiperplásico
- d) Retinopatía del prematuro
- e) Atresia lagrimal

18) el diagnóstico de la otitis media aguda se establece por:

- a) La otoscopía
- b) La impedanciometría
- c) La audiometría
- d) La prueba calórica
- e) La respuesta al tratamiento

19) Una lesión del nervio oculomotor derecho se manifestará en el ojo ipsilateral con las siguientes alteraciones, EXCEPTO:

- a) Midriasis
- b) Imposibilidad de mirar hacia arriba
- c) Imposibilidad de mirar hacia la derecha
- d) Imposibilidad de mirar hacia la izquierda
- e) Ptosis

20) ¿Cómo estarán las pruebas de diapasones, en un paciente con una hipoacusia derecha, secundaria a una enfermedad de Meniere?

- a) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- b) Rinne (+) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- c) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- d) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- e) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda

Prueba 4

1) Una paciente de 6 años presenta eritema de la piel alrededor del ojo izquierdo, compatible con una celulitis periocular. ¿Qué alteración le entregaría una mayor gravedad?

- a) Oftalmoplejia
- b) Fiebre
- c) Rinorrea purulenta
- d) TAC de cavidades paranasales con imagen de pansinusitis
- e) Cultivo positivo para *Streptococcus pneumoniae*

2) Una paciente de 40 años, consulta por vértigo intenso de inicio rápido hace 8 horas, que se ha mantenido constante y se ha asociado a vómitos. No ha presentado síntomas auditivos, ni déficit motor. Al examen físico se aprecia nistagmo a izquierda y lateropulsiones a derecha, con normalidad de la coordinación de los movimientos. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Neuritis vestibular
- c) Enfermedad de Meniere
- d) Vértigo central
- e) Otitis media complicada

3) La asociación de ojo rojo profundo, miosis y disminución de la agudeza visual, debe hacer sospechar:

- a) Queratitis
- b) Uveítis
- c) Glaucoma de ángulo abierto
- d) Glaucoma de ángulo estrecho
- e) Coriorretinitis

4) Una paciente consulta por sensación de oído tapado y otorrea por el oído izquierdo, de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia una perforación timpánica izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de oído
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis media con efusión
- d) Otitis externa localizada
- e) Otitis externa maligna

5) Una paciente de 65 años ha notado algunas dificultades para ver. Al examen físico se aprecia una agudeza visual normal, sin embargo ha perdido gran parte de la visión periférica, manteniendo la visión central. El diagnóstico más probable es:

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Glaucoma crónico
- c) Catarata
- d) Tumor de hipófisis
- e) Edema macular

6) Una paciente de 26 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución de rinorrea acuosa y malestar general, que evolucionó a sensación de presión facial, hiposmia, cefalea que aumenta al agacharse, descarga posterior y rinorrea purulenta abundante. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- b) Iniciar paracetamol y descongestionantes como tratamiento sintomático
- c) Iniciar corticoides intranasales y antihistamínicos orales
- d) Iniciar amoxicilina oral e ibuprofeno
- e) Solicitar nasofibroscopía

7) Un lactante de 2 meses de edad presenta epifora en el ojo izquierdo, asociado a opacidad corneal y bftalmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinoblastoma
- b) Persistencia del vítreo primario hiperplásico
- c) Tracoma
- d) Atresia del conducto lacrimal
- e) Glaucoma congénito

8) Un paciente de 60 años consulta por disfonía de 4 semanas de evolución, que en ocasiones se asocia a tos irritativa. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cuello
- b) Solicitar nasofibroscofia
- c) Iniciar terapia para mejorar la técnica vocal
- d) Indicar corticoides orales y controlar en 5 días
- e) Indicar AINEs y controlar en caso de persistencia de los síntomas

9) La lesión de la cintilla óptica izquierda se traduce clínicamente es:

- a) Hemianopsia heterónima binasal
- b) Hemianopsia heterónima bitemporal
- c) Hemianopsia homónima derecha de alta congruencia
- d) Hemianopsia homónima izquierda de alta congruencia
- e) Hemianopsia homónima derecha de baja congruencia

10) Usted recibe a un niño en la urgencia porque se habría metido una pequeña pelotita de plástico en el oído izquierdo. A la otoscopia se observa el cuerpo extraño de cerca de 6mm de diámetro en el conducto auditivo externo. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Aplicar vaselina líquida y esperar a que salga espontáneamente
- c) Realizar irrigación con chorro de agua tibia
- d) Realizar extracción cuidadosa con pinzas
- e) Derivarlo al otorrinolaringólogo

11) Un paciente presenta ojo rojo, asociado a marcada fotofobia. Al examen físico se aprecia ojo rojo periquerático y blefarospasmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratitis aguda
- b) Uveítis aguda
- c) Escleritis
- d) Epiescleritis
- e) Glaucoma agudo

12) Una paciente presenta hipoacusia derecha que ha aumentado en el último tiempo. La otoscopia no muestra alteraciones por lo que se realizan pruebas de diapasones, que muestran Rinne (+) a izquierda y (-) a derecha y Weber que lateraliza a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Presbiacusia
- b) Otitis media fibroadesiva
- c) Otoesclerosis
- d) Sordera súbita
- e) Trauma acústico

13) Un paciente de 19 años consulta por odinofagia muy intensa, asociada a imposibilidad de abrir la boca. Al examen físico se aprecia eritema faríngeo, con exudado bilateral y abombamiento del pilar amigdalino izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar penicilina benzatina intramuscular y analgésicos orales
- b) Indicar amoxicilina oral
- c) Indicar amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral
- d) Hospitalizar para tratamiento endovenoso con ceftriaxona + clindamicina
- e) Hospitalizar para drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico

14) Identifique la asociación CORRECTA entre la patología y el efecto de mirar a través de un agujero estenoico.

- a) Presbicia – Agudeza visual empeora el mirar a través de un agujero estenoico
- b) Astigmatismo – Agudeza visual mejora el mirar a través de un agujero estenoico
- c) Retinopatía diabética – Agudeza visual mejora el mirar a través de un agujero estenoico
- d) Glaucoma crónico – Agudeza visual empeora el mirar a través de un agujero estenoico
- e) Catarata – Agudeza visual mejora el mirar a través de un agujero estenoico

15) Un paciente diabético de 60 años, consulta por un cuadro de 3 días de visión de luces y puntos negros, al que hoy se le agregó pérdida de una parte importante de la visión del ojo derecho, permaneciendo con visión inferonasal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia vítrea
- b) Edema macular
- c) Degeneración macular relacionada con la edad
- d) Desprendimiento de retina
- e) Glaucoma

16) Un paciente de 16 años consulta por obstrucción nasal importante, que en ocasiones es más intensa que en otras. Además refiere estornudos frecuentes y prurito nasal. Al examen físico se aprecia mucosa nasal pálida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar corticoides tópicos intranasales
- b) Iniciar antihistamínicos orales
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Iniciar descongestionantes tópicos
- e) Solicitar un prick test

17) Un niño de 8 años consulta por ojo rojo izquierdo de dos días de evolución. Refiere que despierta con los ojos pegados. Al examen físico se aprecia conjuntiva tarsal hiperémica, con abundante secreción purulenta. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar aseo ocular, sin necesidad de colirios
- b) Indicar colirio de gentamicina cada 2 horas y ungüento antibiótico durante la noche
- c) Indicar tratamiento sintomático con AINES
- d) Indicar cloxacilina oral
- e) Indicar ciprofloxacino oral

18) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un paciente con una fractura nasal reciente que presenta un hematoma del tabique?

- a) Solicitar TAC de cavidades paranasales y decidir conducta según resultados
- b) Solicitar RMN de cavidades paranasales y decidir conducta según resultados
- c) Controlar en 7 días para evaluar cirugía
- d) Compresión del tabique nasal
- e) Drenaje quirúrgico de inmediato

19) La lesión del cuarto nervio craneal derecho producirá:

- a) Imposibilidad para mirar hacia arriba
- b) Imposibilidad para mirar hacia lateral
- c) Imposibilidad para mirar hacia inferonasal
- d) Miosis
- e) Midriasis

20) Un paciente de 5 años consulta por otalgia derecha intensa, asociada a otorrea. Al examen físico se aprecia eritema difuso del conducto auditivo externo, con secreción purulenta. El tratamiento más adecuado es:

- a) Analgésicos y amoxicilina oral
- b) Analgésicos y ciprofloxacino tópico
- c) Analgésicos y ceftazidima endovenosa
- d) Analgésicos y cloxacilina oral
- e) Analgésicos y penicilina intramuscular

Prueba 5

1) Una paciente de 6 años presenta eritema de la piel alrededor del ojo izquierdo, compatible con una celulitis periocular. ¿Qué alteración le entregaría una MENOR gravedad?

- a) Oftalmoplejia
- b) Proptosis
- c) Disminución de la agudeza visual
- d) TAC de cavidades paranasales con imagen de pansinusitis
- e) Intenso dolor ocular

2) Una paciente de 40 años, consulta por vértigo intenso de inicio rápido hace 8 horas, que se ha mantenido constante y se ha asociado a vómitos. No ha presentado síntomas auditivos, ni déficit motor. Al examen físico se aprecia nistagmo multidireccional. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Neuronitis vestibular
- c) Enfermedad de Meniere
- d) Vértigo central
- e) Otitis media complicada

3) La asociación de ojo rojo profundo, semimidriasis fija, dolor ocular y disminución de la agudeza visual, debe hacer sospechar:

- a) Queratitis
- b) Uveítis
- c) Glaucoma de ángulo abierto
- d) Glaucoma de ángulo estrecho
- e) Coriorretinitis

4) Una paciente consulta por sensación de oído tapado y otorrea por el oído izquierdo, de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia una perforación timpánica izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de oído
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis media con efusión
- d) Otitis externa localizada
- e) Otitis externa maligna

5) Una paciente de 65 años ha notado algunas dificultades para ver. Al examen físico se aprecia una agudeza visual normal, sin embargo ha perdido gran parte de la visión periférica, manteniendo la visión central. El diagnóstico más probable es:

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Glaucoma crónico
- c) Catarata
- d) Tumor de hipófisis
- e) Edema macular

6) Una paciente de 26 años consulta por un cuadro de 10 días de evolución de rinorrea acuosa y malestar general, que evolucionó a sensación de presión facial, hiposmia, cefalea que aumenta al agacharse, descarga posterior y rinorrea purulenta abundante. El tratamiento de elección es:

- a) Sintomático
- b) Quirúrgico
- c) Amoxicilina oral
- d) Amoxicilina + ácido clavulánico oral
- e) Cefadroxilo oral

7) Un lactante de 2 meses de edad presenta leucocoria en el ojo izquierdo, asociado a estrabismo convergente y cierto grado de exoftalmo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Retinoblastoma
- b) Persistencia del vítreo primario hiperplásico
- c) Tracoma
- d) Catarata congénita
- e) Glaucoma congénito

8) Un paciente de 60 años fumadura consulta por disfonía de 4 meses de evolución, que en ocasiones se asocia a tos irritativa. Su voz es de carácter “leñoso” y el examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cuello
- b) Solicitar nasofibroscofia
- c) Iniciar terapia para mejorar la técnica vocal
- d) Indicar corticoides orales y controlar en 5 días
- e) Indicar AINEs y controlar en caso de persistencia de los síntomas

9) La lesión del lóbulo occipital izquierdo se traduce clínicamente es:

- a) Hemianopsia heterónima binasal
- b) Hemianopsia heterónima bitemporal
- c) Hemianopsia homónima derecha de alta congruencia
- d) Hemianopsia homónima izquierda de alta congruencia
- e) Hemianopsia homónima derecha de baja congruencia

10) Usted recibe a un niño en la urgencia porque se habría metido un poroto en la nariz hace 2 días y actualmente presenta inorrea purulenta abundante. A la nasoscopia se observa el cuerpo extraño de cerca de 6mm de diámetro en la fosa nasal izquierda. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Iniciar antibióticos y esperar a que salga espontáneamente
- c) Realizar irrigación con chorro de agua tibia
- d) Realizar extracción cuidadosa con pinzas
- e) Derivarlo al otorrinolaringólogo

11) Un paciente presenta ojo rojo, asociado a marcada fotofobia. Al examen físico se aprecia ojo rojo periquerático y blefarospasmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratitis aguda
- b) Uveítis aguda
- c) Escleritis
- d) Epiescleritis
- e) Glaucoma agudo

12) Una paciente presenta hipoacusia derecha que ha aumentado en el último tiempo. Se realizan pruebas de diapasones, que muestran Rinne (+) a izquierda y (-) a derecha y Weber que lateraliza a derecha. El diagnóstico MENOS probable es:

- a) Presbiacusia
- b) Otitis media fibroadesiva
- c) Otosclerosis
- d) Otitis media con efusión
- e) Colesteatoma

13) Un paciente de 19 años consulta por odinofagia muy intensa, asociada a imposibilidad de abrir la boca. Al examen físico se aprecia eritema faríngeo, con exudado bilateral y abombamiento del pilar amigdalino izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Amigdalitis ulceronecrótica
- b) Angina de Ludwig
- c) Absceso retrofaríngeo
- d) Absceso periamigdalino
- e) Absceso parafaríngeo

14) Identifique la asociación CORRECTA entre la patología y el efecto de mirar a través de un agujero estenopeico.

- a) Hipermetropía – Agudeza visual mejora el mirar a través de un agujero estenopeico
- b) Astigmatismo – Agudeza visual empeora el mirar a través de un agujero estenopeico
- c) Retinopatía diabética – Agudeza visual mejora el mirar a través de un agujero estenopeico
- d) Glaucoma crónico – Agudeza visual empeora el mirar a través de un agujero estenopeico
- e) Catarata – Agudeza visual mejora el mirar a través de un agujero estenopeico

15) Un paciente diabético de 60 años, consulta por un cuadro de 3 días de visión de luces y puntos negros, al que hoy se le agregó pérdida de una parte importante de la visión del ojo derecho, permaneciendo con visión inferonasal. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia vítrea
- b) Edema macular
- c) Degeneración macular relacionada con la edad
- d) Desprendimiento de retina
- e) Glaucoma

16) Un paciente de 16 años consulta por rinorrea acuosa importante, que en ocasiones es más intensa que en otras. Además refiere estornudos frecuentes y prurito nasal, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia mucosa nasal pálida. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar corticoides tópicos intranasales
- b) Iniciar antihistamínicos orales
- c) Iniciar corticoides orales
- d) Iniciar descongestionantes tópicos
- e) Solicitar un prick test

17) Un niño de 8 años consulta por ojo rojo izquierdo de dos días de evolución. Refiere que despierta con los ojos pegados. Al examen físico se aprecia conjuntiva tarsal hiperémica, con abundante secreción purulenta. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar aseo ocular, sin necesidad de colirios
- b) Indicar colirio de gentamicina cada 2 horas y ungüento antibiótico durante la noche
- c) Indicar tratamiento sintomático con AINES
- d) Indicar cloxacilina oral
- e) Indicar ciprofloxacino oral

18) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un paciente con una fractura nasal reciente que presenta un hematoma del tabique?

- a) Solicitar TAC de cavidades paranasales y decidir conducta según resultados
- b) Solicitar RMN de cavidades paranasales y decidir conducta según resultados
- c) Controlar en 7 días para evaluar cirugía
- d) Compresión del tabique nasal
- e) Drenaje quirúrgico de inmediato

19) La lesión del tercer nervio craneal derecho producirá:

- a) Imposibilidad para mirar hacia arriba
- b) Imposibilidad para mirar hacia lateral
- c) Imposibilidad para mirar hacia inferonasal
- d) Miosis
- e) Lagoftalmo

20) Un paciente de 5 años consulta por otalgia derecha intensa, asociada a otorrea. Al examen físico se aprecia eritema difuso del conducto auditivo externo, con secreción purulenta. El tratamiento más adecuado es:

- a) Analgésicos y amoxicilina oral
- b) Analgésicos y ciprofloxacino tópico
- c) Analgésicos y ceftazidima endovenosa
- d) Analgésicos y cloxacilina oral
- e) Analgésicos y penicilina intramuscular

Prueba 6

1) Un paciente de 45 años, consulta por dificultades para mover los ojos. Al examen físico se aprecia que puede ver normalmente hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo al mirar a la izquierda, el ojo derecho permanece en la línea media. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión del III nervio craneal derecho
- b) Lesión del IV nervio craneal derecho
- c) Lesión del VI nervio craneal derecho
- d) Miastenia gravis
- e) Lesión del fascículo longitudinal medial

2) Un paciente de 59 años, presenta abolición del reflejo fotomotor bilateral, sin embargo el reflejo de acomodación permanece conservado. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Neuritis óptica
- b) Pupila de Addie
- c) Lesión del III nervio craneal
- d) Neurosífilis
- e) Síndrome de Horner

3) Un paciente de 68 años consulta por obstrucción nasal izquierda, de varios meses de evolución, asociado a rinorrea serosanguinolenta, en algunas oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer nasosinusal
- b) Angiofibroma nasal
- c) Poliposis nasal
- d) Rinitis alérgica
- e) Sinusitis crónica

4) Un paciente cefalea, sensación de presión facial, fiebre hasta 38°C, descarga posterior y dificultades para oler, desde hace 10 días y que ha empeorado en el último tiempo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de cavidades paranasales
- b) Iniciar tratamiento sintomático
- c) Iniciar amoxicilina oral y tratamiento sintomático
- d) Iniciar corticoides tópicos y antihistamínicos orales
- e) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico y tratamiento sintomático

5) La asociación de ojo rojo profundo, efecto Tyndall y miosis es característico de:

- a) Queratitis
- b) Uveítis
- c) Glaucoma agudo
- d) Glaucoma crónico
- e) Endoftalmitis

6) Un paciente de 30 años consulta por vértigo persistente e intenso, de inicio rápido, hace un día, asociados a vómitos y tendencia a caerse hacia la izquierda. No ha presentado síntomas auditivos y al examen físico se aprecia nistagmo horizontal con fase rápida a la derecha, que disminuye al solicitarle que fije la mirada en un punto. La coordinación motora no presenta alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Neuronitis vestibular
- d) AVE cerebeloso
- e) Tumor cerebral

7) Un paciente con catarata senil presentará con mayor probabilidad:

- a) Defecto pupilar aferente
- b) Pérdida del rojo pupilar
- c) Mejoría de la visión en lugares muy iluminados
- d) Ojo rojo
- e) Dolor ocular

8) Un paciente de 2 años consulta por irritabilidad y fiebre. A la otoscopia se aprecia eritema y abombamiento del tímpano izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar impedanciometría
- b) Solicitar endoscopia
- c) Iniciar paracetamol
- d) Iniciar amoxicilina + paracetamol
- e) Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico + paracetamol

9) Identifique la asociación INCORRECTA entre el hallazgo en el fondo de ojo y la patología:

- a) Hemorragias en llama – Retinopatía hipertensiva
- b) Exudados céreos – Retinopatía diabética
- c) Vasos de neoformación – Retinopatía diabética
- d) Drusas – Degeneración macular relacionada con la edad
- e) Entopsias – Glaucoma de ángulo abierto

10) Un paciente de 50 años, constructor, consulta porque le cuesta oír lo que le hablan. La otoscopia es normal, al igual que la impedanciometría. Sin embargo la audiometría muestra una hipoacusia sensorineural con especial afectación de las frecuencias medias (relacionadas al habla). El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Meniere
- b) Otoesclerosis
- c) Neurinoma del acústico
- d) Trauma acústico
- e) Presbiacusia

11) Un paciente se realiza un fondo de ojo, como parte del seguimiento de su hipertensión arterial, en el que se constata una excavación papilar de 0,4 a derecha y de 0,6 a izquierda. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Neuritis óptica
- b) Retinopatía hipertensiva
- c) Glaucoma crónico
- d) Degeneración macular relacionada con la edad
- e) Trombosis de la vena central de la retina

12) La causa más frecuente de disfonía crónica es:

- a) Cáncer
- b) Mal uso vocal
- c) Viral
- d) Alérgica
- e) Reflujo gastroesofágico

13) Un paciente consulta por fotopsias persistentes en la zona inferonasal del campo visual del ojo izquierdo, desde hace 24 horas. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Lesión de la cintilla óptica
- c) Lesión del lóbulo occipital
- d) Embolia arterial retinal
- e) Uveítis aguda

14) Un paciente de 34 años consulta por ojo rojo y epifora izquierda. Al examen físico se aprecia ojo rojo superficial, con aumento de volumen sensible y eritema en la zona nasoorbital. El diagnóstico más probable es:

- a) Dacrioadenitis aguda
- b) Dacriocistitis aguda
- c) Conjuntivitis aguda
- d) Chalazión
- e) Orzuelo

15) Un paciente consulta por odinofagia y fiebre, asociado a tos y ojo rojo. Al examen físico se aprecian adenopatías cervicales bilaterales y la faringe se aprecia eritematosa, con exudado amigdalino bilateral y una vesícula en la úvula. El agente etiológico más probable es:

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Mycoplasma pneumoniae
- c) Bacterias anaerobias
- d) Adenovirus
- e) Virus parainfluenza

16) Un paciente de 20 años consulta por odinofagia intensa, asociada a trismus y abombamiento del pilar amigdalino derecho. El examen más adecuado para evaluar a este paciente es:

- a) Nasofibroscofia
- b) Ecografía cervical
- c) TAC de cuello
- d) Resonancia magnética nuclear de cuello
- e) Cintigrama con galio

17) Un paciente sufre entrada de ácido clorhídrico en el ojo derecho. La conducta más adecuada es:

- a) Aplicar colirios antibióticos y sello ocular
- b) Aplicar una base tópica sobre el ojo afectado
- c) Realizar lavado con abundante agua por media hora
- d) Realizar lavado ocular con un litro de suero fisiológico
- e) Aplicar corticoides tópicos y sello ocular

18) Un paciente sufre un golpe directo en la nariz, evolucionando con dolor sobre el dorso nasal y equimosis bajo ambos ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de base de cráneo
- b) Fractura nasal
- c) Fractura nasoorbitaria
- d) Hematoma del tabique nasal
- e) Fractura de la lámina pirámica

19) ¿Qué alteración es MENOS probable de encontrar en una orbitopatía distiroidea por enfermedad de Basedow Graves?

- a) Retracción palpebral
- b) Exoftalmo
- c) Queratitis punctata
- d) Miosis
- e) Estrabismo

20) Un paciente de 30 años consulta por epistaxis izquierda de 20 minutos de duración, que no ha cedido a pesar de haberse puesto un algodón en la fosa nasal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar taponamiento anterior
- b) Realizar compresión externa de la nariz y reevaluar
- c) Realizar taponamiento posterior
- d) Realizar aseo nasal con suero fisiológico
- e) Realizar cauterización nasal con nitrato de plata

Prueba 7
VER PRUEBAS TRAUMATOLOGÍA, Prueba 4

Prueba 8
VER DERMATOLOGÍA, Prueba 5

OTORRINOLARINGOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA RESPUESTAS

Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3	Prueba 4	Prueba 5	Prueba 6
1 A	1 D	1 C	1 A	1 D	1 E
2 C	2 C	2 A	2 B	2 D	2 D
3 B	3 C	3 A	3 B	3 D	3 A
4 A	4 B	4 A	4 B	4 B	4 C
5 C	5 A	5 C	5 B	5 B	5 B
6 A	6 B	6 B	6 D	6 C	6 C
7 C	7 C	7 A	7 E	7 A	7 B
8 A	8 E	8 C	8 B	8 B	8 D
9 A	9 D	9 D	9 E	9 C	9 E
10 C	10 E	10 A	10 E	10 E	10 D
11 C	11 B	11 B	11 A	11 A	11 C
12 B	12 A	12 A	12 C	12 A	12 B
13 C	13 E	13 A	13 E	13 D	13 A
14 D	14 A	14 D	14 B	14 A	14 B
15 C	15 A	15 D	15 D	15 D	15 D
16 D	16 D	16 C	16 A	16 B	16 C
17 C	17 C	17 B	17 B	17 B	17 C
18 E	18 B	18 A	18 E	18 E	18 B
19 B	19 A	19 C	19 C	19 A	19 D
20 A	20 C	20 B	20 B	20 B	20 B

VI) PSIQUIATRÍA PRUEBAS

Prueba 1

1) Un paciente de 24 años, consulta porque presenta pensamientos desagradables. Cada vez que escucha las palabras mal, malo y enfermedad tiene la sensación de que algo terrible le va a pasar a él o a su familia. Para evitar esto, se persigna 3 veces y reza un padre nuestro. Sabe que eso no es normal, pero no puede evitarlo y le causa mucha angustia. No presenta alucinaciones y sabe que estas ideas son producidas por su mente. Teme estar volviéndose loco y en el último tiempo se ha sentido triste y desesperado. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por desrealización

2) Una mujer de 55 años sufre de desmayos, con pérdida de conciencia en relación a peleas con sus familiares. Le ha sucedido en varias oportunidades, por lo que sus hijos se encuentran preocupados. Los síntomas no parecen ser manifestados intencionalmente. Su examen físico, exámenes de laboratorio y neuroimágenes son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno facticio
- b) Trastorno por simulación
- c) Trastorno conversivo
- d) Disautonomía
- e) Trastorno disociativo

3) Un hombre de 68 años, diabético, hipertenso, consulta por tos con expectoración y fiebre, a lo que luego se agrega pensamiento desorganizado, inatención, desorientación, alucinaciones visuales e ideas paranoides. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad, cluster A
- b) Psicosis aguda
- c) Demencia
- d) Síndrome confusional agudo
- e) Encefalitis

4) El tratamiento más adecuado para el delirium tremens es

- a) Etanol
- b) Haloperidol
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Carbamazepina
- e) Diazepam

5) Una mujer de 44 años se divorcia hace 1 mes, luego de haber estado casada por 15 años. Evolucionando con irritabilidad y ánimo disfórico. En algunas ocasiones se siente ansiosa y mantiene la casa mucho más desordenada de lo habitual. Se reúne mucho menos con sus amigas. No ha tenido cambios en el peso ni en sus hábitos de sueño. El diagnóstico más adecuado es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Depresión mayor
- c) Reacción normal al estrés
- d) Trastorno por estrés postraumático
- e) Trastorno disociativo

6) Mujer de 57 años ha dejado de usar el transporte público, porque teme que la asalten. Por esto sale cada vez menos de su casa. También presenta miedo a que puedan entrar a su casa y le roben. No le gusta que sus hijos manejen, ya que siente que pueden chocar y morir, lo que le causa mucha angustia. Parece que está esperando que algo malo suceda. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de pánico
- c) Depresión mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Trastorno de personalidad evitativa

7) Paciente de 54 años, sufre accidente de tránsito hace 5 días, en que salió ileso, sin embargo su acompañante murió. Evoluciona con gran ansiedad, presentando varias crisis de pánico en relación a recuerdos vivos del momento del accidente. Lloro con facilidad, tiene muchas dificultades para dormir y presenta pesadillas del episodio. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Trastorno de estrés agudo
- e) Reacción normal al estrés

8) Un hombre de 44 años, afirma ser capaz de controlar el clima y está seguro de que él es responsable de evitar la mayoría de los huracanes, que azotan el mundo. Al ser interrogado de cómo puede ser eso posible, explica con lujo de detalles la manera como adquirió ese don hace muchos años y no acepta ninguna otra explicación. No ha presentado alucinaciones y se desempeña bien en su trabajo. Tiene buenas relaciones con sus amigos y familiares y nunca habla de su poder porque sabe que no lo entenderían. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad
- e) Psicosis reactiva

9) Hombre de 33 años, consulta porque se encuentra triste e irritable porque rompió recientemente con su novia, con la que tuvo una relación de 4 meses, muy intensa, con muchas peleas. Presenta peleas frecuentes con sus familiares y reacciona con ira intensa, la que cede en cosa de horas. Al hablar de su exnovia, cambia de opinión completamente entre una entrevista y otra. Refiere que consume alcohol y se embriaga con frecuencia. Tiene cortes en sus brazos que se ha realizado en varias instancias, desde su juventud. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión atípica
- b) Trastorno bipolar
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Trastorno de personalidad antisocial
- e) Trastorno adaptativo

10) ¿Cuál de los siguientes NO es un efecto adverso de los antidepresivos tricíclicos?

- a) Hipertensión arterial
- b) Alza de peso
- c) Constipación
- d) Sensación de boca seca
- e) Arritmias cardíacas

11) ¿Cuál de los siguientes fármacos pueden aumentar los niveles plasmáticos de litio, hasta valores peligrosos?

- a) Diuréticos y bloqueadores de calcio
- b) AINEs y diuréticos
- c) IECAs y diuréticos
- d) Antidepresivos tricíclicos y diuréticos
- e) AINEs y antipsicóticos

12) Una madre trae a su hijo de 6 años, porque ha bajado considerablemente su rendimiento escolar y se encuentra irritable y en algunas ocasiones, agresivo. Comparte menos con sus amigos del colegio. Ella refiere tener problemas con su marido y que actualmente están durmiendo en camas separadas. El diagnóstico que debe sospecharse es:

- a) Trastorno del desarrollo
- b) Trastorno por ansiedad de separación
- c) Depresión
- d) Maltrato infantil
- e) Trastorno de conducta

13) El tratamiento farmacológico de elección para el trastorno de pánico es:

- a) Benzodiazepinas
- b) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Antidepresivos tricíclicos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Antipsicóticos atípicos

14) El tratamiento farmacológico de elección para la depresión, en pacientes mayores de 65 años, es:

- a) Antidepresivos tricíclicos
- b) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Antidepresivos inhibidores de la monoamino oxidasa
- d) Estabilizadores del ánimo
- e) Antipsicótico en dosis bajas

15) Una mujer de 27 años, enfermera, con buen rendimiento laboral y buenas relaciones interpersonales, se define a sí misma como una persona tranquila y conservadora. Sin embargo cuando consume alcohol presenta gran desinhibición, hace el ridículo, llora y habla mucho, incluso con desconocidos. Ha tenido conductas sexuales de riesgo, durante algunos de estos episodios. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad límite
- b) Trastorno de personalidad histriónica
- c) Síndrome de abstinencia de alcohol
- d) Embriaguez patológica
- e) Dependencia a alcohol

16) Un paciente de 58 años, con antecedentes de síndrome de intestino irritable, cefalea tensional y fibromialgia, consulta por molestias faríngeas fluctuantes, de larga evolución. Refiere que siente como si tuviera una pelota en la faringe, la que no puede tragar (globus). Al examen físico no se aprecian alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Depresión
- c) Hipocondría
- d) Trastorno por somatización
- e) Trastorno de personalidad dependiente

17) Una mujer trae a su hijo de 6 años, porque es muy insolente y no lo puede controlar. En muchas ocasiones hace lo contrario a lo que se le pide y hace berrinches cuando no se hace lo que él pide. El diagnóstico más probable es:

- a) Déficit atencional hiperactivo
- b) Síndrome de Asperger
- c) Trastorno oposicionista desafiante
- d) Depresión infantil
- e) Trastorno de conducta

18) Las alucinaciones características de la esquizofrenia son:

- a) Visión de animales grandes y pequeños
- b) Visión de personas y monstruos
- c) Audición de órdenes y comentarios
- d) Audición de gritos y ruidos
- e) Sensación de pellizcos y roces

19) Una mujer de 23 años, consulta para operarse los dedos de las manos, porque los considera horribles, al punto de usar guantes para ocultarlos de los demás. Al examen físico sus dedos son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno dismórfico corporal
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Esquizofrenia
- e) Depresión psicótica

20) ¿Qué nombre tiene el cuadro, caracterizado por ánimo bajo o disfórico, de más de 2 años de duración, sin cumplir criterios de depresión mayor?:

- a) Acatisia
- b) Ciclotimia
- c) Distimia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Depresión atípica

Prueba 2

1) Un paciente de 36 años, sin antecedentes de importancia, trabajador de la construcción, es traído por su familia, ya que él refiere que su mujer lo engaña. La acusa de mantener relaciones con los profesores de su hijo menor, con un diputado y con un carabinero. Explica claramente cómo empezó a engañarlo para molestarlo y humillarlo, sin embargo nunca la ha sorprendido directamente. Contrató un detective privado, sin lograr conseguir pruebas, a lo que él argumenta que ella también lo engañó con dicho detective. La mujer se muestra muy preocupada y niega ser infiel, explicando que desde hace 5 años que su marido está con esas ideas y que en el último tiempo la situación se ha vuelto insostenible. Sus hijos también se muestran preocupados, y creen que su papá se está volviendo loco.

El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Demencia
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

2) ¿Qué medicamento es más útil para prevenir la recurrencia de episodios depresivos o maníacos en un paciente diagnosticado de trastorno bipolar?

- a) Fluoxetina
- b) Ácido valproico
- c) Benzodicepinas
- d) Inhibidores de la monoamino-oxidasa
- e) Clozapina

3) La fobia social se caracteriza principalmente por:

- a) Ansiedad y temor de estar en lugares con mucha gente
- b) Expectación ansiosa de la ocurrencia de una calamidad
- c) Ansiedad ante situaciones en que se será evaluado por los demás
- d) Ausencia de amigos íntimos
- e) Ansiedad y temor de sufrir un accidente y no ser ayudado por los demás

4) Un paciente de 67 años, diabético e hipertenso, presenta desde hace 24 horas agitación psicomotora, aludiendo que unos chamanes le mandan fuego a su cama. La familia ha intentado calmarlo, sin conseguirlo y de hecho el paciente no reconoció a uno de sus hijos. Previo a estos síntomas no presentaba antecedente psiquiátricos. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Trastorno disociativo
- e) Demencia

5) ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un paciente con trastorno conversivo?

- a) Mujer de 50 años, obesa, hipertensa, con cefaleas recurrentes, dolor abdominal crónico, prurito faríngeo y parestesias recurrentes, que se ha realizado múltiples exámenes sin encontrar alteraciones
- b) Mujer de 67 años, que pierde súbitamente la vista de ambos ojos, durante una pelea con su marido y recuperándola posteriormente. Se realiza el estudio pertinente, sin hallazgos.
- c) Hombre de 45 años que finge estar enfermo para conseguir cuidados por parte de sus familiares
- d) Mujer de 26 años que presenta dolor epigástrico cada vez que se siente angustiada o presionada
- e) Hombre de 36 años que considera que sus orejas son horribles, razón por la cual se deja el pelo largo para ocultarlas y ha pensado en operarlas en varias oportunidades. Al examen sus orejas son normales

6) La desrealización y la despersonalización son:

- a) Síntomas conversivos
- b) Síntomas de somatización
- c) Síntomas disociativos
- d) Síntomas psicóticos
- e) Síntomas ansiosos

7) Un paciente de 30 años fue despedido de su trabajo hace cerca de 6 meses. Además su madre sufrió un accidente vascular hace 4 meses, razón por la cual él debe cuidarla. Desde hace 2 meses está con muy poco ánimo, llora con frecuencia, presenta insomnio y ha bajado de peso alrededor de 8 kilogramos. Presenta importante desesperanza y refiere que su madre enfermó producto de su ineptitud e incapacidad de encontrar un nuevo trabajo y que muy probablemente él correrá la misma suerte. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipocondría
- b) Trastorno delirante
- c) Distimia
- d) Depresión psicótica
- e) Depresión atípica

8) Una mujer de 50 años casi no sale de su casa, por miedo a sufrir un accidente o ser víctima de robos. Además mantiene la casa con llave por miedo a ser asaltada. No le gusta que sus nietos salgan a la calle porque les puede pasar algo malo. Todo esto ha limitado considerablemente sus actividades familiares y sociales. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno de pánico
- d) Trastorno de angustia generalizada
- e) Fobia social

9) Un paciente sufre ataque por un perro de gran tamaño, resultando con algunas heridas en la pierna derecha y con grandes daños en su ropa. Durante las horas siguientes sufre varias crisis de ansiedad, y se aprecia muy angustiado al recordar el hecho. Refiere que no ha podido llorar y que cada vez que cierra los ojos ve al perro atacándolo. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno de pánico
- d) Trastorno de estrés agudo
- e) Reacción normal

10) El tratamiento de la depresión recurrente suele ser:

- a) Inhibidores de la recaptura de serotonina a permanencia
- b) Inhibidores de la recaptura de serotonina, asociados a litio, a permanencia
- c) Inhibidores de la recaptura de serotonina durante los episodios, suspendiendo durante los períodos de remisión
- d) Inhibidores de la recaptura de serotonina, asociados a antipsicóticos, a permanencia
- e) Litio a permanencia y antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina, durante las crisis

11) Un paciente ha dejado de salir de su casa, ha descuidado el orden de la misma y también su aspecto personal. Es muy unido a la religión y lee la Biblia a diario. Escucha voces que comentan todos sus actos y que lo insultan. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Esquizofrenia paranoide
- d) Trastorno adaptativo
- e) Episodio psicótico reactivo

12) Un niño de 10 años presenta un comportamiento agresivo y desconsiderado con los demás. Vive con su abuela a quien le roba en algunas ocasiones. Ha participado en actos de vandalismo, destruyendo vidrios y faroles, pelea con frecuencia con otros menores y habría consumido alcohol en varias oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Depresión infantil
- e) Dependencia a alcohol

13) El tratamiento farmacológico de elección para el trastorno de pánico es:

- a) Benzodiacepianas
- b) Antipsicóticos típicos
- c) Antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina
- d) Antidepresivos tricíclicos
- e) Estabilizadores del ánimo

14) El tratamiento de elección del delirium tremens es:

- a) Haldol
- b) Diazepam
- c) Etanol
- d) Risperidona
- e) Clorpromazina

15) Respecto al Trastorno obsesivo compulsivo es FALSO que:

- a) El tratamiento farmacológico suele ser poco efectivo por lo que sólo está indicado en los casos refractarios
- b) Las obsesiones más comunes son las de contaminación y de duda
- c) El paciente identifica las obsesiones como parte de su propia mente
- d) Tiene una prevalencia aproximada de 1%
- e) No suele presentar crisis de pánico

16) ¿Cuál de las siguientes opciones es MENOS probable de encontrar en un paciente con un trastorno bipolar, cursando un episodio maniaco?

- a) Hipersomnia
- b) Agitación psicomotora
- c) Fuga de ideas
- d) Verborrea
- e) Ánimo expansivo

17) Una paciente de 21 años presenta peleas muy frecuentes con su familia y con su pareja, manteniendo siempre relaciones inestables. Consume alcohol y se emborracha los fines de semana y se ha realizado cortes en sus antebrazos. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Trastorno de personalidad antisocial
- c) Esquizofrenia hebefrénica o desorganizada
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de personalidad limítrofe

18) Un paciente de 30 años lava la ropa en 3 ocasiones cada una y la plancha entre 3 y 5 veces antes de ponérsela, ya que siente que en caso contrario presentará muy mal olor. Por esta razón suele perder mucho tiempo y la ropa suele dañarse rápido. Sabe que es ridículo, pero no lo puede evitar. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno adaptativo

19) Las demencias se caracterizan principalmente por:

- a) Alucinaciones visuales
- b) Pérdida del juicio de realidad
- c) Defecto de la atención
- d) Alteración de la memoria
- e) Compromiso de conciencia

20) La anorexia nervosa presenta con MENOR probabilidad:

- a) Desnutrición
- b) Pérdida del control sobre la comida
- c) Amenorrea
- d) Inducción de vómitos
- e) Alteración de la percepción corporal

Prueba 3

1) El tratamiento farmacológico de elección de la depresión en los adultos mayores es:

- a) Benzodiacepinas
- b) Antidepresivos tricíclicos
- c) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- d) Ácido valproico
- e) Antipsicóticos atípicos

2) Un paciente de 24 años es una persona solitaria que trabaja en una empresa de despacho de encomiendas. Sus compañeros de trabajo refieren que es muy apático, afectivamente plano y que tiene algunas ideas de que puede comunicarse con Dios. Él refiere que es el mesías y que Dios le ha encomendado la salvación del mundo y que le dice quiénes son buenos espíritus y quiénes malos. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Delirium
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno de personalidad esquizotípica

3) Usted recibe a una paciente en el servicio de urgencia, la que perdió la consciencia luego de tener una pelea telefónica con su novio. El examinarla no responde a las palabras, presenta una postura hipertónica generalizada, con las manos apretadas y ofrece resistencia al intentar mover sus extremidades o abrir sus ojos. Sus signos vitales son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por somatización
- b) Trastorno por conversión
- c) Trastorno facticio
- d) Trastorno disociativo
- e) Intoxicación medicamentosa

4) Las características principales del trastorno de personalidad límite son:

- a) Autoestima baja e inseguridad
- b) Escisión, agresividad e impulsividad
- c) Inseguridad y dificultad para mostrar desacuerdo
- d) Apatía y falta de motivación
- e) Ideas de referencia y estilo de vida “extraño”

5) La anorexia nervosa puede presentar todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Atracones
- b) Alteración de la percepción corporal
- c) Amenorrea
- d) Uso de laxantes
- e) Elevación de las transaminasas

6) Una mujer de 25 años es muy ordenada en su casa y en el trabajo. Suele seguir muchos rituales para sus actividades y es muy preocupada de los detalles. Además es frecuente que guarde muchas cosas que podrían ser consideradas inútiles, por la posibilidad de que en algún momento las necesite. Sin embargo suele molestarse cuando las cosas no se hacen a su modo, lo que le ha traído malas relaciones con algunos de sus compañeros de trabajo. Además, muchas veces ha debido postergar la entrega de algunos trabajos, ya que pierde mucho tiempo en los detalles. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad obsesiva compulsiva
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Manía
- d) Histeria
- e) Trastorno disociativo

7) ¿Qué síntoma sería MENOS probable de presentarse en un paciente con depresión?

- a) Verborrea
- b) Anhedonia
- c) Hipersomnia
- d) Ideación suicida
- e) Desconcentración

8) Un niño es muy desordenado y difícil de controlar, ya que se distrae fácilmente y cambia continuamente de actividad. Además presenta un rendimiento escolar malo y es considerado como desordenado por sus profesores. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno por ansiedad de separación
- d) Depresión infantil
- e) Trastorno por déficit atencional

9) El tratamiento de elección del trastorno obsesivo compulsivo es:

- a) Psicoterapia
- b) Benzodiacepinas
- c) Antidepresivos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Antipsicóticos

10) Un paciente se divorcia luego de 6 años de matrimonio, evolucionando con irritabilidad y desmotivación. Además acude con más frecuencias a bares y maneja bajo las influencias del alcohol, a pesar de ser un hombre responsable previo a su separación. A parte de esto no ha presentado otros cambios de importancia y su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de estrés postraumático
- b) Depresión
- c) Trastorno adaptativo
- d) Distimia
- e) Trastorno bipolar en fase maníaca

11) Una vez manejada la manía aguda, el trastorno bipolar debe ser estabilizado utilizando:

- a) Litio
- b) Antidepresivos
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Benzodiacepinas
- e) Fenitoína

12) Un paciente de 32 años cree que la PDI lo investiga y espía constantemente, razón por la cual ya no usa celular ni internet, porque pueden ser usados como medio para rastrearlo e interceptar sus conversaciones. No ha presentado alucinaciones y aparte de eso, se desenvuelve normalmente en su trabajo y vida social. Su familia está muy preocupada y no entienden qué le pasa. Al preguntarle sobre el tema, explica que un día los vehículos de la PDI se instalaron fuera de su casa y en una instancia posterior escuchó una conversación acoplada en su celular, lo que le confirmó sus sospechas de que estaba siendo espiado. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión psicótica
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno delirante
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Esquizofrenia

13) Un paciente cursando por una depresión severa ingiere varias pastillas con intención suicida. ¿Qué medicamento presenta una mayor peligrosidad?

- a) Fluoxetina
- b) Amitriptilina
- c) Risperidona
- d) Carbacepina
- e) Alprazolam

14) Un paciente alcohólico es traído por agitación psicomotora y alucinaciones de arañas y culebras que lo atacan. Además presenta un marcado temblor de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Intoxicación por metanol
- b) Encefalopatía de Wernicke
- c) Intoxicación etílica
- d) Encefalopatía hepática
- e) Síndrome de privación

15) ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente del haloperidol?

- a) Constipación
- b) Síntomas extrapiramidales
- c) Disfunción sexual
- d) Palpitaciones
- e) Aumento de peso

16) Un paciente de 37 años ha presentado 4 crisis de pánico en el último mes, sin poder identificar una causa clara. Refiere estar muy asustado con lo que le pasa, ya que teme que pueda sufrir un infarto en alguna de las próximas crisis. Debido a esto ha limitado sus salidas de la casa y evita lugares como el metro y las calles muy transitadas, por miedo a que presente una crisis y nadie lo ayude. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Fobia social
- d) Trastorno de estrés postraumático
- e) Trastorno por somatización

17) Un paciente de 34 años ingresa por dolor precordial. Al examen físico está sudoroso, taquicárdico a 120 latidos por minuto y con presión arterial de 200/120 mmHg. Además destaca midriasis bilateral. Refiere haber consumido cocaína. La medida MENOS adecuada es:

- a) Preguntar por el consumo de otras sustancias
- b) Instalar monitoreo electrocardiográfico
- c) Administrar propranolol
- d) Administrar benzodiazepinas
- e) Solicitar troponinas plasmáticas

18) Una mujer es diagnosticada de cáncer de endometrio y al ser informada comienza a reírse y hablar de manera incoherente y luego no recuerda nada de lo sucedido. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno disociativo
- c) Trastorno por estrés agudo
- d) Trastorno somatomorfo
- e) Hipocondría

19) Un paciente de 20 años siente mucha ansiedad y vergüenza al realizar actividades en público como exponer, comer y bailar. Por esta razón evita ir a lugares donde tiene que realizar este tipo de actividades ya que le angustia que los demás lo juzguen. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Fobia social
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno de personalidad evitativa
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

20) Escoja la asociación INCORRECTA entre el tipo de demencia y su manifestación clínica:

- a) Hidrocefalia normotensiva – Pérdida de la atención, alucinaciones y desorientación temporoespacial
- b) Demencia vascular – Inicio relativamente brusco y presencia de signos focales
- c) Demencia por cuerpos de Lewy – Fallas de memoria, síntomas motores y alucinaciones
- d) Demencia frontotemporal – Desinhibición en el lenguaje y actitudes
- e) Demencia senil – Pérdida de la memoria reciente y dificultad para realizar tareas habituales

Prueba 4 (PSIQUIATRÍA Y SALUD PÚBLICA)

1) La efectividad corresponde a:

- a) La capacidad de una intervención de lograr resultados favorables medidos en años de vida ganados, ajustados por calidad
- b) La capacidad de una intervención de lograr resultados favorables a menor costo
- c) La capacidad de una intervención de lograr resultados favorables en condiciones ideales, controladas
- d) La capacidad de una intervención de lograr resultados favorables en condiciones similares a las reales
- e) La capacidad de una intervención de lograr resultados favorables cuando otras intervenciones han fallado previamente

2) Un paciente de 32 años está convencido de que su mujer lo engaña con un amante. Ella lo niega rotundamente y dice que su esposo está volviéndose loco con ese tema. Por esto, él la sigue e incluso ha contratado un detective para que la espíe, sin lograr ninguna información. A pesar de esto él insiste en el engaño de su mujer, ya que ha visto manchas en las sábanas de la casa, que con toda seguridad son producto de la infidelidad. No ha presentado alucinaciones y el resto de su examen psiquiátrico es normal, al igual que el examen neurológico. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno obsesivo compulsivo
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno bipolar

3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Los pacientes pertenecientes al tramo D de FONASA pueden optar al sistema de libre elección
- b) A los pacientes pertenecientes al tramo B de FONASA no se les exige copago
- c) Los pacientes pertenecientes al tramo A de FONASA reciben atención gratuita
- d) Los pacientes del tramo B de FONASA no pueden optar al sistema de libre elección
- e) A los pacientes del tramo C de FONASA se les exige copago

4) Las inmunizaciones o vacunas son medidas de:

- a) Protección de salud
- b) Prevención primaria
- c) Prevención de daños
- d) Prevención secundaria
- e) Prevención terciaria

5) Una mujer de 54 años dejó de ir al trabajo por miedo a que la asaltaran en el camino o que sufriera un accidente de tránsito. Cada vez sale menos de la casa y mantiene todo con llave, porque teme que puedan entrar a robar a la casa. Esto le ha producido una menor interacción con sus familiares y amigos. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de pánico
- c) Depresión mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Trastorno de personalidad paranoide

6) Se evaluó la utilidad de una nueva prueba de sangre oculta en deposiciones, como pesquisa de cáncer de colon. Para esto se realizan tomas a 200 pacientes con sospecha clínica de cáncer de colon y se comparó con el gold estándar: la colonoscopia, obteniéndose los siguientes resultados:

	Colonoscopia (+)	Colonoscopia (-)
Prueba (+)	33	17
Prueba (-)	7	143

El valor predictivo negativo de la nueva prueba es:

- a) 33/40
- b) 143/160
- c) 33/50
- d) 143/150
- e) 7/143

7) En una población de 3.000 personas hay 1.000 que fuman. Se sabe que la tasa de incidencia de cáncer de vejiga, a lo largo del tiempo es de 5% en los pacientes no fumadores y de 10% en los pacientes fumadores. Si ninguno de los pacientes de la población fumara, ¿Qué porcentaje de los casos totales se prevendría?

- a) 25%
- b) 33%
- c) 50%
- d) 66%
- e) 75%

8) Una paciente de 23 años corta el gas y la luz de la casa antes de salir, porque si no lo hace tiene la sensación de que puede explotar. En algunas ocasiones se ha regresado de la playa a cortar el gas y la luz, ya que la persona que debía hacerlo, lo olvidó. Ella sabe que es exagerado y ridículo, pero no hacerlo le causa mucha ansiedad y malestar. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno obsesivo compulsivo
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno de estrés postraumático
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno adaptativo

9) ¿A qué tipo de estudio corresponde el siguiente enunciado?

Se identifica un grupo de 200 pacientes diagnosticados de cáncer de estómago y se aleatorizan a recibir tratamiento quirúrgico exclusivo o tratamiento quirúrgico, asociado a quimioterapia postoperatoria. Se comparan las tasas de mortalidad y recaídas.

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) Transversal
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Ensayo de campo

10) La demencia frontotemporal se caracteriza fundamentalmente por:

- a) Síntomas extrapiramidales
- b) Alucinaciones visuales
- c) Caídas frecuentes
- d) Afasia de expresión
- e) Desinhibición

11) ¿Cuál de los siguientes es un efecto adverso de los antidepresivos tricíclicos?

- a) Hipertensión arterial
- b) Diarrea
- c) Baja de peso
- d) Glaucoma
- e) Sialorrea

12) ¿Qué entidad se encarga de administrar los recursos económicos del sistema de salud público Chileno?

- a) FONASA
- b) CENABAST
- c) Servicio de salud
- d) Consultorio
- e) Seremi

13) Una paciente de 33 años presenta un cuadro de 4 semanas de evolución de tristeza e insomnio. No identifica una causante clara, pero tiene baja autoestima y se considera inútil y no querida. Le cuesta mucho concentrarse en su trabajo y no se junta con amigos, ni realiza actividades recreativas, ya que no le hacen sentir mejor. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar un TAC de cerebro y un ECG y decidir conducta según hallazgos
- b) Solicitar exámenes generales e iniciar un antidepresivo IRSS
- c) Iniciar un anticonvulsivante
- d) Iniciar antipsicóticos y antidepresivos
- e) Iniciar psicoterapia, sin necesidad de fármacos, con controles mensuales

14) ¿Cómo se llama a aquel trastorno caracterizado por fingir una patología, bajo control voluntario, con el fin de ganar atención y cuidados?

- a) Disociativo
- b) Conversivo
- c) Facticio
- d) Somatomorfo
- e) Simulación

15) Si se quiere descartar una patología se requiere un test con:

- a) Validez interna
- b) Alta sensibilidad
- c) Alto valor predictivo positivo
- d) Bajo precio y fácil de implementar
- e) Alta especificidad

16) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y clínica es incorrecta?

- a) Disquinesia tardía – Movimientos reptantes de la lengua
- b) Balismo – Movimientos bruscos de los grupos musculares proximales
- c) Acatisia – Malestar al permanecer quieto, que se alivia con cambios frecuentes de posición
- d) Disonía – Disminución del tono muscular y reflejos osteotendíneos
- e) Parkinsonismo – Temblor de reposo

17) Usted desea comparar los niveles plasmáticos de vitamina B12, en relación al hematocrito, ambos como variables continuas, en una población de 200 pacientes. La mejor prueba para determinar la significancia estadística es:

- a) La "t" de Student
- b) El análisis de varianza
- c) El análisis estratificado
- d) La "r" de Pearson
- e) El Chi cuadrado

18) Una mujer de 23 años presenta relaciones interpersonales muy intensas e inestables. Además es muy impulsiva en las compras y también en el consumo de algunas sustancias. Sus familiares refieren que responde con ira y agresividad cuando se siente agredida, lo que suele ser muy frecuente. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno de personalidad paranoide
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Trastorno de adaptación
- e) Trastorno esquizoafectivo

19) Usted cuenta con la siguiente información:

Población total: 1.000 habitantes, muertes totales: 14, muertes por influenza: 2, casos de influenza: 140

Calcule la tasa de letalidad de la influenza

- a) $140/1.000$
- b) $14/1.000$
- c) $2/1.000$
- d) $2/140$
- e) $2/14$

20) Un paciente consume una sustancia, presentando palpitaciones, mareos y temblor. Al examen físico está pálido, sudoroso, con taquicardia e hipertensión importante, con midriasis y fiebre hasta 38° C, sin presentar signos focales. ¿Qué sustancia es más probable de ser la causante de este cuadro?

- a) Rivastigmina
- b) Alcohol
- c) Demerol
- d) Cocaína
- e) Imipramina

1) Una mujer de 21 años presenta pésimas relaciones familiares con sus padres y con su hermano. Pelean frecuentemente y ella incluso ha llegado a agredir a su madre. Además presenta una relación muy intensa e inestable con su novio, con quien ha terminado y vuelto en reiteradas ocasiones. En 2 oportunidades ha intentado suicidarse, la última de ellas con ingestión de benzodiazepinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Depresión psicótica
- c) Esquizofrenia hebefrénica
- d) Trastorno de personalidad antisocial
- e) Trastorno de personalidad límite

2) Una paciente consulta porque astenia y disestesias de las extremidades inferiores de larga data, que han empeorado en el último tiempo. Además refiere náuseas y dolor abdominal recurrente y en algunas ocasiones sensación de cuerpo extraño faríngeo (globus). Cuenta con numerosos exámenes que descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Trastorno por somatización
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno delirante crónico

3) Una paciente de 20 años ha presentado en 3 oportunidades un cuadro caracterizado por angustia, disnea, palpitaciones, vértigo, náuseas y sensación de muerte, que inicia y se instala relativamente rápido, durando cerca de 15 minutos. Refiere que los episodios inician de manera inesperada y tienen mucho miedo a que se repitan y pueda morir. El tratamiento más adecuado de la patología descrita, es:

- a) Benzodiazepinas
- b) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Litio
- d) Antipsicóticos atípicos
- e) Anticonvulsivantes

4) Una mujer de 55 años presenta miedo a que la asalten, por lo que ha dejado de salir de su casa. Además no le gusta que su marido ni que su hijo manejen por miedo a que puedan chocar. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Fobia social
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de personalidad evitativo
- d) Depresión
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

5) El trastorno delirante crónico se caracteriza principalmente por presentar:

- a) Ideas paranoides
- b) Delirio sistematizado
- c) Alucinaciones visuales
- d) Alucinaciones auditivas
- e) Juicio de la realidad conservado

6) Un paciente de 25 años es traído por su madre, ya que desde hace un mes que anda con ideas extrañas acerca de contactarse con Dios. Refiere que Dios le habla y que le dice que el mundo se está acabando. La madre refiere que ha descuidado su aspecto personal y que se ha retraído bastante. Previo a este episodio, era un hombre muy religioso, poco expresivo y con pocos amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Depresión psicótica
- e) Trastorno de personalidad esquizotípica

7) Un hombre de 80 años con antecedente de artrosis, presenta ánimo bajo y tristeza. Refiere que sus

dolores articulares en las caderas limitan mucho sus actividades y se siente viejo e inútil, además que sus amigos antiguos han fallecido en su mayoría. Piensa que vivir en esas condiciones no sirve y que debería morir ahora, sin embargo no presenta ideación suicida. Refiere que duerme poco y que se junta menos con sus familiares y amigos. La conducta más adecuada, además de mejorar el tratamiento analgésico de la artrosis, es:

- a) Iniciar psicoterapia
- b) Iniciar psicoterapia y quetiapina
- c) Iniciar psicoterapia y sertralina
- d) Iniciar psicoterapia y amitriptilina
- e) Iniciar psicoterapia y ácido valproico

8) En un paciente con una manía aguda se espera encontrar todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Anhedonia
- b) Verborrea
- c) Aumento de la libido
- d) Insomnio
- e) Ánimo irritable

9) Un paciente de 35 años consulta por dolor precordial. Al examen físico está muy agitado, sudoroso, con temperatura 37,8°C, FC: 130 x', PA: 180/110 mmHg y con midriasis bilateral. El resto del examen físico no aporta mayor información. Como antecedente tendría adicción a las drogas. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo inicial de este paciente?

- a) Propanolol
- b) Bicarbonato
- c) Benzodiazepinas
- d) Haloperidol
- e) Naloxona

10) En el tratamiento del alcoholismo es útil el acaprosato, ya que actúa:

- a) Como un fármaco aversivo
- b) Como un fármaco desmotivante
- c) Sustituyendo el efecto del alcohol en el sistema nervioso central
- d) Aumentando la metabolización hepática del alcohol
- e) Disminuyendo la metabolización hepática del alcohol

11) ¿Quién financia el tratamiento de las enfermedades profesionales?

- a) Las municipalidades
- b) Fonasa
- c) Los trabajadores
- d) Los empleadores
- e) El servicio de salud

12) Se inventa un examen de laboratorio, destinado a diagnosticar las infecciones pleurales. Se realiza un estudio en una muestra representativa, que determina que de 10 pacientes que obtienen un resultado positivo, 9 están realmente infectados. Esto quiere decir que:

- a) La sensibilidad es 90%
- b) La especificidad es 90%
- c) El likelihood ratio es 90%
- d) El valor predictivo positivo es 90%
- e) El valor predictivo negativo es 90%

13) Se comparan los niveles plasmáticos promedio de paratohormona en pacientes con insuficiencia renal con pacientes sanos. ¿Qué prueba es más adecuada para calcular la significancia estadística?

- a) "t" de student
- b) Análisis de varianza
- c) "r" de Pearson
- d) Chi cuadrado
- e) Test exacto de Fisher

14) En una población de 100.000 personas, hay 1.000 enfermos de una patología crónica. En un año enferman 200 personas adicionales, sin embargo mueren 100 enfermos y se mejoran 100 de los que estaban inicialmente enfermos. Calcule la tasa de incidencia acumulada aproximada:

- a) 1%
- b) 0,1%
- c) 0,2%
- d) 50%
- e) 10%

15) La mastocitosis es una enfermedad muy infrecuente. Se quiere determinar su relación con la exposición a arsénico. ¿Qué tipo de estudio sería el más útil para esto?

- a) Transversal
- b) De cohortes
- c) De casos y controles
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Serie de casos clínicos

16) Los pacientes Fonasa A:

- a) Pagan un copago del 10% al atenderse en hospitales públicos
- b) Pagan un copago del 10% al atenderse en los consultorios
- c) Sólo tienen cobertura de las AUGE
- d) Pagan el 7% de su sueldo a Fonasa
- e) No tienen acceso al sistema de libre elección

17) La capacidad de una intervención de dar resultados favorables a menor costo se denomina:

- a) Eficacia
- b) Efectividad
- c) Utilidad
- d) Eficiencia
- e) Beneficio

18) En un ensayo clínico se compara la efectividad del clopidogrel comparado con la aspirina. Para esto se forman 2 grupos de 100 pacientes cada uno. El primer grupo recibe aspirina y corresponde a pacientes con antecedente infarto al miocardio, tratados con trombolisis. El segundo grupo recibe el clopidogrel y corresponde a pacientes con infarto al miocardio, tratados con angioplastia primaria. Se comparan las tasas de complicaciones y de mejoría. Se puede afirmar que:

- a) El valor p será mayor a 0,05 y por lo tanto no se encontrarán diferencias significativas entre ambos grupos
- b) El riesgo relativo no podrá ser calculado
- c) El estudio no es válido, ya que presenta un sesgo de selección
- d) Debe hacerse un diseño de ensayo clínico cruzado
- e) Para que este estudio sea válido se debe realizar doble ciego

19) ¿Qué parámetro permite estimar de mejor manera la proporción de casos de una enfermedad que se deben a un factor de riesgo en una población determinada?

- a) Riesgo relativo
- b) Tasa de morbilidad
- c) Riesgo atribuible porcentual poblacional
- d) Odds Ratio
- e) Likelihood ratio

20) Se inicia una campaña de promoción de alimentación saludable y actividad física por difusión por radio y televisión, en un país "X". Se compara la mortalidad cardiovascular con un país "Y" en el que no se ha realizado la campaña. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Estudio de intervención comunitaria
- b) Ensayo de campo
- c) Estudio ecológico
- d) Estudio de cohortes
- e) Estudio observacional

Prueba 6

1) Un paciente de 24 años, consulta porque presenta pensamientos desagradables. Cada vez que escucha las palabras mal, malo y enfermedad tiene la sensación de que algo terrible le va a pasar a él o a su familia. Para evitar esto, se persigna 3 veces y reza un padre nuestro. Sabe que eso no es normal, pero no puede evitarlo y le causa mucha angustia. No presenta alucinaciones y sabe que estas ideas son producidas por su mente. Teme estar volviéndose loco y en el último tiempo se ha sentido triste y desesperado. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por desrealización

2) Mujer de 57 años ha dejado de usar el transporte público, porque teme que la asalten. Por esto sale cada vez menos de su casa. También presenta miedo a que puedan entrar a su casa y le roben. No le gusta que sus hijos manejen, ya que siente que pueden chocar y morir, lo que le causa mucha angustia. Pareciera que está esperando que algo malo suceda. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de pánico
- c) Depresión mayor
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Trastorno de personalidad evitativa

3) ¿Cuál de los siguientes NO es un efecto adverso de los antidepresivos tricíclicos?

- a) Hipertensión arterial
- b) Alza de peso
- c) Constipación
- d) Sensación de boca seca
- e) Arritmias cardíacas

4) Las alucinaciones características de la esquizofrenia son:

- a) Visión de animales grandes y pequeños
- b) Visión de personas y monstruos
- c) Audición de órdenes y comentarios
- d) Audición de gritos y ruidos
- e) Sensación de pellizcos y roces

5) ¿Qué nombre tiene el cuadro, caracterizado por ánimo bajo o disfórico, de más de 2 años de duración, sin cumplir criterios de depresión mayor?:

- a) Acatisia
- b) Ciclotimia
- c) Distimia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Depresión atípica

6) Un paciente de 36 años, sin antecedentes de importancia, trabajador de la construcción, es traído por su familia, ya que él refiere que su mujer lo engaña. La acusa de mantener relaciones con los profesores de su hijo menor, con un diputado y con un carabinero. Explica claramente cómo empezó a engañarlo para molestarlo y humillarlo, sin embargo nunca la ha sorprendido directamente. Contrató un detective privado, sin lograr conseguir pruebas, a lo que él argumenta que ella también lo engañó con dicho detective. La mujer se muestra muy preocupada y niega ser infiel, explicando que desde hace 5 años que su marido está con esas ideas y que en el último tiempo la situación se ha vuelto insostenible. Sus hijos también se muestran preocupados, y creen que su papá se está volviendo loco. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno delirante
- d) Demencia
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

7) ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un paciente con trastorno conversivo?

- a) Mujer de 50 años, obesa, hipertensa, con cefaleas recurrentes, dolor abdominal crónico, prurito faríngeo y parestesias recurrentes, que se ha realizado múltiples exámenes sin encontrar alteraciones
- b) Mujer de 67 años, que pierde súbitamente la vista de ambos ojos, durante una pelea con su marido y recuperándola posteriormente. Se realiza el estudio pertinente, sin hallazgos.
- c) Hombre de 45 años que finge estar enfermo para conseguir cuidados por parte de sus familiares
- d) Mujer de 26 años que presenta dolor epigástrico cada vez que se siente angustiada o presionada
- e) Hombre de 36 años que considera que sus orejas son horribles, razón por la cual se deja el pelo largo para ocultarlas y ha pensado en operarlas en varias oportunidades. Al examen sus orejas son normales

8) Un paciente sufre ataque por un perro de gran tamaño, resultando con algunas heridas en la pierna derecha y con grandes daños en su ropa. Durante las horas siguientes sufre varias crisis de ansiedad, y se aprecia muy angustiado al recordar el hecho. Refiere que no ha podido llorar y que cada vez que cierra los ojos ve al perro atacándolo. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno de pánico
- d) Trastorno de estrés agudo
- e) Reacción normal

9) El tratamiento farmacológico de elección para el trastorno de pánico es:

- a) Benzodiacepianas
- b) Antipsicóticos típicos
- c) Antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina
- d) Antidepresivos tricíclicos
- e) Estabilizadores del ánimo

10) Un paciente de 30 años afirma que su padre lo odia y quiere humillarlo frente a todos, sin embargo sus otros familiares dicen todo lo contrario y que su padre está muy preocupado por lo que piensa el paciente. Al indicarle esto, afirma que su padre es muy cínico y trata de convencer a los demás de que está loco, para ponerlos en su contra. No ha presentado alucinaciones y el examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno obsesivo compulsivo
- b) Esquizofrenia
- c) Depresión
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno de personalidad paranoide

11) Un paciente de 24 años es una persona solitaria que trabaja en una empresa de despacho de encomiendas. Sus compañeros de trabajo refieren que es muy apático, afectivamente plano y que tiene algunas ideas de que puede comunicarse con Dios. Él refiere que es el mesías y que Dios le ha encomendado la salvación del mundo y que le dice quiénes son buenos espíritus y quiénes malos. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Delirium
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Trastorno de personalidad esquizoide
- e) Trastorno de personalidad esquizotípica

12) La anorexia nervosa puede presentar todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) Atracones
- b) Alteración de la percepción corporal
- c) Amenorrea
- d) Uso de laxantes
- e) Elevación de las transaminasas

13) El tratamiento de elección del trastorno obsesivo compulsivo es:

- a) Psicoterapia
- b) Benzodiazepinas
- c) Antidepresivos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Antipsicóticos

14) Una vez manejada la manía aguda, el trastorno bipolar debe ser estabilizado utilizando:

- a) Litio
- b) Antidepresivos
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Benzodiazepinas
- e) Fenitoína

15) Un paciente alcohólico es traído por agitación psicomotora y alucinaciones de arañas y culebras que lo atacan. Además presenta un marcado temblor de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

- a) Intoxicación por metanol
- b) Encefalopatía de Wernicke
- c) Intoxicación etílica
- d) Encefalopatía hepática
- e) Síndrome de privación

16) Escoja la asociación INCORRECTA entre el tipo de demencia y su manifestación clínica:

- a) Hidrocefalia normotensiva – Pérdida de la atención, alucinaciones y desorientación temporoespacial
- b) Demencia vascular – Inicio relativamente brusco y presencia de signos focales
- c) Demencia por cuerpos de Lewy – Fallas de memoria, síntomas motores y alucinaciones
- d) Demencia frontotemporal – Desinhibición en el lenguaje y actitudes
- e) Demencia senil – Pérdida de la memoria reciente y dificultad para realizar tareas habituales

17) Una paciente de 33 años presenta un cuadro de 4 semanas de evolución de tristeza e insomnio. No identifica una causante clara, pero tiene baja autoestima y se considera inútil y no querida. Le cuesta mucho concentrarse en su trabajo y no se junta con amigos, ni realiza actividades recreativas, ya que no le hacen sentir mejor. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar un TAC de cerebro y un ECG y decidir conducta según hallazgos
- b) Solicitar exámenes generales e iniciar un antidepresivo IRSS
- c) Iniciar un anticonvulsivante
- d) Iniciar antipsicóticos y antidepresivos
- e) Iniciar psicoterapia, sin necesidad de fármacos, con controles mensuales

18) ¿Cómo se llama a aquel trastorno caracterizado por fingir una patología, bajo control voluntario, con el fin de ganar atención y cuidados?

- a) Disociativo
- b) Conversivo
- c) Facticio
- d) Somatomorfo
- e) Simulación

19) Un paciente consume una sustancia, presentando palpitaciones, mareos y temblor. Al examen físico está pálido, sudoroso, con taquicardia e hipertensión importante, con midriasis y fiebre hasta 38° C, sin presentar signos focales. ¿Qué sustancia es más probable de ser la causante de este cuadro?

- a) Rivastigmina
- b) Alcohol
- c) Demerol
- d) Cocaína
- e) Imipramina

20) Las características principales del trastorno de personalidad límite son:

- a) Autoestima baja e inseguridad
- b) Escisión, agresividad e impulsividad
- c) Inseguridad y dificultad para mostrar desacuerdo
- d) Apatía y falta de motivación
- e) Ideas de referencia y estilo de vida “extraño”

21) NO CONTESTE

¿Cuál de los siguientes fármacos pueden aumentar los niveles plasmáticos de litio, hasta valores peligrosos?

- a) Diuréticos y bloqueadores de calcio
- b) AINEs y diuréticos
- c) IECAs y diuréticos
- d) Antidepresivos tricíclicos y diuréticos
- e) AINEs y antipsicóticos

1) Un paciente de 30 años, presenta un cuadro alucinatorio crónico, con poca motivación, ineficiencia y escasa expresión de sentimientos, asociado a ideas mantener de relación directa con Dios. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno de personalidad esquizoide
- d) Trastorno de personalidad esquizotípico
- e) Delirium

2) Un paciente de 23 años termina una relación amorosa, de 4 años de duración, hace un mes, evolucionando con ánimo irritable y disfórico. Refiere que se ha dejado de juntar con los amigos que tenían en común y que se ha emborrachado varias veces, cuando antes rara vez lo hacía. EL diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno por adaptación
- d) Trastorno por estrés agudo
- e) Distimia

3) Un paciente observa como una persona se suicida arrojándose a las líneas del metro. Dos meses después evoluciona con ansiedad, recuerdos vivos del hecho y pesadillas. Refiere que ya no usa el metro, porque le causa mucha angustia. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de ansiedad generalizada
- d) Trastorno de estrés postraumático
- e) Trastorno de pánico

4) Un paciente es afectivamente plano y se relaciona muy poco con otras personas, ya que refiere que no le interesa. No tiene amigos íntimos ni pareja y parece indiferente a las críticas o halagos. No ha presentado alucinaciones y su juicio de la realidad está conservado. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno de personalidad evitativo
- c) Trastorno de personalidad esquizoide
- d) Trastorno de personalidad esquizotípico
- e) Trastorno de personalidad antisocial

5) El trastorno de angustia se caracteriza principalmente por:

- a) Presentar expectación ansiosa
- b) Presentar crisis de pánico sin una causa identificable
- c) Presentar agorafobia
- d) No presentar conductas evitativas
- e) Presentarse en mujeres de edad avanzada

6) ¿Cuál de los siguientes es un efecto adverso de los antidepresivos tricíclicos?

- a) Hipertensión arterial
- b) Insomnio
- c) Diarrea
- d) Aumento de peso
- e) Vómitos

7) El tratamiento farmacológico de elección de la depresión durante el embarazo es:

- a) Fluoxetina
- b) Venlafaxina
- c) Mirtazapina
- d) Amitriptilina
- e) Moclobemida

8) Una paciente sufre la muerte de su esposo hace 1 mes, en un accidente de tránsito. Evoluciona con mucha tristeza, recuerdos de su marido y sentimientos de soledad. Refiere que en ocasiones presenta

rabia e irritabilidad ya que considera muy injusto el suceso. Ha bajado un kilogramo de peso y duerme cerca de 8 horas al día. El diagnóstico más probable es:

- a) Duelo normal
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Depresión psicótica
- d) Depresión atípica
- e) Depresión melancólica

9) Una paciente de 30 años presenta un cuadro crónico caracterizado por ideas recurrentes de que algo malo le pasará a su familia, a menos que los llame por teléfono. Por esto los llama varias veces al día, siendo inoportuna en algunas ocasiones y gastando mucho dinero en la cuenta del teléfono. Ella sabe que es exagerado, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno por ansiedad generalizada
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Depresión psicótica

10) Una paciente sufre el robo de su vehículo. Reacciona muy tranquila, explicando que todo es en realidad una pesadilla y no está sucediendo en realidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de estrés postraumático
- b) Trastorno de estrés agudo
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno adaptativo

11) ¿Qué es MENOS probable de hallar en un paciente narcicista?

- a) Envidia
- b) Autoestima baja
- c) Aprovechamiento de los demás
- d) Autoagresión
- e) Carencia de empatía

12) Una paciente cursando una depresión inicia tratamiento con citalopram 10 mg/día, evolucionando 2 semanas después con irritabilidad, insomnio, verborrea y fuga de ideas. La conducta más adecuada es:

- a) Aumentar la dosis de citalopram a 20 mg al día
- b) Disminuir la dosis de citalopram a 5 m/día
- c) Cambiar el citalopram por fluoxetina 20 mg/día
- d) Suspender el citalopram y derivar a especialista
- e) Mantener el citalopram y agregar ácido valproico

13) Un paciente de 40 años, diagnosticado de un trastorno delirante crónico, inicia tratamiento con risperidona. Sin embargo al segundo día presenta contracción tónica y dolorosa del músculo esternocleidomastoideo derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Distonía
- b) Acatisia
- c) Disquinesia
- d) Balismo
- e) Atetosis

14) Un paciente de 79 años presenta desde algún tiempo, un cuadro de problemas de memoria, asociado a caídas frecuentes y alucinaciones visuales. Al examen físico presenta temblor de reposo de la mano izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia por cuerpos de Lewy
- b) Tumor cerebral
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Demencia frontotemporal

15) Usted evalúa un paciente de 50 años que acude a un chequeo médico con exámenes generales, en

el que se constata elevación marcada de la GGT y discreta de la GOT, sin otras alteraciones. Al interrogarlo mejor se confirma que consume cerca de una botella de vino al día, sin embargo él afirma que no le interesa dejar de tomar y que seguirá haciéndolo aunque le haga mal. Además de explicarle que está presentando daño hepático, por el consumo de alcohol, la conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizarlo contra su voluntad e iniciar terapia para conseguir la abstinencia
- b) Indicar disulfiram
- c) Iniciar antipsicóticos atípicos
- d) Iniciar antidepresivos
- e) Aconsejarle que deje de consumir alcohol, sin medidas adicionales

16) El tratamiento de elección del trastorno obsesivo compulsivo es:

- a) Psicoterapia
- b) Benzodiacepinas
- c) Antidepresivos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Antipsicóticos

17) Un paciente consume una sustancia con intención suicida, evolucionando con compromiso de conciencia y depresión respiratoria. Al examen físico presenta sopor profundo y frecuencia respiratoria de 5 respiraciones por minuto. Las pupilas son isocóricas y no presenta signos focales en el examen neurológico. La sustancia probablemente es:

- a) Un opiáceo
- b) Una benzodiacepina
- c) Un organofosforado
- d) Un anticolinérgico
- e) Un alfa-agonista

18) La principal característica de la fobia social es:

- a) La pérdida del juicio de la realidad
- b) la falta de amigos íntimos
- c) La ansiedad ante las situaciones en las que pueda ser evaluado por el público
- d) La expectación ansiosa
- e) La abulia

19) Un paciente de 50 años presenta mucho miedo a tener un cáncer digestivo, ya que presenta molestias abdominales como distensión y flatulencia. Se realiza un TAC de abdomen y pelvis y una colonoscopia, resultando ambos normales. Sin embargo pide que le realicen más exámenes, ya que cree que padece de alguna enfermedad grave y que no fue detectada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Trastorno por somatización
- c) Trastorno por conversión
- d) Trastorno facticio
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

20) Un paciente de 80 años presenta un cuadro de agitación psicomotora y desorientación temporo-espacial. Al examen físico está inatento y no es capaz de invertir series. La conducta más adecuada es:

- a) Hospitalizar, indicar medidas generales y realizar exámenes generales en busca de alteraciones infecciosas o metabólicas
- b) Solicitar TAC de cerebro e iniciar anticonvulsivantes
- c) Solicitar punción lumbar e iniciar antibióticos endovenosos
- d) Enviar a domicilio con medidas generales y manejo por un equipo multidisciplinario
- e) Enviar a domicilio con un inhibidor de la acetilcolinesterasa y un antipsicótico atípico

Prueba 8 (PSIQUIATRÍA + ENDOCRINOLOGÍA)

1) Una paciente de 38 años consulta por astenia, palpitaciones y diarrea, que iniciaron hace cerca de unos meses y que han ido en aumento. Refiere además que se siente muy incómoda en los días calurosos. Al examen físico está taquicárdica, con pulso irregular, normotensa, con piel fina y húmeda. La mirada es expresiva con retracción palpebral y cierto grado de proptosis y se palpa un bocio difuso, no doloroso. ¿Qué alteración es MENOS probable de ser hallada en esta paciente?

- a) TSH suprimida
- b) Presencia de anticuerpos contra el receptor de TSH
- c) Elevación de la tiroxina plasmática
- d) Disminución de la captación tiroidea de yodo
- e) Mixedema pretibial

2) Un paciente consulta por astenia, debilidad muscular y náuseas de varias semanas de evolución. Al examen físico se observan máculas hiperpigmentadas en la boca y en la cara. ¿Qué examen(es) debe(n) ser solicitado(s) ante este cuadro clínico?

- a) Cortisol y ACTH plasmáticos basales
- b) Cortisol plasmático basal y post-dexametasona
- c) Cortisol plasmático basal y post-ACTH
- d) Cortisol plasmático basal y nocturno
- e) Cortisol y ACTH en orina

3) Una paciente de 35 años consulta por astenia, constipación, debilidad y problemas de visión, de lenta evolución. Al examen físico se aprecia disminución del campo visual temporal de ambos ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Apoplejía hipofisiaria
- b) Síndrome de Sheehan
- c) Tumor hipofisiario
- d) Síndrome de la silla turca vacía
- e) Hiperprolactinemia

4) Una paciente de 33 años, esquizofrénica, presenta galactorrea. Refiere ausencia de menstruaciones desde hace 4 meses, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- b) Prolactinoma hipofisiario
- c) Hipogonadismo hipergonadotrópico
- d) Síndrome de ovario poliquístico
- e) Hiperprolactinemia secundaria a fármacos

5) Un paciente consulta por astenia y alza de peso. Al examen físico está hipertenso, se aprecia atrofia muscular y obesidad de disposición centripeta. En sus exámenes destaca glicemia de ayuno: 180 mg/dl, creatinina: 1,0 mg/dl, K: 3,0 mEq/l, Na: 142 mEq/l, Cl: 103 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Diabetes mellitus 2
- c) Enfermedad de Addison
- d) Acromegalia
- e) Hipotiroidismo

6) Una paciente presenta dolor cervical y malestar general. Al examen físico se palpa bocio doloroso y se solicita TSH que resulta 0,1 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiroiditis de Hashimoto
- b) Enfermedad de Basedow Graves
- c) Tiroiditis de Quervein
- d) Tiroiditis de Riedel
- e) Bocio multinodular tóxico

7) Un paciente de 26 años, con hipertensión arterial, se realiza exámenes generales, en los que destaca hipokalemia, por lo que se solicita índice de aldosterona/ARP, el que resulta 60 (VN: menor a

25). EL tratamiento de la patología descrita es:

- a) Cirugía vascular de arterias renales
- b) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
- c) Cirugía de las glándulas suprarrenales
- d) Propanolol
- e) Espironolactona

8) Un paciente hipotiroideo, en tratamiento con 75 ug de levotiroxina al día, se controla TSH que resulta 0,2 UI/l. La conducta más adecuada es:

- a) Agregar propiltiouracilo
- b) Mantener el tratamiento
- c) Agregar betabloqueo
- d) Aumentar la dosis de levotiroxina
- e) Disminuir la dosis de levotiroxina

9) Un paciente de 80 años se realiza un perfil bioquímico, en el que se aprecia calcio: 12,0 mEq/l, albúmina: 2,0 g/dl, fósforo: 7 mg/dl y fosfatasa alcalinas: 300 UI/l. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipercalcemia maligna
- b) Hipercalcemia ficticia
- c) Hiperparatiroidismo primario
- d) Hiperparatiroidismo secundario
- e) Hipervitaminosis D

10) Un paciente de 50 años consulta por astenia, debilidad muscular, disminución de la libido y disfunción sexual, con pérdida de las erecciones matinales. El examen físico muestra disminución del vello corporal. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Hipogonadismo
- c) Depresión
- d) Hipotiroidismo
- e) Diabetes mellitus

11) Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, inadecuadamente tratado, suelen complicarse con:

- a) Depresión
- b) Manía
- c) Delirio
- d) Síntomas disociativos
- e) Síntomas conversivos

12) Una mujer presenta crisis de pánico en una oportunidad, mientras iba sola en un ascensor. Desde entonces ha presentado 4 crisis de pánico, sin poder identificar un desencadenante claro y refiere miedo a que le pase algo durante esas crisis y no reciba ayuda, por lo que evita quedarse sola y salir de su casa. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno fóbico social
- d) Fobia específica
- e) Trastorno de estrés postraumático.

13) Las obsesiones del TOC se caracterizan por todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Que el paciente las reconoce como propias de su mente
- b) Producir angustia, la que sólo se disipa al realizar un ritual
- c) Ser frecuentemente ideas de contaminación o duda
- d) Que el paciente las considera como irracionales
- e) Asociarse a alteraciones perceptuales

14) Un paciente consulta por un cuadro crónico de ideas paranoides, alucinaciones visuales y

marcado aplanamiento afectivo. El tratamiento de elección es:

- a) Neurolépticos orales
- b) Neurolépticos de depósito
- c) Antidepresivos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Benzodiacepinas

15) Una mujer asegura que Barack Obama está profundamente enamorado de ella y que se lo muestra a través de sus discursos, pero que no ha podido estar con ella, debido a que sus obligaciones como presidente y la CÍA se lo prohíben. Explica que todo comenzó con la visita del presidente estadounidense a Chile hace varios meses. Sus familiares se muestran preocupados, ya que habla frecuentemente de eso y no entienden qué le pasa. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad histriónica
- b) Trastorno bipolar en fase maníaca
- c) Trastorno delirante
- d) Trastorno de personalidad narcicista
- e) Trastorno disociativo

16) Un paciente consulta por ánimo bajo, anhedonia, aumento de las horas de sueño y subida de peso de 10 Kg en los últimos 3 meses. Refiere que siente muchas ganas de comer cosas dulces, especialmente chocolates, lo que lo ha hecho engordar. El tratamiento más adecuado para este paciente es:

- a) Antidepresivos tricíclicos
- b) Anticonvulsivantes
- c) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- d) Antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa
- e) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina más antipsicóticos atípicos

17) Una paciente de 24 años consulta porque se siente ansiosa y en ocasiones triste. Refiere que es muy insegura, le cuesta expresar desacuerdo y tomar decisiones por sí misma, lo que hace que en ocasiones su marido y su jefe se molesten con ella, lo que le causa mucha angustia. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno de personalidad
- d) Trastorno depresivo
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

18) ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA entre el medicamento y sus efectos adversos?

- a) Ácido valproico – Aumento de peso
- b) Risperidona - Disonía
- c) Haloperidol - Disonía
- d) Escitalopram – Disminución de la libido
- e) Imipramina - Diarrea

19) Usted recibe a un paciente que refiere que tiene pesadillas y recuerdos muy vivos acerca de un incendio que sucedió hace 2 meses en la casa donde él vivía, en el que resultó con algunas quemaduras de segundo grado y perdió gran parte de sus bienes. Refiere que le causa mucha angustia recordarlo y que sólo ver fuego le produce ansiedad, al punto que no es capaz de entrar a la cocina, cuando están cocinando algo. Refiere que le cuesta expresar qué es lo que le pasa, pero que está muy incómodo con la situación. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica
- b) Trastorno de angustia
- c) Trastorno de angustia generalizada
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno por estrés postraumático

20) Un paciente de 25 años consulta por tristeza, anhedonia, insomnio y baja de peso de 5 kg, de un mes de evolución, asociado a disminución en la concentración e ideas de desesperanza. No es capaz de identificar un desencadenante claro y ha visto afectada su vida laboral. Al ser interrogado, refiere que hace tres años sufrió un cuadro similar, autolimitado, luego de 8 meses y que cinco años atrás sufrió un cuadro que describe con “mucha energía y ganas de hacer cosas, en las que hice varios negocios, sin embargo todos fracasaron. Casi no necesitaba dormir y tuve muchos problemas con mis familiares y amigos”. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar fluoxetina
- b) Iniciar amitriptilina
- c) Derivar a especialista para inicio de neurolépticos
- d) Derivar a especialista para inicio de litio
- e) Administrar haloperidol intramuscular y hospitalizar

Prueba 9

VER LIBRO DE BANCO DE PREGUNTAS TOMO II, PREGUNTAS GINECOLOGÍA Prueba 6

RESPUESTAS PSIQUIATRÍA

Prueba 1	8 D	16 B	2 B	8 D	16 C
1 D	9 D	17 C	3 B	9 C	17 B
2 C	10 A	18 B	4 E	10 D	18 C
3 D	11 C	19 B	5 B	11 A	19 A
4 E	12 A	20 A	6 B	12 A	20 A
5 A	13 C		7 C	13 C	
6 D	14 B		8 A	14 A	Prueba 8
7 D	15 A	Prueba 4	9 C	15 E	1 D
8 C	16 A	1 D	10 B	16 A	2 C
9 C	17 E	2 D	11 D	17 B	3 C
10 A	18 B	3 D	12 D	18 C	4 E
11 B	19 D	4 B	13 A	19 D	5 A
12 C	20 B	5 D	14 C	20 B	6 C
13 B		6 D	15 C	21 ByC	7 E
14 B		7 A	16 E		8 E
15 D	Prueba 3	8 A	17 D	Prueba 7	9 A
16 D	1 C	9 D	18 C	1 B	10 B
17 C	2 A	10 E	19 C	2 C	11 A
18 C	3 B	11 D	20 A	3 D	12 A
19 A	4 B	12 A		4 C	13 E
20 C	5 A	13 B		5 B	14 A
	6 A	14 C		6 D	15 C
	7 A	15 B		7 A	16 D
	8 E	16 D	Prueba 6	8 A	17 C
Prueba 2	9 C	17 D	1 D	9 D	18 E
1 C	10 C	18 C	2 D	10 D	19 E
2 B	11 A	19 D	3 A	11 D	20 D
3 C	12 C	20 D	4 C	12 D	
4 A	13 B		5 C	13 A	
5 B	14 E	Prueba 5	6 C	14 A	
6 C	15 B	1 E	7 B	15 E	
7 D					

VII) SALUD PÚBLICA PRUEBAS

Prueba 1

1) ¿Cuál de las siguientes opciones, NO corresponde a una medida de prevención primaria?

- a) Vacunación
- b) Saneamiento ambiental
- c) Fluorificación del agua potable
- d) Hábitos saludables
- e) Mamografía anual

2) Se eligieron 300 pacientes, diagnosticados de pancreatitis aguda y 600 pacientes de características similares, pero sanos y se les preguntó sobre consumo previo de alcohol, comparándose los resultados. Este estudio corresponde a un modelo de:

- a) Caso control
- b) Cohortes
- c) Estudio trasversal
- d) Ensayo clínico
- e) Estudio experimental

3) La atención primaria de salud, en Chile, se financia principalmente a través de:

- a) El aporte per cápita
- b) El 7% del sueldo de los trabajadores
- c) El aporte municipal
- d) El aporte de los empleadores
- e) El copago de los pacientes

4) Las dos estrategias que pueden usarse para evitar sesgos producidos por variables de confusión, son:

- a) Aleatorización estratificada y apareamiento (matching)
- b) Enmascaramiento (doble ciego) y randomización
- c) Aumentar el tamaño de la muestra y estratificación
- d) Matching y enmascaramiento
- e) Aleatorización y aumento del tamaño de la muestra

5) ¿A qué tipo de estudio corresponde el estudio de Framingham, que empezó en 1949 para identificar factores de riesgo de enfermedad coronaria, en el que de entre 10.000 personas que vivían en Framingham de edades comprendidas entre los 30 y los 59 años, se seleccionó una muestra representativa de ambos sexos, reexaminándose cada dos años en busca de señales de enfermedad coronaria?:

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) Transversal
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Ensayo de campo

6) La probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad infecciosa durante un período de tiempo se denomina:

- a) Incidencia acumulada
- b) Prevalencia
- c) Letalidad
- d) Riesgo atribuible
- e) Riesgo atribuible porcentual

7) Se quiere comparar el valor de la glicemia entre dos poblaciones distintas. La mejor prueba para determinar la significancia estadística es:

- a) Riesgo relativo
- b) La "t" de Student
- c) La prueba de Chi cuadrado
- d) La "r" de Pearson
- e) El Odds Ratio

8) El factor que más incide en la forma actual de la pirámide poblacional chilena es:

- a) La natalidad
- b) La mortalidad
- c) Las emigraciones
- d) Las inmigraciones
- e) El crecimiento vegetativo

9) Las mutuales de seguridad tienen como función prestar servicios de prevención, curación y rehabilitación de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Se financian principalmente a través de:

- a) El impuesto específico de la salud
- b) Los impuestos generales
- c) La cotización del empleador al seguro de accidentes laborales
- d) La cotización del trabajador al seguro de accidentes laborales
- e) El copago de los trabajadores

10) En una población de 1000 individuos, previamente sanos, se producen 144 casos de influenza AH1N1, durante el invierno. Esto quiere decir que:

- a) La prevalencia de Influenza AH1N1 es 144 casos por 1000 habitantes
- b) La incidencia de influenza AH1N1 es 144 casos por 1000 habitantes
- c) La tasa de enfermedad es 0,144
- d) La tasa de mortalidad de influenza AH1N1 es 144 por 1000 habitantes
- e) El riesgo relativo es 0,144

11) En un estudio prospectivo se calcularon las incidencias de AVE hemorrágico en pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular y en pacientes tratados con cumarínicos, obteniéndose valores de 5,25 por 1000 y 7 por 1000, respectivamente. El riesgo relativo fue 0,75 y el valor $p = 0,01$. Indique cuál de las siguientes alternativas es verdadera.

- a) El riesgo de padecer un AVE hemorrágico es un 25% menor al usar heparina de bajo peso molecular, en lugar de cumarínicos.
- b) El riesgo de padecer un ave hemorrágico al usar heparina de bajo peso molecular es de 1%
- c) El riesgo de padecer un ave hemorrágico al usar cumarínicos es de 1%
- d) El riesgo de sufrir un AVE hemorrágico es 1,75 veces mayor al usar cumarínicos, en lugar de heparina de bajo peso molecular
- e) No es posible predecir los riesgos, ya que no se alcanza la significancia estadística

12) Las medidas que incentivan hábitos de higiene, actividad física y alimentación saludable, se denominan:

- a) Protección de salud
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención específica
- d) Promoción de salud
- e) Predicción de salud

13) Los estudios de casos y controles se caracterizan por:

- a) Tener pocos sesgos
- b) Calcular las incidencias de enfermedad
- c) Poder relacionar una enfermedad con varios factores de riesgo
- d) Ser prospectivos
- e) Ser experimentales

14) En un ensayo clínico controlado se comparan dos tratamientos antiagregantes "A" y "B" como prevención de infarto agudo al miocardio. El tratamiento "A" presentó una menor incidencia de infarto, con un RR: 0,88, respecto al tratamiento "B" y un valor $p: 0,06$. Esto quiere decir que:

- a) El tratamiento "A" es mejor que el tratamiento "B"
- b) La probabilidad de que el tratamiento "A" sea mejor que el tratamiento "B" es 0,88
- c) Ambos tratamientos son igualmente efectivos
- d) Si ambos tratamientos fueran iguales, la probabilidad de encontrar esta diferencia en un estudio similar, sería 0,06
- e) La probabilidad de que el tratamiento "A" sea mejor que el tratamiento "B" es 0,94

15) El indicador que expresa mejor la reducción de riesgo, al retirar un factor de riesgo de una población es:

- a) Odds Ratio
- b) Riesgo absoluto
- c) Riesgo relativo
- d) Riesgo atribuible porcentual poblacional
- e) Riesgo atribuible

16) La tasa de mortalidad perinatal tiene como numerador a:

- a) Las muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y el nacimiento
- b) Las muertes producidas entre las 22 semanas de gestación y los 7 días de vida
- c) Las muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida
- d) Las muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y los 28 días de vida
- e) Las muertes producidas entre el nacimiento y los 28 días de vida

17) La institución del sistema de salud que se encarga de adquirir insumos al por mayor, y con un mejor poder de negociación, de modo de entregarlos a menor precio a los prestadores de salud, es:

- a) La CENABAST
- b) El ISP
- c) FONASA
- d) El servicio de salud
- e) El SEREMI

18) Una prueba diagnóstica para la patología "A", tiene una sensibilidad de 0,9 y una especificidad de 0,8. Si la tasa de prevalencia de la patología A es 0,1, calcule el valor predictivo positivo (aproximado) de la prueba diagnóstica:

- a) 0,25
- b) 0,33
- c) 0,50
- d) 0,67
- e) 0,80

19) El mejor estimador de la magnitud de la infección por VIH, en una población es:

- a) Tasa de prevalencia
- b) Tasa de incidencia acumulada
- c) Tasa de mortalidad específica por VIH
- d) Tasa de mortalidad general
- e) Tasa de letalidad de VIH

20) Se evaluó la utilidad de una nueva prueba de sangre oculta en deposiciones, como pesquisa de cáncer de colon. Para esto se realizan tomas a 200 pacientes con sospecha clínica de cáncer de colon y se comparó con el gold estándar: la colonoscopia, obteniéndose los siguientes resultados:

	Colonoscopia (+)	Colonoscopia (-)
Prueba (+)	33	17
Prueba (-)	7	143

La especificidad de la nueva prueba es aproximadamente:

- a) 40%
- b) 66%
- c) 83%
- d) 89%
- e) 95%

Prueba 2

1) Se seleccionan 30 pacientes diagnosticadas de lupus sistémico y 60 pacientes sanos y se les pregunta si fumaban antes de ser diagnosticados. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) Transversal
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Ensayo de campo

2) El mejor tipo de estudio, desde el punto de vista técnico y ético, para determinar la relación entre el tabaco y la aparición de cáncer de vejiga, es:

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) Transversal
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Ensayo de campo

3) La asociación entre un factor de riesgo y una patología se determina preferentemente a través de:

- a) Riesgo relativo
- b) Riesgo atribuible porcentual
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Likelihood ratio
- e) Incidencia acumulada

4) La institución encargada de fiscalizar a los laboratorios privados es:

- a) Secretaría regional ministerial
- b) Instituto de salud pública
- c) Fondo nacional de salud
- d) Municipalidades
- e) Instituto médico legal

5) Los consultorios públicos de atención primaria se financian principalmente a través de:

- a) El 7% de aporte de los trabajadores
- b) La ley de presupuesto
- c) El aporte per cápita
- d) Los municipios
- e) El servicio de salud

6) ¿Cuál de las siguientes situaciones está cubierta por la asociación chilena de seguridad y la mutual de seguridad?

- a) Una profesora sufre un infarto miocárdico mientras hacía clases
- b) Una asesora del hogar presenta embarazo de 34 semanas de gestación
- c) Un obrero de la construcción es diagnosticado de cáncer gástrico
- d) Un oficinista sufre una fractura de tobillo, mientras jugaba fútbol con sus compañeros de trabajo
- e) Una secretaria presenta un accidente de tránsito mientras acudía a su trabajo

7) Se seleccionan 300 pacientes con hipercolesterolemia y se aleatorizan a 3 grupos de 100 pacientes cada uno. El primer grupo recibe atorvastatina, el segundo grupo recibe gemfibrozilo y el tercero recibe una asociación entre gemfibrozilo y atorvastatina. Se comparan las tasas de aparición de hepatitis entre los tres grupos. La mejor prueba para determinar la significancia estadística es:

- a) La "t" de Student
- b) Chi cuadrado
- c) La "r" de Pearson
- d) Prueba exacta de Fisher
- e) Análisis de varianza

8) Se evaluó la utilidad de una nueva prueba de sangre oculta en deposiciones, como pesquisa de cá

ncer de colon. Para esto se realizan tomas a 200 pacientes con sospecha clínica de cáncer de colon y se comparó con el gold estándar: la colonoscopia, obteniéndose los siguientes resultados:

	Colonoscopia (+)	Colonoscopia (-)
Prueba (+)	33	17
Prueba (-)	7	143

La sensibilidad de la nueva prueba es:

- a) 33/40
- b) 143/160
- c) 33/50
- d) 143/150
- e) 7/143

9) Una prueba diagnóstica tiene un valor predictivo positivo de 0,84. Esto quiere decir que:

- a) La probabilidad de detectar a un sano es de 84%
- b) Si un paciente presenta un resultado positivo, tiene un 84% de probabilidades de que tenga la enfermedad
- c) Si un paciente está enfermo, la prueba resultará positiva con un 84% de probabilidad
- d) Un 84% de los pacientes enfermos presentarán una prueba positiva
- e) Un 84% de los verdaderos positivos estarán enfermos

10) Los estudios de casos y controles se caracterizan por:

- a) Ser observacionales
- b) Ser útiles para determinar el pronóstico de una enfermedad
- c) Ser prospectivos
- d) Tener alto costo
- e) Incluir muchos pacientes

11) Calcule la tasa de incidencia de VIH con los siguientes datos:

Tamaño de la población: 10.000 habitantes

Casos de VIH actuales: 200

Casos nuevos de VIH: 10

Muertes totales del periodo: 50

Muertes por SIDA del periodo: 5

- a) 5 por 100 habitantes
- b) 5 por 10.000 habitantes
- c) 100 por 100.000 habitantes
- d) 210 por 100.000 habitantes
- e) 215 por 100.000 habitantes

12) En una población de 1.000 pacientes, ocurren 50 casos de una enfermedad infecciosa, de los cuales 20 mueren. Además se producen 100 muertes por otras causas. La tasa de letalidad (sin amplificar) de la enfermedad es:

- a) 50/1.000
- b) 20/50
- c) 50/150
- d) 20/150
- e) 130/1.000

13) La tasa de mortalidad perinatal tiene como numerador a:

- a) Las muertes producidas entre el nacimiento y los 7 días de vida
- b) Las muertes producidas entre el nacimiento y los 28 días de vida
- c) Las muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y el nacimiento
- d) Las muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y los 7 días de vida
- e) Las muertes producidas entre las 28 semanas de gestación y los 28 días de vida

14) El mejor parámetro para determinar el impacto del cáncer gástrico es:

- a) Tasa de mortalidad por cáncer gástrico
- b) Tasa de prevalencia de cáncer gástrico
- c) Tasa de incidencia acumulada de cáncer gástrico
- d) Tasa de mortalidad general
- e) Tasa de letalidad

15) Se realiza un ensayo de campo, administrando una nueva vacuna contra la influenza en un grupo de 50 pacientes y comparando con otro grupo de 50 pacientes, que reciben la vacuna tradicional. Se mide la tasa de incidencia de influenza y se observa que es menor en el grupo que recibió la nueva vacuna, con un riesgo relativo de 0,8 y con un intervalo de confianza de 95% de 0,6 – 1,1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta?

- a) Entre un 0,6% y un 1,1% de los pacientes, que reciben la nueva vacuna, presentarán influenza
- b) La nueva vacuna sólo tiene un 80% de la eficacia de la vacuna original
- c) La nueva vacuna brinda un 20% adicional de protección contra la influenza
- d) Ambas vacunas brindan protecciones contra la influenza cercanas al 80%
- e) No existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas vacunas

16) Un ensayo clínico pretende comparar dos tratamientos para el manejo de la diabetes tipo II. Para esto se forman dos grupo de 100 pacientes cada uno. Uno de los grupos está compuesto por pacientes de sexo masculino con un promedio de edad de 55 años y el segundo está compuesto por pacientes de ambos sexos, en igual proporción, con un promedio de edad de 43 años. ¿Qué tipo de error puede detectar en este estudio?

- a) Sesgo de selección
- b) Error aleatorio
- c) Sesgo por variable confundente
- d) Sesgo de información
- e) Sesgo por enmascaramiento

17) La efectividad se refiere a:

- a) La capacidad de una intervención de lograr los objetivos a menores costos
- b) La capacidad de una intervención de conseguir los objetivos en condiciones ideales
- c) La capacidad de una intervención de obtener resultados positivos en condiciones similares a la vida real
- d) La capacidad de una intervención de conseguir una mayor cantidad de años de vida, ajustados por calidad
- e) El parámetro de comparación que permite elegir la alternativa que signifique los menores costos

18) El saneamiento ambiental, la disponibilidad de agua potable y la de alcantarillado son medidas de:

- a) Prevención secundaria
- b) Prevención terciaria
- c) Protección de la salud
- d) Promoción de la salud
- e) Prevención específica

19) Los principales problemas de salud en una población, cuya pirámide poblacional es joven, son:

- a) Del adulto mayor
- b) Degenerativos
- c) Materno-infantiles
- d) Psiquiátricos
- e) Cardiovasculares

20) Respecto a los afiliados a Fonasa es FALSO que:

- a) Los pacientes Fonasa C deben pagar un monto adicional durante su atención (Copago)
- b) Los pacientes Fonasa B no realizan copago
- c) Los pacientes Fonasa A no realizan aportes en dinero
- d) Los pacientes Fonasa A pueden optar al sistema de libre elección
- e) Los pacientes Fonasa D pagan el 7% de su sueldo todos los meses

21) En una población existe una prevalencia de insuficiencia renal crónica de 2%. Se desarrolla un nuevo sistema de pesquisa de IRC, que ocupa un sistema de medición inmediato, con sangre capilar, similar a un hemogluco-test. Este nuevo sistema es capaz de detectar al 90% de los pacientes con IRC, sin embargo cataloga como enfermos a un 20% de los pacientes sanos. El valor predictivo positivo tiene un valor:

- a) Mayor a 90%
- b) Entre 60% y 90%
- c) Entre 30% y 90%
- d) Entre 10% y 30%
- e) Menor a 10%

Prueba 3

1) Durante el año 2009 hubo 8.000 casos de influenza B, todos los que se presentaron entre los meses de julio y agosto. Del total de casos, 16 personas murieron por esa causa y el resto mejoró. El total de la población es 8.000.000 de personas. Así la tasa de mortalidad de la influenza B fue:

- a) $0,2 \times 100.000$
- b) 10×100.000
- c) 100×100.000
- d) 200×100.000
- e) 1.000×100.000

2) La probabilidad de estar enfermo equivale a:

- a) La morbilidad
- b) La letalidad
- c) La prevalencia
- d) La incidencia
- e) La sensibilidad

3) FONASA se financia mayoritariamente a través de:

- a) El aporte del 7% de los trabajadores
- b) El presupuesto general del estado
- c) El copago de los trabajadores
- d) El aporte per cápita
- e) El aporte de los empleadores

4) La proporción de los casos de cáncer de vejiga urinaria, que son debidas al cigarrillo, en los pacientes fumadores, es:

- a) El riesgo relativo
- b) El riesgo atribuible
- c) El riesgo atribuible porcentual
- d) El riesgo atribuible poblacional
- e) La tasa de incidencia

5) La tasa de mortalidad infantil tiene como numerador y como denominador respectivamente a:

- a) Las muertes producidas en los menores de 14 años y el total de la población
- b) Las muertes producidas en los menores de 14 años y la población menor de 14 años
- c) Las muertes producidas en los menores de un año y el total de la población
- d) Las muertes producidas en los menores de un año y la población menor de 1 año
- e) Las muertes producidas en los menores de un año y los nacidos vivos

6) Se quiere comparar el porcentaje de pacientes diagnosticados de hipertensión arterial en 3 grupos, según el peso. Los grupos son obesos, sobrepeso y normopeso. La mejor alternativa para determinar la significancia estadística es usar:

- a) La t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) Análisis de varianza
- d) La r de Pearson
- e) El test exacto de Fisher

7) Un examen destinado a detectar la presencia de rotavirus en las deposiciones es realizado a 300 pacientes con diarrea. Se utilizó la PCR como gold standard de comparación, obteniéndose los

siguientes resultados:

	PCR (+)	PCR (-)
Test (+)	80	10
Test (-)	20	190

La sensibilidad del test es:

- a) 80 / 90
- b) 80 / 100
- c) 80 / 300
- d) 190 / 200
- e) 190 / 210

8) Un ensayo clínico controlado y aleatorizado, compara dos tratamientos antibióticos A y B, para el tratamiento de las neumonías aspirativas. Para esto aplica cada tratamiento a 3.000 pacientes con este diagnóstico y se comparan las tasas de mortalidad y de efectos adversos. Se obtienen los siguientes resultados:

	Fármaco A	Fármaco B	Riesgo relativo	p
Tasa de mortalidad	0,67%	0,56%	1,2	0,97
Tasa de efectos adversos	6,67%	1,33%	5,0	0,01

¿Qué fármaco recomendaría?

- a) El antibiótico A porque tiene menos efecto adversos
- b) El antibiótico A porque reduce más la mortalidad
- c) El antibiótico B porque tiene menos efecto adversos
- d) El antibiótico B porque reduce más la mortalidad
- e) Cualquiera de los antibióticos A o B, ya que presentan resultados similares

9) La capacidad de una intervención (por ejemplo dar un fármaco) de generar resultados positivos (ejemplo mejoría de cierta enfermedad), en condiciones controladas o ideales, se denomina:

- a) Utilidad
- b) Riesgo relativo
- c) Eficacia
- d) Riesgo atribuible
- e) Eficiencia

10) Se eligen 250 pacientes diagnosticados de glioblastoma multiforme y 360 pacientes sanos, de edades similares y se les pregunta si estuvieron expuestos a arsénico en el pasado. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Transversal
- b) Casos y controles
- c) Cohortes
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Metanálisis

11) ¿Qué se puede hacer para disminuir el error aleatorio, alfa o tipo 1?

- a) Enmascarar
- b) Aleatorizar
- c) Estratificar
- d) Ajustar tasas
- e) Aumentar el tamaño de la muestra

12) Una nueva crema se utiliza para disminuir la aparición de lentigos solares. Para probar sus resultados ha realizado múltiples estudios de muy buena calidad, que llegaron a la conclusión de que usar la crema supone un riesgo relativo (RR) de 0,70 [0,65- 0,75, para un IC de 95%]. Esto significa que:

- a) El riesgo de desarrollar lentigos solares es un 70% menor si se usa la crema
- b) El 70% de los pacientes que usan la crema no desarrollarán lentigos solares
- c) Sólo el 0,7% de los pacientes que usan la crema desarrollarán lentigos solares
- d) La crema disminuye la aparición de lentigos solares en un 30%
- e) La crema no es efectiva en la prevención de los lentigos solares

13) Respecto al ensayo clínico es cierto que:

- a) Siempre es retrospectivo

- b) Siempre es experimental
- c) Siempre es aleatorizado
- d) Siempre es doble ciego
- e) Siempre usa placebo como grupo de control

14) ¿Cuál de las siguientes medidas es de prevención primaria?

- a) Controlar la presión arterial a pacientes sanos
- b) Usar colchón antiescaras en un paciente postrado
- c) Iniciar una campaña escolar de lavado de dientes
- d) Iniciar insulina en un paciente diabético tipo 2
- e) Tomas Papanicolaou

15) Calcule el Odds Ratio, con los siguientes datos obtenidos de un estudio de casos y controles:

	Casos	Controles
Factor de riesgo (+)	40	20
Factor de riesgo (-)	160	280

- a) 0,33
- b) 0,36
- c) 2,73
- d) 3
- e) 3,5

16) ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un estudio de costo-beneficio?

- a) Se evalúa la entrega gratuita de triterapia antirretroviral para pacientes VIH, afiliados al sistema público y se compara con la reducción de los costos de hospitalización y tratamiento por infecciones oportunistas
- b) Se evalúa el uso de triterapia antirretroviral en pacientes VIH, afiliados al sistema público y se calcula el costo de disminuir la mortalidad
- c) Se evalúa el uso de triterapia antirretroviral en pacientes VIH, afiliados al sistema público y se calcula el costo de ganar un año de vida ajustado por calidad
- d) Se evalúa el uso de triterapia antirretroviral en pacientes VIH, afiliados al sistema público y se calculan las tasas de efectos adversos (costos) y las tasas de mejoría y reducción de la mortalidad (beneficios)
- e) Se evalúa el uso de triterapia antirretroviral en pacientes VIH, afiliados al sistema público y se compara con un grupo de pacientes que recibe un placebo

17) El instituto de salud pública tiene varias funciones. Una de ellas es:

- a) Realizar autopsias en las muertes violentas
- b) Asignar los recursos económicos en la atención primaria
- c) Fiscalizar el funcionamiento de farmacias y laboratorios
- d) Obtener insumos a bajo precio
- e) Atender a los reclamos de los pacientes afiliados a Fonasa y de los afiliados a Isapre

18) Se realiza un estudio clínico controlado que compara el uso de metotrexato y de infliximab para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Se cuenta con 100 pacientes y se asignan a recibir metotrexato a los 50 pacientes con menor gravedad de la enfermedad y a recibir infliximab los 50 pacientes más graves. ¿Qué tipo de error se visualiza en este estudio?

- a) Error aleatorio
- b) Sesgo de selección
- c) Sesgo de medida
- d) Sesgo de variable de confusión
- e) Sesgo de intervención

19) El valor predictivo negativo de la mamografía es 0,96. Esto quiere decir que:

- a) Una mujer con cáncer de mama, obtendrá un resultado negativo, con una probabilidad de 4%

- b) Una mujer sin cáncer de mama, obtendrá un resultado negativo, con una probabilidad de 96%
- c) Una mujer que obtiene un resultado positivo en el test, estará libre de cáncer de mama con un 4% de probabilidad
- d) Una mujer que obtiene un resultado negativo en el test, presentará cáncer de mama con un 4% de probabilidad
- e) El 96% de las mujeres con cáncer de mama serán detectadas por el test

20) Se eligen 600 pacientes, de los cuales 89 sólo fuman, 187 sólo beben y 156 fuman y beben. Se siguen en el tiempo y se observa la aparición de cáncer pulmonar, vesical y gástrico. ¿Qué tipo de estudio es?

- a) Caso y control
- b) Estudio de prevalencia
- c) Ecológico
- d) Ensayo de campo
- e) Cohortes

1) Una paciente quería saber si padecía cierta enfermedad, que es frecuente en la población. Se realizó un examen diagnóstico con una altísima especificidad y resultó positivo. Respecto a esto se puede afirmar que:

- a) Debe realizarse un nuevo examen que tenga una alta sensibilidad
- b) Debe realizarse un nuevo examen que tenga un alto valor predictivo negativo
- c) Hay que tranquilizarla y explicarle que lo más probable es que se trate de un falso positivo
- d) Debe repetirse el mismo examen para confirmar
- e) Es probable que padezca la enfermedad, ya que dependiendo de la prevalencia, los exámenes con alta especificidad suelen tener altos valores predictivos positivos

2) Se realiza un estudio transversal en un total de 1.000 personas, en el que se realizan tomas de presión, determinando si padecen de HTA o no y se registran las medidas antropométricas determinando si son obesos, si tienen sobrepeso o si son normopeso. Se determina así que hay 350 pacientes obesos, 300 pacientes con sobrepeso y 350 pacientes normopeso. De los pacientes obesos un 30% resulta hipertenso, de los pacientes con sobrepeso, un 15% y de los pacientes normopeso, sólo lo el 9%. ¿Qué prueba utilizaría para determinar si existe una asociación estadísticamente significativa entre la hipertensión arterial y la obesidad o el sobrepeso?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) Análisis de Varianza
- d) Test exacto de Fisher
- e) r de Pearson

3) La CENABAST tiene como función:

- a) Fiscalizar a los proveedores de insumos médicos
- b) Comprar todos los insumos utilizados por el sistema público de salud y distribuirlos a lo largo del país
- c) Realizar compras por volumen de modo de aumentar el poder de negociación y poder ofrecérselos a menores precios a los prestadores de la salud pública
- d) Verificar el adecuado uso de los insumos médicos por parte de las entidades prestadoras de la salud pública
- e) Comprar a un mismo proveedor todos los insumos médicos que el sistema público necesita

4) La probabilidad de estar enfermo corresponde a:

- a) La morbilidad
- b) La prevalencia
- c) La incidencia
- d) El riesgo relativo
- e) El likelihood ratio

5) La tasa de mortalidad por cáncer de estómago corresponde a:

- a) El cociente entre las muertes producidas por cáncer de estómago y la población total
- b) El cociente entre las muertes producidas por cáncer de estómago y los casos nuevos de cáncer de estómago
- c) El cociente entre las muertes producidas por cáncer de estómago y los casos totales de cáncer de estómago
- d) El cociente entre las muertes producidas por cáncer de estómago y el total de muertes de la población
- e) El cociente entre las muertes producidas por cáncer de estómago y el total de muertes por cáncer

6) Calcule el valor predictivo positivo, con la siguiente tabla:

	Enfermos	Sanos
Test positivo	50	25
Test negativo	100	200

- a) 50/75
- b) 50/100
- c) 50/150
- d) 25/75
- e) 25/225

7) La disminución del riesgo, que se lograría si se eliminara un factor de riesgo en el grupo de

personas expuestas a dicho factor, se denomina:

- a) Riesgo atribuible
- b) Riesgo relativo
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Odds ratio
- e) Likelihood ratio

8) Se realiza un ensayo clínico que compara un fármaco A versus un fármaco B para el tratamiento del hanta. Se obtienen los siguientes resultados:

	Fármaco A	Fármaco B	RR [IC 95%]
Tasa de mejoría	80%	70%	1,14 [1,10-1,20]
Tasa de efectos adversos	1%	0,1%	10 [0,8-80]

¿Qué fármaco recomendaría?

- a) El A o B indistintamente, ya que no muestran diferencias significativas
- b) El A porque es más eficaz
- c) El B porque tiene menos efectos adversos
- d) El A porque tiene menos efectos adversos
- e) El B porque es más eficaz

9) Se seleccionan 100 pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas y 140 pacientes sanos y se les pregunta sobre si fumaron y consumieron alcohol durante su juventud. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Ecológico
- b) De prevalencia
- c) De casos y controles
- d) De cohortes
- e) Ensayo clínico

10) Respecto a los estudios de cohortes es FALSO que:

- a) Permiten calcular la incidencia de manera directa
- b) Son buenos para evaluar patologías que demoran muchos años en aparecer
- c) Son caros
- d) Son observacionales
- e) Se ven afectados por las pérdidas de individuos

11) Calcule el riesgo relativo aproximado de estar expuesto a arsénico para el desarrollo de cáncer de piel basocelular con la siguiente información:

	Cáncer Basocelular	Sanos	TOTAL
Expuestos a As	50	50	100
No expuestos a As	300	600	900
TOTAL	350	650	1.000

- a) 1,2
- b) 1,5
- c) 1,8
- d) 2,0
- e) 2,5

12) Mediante un estudio se determina que es más barato vacunar a toda la población contra el sarampión, que tener que tratar a los enfermos y rehabilitar a quienes quedan con secuelas. ¿Qué tipo de estudio es?

- a) Costo-eficacia
- b) Eficiencia
- c) Costo-utilidad
- d) Costo-beneficio
- e) Minimización de costos

13) Un ensayo clínico pretende evaluar la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cuello uterino en el largo plazo. Sin embargo se sabe que la actividad sexual es un factor que se relaciona tanto con el uso de ACO como con el desarrollo de CCU. ¿Qué solución plantearía para evitar este problema?

- a) Realizar una aleatorización estratificada
- b) Aumentar el tamaño de la muestra
- c) Hacer doble ciego
- d) Utilizar métodos diagnósticos de CCU que sean sensibles y específicos
- e) Realizar el estudio sólo con mujeres que no mantengan actividad sexual

14) La toma habitual de presión arterial, como método de screening corresponde a una actividad de:

- a) Promoción de la salud
- b) Protección de la salud
- c) Prevención primaria
- d) Prevención secundaria
- e) Prevención terciaria

15) Fonasa en la actualidad se financia principalmente de:

- a) El aporte per cápita
- b) El aporte del 7% de los trabajadores
- c) El aporte fiscal directo
- d) El copago de los trabajadores
- e) El dinero autogestionado

16) ¿Cuál de las siguientes situaciones debe ser atendida por la mutual de seguridad o la ACHS en un trabajador, cuyo empleador lo tiene afiliado a alguna de estas instituciones?

- a) Trabajador agrícola sufre quemaduras por sol mientras trabajaba en el campo
- b) Trabajador sufre un infarto mientras estaba en su trabajo
- c) Trabajador es contagiado de influenza por un compañero de trabajo
- d) Trabajadora inicia metrorragia intensa en su lugar de trabajo
- e) Trabajadora con 20 semanas de embarazo inicia metrorragia intensa y dolor abdominal en su lugar de trabajo

17) ¿Cuál de los siguientes indicadores es mejor para evaluar la producción de un hospital público?

- a) Número de pacientes hospitalizados
- b) Promedio de días de estadía
- c) Porcentaje de muertes en los pacientes hospitalizados
- d) Cantidad de dinero autogestionado
- e) Índice de ocupación de camas

18) Cuando se enfatiza en la prevención primaria:

- a) Aumenta la eficiencia de la intervención
- b) Aumenta la prevalencia pero disminuyen las secuelas
- c) Se requiere una cobertura menor para lograr los mismos resultados
- d) Disminuye la incidencia, pero aumentan las secuelas
- e) Disminuye el costo de la intervención, pero aumenta la incidencia

19) Un examen diagnóstico tiene sensibilidad: 90%, especificidad: 85%, valor predictivo positivo: 50%, valor predictivo negativo: 98%. Un paciente se realiza dicho examen y resulta positivo. ¿Qué probabilidad tiene de estar enfermo?

- a) 90%
- b) 85%
- c) 50%
- d) 98%
- e) 100%

20) ¿Qué tendencias han presentado las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento poblacional en Chile en los últimos 10 años?

- a) Leve disminución, estable y leve disminución, respectivamente
- b) Gran disminución, estable y leve aumento, respectivamente
- c) Leve disminución, gran disminución y leve aumento, respectivamente
- d) Gran disminución, leve aumento y estable, respectivamente
- e) Estable, gran disminución y leve aumento respectivamente

21) El efecto de retirar los factores de riesgo de una patología, se evalúa mejor a través de la disminución de:

- a) La tasa de incidencia de la patología
- b) La tasa de prevalencia de la patología
- c) La tasa de mortalidad
- d) La tasa de incidencia de los factores de riesgo
- e) La tasa de prevalencia de los factores de riesgo

1) Se decide realizar un estudio que pretende evaluar si existe algún tipo de relación entre el hipotiroidismo congénito y el desarrollo de tumores del sistema endocrino. Para esto se seleccionan 100 pacientes con hipotiroidismo congénito y 100 pacientes sanos y se siguen en el tiempo, calculándose las tasas de aparición de tumores del sistema endocrino. ¿Qué prueba estadística será más adecuada para determinar la significancia estadística de esta asociación?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) Análisis de varianza
- d) r de Pearson
- e) Test exacto de Fisher

2) Respecto a la atención en la salud pública chilena es VERDADERO que:

- a) Los pacientes Fonasa B deben realizar un copago en la atención hospitalaria
- b) Los pacientes Fonasa B no tienen derecho a la atención por el sistema de libre elección, mediante la compra de bonos
- c) La atención primaria en los consultorios depende de la gestión de las municipalidades
- d) La atención en urgencia no tiene copago para ninguno de los pacientes afiliados a Fonasa
- e) Los pacientes Fonasa no pueden atenderse en clínicas privadas, a menos que paguen la totalidad de los costos de manera particular

3) ¿De dónde se obtienen los recursos para el manejo de los accidentes laborales y del trayecto?

- a) Del aporte fiscal directo
- b) Del aporte per cápita
- c) Del aporte de las municipalidades
- d) Del aporte de las mutuales de seguridad
- e) Del aporte de los empleadores

4) ¿Qué factor es el más determinante en la forma de la pirámide poblacional chilena?

- a) La natalidad
- b) La mortalidad
- c) El crecimiento
- d) Las inmigraciones
- e) Las emigraciones

5) Una paciente se realiza un examen diagnóstico de cáncer de mama, cuyo valor predictivo negativo es 98%. Esto quiere decir que:

- a) En caso de estar sana, el examen saldrá negativo con un 98% de probabilidad
- b) En caso de estar enferma, el examen saldrá negativo, sólo con un 2% de probabilidad
- c) En caso de que el examen resulte positivo, tendrá una probabilidad de sólo un 2% de no tener la enfermedad
- d) En caso de que el examen resulte negativo, tendrá un 98% de probabilidad de no padecer la enfermedad
- e) El 98% de los verdaderos negativos corresponden a personas sin la enfermedad

6) En una población se determina que el consumo de cigarrillos tiene un riesgo atribuible porcentual poblacional (RAP%) de 90% para el desarrollo de cáncer de pulmón. Esto quiere decir que:

- a) El 90% de los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón
- b) El 90% de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores
- c) El cigarrillo aumenta en un 90% el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón
- d) Cerca de la mitad de la población es fumadora y tienen 9 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, que aquellos que no fuman
- e) Sólo un 10% de los casos de cáncer de pulmón de esta población se deben a una causa distinta del cigarrillo

7) ¿Cuál es el mejor estimador de la importancia de una enfermedad grave y de corta duración en una población?

- a) Tasa de incidencia
- b) Tasa de prevalencia
- c) Tasa de mortalidad
- d) Riesgo atribuible
- e) Riesgo relativo

8) Calcule la sensibilidad del antígeno Ca-19.9 para el diagnóstico de cáncer de páncreas, utilizando la siguiente información:

	Enfermos de Cá Páncreas	Sanos	Total
Ca-19.9 elevado	72	40	112
Ca-19.9 normal	18	160	178
Total	90	200	290

- a) 72/112
- b) 180/178
- c) 72/90
- d) 180/200
- e) 72/160

9) El mejor parámetro para determinar la frecuencia con la que se va presentando una enfermedad a lo largo de un período es:

- a) Incidencia acumulada
- b) Letalidad
- c) Prevalencia
- d) Mortalidad
- e) Riesgo relativo

10) El mejor tipo de estudio para determinar la relación entre un factor de riesgo y una patología que demora muchos años en aparecer es:

- a) Estudio de casos y controles
- b) Ensayo clínico controlado
- c) Estudio de cohortes
- d) Estudio de prevalencia
- e) Ensayo de campo

11) Se realiza un ensayo clínico controlado que evalúa el efecto de dos antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina en el trastorno de estrés postraumático, obteniéndose los siguientes resultados.

	Fluoxetina + Psicoterapia	Escitalopram + Psicoterapia	RR [IC 95%]
Tasa de mejoría	96%	96%	1,0 [0,5 - 1,5]
Incidencia de efectos adversos	4%	2%	2,0 [0,8 - 3,3]
Tasa de desarrollo de complicaciones psiquiátricas	12%	18%	0,67 [0,5 - 0,8]

¿Qué tratamiento recomendaría entre estas dos alternativas?

- a) La fluoxetina porque tiene menos efectos adversos
- b) La fluoxetina porque tiene menor tasa de desarrollo de complicaciones psiquiátricas
- c) La fluoxetina, porque es más eficaz
- d) El escitalopram porque tiene una menor tasa de efectos adversos
- e) Cualquiera de los dos, ya que no existen diferencias significativas entre ambos

12) Para evitar el sesgo de selección es recomendable:

- a) Realizar una selección aleatorizada
- b) Realizar apareamiento o matching
- c) Realizar doble ciego
- d) Realizar un análisis estratificado
- e) Asegurar un adecuado registro de todos los eventos

13) Se realiza un estudio que evalúa la aparición de complicaciones hepáticas en pacientes que consumen homeopatía para el tratamiento de cualquier enfermedad. Para esto, se escogen 1.000 pacientes que consumen homeopatía y otros 1.000 pacientes que no la utilizan y se controlan anualmente con examen clínico y pruebas hepáticas, por 5 años, comparándose los resultados. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Ensayo clínico
- b) Casos y controles
- c) Cohortes
- d) Prevalencia
- e) Ensayo de campo

14) Se realiza un estudio para evaluar la eficacia del fármaco A, comparado con el fármaco B. Este último es el tratamiento habitual de una enfermedad. Se escogen 20 pacientes y se forman 2 grupos de 10 pacientes cada uno. Cada grupo recibe uno de los fármacos. No se observan efectos adversos en ninguno de los dos grupos y se obtiene que el fármaco A es mejor que el fármaco B (RR = 0,5), sin embargo el valor "p" resulta 0,08. La conducta más adecuada es:

- a) Descartar el fármaco A como tratamiento válido para dicha enfermedad
- b) Utilizar el fármaco A como un tratamiento válido
- c) Realizar un nuevo estudio con un mayor número de pacientes
- d) Indicar la asociación del fármaco A + B como el nuevo tratamiento válido
- e) Realizar un nuevo estudio que compare el fármaco A contra un placebo

15) Calcule el Odds ratio aproximado, utilizando la siguiente información de un estudio de prevalencia. Elija la alternativa que contenga al valor de dicho OR.

	Gastritis antral (+)	Gastritis antral (-)	Total
H. Pylori (+)	600	150	750
H Pylori (-)	50	200	250
Total	650	350	1000

- a) Menor a 1
- b) Entre 1 y 5
- c) Entre 5 y 10
- d) Entre 10 y 15
- e) Mayor a 15

16) La tasa de mortalidad materna corresponde a:

- a) Muertes de mujeres embarazadas / total de embarazos
- b) Muertes relacionadas con el embarazo, parto y puerperio / nacidos vivos
- c) Muertes relacionadas con el embarazo, parto y puerperio / total de embarazos
- d) Muertes de mujeres que han sido madres / total de embarazos
- e) Muertes de mujeres embarazadas / nacidos vivos

17) Se pretende confirmar una enfermedad en un paciente. Para esto se necesita un examen con:

- a) Alta sensibilidad
- b) Alta especificidad
- c) Alto valor predictivo negativo
- d) Bajo likelihood ratio positivo
- e) Bajo likelihood ratio negativo

18) Se realiza un estudio que determina que es más barato operar a todos los pacientes con colelitiasis, que tratar a aquellos que desarrollan complicaciones como el cáncer de vesícula biliar y las colecistitis aguda grave. ¿Qué tipo de estudio es?

- a) Costo-eficacia
- b) Costo-eficiencia
- c) Costo-utilidad
- d) Costo-beneficio
- e) Minimización de costos

19) Las actividades que promueven un estilo de vida saludable, con alimentación adecuada y ejercicios habituales corresponde a:

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Prevención específica
- e) Protección de la salud

20) En un pueblo africano de 1.000 personas, aparecen 60 casos de ébola durante un año, de los cuales 54 mueren. Calcule la letalidad del ébola:

- a) 90%
- b) 54 por mil
- c) 60 por mil
- d) 90 por mil
- e) 1,1

Prueba 7
VER PSIQUIATRÍA prueba 5

SALUD PÚBLICA RESPUESTAS

Prueba 1	20 D	18 C	14 C	10 B	3 D
1 E		19 C	15 E	11 B	4 A
2 A		20 D	16 A	12 D	5 D
3 A	Prueba 2	21 E	17 C	13 A	6 E
4 A	1 A		18 B	14 D	7 A
5 B	2 B		19 D	15 C	8 C
6 A	3 A	Prueba 3	20 E	16 A	9 A
7 B	4 B	1 A	Prueba 4	17 B	10 A
8 A	5 C	2 C	1 E	18 A	11 B
9 C	6 E	3 B	2 B	19 C	12 A
10 B	7 B	4 C	3 C	20 A	13 C
11 A	8 A	5 E	4 B	21 A	14 C
12 D	9 B	6 B	5 A		15 E
13 C	10 A	7 B	6 A	Prueba 5	16 B
14 D	11 C	8 C	7 A	1 B	17 B
15 E	12 B	9 C	8 B	2 C	18 D
16 C	13 D	10 B	9 C		19 A
17 A	14 C	11 E			20 A
18 B	15 E	12 D			
19 A	16 A	13 B			
	17 C				

VIII) PRUEBAS GRANDES CIRUGÍA, ESPECIALIDADES, SALUD PÚBLICA y PSIQUIATRÍA

Prueba 1

1) Un niño de 3 años presenta retraso del lenguaje y parece no escuchar bien cuando se le habla. Actualmente dice cerca de 100 palabras, con múltiples errores en la pronunciación, mayores a los esperados para su edad. A la otoscopia se observan tímpanos rosados bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar impedanciometría
- c) Iniciar antibióticos
- d) Indicar audífonos
- e) Derivar para cirugía de implante coclear

2) El aumento del tamaño muestral es útil para disminuir:

- a) Los sesgos de selección
- b) Los sesgos de información
- c) Los sesgos por variable confundente
- d) El error aleatorio o tipo 1
- e) Los sesgos de medición

3) Una mujer de 24 años se separa de su marido, con quien llevaba sólo 2 años de casada, evolucionando con tristeza, falta de motivación, labilidad emocional e ideas de muerte. Ha dejado de ir al gimnasio y de juntarse con sus amigas, porque se siente avergonzada de su situación y ya no le genera bienestar el relacionarse con otros. Además ha bajado considerablemente su rendimiento en el trabajo y refiere que le es muy difícil concentrarse. Los síntomas se han vuelto especialmente intensos en el último mes, por lo que decide consultar. El diagnóstico más probable es:

- a) Duelo normal
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Distimia
- d) Trastorno adaptativo
- e) Depresión mayor

4) ¿Cuál de las siguientes alteraciones espera encontrar en un paciente con cataratas?

- a) Alteración del rojo pupilar
- b) Defecto pupilar aferente
- c) Midriasis
- d) Anisocoria
- e) Leucoma

5) Un paciente presenta un tumor testicular derecho, que es confirmado con ecografía testicular, por lo que se decide realizar una orquiectomía radical. La biopsia quirúrgica es informada como seminoma puro y los marcadores tumorales demuestran alfa-fetoproteína negativa y beta-HCG levemente positiva. Además, el TAC abdominal no muestra adenopatías retroperitoneales y la radiografía de tórax es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar radioterapia retroperitoneal
- b) Realizar quimioterapia
- c) Realizar linfadenectomía lumboaórtica (LALA)
- d) Realizar orquiectomía bilateral
- e) Sospechar teratoma maligno y reestudiar la pieza quirúrgica

6) La tiroidectomía total se clasifica como una herida de tipo:

- a) Limpia
- b) Limpia contaminada
- c) Contaminada
- d) Sucia
- e) Superficial

7) Un paciente de 35 años consulta por aparición de una lesión dolorosa en el muslo derecho, de rá

pido crecimiento en algunas horas. Al examen físico se observa una placa de 15 x 10 cm con centro necrótico, rodeado de un área violácea y por fuera una zona eritematosa. El diagnóstico más probable es:

- a) Pioderma gangrenoso
- b) Ectima gangrenoso
- c) Fasceítis necrotizante
- d) Loxocelismo
- e) Mucormicosis

8) Un paciente cae de una bicicleta, cayendo sobre la extremidad superior izquierda, resultando con una fractura supracondílea de húmero. Además presenta anestesia de la cara palmar de los dedos medio, índice y pulgar, asociada a imposibilidad de flectarlos. ¿Qué estructura se encuentra afectada con mayor probabilidad?

- a) Nervio mediano
- b) Nervio cubital
- c) Nervio radial
- d) Nervio musculocutáneo
- e) Nervio axilar

9) La probabilidad de enfermar en un período de tiempo, se denomina:

- a) Tasa de ataque
- b) Tasa de incidencia
- c) Tasa de letalidad
- d) Tasa de prevalencia
- e) Tasa de transmisibilidad

10) Un paciente de 25 años vive con sus padres y trabaja esporádicamente en diversos trabajos, sin embargo nunca ha podido conseguir un trabajo estable, ya que es considerado como ineficiente y extraño por sus compañeros de trabajo. Es marcadamente apático, no tiene amigos y en muchas ocasiones habla de espíritus malignos y brujas que lo persiguen y ponen a la gente contra él. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad paranoide
- b) Trastorno de personalidad esquizoide
- c) Trastorno de personalidad esquizotípico
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Esquizofrenia

11) Un paciente ingresa a cirugía de urgencia por una herida penetrante abdominal. ¿Qué medida estaría MENOS indicada para el manejo anestésico de este paciente?

- a) Administración de oxígeno al 100%
- b) Inducción con drogas endovenosas
- c) Ventilación con ambú
- d) Relajación con succinilcolina
- e) Intubación ototraqueal

12) La visión tubular es característica de:

- a) Compresión del quiasma óptico
- b) Glaucoma de ángulo abierto
- c) Desprendimiento de retina
- d) Degeneración macular relacionada con la edad
- e) Edema macular

13) ¿Cuál de las siguientes situaciones NO debe ser manejada de manera quirúrgica?

- a) Insuficiencia mitral severa, secundaria a endocarditis bacteriana aguda, por estafilococo dorado
- b) Estenosis aórtica, asociada a angina crónica y síncope de esfuerzo
- c) Insuficiencia aórtica, asociada a marcada disnea y disminución de la capacidad funcional
- d) Estenosis mitral severa, con elevado gradiente transvalvular y área de abertura valvular de 0,6 cm
- e) Endocarditis bacteriana subaguda, sobre válvula aórtica bicúspide

14) Una nueva prueba de detección de fenilcetonuria presenta un valor predictivo positivo de 50% y un valor predictivo negativo de 100%. Con esta información se puede afirmar que:

- a) La sensibilidad será de 100%
- b) La especificidad será de 100%
- c) Si un paciente presenta un resultado positivo se confirma la enfermedad
- d) No existirán falsos positivos
- e) La prevalencia de la enfermedad es más baja de lo esperado

15) Un hombre de 25 años es considerado como antipático y petulante por sus compañeros de universidad. Es muy envidioso y muchas veces se burla de quienes obtienen malas calificaciones calificándolos de estúpidos. Explica que sus compañeros lo aíslan porque se sienten envidiosos de su inteligencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Episodio maníaco
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno de personalidad narcisista
- d) Trastorno de personalidad antisocial
- e) Trastorno de conducta

16) La uropatía obstructiva no complicada, secundaria a una hiperplasia benigna de la próstata, suele tratarse con:

- a) Cirugía
- b) Sonda Foley
- c) Alfa-agonistas
- d) Beta-agonistas
- e) Alfa-antagonistas

17) Un paciente presenta vértigo desde hace una hora, lo que le dificulta la marcha, sufriendo varias caídas. Al examen físico se aprecia nistagmos espontáneo, multidireccional, que se mantiene constante al solicitarle que fije la mirada en un punto. Al cerrar los ojos presenta tendencia a caer hacia cualquier lado, la marcha es descoordinada y presenta gran torpeza a los movimientos de las extremidades. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antivertiginosos orales de manera horaria por 7 días
- b) Iniciar corticoides según horario y antivertiginosos según síntomas
- c) Solicitar examen de octavo par e iniciar tratamiento sintomático con flunarizina
- d) Indicar manobras de reposición y antivertiginosos
- e) Hospitalizar y solicitar resonancia magnética de cerebro

18) Un paciente de 30 años presenta dolor lumbar muy intenso que inició al levantar un mueble y que le impide la mayoría de los movimientos de la columna lumbar. Al examen físico se observa muy adolorido, con signos vitales normales y limitación de la flexión y rotación de la columna lumbar, debido al dolor. El examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de columna lumbar
- b) Solicitar TAC de columna lumbar
- c) Solicitar RMN de columna lumbar
- d) Indicar reposo absoluto y relajantes musculares
- e) Indicar AINEs y reposo relativo

19) Un paciente de 65 años presenta olvidos frecuentes y repetición de algunas ideas, asociados a dificultad para realizar sus tareas habituales. En el examen mental invierte series con normalidad, y mantiene la memoria a largo plazo, sin embargo presenta varias fallas en las pruebas de memoria reciente. El examen neurológico no presenta signos focales y sólo destaca cierta torpeza motora, sin signos cerebelosos. El diagnóstico más probable es:

- a) Envejecimiento normal
- b) Depresión
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Delirium
- e) Demencia por cuerpos de Lewy

20) Una paciente de 45 años lava la loza con un nuevo detergente, presentando a las 6 horas prurito, eritema y dolor de las manos. Al examen se observa edema, eritema, microvesículas y grietas en ambas manos. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Dermatitis de contacto irritativa
- c) Urticaria aguda
- d) Dermatitis atópica
- e) Síndrome de Steven Johnson

21) Un paciente de 20 años cae a nivel, apoyando la mano en extensión. Presenta dolor leve, manteniendo los movimientos de la mano, sin embargo al examen físico presenta importante dolor a la palpación de la tabaquera anatómica. El diagnóstico más probable es:

- a) Tendinitis de Quervein
- b) Fractura de trapecio
- c) Fractura de escafoides
- d) Fractura de trapezoide
- e) Fractura de la apófisis estiloides del radio

22) Se seleccionan 1.000 pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca severa, de los cuales 500 son tratados con enalapril, atenolol, furosemida y espironolactona, mientras que a los otros 500, además de recibir esos medicamentos, se les implanta un marcapasos con resincronización. Se evalúa a la mejoría de los síntomas, la ocurrencia de arritmias, y las sobrevidas promedios en ambos grupos. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) De prevalencia
- b) Ensayo clínico
- c) Cohortes
- d) Casos y controles
- e) Ensayo de campo

23) El litio suele ser el estabilizador del ánimo de elección para la mantención de los pacientes con trastorno bipolar, excepto en el embarazo, por ser teratogénico. La intoxicación por litio suele manifestarse como:

- a) Midriasis, palpitaciones e hipotonía
- b) Miosis, temblor e hipertonía
- c) Temblor, síntomas gastrointestinales y confusión
- d) Anuria, confusión y depresión respiratoria
- e) Tetania, depresión respiratoria y taquicardia

24) Una asesora del hogar presenta una amputación de la falange distal del dedo medio izquierdo, mientras cocinaba en la casa en que trabaja desde hace 3 años. Tiene contrato vigente y está afiliada a una AFP y a FONASA, en categoría C, sin embargo no está afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad ni a la Mutual de Seguridad. Los costos del tratamiento y rehabilitación, deberían ser financiados por:

- a) FONASA
- b) La Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad
- c) La AFP
- d) El empleador
- e) La trabajadora

25) Una paciente de 28 años presenta desde hace 6 meses placas eritematosas, con descamación fina, ligeramente pruriginosas en el cuero cabelludo y en las cejas, recidivantes, con periodos de mayor actividad. El diagnóstico más probable es:

- a) Urticaria crónica
- b) Eccema numular
- c) Dermatitis de contacto
- d) Dermatitis seborreica
- e) Psoriasis

26) En el glaucoma agudo, usted espera encontrar todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Aumento de la tonicidad del ojo comprometido
- b) Miosis que no responde a la luz
- c) Vómitos
- d) Ojo rojo profundo
- e) Dolor

27) Una paciente de 65 años consulta por fiebre y dolor en el hemiabdomen inferior, mayor a la izquierda. Al examen se aprecia dolor a la palpación abdominal, especialmente en la fosa iliaca izquierda, asociado a resistencia muscular. ¿Qué medida NO tomaría frente a esta paciente?

- a) Indicar régimen liviano
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Iniciar antibióticos de amplio espectro
- d) Realizar colonoscopia de urgencia
- e) Administrar analgésicos

28) Una paciente consulta por nerviosismo, palpitaciones, diarrea y baja de peso. Ha presentado en 2 oportunidades palpitaciones intensas, asociadas a disnea y sensación de muerte. Al examen físico destaca piel fina y húmeda, temblor fino de extremidades inferiores y se palpa pulso irregular. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno conversivo
- d) Hipertiroidismo
- e) Trastorno por somatización

29) Se desea comparar el valor del hematocrito de dos grupos. El primero está compuesto por 100 pacientes insuficientes renales, tratados con hierro endovenoso y el segundo está formado por 150 pacientes con insuficiencia renal, tratados con eritropoyetina subcutánea. La mejor prueba para determinar la significancia estadística es:

- a) Chi cuadrado
- b) "t" de Student
- c) Análisis de varianza
- d) "r" de Pearson
- e) Prueba de distribución normal

30) Un paciente de 70 años, sin antecedentes ni hábitos de importancia, consulta por vómitos postprandiales, asociados a baja de peso. Refiere que vomita luego de cada comida y que este cuadro ha ido empeorando progresivamente, desde hace 5 meses. Al examen físico se aprecia pálido y enflaquecido. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar prokinéticos
- b) Iniciar metronidazol
- c) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Solicitar endoscopia digestiva alta

31) Un paciente de 60 años, obrero de la construcción, fumador habitual, consumidor de alcohol, es traído al servicio de urgencias, ya que se presenta muy agitado, con alucinaciones visuales de serpientes y lagartijas que lo atacan y trepan por su cuerpo. Al examen físico se aprecia agitación psicomotora y marcado temblor. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar haloperidol 10 mg intramuscular, solicitar exámenes generales y un TAC de cerebro
- b) Administrar haldol 1 mg endovenoso e iniciar estudio de patología infecciosa
- c) Administrar suero glucosado y tiamina endovenosa
- d) Solicitar exámenes generales e iniciar clozapina oral
- e) Administrar diazepam endovenoso y solicitar exámenes generales

32) El tratamiento de un tumor renal sólido de 5 cm en un paciente previamente sano, suele ser:

- a) Nefrectomía radical más quimioterapia postoperatoria

- b) Nefrectomía radical más radioterapia postoperatoria
- c) Nefrectomía radical
- d) Nefrectomía parcial más quimioterapia postoperatoria
- e) Nefrectomía parcial más radioterapia postoperatoria

33) Un paciente sufre atropello, con un importante golpe en el pecho. Evoluciona con dificultad respiratoria, que requiere de oxígeno al 30%, para alcanzar saturaciones arteriales normales. Al examen se está taquicárdico, normotenso, con yugulares normales y tórax simétrico. Se auscultan crépitos bilaterales, mayores en el campo pulmonar izquierdo, El diagnóstico más probable es:

- a) Hemotórax
- b) Neumotórax a tensión
- c) Neumotórax normotensivo
- d) Contusión pulmonar
- e) Taponamiento cardíaco

34) Un paciente de 35 años presenta una lesión pruriginosa en la zona posterior del cuello desde hace algunos meses. Al examen se aprecia una placa de 7 cm de diámetro, eritematosa, liquenificada, con descamación fina, algunas costras y signos de grataje. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto
- b) Liquen simple
- c) Liquen plano
- d) Prúriga
- e) Psoriasis

35) ¿Cuál de las siguientes valvulopatías es especialmente riesgosa, desde el punto de vista cardiovascular, en el manejo anestésico de un paciente?

- a) Estenosis aórtica
- b) Estenosis mitral
- c) Insuficiencia tricuspídea
- d) Insuficiencia aórtica
- e) Insuficiencia mitral

36) ¿Qué institución representa al ministerio de salud en las distintas regiones del país?

- a) CENABAST
- b) FONASA
- c) Municipalidad
- d) SEREMI
- e) Servicio de Salud

37) Un paciente de 25 años, mientras jugaba fútbol, sufre varo forzado de la rodilla derecha, evolucionando con intenso dolor. Al examen presenta dolor muy intenso a la palpación de la cara lateral de la rodilla derecha y al reproducir el varo. La maniobra de Appley es negativa, al igual que los signos de cajón y los bostezos. El diagnóstico más probable es:

- a) Lesión meniscal aguda
- b) Tendinitis de la pata de ganso
- c) Esguince de rodilla
- d) Rotura de ligamento colateral medial
- e) Fractura de rodilla

38) Una mujer refiere que presenta rinorrea y obstrucción nasal diaria, de predominio nocturno y que se exacerba cuando limpia la casa. También presenta estornudos frecuentes y prurito nasal. ¿Qué tratamientos recomendaría para la patología descrita?

- a) Antihistamínicos H2 orales y corticoides orales
- b) Descongestionantes orales y corticoides tópicos
- c) Antihistamínicos H2 tópicos y corticoides orales
- d) Antihistamínicos H1 orales y corticoides tópicos
- e) Descongestionantes tópicos y corticoides orales

39) Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que no es adecuadamente tratado, suelen complicarse con:

- a) Agorafobia
- b) Depresión
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno de angustia

40) Un paciente de 30 años presenta un aumento de volumen en el antebrazo izquierdo de 4 cm, de diámetro, no doloroso, de muy lento crecimiento, en 5 años. Al examen físico se palpa un tumor bajo la piel, de consistencia blanda, bordes bien definidos y regulares. La piel se moviliza fácilmente sobre dicho tumor y no presenta alteraciones macroscópicas. El diagnóstico más probable es:

- a) Celulitis
- b) Sarcoma de partes blandas
- c) Melanoma nodular
- d) Lipoma
- e) Quiste sebáceo

41) Un paciente de 23 años presenta máculas hipopigmentadas en las manos, cerca de los ojos y de la boca, que aparecieron hace varios meses y que han ido aumentando de tamaño. No presentan dolor, prurito ni signos inflamatorios. El diagnóstico más probable es:

- a) Vitiligo
- b) Pityriasis alba
- c) Pityriasis versicolor
- d) Dermatitis de contacto
- e) Psoriasis guttata

42) ¿Cuál de las siguientes alteraciones requiere de derivación al oftalmólogo?

- a) Cuerpo extraño tarsal
- b) Contusión ocular
- c) Herida palpebral transfixiante
- d) Dacriocistitis aguda
- e) Hemorragia subconjuntival

43) Una paciente de 14 años presenta baja de peso, diarrea y amenorrea desde hace algunos meses. Es muy delgada, pesando 40 kilogramos, sin embargo ella se considera obesa y por eso vomita después de ser obligada a comer. La madre la sorprendió usando lactulosa y sibutramina. El diagnóstico más probable es:

- a) Anorexia nervosa
- b) Enfermedad celíaca
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Bulimia

44) Un estudio pretende determinar la relación entre el uso de anticonceptivos orales y la aparición de cáncer de cuello uterino, sin embargo se sabe que las mujeres que presentan actividad sexual con varias parejas tienen más incidencia de cáncer de cuello uterino y que también suelen ocupar anticonceptivos orales con mayor frecuencia que aquellas con pareja única o sin actividad sexual. Con esta información, se puede afirmar que:

- a) No se puede determinar si existe relación entre el uso de anticonceptivos orales y el cáncer de cuello uterino
- b) El efecto carcinogénico de los anticonceptivos orales sería mayor en aquellas pacientes que mantienen actividad sexual con varias parejas
- c) La actividad sexual con varias parejas actuaría como variable de confusión
- d) El uso de anticonceptivos orales no se relacionaría con la aparición de cáncer de cuello uterino, ya que éste es causado por el virus papiloma humano
- e) Aquellas mujeres que mantienen varias parejas sexuales no deben ocupar anticonceptivos orales, ya que aumentarían aún más el riesgo de presentar cáncer de cuello uterino

45) La causa más frecuente de fiebre, durante las 24 horas siguientes a una cirugía, es:

- a) Infección de la herida operatoria

- b) Neumonía
- c) Atelectasias
- d) Secundaria los medicamentos
- e) Flebitis

46) Un paciente consulta por dolor ocular intenso, especialmente al estar expuesto a la luz, lo que le impide abrir el ojo. Al examen se observa ojo rojo profundo, sin secreción. Las pupilas son isocóricas y los reflejos fotomotor y de acomodación se encuentran conservados. El diagnóstico más probable es:

- a) Uveítis aguda
- b) Iridociclitis
- c) Queratitis aguda
- d) Glaucoma de ángulo abierto
- e) Conjuntivitis por adenovirus

47) ¿Qué alteración NO esperaría encontrar en un paciente con trastorno por somatización?

- a) Prurito faríngeo
- b) Convulsiones "atípicas"
- c) Disfagia
- d) Dolor abdominal
- e) Disuria

48) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- a) La incontinencia urinaria de urgencias se caracteriza por pérdidas de pequeñas cantidades de orina
- b) La incontinencia urinaria de esfuerzos presenta contracciones no inhibidas en la cistomanometría
- c) Ante un escape continuo de orina, a modo de goteo persistente, debe sospecharse una incontinencia urinaria de esfuerzos
- d) La incontinencia urinaria de urgencias suele ser de resolución quirúrgica
- e) La vejiga neurogénica suele tratarse con autocateterismo limpio

49) Una paciente de 17 años ingiere 100 comprimidos de loratadina hace 4 horas. Al examen físico sus signos vitales son normales y no presenta otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar lavado gástrico
- b) Enviar a domicilio, tranquilizando a los familiares, ya que la loratadina es un medicamento relativamente inocuo
- c) Enviar a domicilio, prevenir a los familiares de esconder los medicamentos más peligrosos e indicar control ambulatorio en el policlínico de salud mental
- d) Observar por 6 horas y en caso de no presentar empeoramiento enviar a domicilio con antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina y control en el policlínico de salud mental
- e) Hospitalizar, mantener en observación, indicando evaluación psiquiátrica

50) Un hombre de 65 años presenta varias lesiones en la frente y en dorso de las manos, indoloras, no pruriginosas, solevantadas, ásperas al tacto, y con fina descamación, de lento crecimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis seborreicas
- b) Queratosis actínicas
- c) Léntigos solares
- d) Carcinomas espinocelulares
- e) Dermatitis seborreica

51) Un paciente de 35 años presenta rotación e inversión forzada del pie izquierdo, al tropezar en una escalera, evolucionando con intenso dolor e imposibilidad de apoyar el pie. Al examen se observa gran edema y equimosis del tobillo izquierdo, asociados a intenso dolor a la palpación de la zona y especialmente de los maléolos. EL diagnóstico más probable es:

- a) Rotura del tendón aquiliano
- b) Esguince de tobillo grado I
- c) Esguince de tobillo grado II
- d) Rotura de la sindesmosis peroneo-tibial
- e) Fractura de tobillo

52) Una paciente de 30 años presenta un cuadro de palpitaciones, disnea, opresión precordial, parestesias y marcada angustia, de instalación relativamente rápida, mientras estaba en el metro.

Luego de esa vez ha presentado 3 episodios similares, sin poder identificar un desencadenante claro. Está muy preocupada por lo que le ha pasado, porque cree que podría sufrir un infarto en alguno de esos eventos, razón por la cual evita ir al metro y sale siempre acompañada. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de angustia con agorafobia
- c) Trastorno de pánico sin agorafobia
- d) Fobia social
- e) Fobia específica

53) Un paciente de 60 años consulta por intenso dolor abdominal, epigástrico, irradiado a dorso, de 6 horas de evolución, asociado a vómitos alimentarios y marcado compromiso del estado general. Evoluciona con dificultad respiratoria y tendencia a la hipotensión. Al examen físico presenta pulso de 105 lpm, PA: 90/50 mmHg, t°: 37,5°C, auscultación cardíaca con ritmo regular en 2 tonos y auscultación pulmonar con crépitos difusos bilaterales. En sus exámenes de sangre presenta creatinina: 1,7 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, Na: 133 mEq/l, K: 4,7 mEq/l, Cl: 97 mEq/l, Ca: 7,8 mg/dl, hematocrito: 32%, glóbulos blancos: 16.700 por mm³, plaquetas: 400.000 por mm³, GOT: 230 U/l, bilirrubina: 2,1 mg/dl, pH: 7,3, PaO₂: 58 mmHg, PaCO₂: 40 mmHg. La radiografía de tórax demuestra edema pulmonar y el electrocardiograma sólo muestra alteraciones inespecíficas de la repolarización. El diagnóstico más probable es:

- a) Disección aórtica
- b) Accidente vascular mesentérico
- c) Perforación de úlcera gástrica
- d) Pancreatitis aguda
- e) Infarto agudo al miocardio

54) ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre patología y clínica es incorrecta?

- a) Disquinesia tardía – Movimientos reptantes de la lengua
- b) Balismo – Movimientos reptantes de grupos musculares pequeños de la zona distal de las extremidades
- c) Acatisia – Malestar al permanecer quieto, que se alivia con cambios frecuentes de posición
- d) Distonía – Aumento del tono de un grupo de músculos
- e) Parkinsonismo – Temblor de reposo

55) Respecto a los estudios de casos y controles es FALSO que:

- a) Son muy útiles para estudiar patologías poco frecuentes
- b) Suelen ser de bajo costo
- c) Permiten calcular el odds ratio
- d) Permiten determinar causalidad
- e) Permiten determinar el pronóstico de una patología

56) ¿Cuál de las siguientes patologías tiene mayor sobrevida?

- a) Cáncer de pulmón
- b) Cáncer de colon
- c) Cáncer de esófago
- d) Cáncer de estómago
- e) Hepatocarcinoma

57) ¿Cuál de los siguientes enunciados es más representativo de una amigdalitis pultácea complicada?

- a) Fiebre de 40°C, asociada a compromiso del estado general
- b) Presencia de múltiples adenopatías cervicales, sensibles a la palpación
- c) Dolor muy intenso, que impide la apertura bucal
- d) Náuseas y vómitos alimentarios en varias oportunidades
- e) "Voz de papa caliente" y ronquidos en el sueño

58) Un paciente de 54 años, hipertenso, portador de una arritmia completa por fibrilación auricular, presenta, de manera súbita, dolor en la extremidad izquierda, asociada a parestesias. Al examen físico

se aprecia palidez y ausencia de pulso en dicha extremidad. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina y solicitar eco-doppler de extremidades inferiores
- b) Solicitar pletismografía de volumen de extremidades inferiores
- c) Realizar un bypass femoro-femoral
- d) Administrar heparina endovenosa y realizar angiografía femoral
- e) Solicitar Holter de arritmias e iniciar antiagregantes plaquetarios

59) Calcule el Odds Ratio del consumo de cigarrillo para el desarrollo de cáncer de vejiga, con la siguiente información (Valor aproximado):

	Cáncer de Vejiga	Sanos	TOTAL
Fumadores	100	100	200
No fumadores	50	300	350
TOTAL	150	400	550

- a) 0,17
- b) 2,00
- c) 2,67
- d) 3,50
- e) 6,00

60) Un paciente de 32 años es traído por sus familiares, ya que presenta ideas extrañas y está muy irritable. Trabaja hasta avanzadas horas de la noche en un nuevo proyecto que ha decidido emprender y se despierta temprano, para proseguir con sus actividades, habiendo incurrido en grandes gastos de dinero. El se ve muy molesto con su situación y refiere que sus familiares no confían en él y por eso no lo dejan seguir adelante con el negocio que está iniciando, en el que obtendrá grandes utilidades. Habla mucho y pasa fácilmente de un tema a otro. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno bipolar en fase maníaca
- d) Depresión psicótica
- e) Trastorno adaptativo

61) Una paciente de 24 años presenta dolor lumbar, irradiado a la vulva, muy intenso, desde hace 1 hora. Ha presentado varios episodios de vómitos y a la observación se aprecia muy inquieta. EL diagnóstico de sospecha es:

- a) Colecistitis aguda
- b) Colédocolitiasis
- c) Cólico renal
- d) Pielonefritis aguda
- e) Infarto mesentérico

62) ¿Cuál de los siguientes parámetros es más adecuado para medir la productividad de un hospital?

- a) Índice de ocupación de camas
- b) Número de pacientes hospitalizados
- c) Promedio de días de estadía
- d) Recursos propios generados
- e) Nivel de endeudamiento

63) Un paciente de 20 años presenta autoestima muy baja y no se relaciona con otras personas, porque se considera inferior y teme ser rechazado. Por esto evita los trabajos en grupo y no acude a fiestas ni otras actividades donde deba interactuar con los demás. Refiere que le gustaría tener amigos, pero su timidez se lo dificulta. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Distimia
- c) Fobia social
- d) Trastorno de personalidad evitativo
- e) Síndrome de Asperger

64) Un paciente de 35 años presenta otalgia intensa, asociada a otorrea. Al examen físico se observa marcado eritema del conducto auditivo externo, con abundante otorrea, sin compromiso del tímpano.

La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar amoxicilina oral y analgésicos
- b) Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y analgésicos
- c) Iniciar ciprofloxacino en gotas óticas y analgésicos
- d) Derivar a otorrinolaringología, de manera urgente
- e) Hospitalizar e iniciar analgésicos y aminoglicósidos endovenosos

65) ¿Cómo se compran los medicamentos en los consultorios?

- a) Se compran a distintos proveedores, según su precio, calidad y garantías
- b) Se compran al mismo laboratorio
- c) Los compra la CENABAST y luego los asigna al consultorio
- d) Los compra el Servicio de Salud y luego los asigna al consultorio
- e) Se compran al proveedor más barato y con menores tiempos de entrega

66) Una paciente de 35 años presenta una fractura de fémur derecho, durante un accidente de tránsito. Evolucionando con importante dolor, que día a día se hace más intenso. Al examen físico presenta importante dolor a la movilización de los ortijos y se aprecia adelgazamiento de la piel del pie derecho y disminución de los fanéreos. La sensibilidad y los pulsos distales son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Retraso de la consolidación
- b) Pseudoartrosis (no unión)
- c) Síndrome compartimental
- d) Distrofia simpático refleja
- e) Retracción isquémica de Volkmann

67) Una paciente de 54 años, fumadora, presenta hematuria en 2 ocasiones, sin otros síntomas. Al examen físico no se aprecian alteraciones. Se solicita un sedimento de orina que muestra más de 100 glóbulos rojos por campo, sin dismorfia. El hemograma, la creatinina y los electrolitos plasmáticos son normales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar perfil uretral
- b) Solicitar uretrocistografía retrógrada endoscópica
- c) Solicitar ANA, ANCA y complemento
- d) Solicitar ecografía renal y vesical
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

68) Se realiza un test de tolerancia a la glucosa a 500 personas, diagnosticadas de obesidad y a 500 personas, con peso normal, determinando la cantidad de pacientes diabéticos e intolerantes a la glucosa en cada uno de los grupos. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Casos y controles
- b) Ensayo clínico
- c) Cohortes
- d) Transversal
- e) Ecológico

69) Un niño de 5 años es diagnosticado de trastorno oposicionista desafiante. ¿Qué situación NO le parece acorde con este diagnóstico?

- a) Rabietas cuando no se hace lo que quiere
- b) Buenas relaciones con sus compañeros de juegos
- c) Inteligencia normal
- d) Robos de pequeñas cantidades de dinero a sus padres
- e) Actitud irreverente al recibir una orden

70) Respecto a los nódulos pulmonares solitarios es cierto que:

- a) Habitualmente son de origen maligno
- b) Frecuentemente producen dolor
- c) El quiste hidatídico pulmonar se diagnostica mediante ecografía de tórax
- d) Las radiografías previas no suelen ser de mucha utilidad
- e) Los nódulos parahiliares se biopsian mediante punción percutánea, guiada por imagen

Prueba 2

1) ¿Cuál de las siguientes alternativas NO es concordante con el diagnóstico de vértigo periférico?

- a) Tinnitus
- b) Nistagmos multidireccional
- c) Vómitos
- d) Inicio súbito
- e) Disminución de los síntomas al fijar la mirada

2) La bulimia nervosa se caracteriza fundamentalmente por:

- a) Sobrepeso
- b) Presencia de atracones
- c) Desnutrición
- d) Vómitos autoinducidos
- e) Uso de laxantes

3) Una paciente de 45 años presenta gran tristeza y desesperanza, llorando con frecuencia y sintiéndose muy fatigada. Refiere que ya nada le levanta el ánimo, ni siquiera las cosas que habitualmente la divertían y que ha pensado en morirse en varias oportunidades, de hecho un día estuvo a poco de tomar unas pastillas para suicidarse. Su madre murió hace 3 meses y actualmente está muy endeudada. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión mayor
- b) Distimia
- c) Trastorno bipolar
- d) Depresión psicótica
- e) Trastorno psicótico

4) El tratamiento de la rinitis alérgica perenne es:

- a) Corticoides orales y/o antihistamínicos orales
- b) Antihistamínicos tópicos y/o inhibidores de leucotrienos orales
- c) Corticoides tópicos y/o antihistamínicos orales
- d) Antihistamínicos orales y/o inhibidores de leucotrienos orales
- e) Corticoides orales y/o antihistamínicos tópicos

5) Un paciente de 47 años consulta por dolor abdominal intenso, localizado en el hipocondrio derecho y asociado a vómitos. Al examen físico está febril hasta 38,5°C, con FC: 94x', PA: 120/80 mmHg. El abdomen es doloroso, especialmente en el hipocondrio derecho. Se solicitan exámenes que demuestran hematocrito normal, con leucocitosis de 16.500 x mm³, plaquetas normales, lipasa normal, transaminasas normales, bilirrubina: 1,6 mg/dl, fosfatasas alcalinas normales y pruebas de función renal normales. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar endoscopia digestiva alta
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar radiografía de abdomen de pie
- e) Iniciar antibióticos endovenosos

6) Para evitar sesgos por variable confundente se debe:

- a) Aumentar el tamaño de la muestra
- b) Aleatorizar estratificadamente
- c) Enmascarar la información (doble ciego)
- d) Utilizar un grupo de control
- e) Calcular el error alfa

7) Un paciente debe lavar sus manos luego de tocar cualquier superficie que no esté previamente esterilizada, porque queda con la sensación de infectarse con gérmenes. Esto le causa mucha

angustia, ya que es visto como una persona rara por sus compañeros de trabajo y familiares, pero no lo puede evitar. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno delirante
- d) Esquizofrenia
- e) Manía

8) Es característico de los vicios de refracción:

- a) La baja prevalencia en la población
- b) La disminución simétrica del rojo pupilar
- c) La mejoría de la agudeza visual al mirar por un agujero estenopeico
- d) La ausencia de reflejo de acomodación
- e) Las alteraciones en la visión de colores

9) El tratamiento del cáncer de próstata avanzado con metástasis óseas es:

- a) Paliativo
- b) Quirúrgico
- c) Radioterapia
- d) Quimioterapia más radioterapia
- e) Hormonoterapia

10) Un paciente de 57 años consulta por dolor abdominal muy intenso, de tipo cólico, asociado a vómitos alimentarios y distensión abdominal progresiva. Refiere que estuvo hospitalizado hace 4 años por una apendicitis aguda, la que se resolvió quirúrgicamente con éxito. Al examen físico se aprecia abdomen doloroso, distendido, timpánico, con bazuqueo y aumento de los ruidos intestinales. El diagnóstico más probable es:

- a) Trombosis de la vena mesentérica
- b) Trombosis de la vena porta
- c) Plastrón apendicular
- d) Obstrucción intestinal
- e) Embolía arterial mesentérica

11) La primera causa de disfonía crónica es:

- a) Parálisis del nervio laríngeo recurrente
- b) Cáncer glótico
- c) Cáncer supraglótico
- d) Infecciosa
- e) Funcional

12) Un examen diagnóstico tiene una sensibilidad de 84%. Esto significa que:

- a) El 84% de los pacientes con un resultado positivo tendrán la enfermedad
- b) El 84% de los pacientes sanos obtendrán un resultado negativo
- c) El 84% de los pacientes con un resultado negativo estará libre de la enfermedad
- d) El 84% de los pacientes enfermos presentará un resultado positivo
- e) El 84% de los pacientes con resultado positivo estará libre de enfermedad

13) Un paciente de 30 años presenta, desde hace algunos años, placas eritematodescamativas, indoloras, de 1 a 4 cm de diámetro, localizadas en los codos, rodillas y espalda, que en algunas ocasiones involucionan dejando zonas de hiperpigmentación cutánea. El diagnóstico más probable es:

- a) Pityriasis rosada
- b) Lupus
- c) Psoriasis
- d) Liquen simple
- e) Dermatitis de contacto

14) En las fracturas de la diáfisis humeral se suele comprometer:

- a) El nervio axilar

- b) El nervio radial
- c) La arteria braquial
- d) La vena cefálica
- e) El nervio cubital

15) La verborrea y la ideofugalidad son características de:

- a) La esquizofrenia
- b) La depresión
- c) El trastorno adaptativo
- d) La manía
- e) La distimia

16) El efecto adverso más frecuente que se observa en pacientes que usan antipsicóticos atípicos, como la risperidona, es:

- a) Síntomas extrapiramidales
- b) Vómitos
- c) Aumento de peso
- d) Alucinaciones
- e) Convulsiones

17) Un paciente consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a disminución de la agudeza visual del mismo ojo. Se aprecia ojo rojo profundo, asociado a miosis y leve enoftalmo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma agudo
- b) Glaucoma crónico
- c) Uveítis aguda
- d) Queratitis aguda
- e) Neuritis óptica

18) Un paciente sufre un accidente de tránsito por manejar en estado de ebriedad, resultando con fracturas de ambas piernas y amputación del pie derecho. La kinesioterapia que se indicará será una medida de:

- a) Protección de la salud
- b) Prevención específica
- c) Promoción de la salud
- d) Prevención secundaria
- e) Prevención terciaria

19) Un paciente de 30 años afirma que el diablo lo quiere matar y que posee a sus familiares y vecinos para que lo ataquen. En ocasiones ha intentado meterse en su cuerpo y le habla, amenazándolo e insultándolo. Sus familiares refieren que es muy apático y tranquilo, pero que desde hace algunos meses está con esas ideas, las que cada vez son más intensas. El diagnóstico más probable es:

- a) Psicosis reactiva
- b) Trastorno delirante
- c) Delirium
- d) Esquizofrenia
- e) Demencia

20) ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un inductor?

- a) Flumazenil
- b) Tiopental
- c) Fentanilo
- d) Succinilcolina
- e) Meperidina

21) ¿Qué fármaco se usa como aversivo en el tratamiento del alcoholismo?

- a) Naltrexona

- b) Metanol
- c) Disulfiram
- d) Flumazenil
- e) Bupropion

22) Una paciente de 55 años, diagnosticada de fibrilación auricular crónica, en tratamiento con atenolol, consulta por dolor de inicio súbito en las extremidades inferiores, asociadas a parestesias y dificultad para moverlas. Al examen físico se constatan ambas extremidades inferiores pálidas y frías, con marcada disminución de los pulsos poplíteos y ausencia de los pulsos pedios y tibiales posteriores. La primera medida a realizar es:

- a) Solicitar ecodoppler de extremidades inferiores
- b) Solicitar pletismografía de volumen de extremidades inferiores
- c) Solicitar angiografía de extremidades inferiores
- d) Administrar heparina endovenosa
- e) Administrar estreptoquinasa endovenosa

23) Un paciente consulta por dolor lumbar, irradiado a la extremidad inferior izquierda, por la cara posterior hasta la planta del pie. Al examen físico destaca debilidad para la flexión plantar del pie izquierdo y abolición del reflejo aquileano. ¿Qué raíz está comprometida?

- a) L3
- b) L4
- c) L5
- d) S1
- e) S2

24) Calcule la especificidad de una prueba diagnóstica de tromboembolismo pulmonar (TEP), con la siguiente información: “De un total de mil pacientes, cien de ellos efectivamente presentaron TEP y el resto se consideró sano. La prueba resultó positiva en 90 de los pacientes enfermos y en 45 de los pacientes sanos”.

- a) 95%
- b) 90%
- c) 67%
- d) 33%
- e) 10%

25) Un paciente de 69 años consulta por dolor de la rodilla izquierda, que se acentúa al caminar mucho. Al examen físico presenta movilidad completa e indolora de la rodilla, sin derrame articular ni otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de rodilla
- b) Examinar la cadera
- c) Iniciar paracetamol
- d) Solicitar ecografía rotuliana
- e) Derivar a salud mental

26) Una paciente de 50 años presenta pérdida completa de la visión, bilateral, luego de que su hijo fue arrestado por desórdenes en la vía pública. Luego de varios minutos recupera la vista. Su examen físico, incluyendo un completo examen neurológico y el fondo de ojo, es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno disociativo
- b) Trastorno conversivo
- c) Trastorno facticio
- d) Accidente isquémico transitorio
- e) Trastorno por somatización

27) Son pilares del manejo de una fractura expuesta EXCEPTO:

- a) Aseo con abundante suero fisiológico

- b) Analgesia
- c) Antibióticos endovenosos
- d) Yeso cerrado
- e) Vacunación antitetánica

28) Un paciente con antecedente de una uropatía obstructiva baja debida a hiperplasia benigna de la próstata, consulta por imposibilidad de orinar, asociada a dolor hipogástrico. Al examen físico se palpa un globo vesical. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Administrar bloqueadores alfa-adrenérgicos por vía endovenosa
- b) Solicitar uretrocistografía miccional
- c) Drenar con sonda Nelaton
- d) Instalar una sonda Foley
- e) Realizar una cistostomía percutánea

29) Un paciente presenta marcada disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo de rápida instalación en 2 días. Al examen destaca escape pupilar en dicho ojo (pupila de Marcus Gunn). El diagnóstico más probable es:

- a) Coriorretinitis
- b) Edema macular
- c) Desprendimiento de retina
- d) Neuritis óptica
- e) Trombosis de la vena central de la retina

30) Un paciente de 30 años afirma que su padre lo odia y quiere humillarlo frente a todos, sin embargo sus otros familiares dicen todo lo contrario y que su padre está muy preocupado por lo que piensa el paciente. Al indicarle esto, afirma que su padre es muy cínico y trata de convencer a los demás de que está loco, para ponerlos en su contra. No ha presentado alucinaciones y el examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno obsesivo compulsivo
- b) Esquizofrenia
- c) Depresión
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno de personalidad paranoide

31) Un paciente sufrió una herida por arma blanca en el brazo derecho, hace 3 años, de 5 centímetros de longitud, la que fue suturada 2 días después. Sin embargo la cicatriz quedó solevantada e hiperpigmentada, sin sobrepasar los límites de la herida. El diagnóstico más probable es:

- a) Queloide
- b) Sarcoma
- c) Cicatriz hipertrófica
- d) Melanoma
- e) Dermatitis de contacto alérgica

32) Un paciente de 26 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor torácico con tope inspiratorio. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y se ausculta una clara disminución del murmullo pulmonar derecho asociado a hipersonoridad a la percusión. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar electrocardiograma
- b) Solicitar radiografía de tórax
- c) Solicitar dímero D en sangre venosa
- d) Solicitar angio-TAC de tórax
- e) Puncionar el segundo espacio intercostal en la línea media claviclar

33) Un paciente de 54 años presenta una lesión solevantada en la mejilla derecha, con borde solevantado, brillante y depresión central, asociado a una telangiectasia adyacente. El diagnóstico má

s probable es:

- a) Melanoma
- b) Queratosis actínica
- c) Queratosis seborreica
- d) Carcinoma basocelular
- e) Carcinoma espinocelular

34) Una paciente de 25 años ha presentado en 4 oportunidades sensación de opresión precordial intensa, de instalación relativamente rápida, asociada a disnea, parestesias, sensación de muerte inminente y palpitaciones. No ha podido identificar un desencadenante claro y tiene mucho miedo de sufrir otro episodio similar y morirse o volverse loca en él. El examen físico, así como el Holter de arritmias es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de ansiedad generalizada
- b) Trastorno de ansiedad
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno por somatización
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

35) Usted recibe a un joven de 20 años, muy preocupado, porque acudió a un urólogo extranjero, debido a una tumoración testicular izquierda. Se realizó una ecografía testicular que confirmó la presencia de un tumor testicular izquierdo, sólido, hipoeecogénico, de 3,5 cm de diámetro y se tomaron marcadores tumorales (beta-HCG y alfa-fetoproteína), los que resultaron negativos. Con esta información, dicho urólogo le indicó que debía realizarse una orquiectomía, por lo que el paciente decidió consultar una segunda opinión. La conducta más adecuada es:

- a) Tranquilizar al paciente y solicitar nueva ecografía en 3 meses
- b) Solicitar un TAC de tórax y abdomen y decidir en base a los resultados
- c) Solicitar una biopsia por punción
- d) Indicar una tumorectomía, conservando la porción sana del testículo
- e) Explicarle que efectivamente debe realizarse la orquiectomía

36) Son ventajas de los estudios de casos y controles EXCEPTO:

- a) Son baratos
- b) Permiten inferir causalidad
- c) Presentan relativamente pocos sesgos
- d) Permiten relacionar una enfermedad con distintos factores de riesgo
- e) Son útiles en enfermedades poco frecuentes o que demoran muchos años en manifestarse

37) La incidencia corresponde a:

- a) La proporción de pacientes enfermos existentes en determinado momento
- b) La proporción de pacientes que enferman a lo largo de un período
- c) La proporción de pacientes que mueren de una enfermedad de entre los que la contraen
- d) La proporción de pacientes que mueren de una enfermedad de entre el total de la población
- e) La velocidad con que se transmite una enfermedad

38) Respecto a la sinusitis crónica es FALSO que:

- a) Suele causarse por una obstrucción crónica del complejo ostiomeatal en el meato medio
- b) Los senos más frecuentemente comprometidos son los maxilares, frontales y etmoidales
- c) Su tratamiento antibiótico de elección es la amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Se diagnostica cuando presenta una duración mayor a 4 semanas
- e) La radiografía es la imagen de elección para el estudio anatómico de estos pacientes

39) Una paciente de 70 años sufre caída a nivel, resultando con una fractura de cadera intertrocanterica desplazada, la que se resuelve quirúrgicamente con un DHS (Dinamic Hip Screw). Al día siguiente

presenta disnea súbita, asociada a fiebre y tos con expectoración hemoptoica. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía
- b) Atelectasia
- c) Tromboembolia pulmonar
- d) Endocarditis bacteriana
- e) Embolia grasa

40) Dentro de los trastornos ansiosos de incluye la fobia social, la que se caracteriza principalmente por la:

- a) Incapacidad de establecer relaciones interpersonales
- b) Angustia que se presenta en lugares con mucha gente
- c) Expectación ansiosa
- d) Ansiedad intensa ante el escrutinio de los demás
- e) Angustia y desconcentración durante los exámenes escritos

41) La localización más frecuente de la dermatitis seborreica es:

- a) Cejas y cuero cabelludo
- b) Extremidades superiores
- c) Fosas cubitales y poplíteas
- d) Espalda y pecho
- e) Extremidades inferiores

42) Se eligen 2 grupos de pacientes, el primero son aquellos que consumen drogas de abuso de manera frecuente y el segundo son aquellos que no lo hacen. Se observa la mortalidad y aparición de trastornos del ánimo a lo largo del tiempo. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Casos y controles
- b) Ensayo clínico controlado
- c) Cohortes
- d) De prevalencia
- e) Ensayo de campo

43) En una paciente de 60 años con aumento del diámetro de la excavación de las papilas ópticas, se debe sospechar:

- a) Retinopatía hipertensiva
- b) Hipertensión endocraneana
- c) Neuritis óptica
- d) Glaucoma de ángulo abierto
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

44) Un niño de 4 años es muy desobediente y hace berrinches con mucha frecuencia, especialmente cuando no se hace lo que él quiere. Se lleva bien con sus compañeros, pero en ocasiones es muy insolente con su profesora. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión infantil
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno de conducta
- d) Síndrome de déficit atencional
- e) Trastorno de ansiedad por separación

45) Un paciente de 30 años consulta por dolor lumbar derecho, irradiado a genitales, muy intenso, por lo que cambia continuamente de posición sin lograr encontrar una que lo alivie. Además ha presentado vómitos alimentarios en 3 oportunidades. Al examen físico se observa con agitación psicomotora y presenta dolor a la percusión lumbar derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Cólico renal
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colédocolitiasis
- d) Pielonefritis aguda
- e) Colecistitis aguda

46) Respecto a la máscara laríngea es FALSO que:

- a) No requiere del laringoscopio para su instalación

- b) Protege relativamente bien la vía aérea
- c) Es una alternativa para el manejo de la vía aérea difícil
- d) A través de ella se pueden administrar gases anestésicos
- e) Existen distintos tamaños, para los distintos pacientes

47) Un paciente ingiere una sustancia evolucionando con compromiso de consciencia y depresión respiratoria. Al examen físico destaca miosis con pupilas en punta de alfiler. La sustancia responsable corresponde con mayor probabilidad a:

- a) Un anticolinérgico
- b) Una benzodiacepina
- c) Un opioide
- d) Un organofosforado
- e) Un bloqueador adrenérgico

48) Una paciente de 40 años consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se aprecia un bocio nodular, con un nódulo de cerca de 2,5 cm de diámetro, en la línea media, que asciende con la deglución. Se solicita TSH que resulta normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
- b) Iniciar levotiroxina
- c) Solicitar TAC de cuello
- d) Solicitar ecografía cervical
- e) Resolver quirúrgicamente

49) Se compara el IMC promedio de los pacientes diabéticos con el IMC promedio de los pacientes sin alteraciones del control de la glucosa. ¿Qué prueba es más adecuada para determinar la significancia estadística?

- a) Chi cuadrado
- b) t de Student
- c) ANOVA
- d) r de Pearson
- e) Test normal

50) Un paciente de 50 años consulta por hematoquezia abundante y lipotimias. Al examen físico está taquicárdico, con PA: 100/70 mmHg. El tacto recta demuestra hematoquezia. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar cristaloides endovenosos y realizar colonoscopia de urgencia
- b) Administrar solución de preparación de colon por vía oral y programar
- c) Administrar suero fisiológico y ácido tranexánico por vía endovenosa
- d) Transfundir glóbulos rojos, solicitar TAC de abdomen y pelvis
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

51) La depresión infantil se produce principalmente por:

- a) Maltrato infantil
- b) Disfunción familiar
- c) Herencia genética
- d) Conflictos con hermanos y compañeros de colegio
- e) Sobre exigencia escolar

52) ¿Qué institución obtiene y almacena datos de importancia nacional y los procesa, poniéndolos al servicio del estado y de la comunidad?

- a) Instituto de salud pública
- b) Servicio de salud
- c) Central de abastecimiento
- d) Secretaría regional ministerial
- e) Instituto nacional de estadística

53) ¿Cuál de las siguientes opciones entrega información más valiosa para diferenciar una disfunción eréctil psicológica de una orgánica?

- a) Edad del paciente
- b) Erecciones matinales
- c) Estado de ánimo
- d) Tiempo de evolución
- e) Tamaño testicular

54) En un ensayo clínico se administran anticoagulantes orales a 100 pacientes diagnosticados de trombosis venosa profunda y se administra heparina de bajo peso molecular a otros 100 pacientes. En el grupo con anticoagulante oral se producen 5 casos de hemorragias graves, mientras que en el grupo de heparina se producen 2. Así el riesgo relativo de hemorragias graves al usar anticoagulantes orales es:

- a) 3
- b) 2,5
- c) 1,4
- d) 0,6
- e) 0,25

55) Un paciente consulta por aparición de una placa brillante, eritematosa, de 7 cm de diámetro mayor, con bordes bien definidos, en la extremidad inferior derecha, ligeramente sensible a la palpación, con aumento de la temperatura local. El agente causal más probable es:

- a) Estafilococo dorado
- b) Streptococo beta hemolítico, grupo A
- c) Anaerobios
- d) Pseudomona aureginosa
- e) Escherichia coli

56) Un paciente de 67 años consulta por dolor abdominal bajo de 3 meses de evolución y fatigabilidad. Se solicitan exámenes generales, donde destaca una anemia microcítica. La conducta más adecuada, además de tratar la anemia, es:

- a) Solicitar un TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar una colonoscopia
- c) Solicitar una ecografía abdominal
- d) Solicitar un enema baritado
- e) Solicitar un test de sangre oculta en deposiciones

57) El tratamiento de elección del trastorno de pánico es:

- a) Antidepresivos IRSS
- b) Benzodiazepinas
- c) Antipsicóticos
- d) Anticonvulsivantes
- e) Relajantes musculares

58) Los aneurismas aórticos abdominales tienen un alto riesgo de romperse si sobrepasan los 4,5 cm o si crecen muy rápidamente. Para su seguimiento, periódicamente se deben realizar:

- a) Ecografías abdominales
- b) Angiografías aórticas
- c) Resonancias magnéticas nucleares
- d) Tomografías axiales computarizadas
- e) Cintigrafías con glóbulos rojos marcados

59) Un paciente de 59 años, diabético tipo 2, en tratamiento irregular con metformina, presenta pérdida completa y súbita de la visión del ojo derecho. Al examen físico destaca ausencia de rojo pupilar derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Desprendimiento de retina
- b) Hemorragia vítrea
- c) Trombosis de la vena central de la retina
- d) Embolía de la arteria central de la retina
- e) Edema macular

60) ¿Qué afirmación es verdadera?

- a) Los pacientes FONASA A pueden optar al sistema de libre elección

- b) Los pacientes FONASA B no pueden optar por el sistema de libre elección
- c) Los pacientes FONASA C no realizan copago
- d) Los pacientes FONASA D aportan mensualmente el 7% de su sueldo
- e) Los pacientes FONASA B sólo tienen atención gratuita en la atención primaria y no en la hospitalaria

61) Un hombre de 23 años sufre torsión de la rodilla derecha mientras jugaba fútbol, evolucionando con dolor que le limita la marcha. Al examen físico se aprecia importante dolor al valgo forzado y a la palpación de la zona medial de la rodilla. No presenta otras alteraciones y las radiografías no visualizan lesiones óseas. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura del ligamento cruzado anterior
- b) Lesión del tendón de la pata de ganso
- c) Esguince del ligamento colateral medial
- d) Lesión del menisco medial
- e) Fractura avulsiva de la rótula

62) Un paciente de 27 años tiene peleas muy frecuentes con su pareja, familias y amigos, es emocionalmente inestable y cambia fácilmente de estado de ánimo. Ha tenido varias parejas con las que ha tenido relaciones sentimentales intensas y llenas de problemas. Abusa de drogas y alcohol en algunas oportunidades y en una ocasión trató de suicidarse. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Depresión psicótica
- c) Trastorno bipolar
- d) Trastorno de personalidad límite
- e) Trastorno esquizoafectivo

63) Un paciente con hipoacusia izquierda, presenta prueba de Rinne positiva bilateral y una prueba de Weber que lateraliza a derecha. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- a) Oтоesclerosis
- b) Miringoesclerosis
- c) Sordera súbita
- d) Otitis media con efusión
- e) Otitis media crónica

64) Un paciente es diagnosticado de una hernia inguinal indirecta no complicada. La conducta más adecuada es:

- a) Observa evolución
- b) Indicar uso de faja
- c) Indicar ejercicios de fortalecimiento abdominal
- d) Resolver quirúrgicamente de manera electiva
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

65) Un paciente de 65 años, sin antecedentes de importancia, presenta un tumor renal ecográfico de 6 cm, sólido, en el riñón derecho, diagnosticado en el estudio de una hematuria indolora. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis que no visualiza adenopatías sospechosas ni invasión vascular. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefrectomía radical
- b) Iniciar quimioterapia preoperatoria y resolver quirúrgicamente en una etapa posterior
- c) Iniciar radioterapia preoperatoria y resolver quirúrgicamente en una etapa posterior
- d) Iniciar quimioterapia y radioterapia
- e) Realizar nefrectomía parcial

66) Una paciente de 20 años presenta eritema facial, que compromete ambas mejillas y la nariz, asociado a varias pápulas, algunas pústulas y telangiectasias, sin comedones. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatomiositis
- b) Lupus eritematoso sistémico
- c) Acné
- d) Rosácea
- e) Dermatitis de contacto alérgica

67) La eficacia corresponde a:

- a) La capacidad de una intervención de lograr los objetivos a menores costos
- b) La capacidad de una intervención de conseguir los objetivos en condiciones ideales
- c) La capacidad de una intervención de obtener resultados positivos en condiciones similares a la vida real
- d) La capacidad de una intervención de conseguir una mayor cantidad de años de vida, ajustados por calidad
- e) El parámetro de comparación que permite elegir la alternativa que signifique los menores costos

68) El examen de elección para el diagnóstico de certeza de la otitis media con efusión es

- a) Audiometría
- b) Test de diapasones
- c) Impedanciometría
- d) TAC de oído
- e) Clínico

69) Una mujer de 45 años cree que un famoso cantante está profundamente enamorado de ella y que se lo hace saber a través de la letra de sus canciones y de comentarios y miradas que le entrega por la televisión. Ha intentado comunicarse con él en numerosas oportunidades, sin tener éxito. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad histriónica
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno bipolar
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Esquizofrenia

70) Una paciente de 24 años reprueba el año académico, atrasándose un semestre. Evoluciona con ánimo disfórico e irritabilidad, teniendo algunas peleas con sus padres. Además sale menos con sus amigas y ha descuidado parcialmente su apariencia física. No presenta cambios en el peso ni en los hábitos de sueño. El diagnóstico más probable es:

- a) Distimia
- b) Depresión
- c) Trastorno adaptativo
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Hipomanía

Prueba 3

1) Un paciente de 44 años, apendicectomizado hace 10 meses, presenta aumento de volumen blando y no doloroso, en relación a la cicatriz. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata que aumenta con la maniobra de Valsalva y se palpa un anillo de 2 cm de diámetro en la pared abdominal. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución indicando control en caso de dolor o signos de obstrucción intestinal
- b) Observar y controlar en 6 meses, decidiendo manejo según el crecimiento del anillo o la aparición de síntomas
- c) Solicitar ecografía de pared abdominal y decidir manejo según hallazgos
- d) Resolver quirúrgicamente de manera electiva lo antes posible
- e) Realizar cirugía inmediatamente

2) Un lactante de 30 días, alimentado con fórmula, inicia vómitos de gran cantidad, a los pocos minutos de alimentarse. Ha detenido su incremento de peso, a pesar de presentar apetito aumentado. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Reflujo del lactante
- b) Invaginación intestinal
- c) Enterocolitis necrotizante
- d) Estenosis hipertrófica del píloro
- e) Enfermedad de Hirschsprung

3) ¿Cuál es la conducta más adecuada, ante un paciente de 25 años, al que se le palpa un tumor testicular?

- a) Solicitar biopsia por punción
- b) Realizar orquiectomía radical
- c) Solicitar ecografía testicular
- d) Solicitar marcadores tumorales y decidir conducta según resultados
- e) Realizar tumorectomía

4) ¿Cuál de las siguientes opciones es un dato con mayor especificidad, para el diagnóstico de una sinusitis?

- a) Sensación de presión facial
- b) Descarga posterior
- c) Visualización de pus saliendo por el meato medio
- d) Radiografía de senos paranasales con velamiento del seno maxilar derecho
- e) Cultivo nasal positivo para Staphylococcus aureus

5) Un niño de 6 años presenta ojo rojo bilateral, mayor a derecha, de 7 días de evolución. Habría presentado un cuadro similar un año atrás. Al examen físico se aprecia ojo rojo superficial, con reacción tarsal papilar y escasa secreción ocular. No se palpan adenopatías y el resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis viral
- b) Conjuntivitis alérgica
- c) Conjuntivitis bacteriana
- d) Queratoconjuntivitis actínica
- e) Queratoconjuntivitis Sicca

6) La estratificación es una herramienta que puede usarse tanto en la formación de los grupos a estudiar (aleatorización estratificada), como en el análisis de los datos obtenidos (análisis estratificado). La utilidad de estratificar es:

- a) Disminuir los sesgos por variable confundente
- b) Disminuir los sesgos de selección
- c) Disminuir los sesgos de medida
- d) Disminuir los sesgos de memoria
- e) Disminuir el error aleatorio

7) Un hombre de 44 años sufre ruptura sentimental, evolucionando con ánimo disfórico e irritable. En algunas ocasiones sale con sus amigos y se emborracha, situación que antes no sucedía. No ha

presentado cambios en el peso y duerme de manera normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno por somatización
- d) Psicosis reactiva
- e) Trastorno de personalidad limítrofe

8) Un paciente de 24 años inicia dolor torácico derecho de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se observa en buenas condiciones generales, con signos vitales normales. Destaca hipersonoridad y disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax derecho. Se solicita radiografía de tórax que demuestra un neumotórax derecho del 30%. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución por 24 horas, bajo analgesia endovenosa
- b) Puncionar el segundo espacio intercostal
- c) Instalar tubo pleural
- d) Administrar oxígeno a 2 litros por minuto, analgésicos y antibióticos
- e) Realizar sellamiento pleural con talco

9) Una paciente de 65 años es atacada hace 2 días, por 2 perros de gran tamaño, presentado varias heridas de poca a moderada severidad. Evolucionan con mucha ansiedad, insomnio, pesadillas relacionadas con el incidente y ha presentado 4 crisis de pánico. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia específica
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno de estrés agudo
- d) Trastorno de pánico
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

10) Un paciente de 30 años sufre valgo forzado de la rodilla izquierda, mientras jugaba fútbol. Evolucionan con dolor importante, especialmente a la palpación de la zona medial de la rodilla y al valgo. No presenta signos de derrame articular y la movilidad la articulación es completa. El diagnóstico más probable es:

- a) Rotura de ligamento cruzado anterior
- b) Esguince del ligamento colateral medial
- c) Lesión del menisco medial
- d) Lesión del menisco lateral
- e) Tendinitis anserina

11) La principal utilidad del test cutáneo en la rinitis alérgica es que permite:

- a) Confirmar el diagnóstico en los pacientes con cuadro clínico clásico de rinitis alérgica
- b) Identificar el alérgeno causante de los síntomas, a modo de evitarlo
- c) Decidir el fármaco a utilizar como primera línea de tratamiento
- d) Identificar otras patologías alérgicas concomitantes, como el asma y la urticaria
- e) No tiene utilidad en la rinitis alérgica

12) ¿Cuál de las siguientes situaciones NO cursa con midriasis?

- a) Intoxicación por codeína
- b) Pupilas de Adie
- c) Glaucoma agudo
- d) Parálisis del nervio oculomotor
- e) Uso de atropina tópica

13) Se comparan las tasas de hemorragia grave entre un grupo tratado con un anticoagulante

experimental y otro grupo tratado con heparina de bajo peso molecular. Se calculan las incidencias de hemorragias graves y se obtiene un riesgo relativo de 3, con un intervalo de confianza de 95% de 2,3 a 3,5. Esto significa que:

- a) La probabilidad de sufrir una hemorragia grave es 3 veces mayor en los pacientes tratados con el nuevo anticoagulante
- b) La probabilidad de sufrir una hemorragia grave es 3 veces mayor en los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular
- c) La probabilidad de sufrir una hemorragia es un 3% mayor en los pacientes tratados con el nuevo anticoagulante
- d) La probabilidad de sufrir una hemorragia es un 3% mayor en los pacientes tratados con heparina de bajo peso molecular
- e) No existen diferencias significativas en la incidencia de hemorragias graves, entre ambos fármacos

14) Una mujer de 22 años sufre gran ansiedad al hablar en público y teme hacer el ridículo. Evita hacer presentaciones en su universidad, y en un examen oral sufrió una crisis de angustia, siendo reprobada, a pesar de manejar bien los conocimientos. También refiere que no come en público, ya que teme ser recriminada por su forma de comer. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Fobia simple
- c) Fobia social
- d) Trastorno obsesivo compulsivo
- e) Trastorno de personalidad evitativa

15) Una paciente es operada de várices con anestesia raquídea. Al día siguiente evoluciona con intensa cefalea holocránea, que aumenta al sentarse y al pararse, por lo que debe permanecer en posición horizontal. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar AINES endovenosos y observar evolución
- b) Solicitar TAC de cerebro sin contraste y decidir manejo según hallazgos
- c) Solicitar punción lumbar
- d) Iniciar una asociación de antibióticos y analgésicos endovenosos
- e) Anticoagular de inmediato y solicitar angioTAC de tórax y de cerebro

16) Un paciente de 14 años, consulta por dolor intenso, de 2 horas de evolución en el testículo derecho. Al examen se aprecia testículo derecho con aumento de volumen, eritema e intenso dolor a la palpación. La conducta más adecuada, de entre las siguientes, es:

- a) Solicitar ecografía doppler testicular y decidir manejo según hallazgos
- b) Administrar analgésicos endovenosos y antibióticos
- c) Realizar exploración quirúrgica de inmediato
- d) Observar evolución por 24 horas bajo analgesia endovenosa
- e) Enviar a domicilio con analgésicos orales y controlar en 7 días

17) Paciente de 34 años, consulta porque presenta pensamientos desagradables. Cada vez que sale de su casa debe desconectar la electricidad y el gas, porque tiene la sensación de que se producirá un incendio. Esto le ha traído problemas con su pareja quien lo encuentra muy exagerado. Sabe que esto es ridículo y exagerado, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno esquizoafectivo
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

18) Un paciente de 44 años sufre trauma ocular derecho, con golpe de alta energía. Al examen se observa discoria, enoftalmo y marcada disminución de la agudeza visual. La conducta más adecuada

es:

- a) Iniciar analgésicos, realizar sello ocular con ungüento antibiótico y derivar a oftalmólogo de manera urgente
- b) Realizar aseo ocular con abundante suero fisiológico, realizar sello ocular con ungüento antibiótico y derivar al oftalmólogo de manera urgente
- c) Indicar antibióticos endovenosos y colirios antibióticos, instalar protección ocular no compresiva y derivar al oftalmólogo de manera urgente
- d) Realizar aseo ocular con abundante suero fisiológico, instalar protección ocular no compresiva y derivar de manera urgente al oftalmólogo, bajo antibióticos y analgésicos orales
- e) Administrar analgésicos y antibióticos endovenosos, instalar protección ocular no compresiva y derivar de manera urgente al oftalmólogo

19) El mejor tipo de estudio para determinar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que demora muchos años en manifestarse es:

- a) Caso control
- b) Cohortes
- c) Ensayo clínico
- d) Transversal
- e) Ensayo de campo

20) Una paciente de 68 años, sufre fractura de cadera derecha, la que es reducida y tratada con osteosíntesis. Evoluciona con desorientación y alucinaciones visuales. Al examen se aprecia inatenta, con pensamiento desorganizado e ideas paranoides. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia
- b) Delirium
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Esquizofrenia

21) Paciente de 55 años, consulta por dolor abdominal epigástrico muy intenso, asociado a ictericia y vómitos alimentarios en varias ocasiones. Al examen físico se constata paciente en buenas condiciones generales, icterico, con fascie de dolor, con PA: 140/80, FC: 80x', t°: 36,8°C. El examen abdominal sólo destaca dolor a la palpación epigástrica y en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal. Los exámenes demuestran elevación de la bilirrubina directa y de las fosfatasas alcalinas, con transaminasas y lipasa normales. El hemograma resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Colangitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Colédocolitiasis
- e) Perforación de úlcera gástrica

22) Un paciente asintomático, de 55 años, sin antecedentes personales ni familiares de importancia, se realiza tacto rectal como parte de un chequeo médico, detectándose un nódulo de consistencia dura, de 4 mm en el lóbulo prostático derecho. El antígeno prostático específico (APE) fue de 0,1 ng/ml. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nuevo APE y tacto rectal en 3 meses
- b) Solicitar ecografía prostática y vesical
- c) Iniciar bloqueadores androgénicos
- d) Derivar para biopsia prostática transrectal
- e) Derivar para resección transuretral (RTU)

23) Una mujer de 71 años, presenta una lesión en la mejilla derecha de lento crecimiento a lo largo de 4 años. Al examen se observa una tumoración de 1,7 cm de diámetro, de borde solevantado y ulceración central, con una telangiectasia adyacente. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis actínica
- b) Carcinoma basocelular
- c) Carcinoma espinocelular
- d) Melanoma lentigo maligno
- e) Queratosis seborreica

24) La proporción de casos debidos a un factor de riesgo, en los pacientes expuestos a dicho factor,

se denomina:

- a) Riesgo relativo
- b) Riesgo atribuible porcentual
- c) Riesgo atribuible poblacional
- d) Riesgo atribuible porcentual poblacional
- e) Odds ratio

25) Los fármacos utilizados para el tratamiento de mantención de la enfermedad bipolar son:

- a) Litio y antidepresivos
- b) Antidepresivos y antipsicóticos
- c) Antidepresivos y anticonvulsivantes
- d) Anticonvulsivantes y litio
- e) Litio y antipsicóticos

26) Una mujer puérpera de 10 días, consulta por dolor y enrojecimiento de la mama derecha. Al examen se observa eritema y aumento de volumen con zona fluctuante y dolorosa en dicha mama. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cloxacilina endovenosa, realizar drenaje quirúrgico y mejorar la técnica de lactancia materna
- b) Solicitar mamografía y decidir conducta según hallazgos
- c) Suspender lactancia materna e iniciar cefadroxilo oral y analgésicos
- d) Iniciar analgésicos y ceftriaxona endovenosa y luego resolver quirúrgicamente
- e) Solicitar ecografía mamaria y decidir conducta según hallazgos

27) Un paciente de 67 años, con síntomas de uropatía obstructiva baja, consulta por dolor abdominal bajo e imposibilidad de orinar de 24 horas de evolución. Al examen se palpa globo vesical. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Instalar sonda Foley a permanencia
- b) Realizar drenaje con sonda Nelaton y enviar a domicilio con antibióticos
- c) Instalar cistostomía percutánea
- d) Solicitar urocultivo por punción y decidir manejo según resultado
- e) Solicitar ecografía renal y vesical y decidir manejo según hallazgos

28) Un paciente consulta por ardor ocular intenso, fotofobia, visión de halos coloreados y ojo rojo derecho. Al examen físico se observa ojo rojo profundo y blefarospasmo a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Epiescleritis
- b) Uveítis aguda
- c) Queratitis aguda
- d) Leucoma
- e) Orzuelo

29) Una paciente de 21 años, consulta porque se siente cansada, abatida y triste. Refiere problemas familiares y económicos, a los que no encuentra solución. Ha bajado 6 kilogramos de peso en 2 meses y refiere que duerme cerca de 5 horas diarias, ya que despierta muy temprano y no puede volver a dormirse. Ha bajado notablemente su rendimiento académico y se siente desesperada. El diagnóstico más probable es:

- a) Depresión atípica
- b) Depresión mayor
- c) Trastorno bipolar
- d) Hipotiroidismo
- e) Trastorno adaptativo

30) La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es:

- a) Enfermedad diverticular
- b) Cáncer de colon
- c) Angiodisplasias
- d) Disvertículo de Meckel
- e) Enfermedades inflamatorias intestinales

31) Una mujer de 17 años sufre caída a nivel, con apoyo de la mano derecha en extensión. Evoluciona con intenso dolor en el antebrazo y codo, que limita los movimientos del codo, especialmente a la

pronosupinación. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación cúbito-humeral
- b) Fractura de antebrazo
- c) Fractura supracondílea de húmero
- d) Esguince de codo
- e) Fractura de cúpula radial

32) Una mujer de 17 años presenta aparición de placa eritematosa, clara, con fina descamación, no dolorosa ni pruriginosa, de 4 cm de diámetro, en la región infraclavicular derecha. Dos semanas después evoluciona con aparición de múltiples lesiones similares de menor tamaño en el dorso, pecho, abdomen y zona proximal de las extremidades. No presenta otros síntomas. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Psoriasis
- b) Liquen simple
- c) Pitiriasis versicolor
- d) Pitiriasis rosada
- e) Dermatitis de contacto

33) Una paciente de 37 años sufre pérdida de conciencia en relación a una discusión con su marido, de 15 minutos de duración, que se recupera espontáneamente una vez que se resuelve el conflicto. Habría presentado cuadros similares en oportunidades anteriores, todos ellos en relación a discusiones. El examen físico es normal, al igual que los exámenes de laboratorio. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipocondría
- b) Trastorno disociativo
- c) Trastorno conversivo
- d) Síncopes vasovagales
- e) Trastorno adaptativo

34) Un paciente hipertenso de 75 años se realiza chequeo médico, palpándose un aumento del diámetro de la aorta abdominal. No ha presentado otros síntomas. El examen de elección para confirmar el diagnóstico es:

- a) Ecografía abdominal
- b) Angiografía
- c) Tomografía axial computada de abdomen y pelvis, con contraste
- d) Angioresonancia
- e) Radiografía de abdomen

35) Un niño de 3 años presenta retraso del lenguaje. Dice cerca de 20 palabras y no forma frases, sin embargo el resto de su desarrollo psicomotor es normal. Al examen físico sólo destaca otoscopia que muestra ambos tímpanos rosados. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipoacusia sensorio neural congénita
- b) Otitis media aguda
- c) Otitis media con efusión
- d) Otitis media crónica
- e) Miringoesclerosis

36) La tasa de mortalidad neonatal tiene como numerador a las muertes producidas entre:

- a) El nacimiento y los 7 días de vida
- b) El nacimiento y los 28 días de vida
- c) El nacimiento y los 90 días de vida
- d) La semana 28 de gestación y los 28 días de vida
- e) La semana 28 de gestación y los 7 días de vida

37) Un niño de 10 años presenta un comportamiento agresivo y desconsiderado con los demás. Vive con su abuela a quien le roba en algunas ocasiones. Ha participado en actos de vandalismo,

destruyendo vidrios y faroles, pelea con frecuencia con otros menores y habría consumido alcohol en varias oportunidades. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Trastorno oposicionista desafiante
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Depresión infantil
- e) Dependencia a alcohol

38) Una paciente de 25 años, con antecedente de litiasis renal, presenta dolor en zona lumbar derecha, irradiado a abdomen y genitales. Al examen se observa paciente con agitación psicomotora muy adolorida. Sus signos vitales son normales. Evoluciona al día siguiente con fiebre y orinas de mal olor y la ecografía abdominal demuestra dilatación pielocalicilar derecha, con formación de varias colecciones renales. La conducta más apropiada es:

- a) Realizar litotricia extracorpórea inmediatamente
- b) Iniciar antibióticos endovenosos y analgésico, observando evolución
- c) Enviar a domicilio con tratamiento antibiótico oral por 7 a 10 días
- d) Iniciar antibióticos endovenosos e instalar catéter doble jota
- e) Resolver quirúrgicamente de manera inmediata

39) En una población de 5.000 personas hay 105 pacientes portadores del VIH. Durante el año 2008 se contagiaron 20 pacientes más y fallecieron 15 de los pacientes previamente enfermos. La tasa de incidencia acumulada de VIH es:

- a) 105/5.000
- b) 20/5.000
- c) 110/5.000
- d) 15/105
- e) 15/125

40) Una mujer de 56 años, con antecedentes de úlcera péptica, consulta porque se siente triste y desesperada. Su marido sufrió un infarto cerebral hace un año y desde entonces ella debe cuidarlo. Dice que está cansada, sin ánimo, se siente triste y ya no disfruta de sus actividades. Asegura que su marido se enfermó por culpa de ella, que sus malos deseos le causaron ese daño. Además está muy pesimista porque su úlcera péptica la matará en cualquier momento y según ella no existe tratamiento que pueda salvarla. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno bipolar, con episodio mixto
- c) Depresión psicótica
- d) Trastorno esquizoafectivo
- e) Depresión atípica

41) Una paciente de 70 años sufre caída a nivel cayendo sobre el muslo y cadera derecha. Evoluciona con dolor importante e imposibilidad para caminar, en relación a la ingle y cara interna del muslo derecho. Al examen se aprecia paciente con ligera abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad inferior derecha. Presenta intenso dolor con todos los movimientos del muslo. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de cadera
- b) Luxación posterior de cadera
- c) Fractura de diáfisis femoral
- d) Fractura de pelvis
- e) Fractura de cadera

42) Un niño de 5 años, es traído por su madre, ya que tiene una voz muy ronca y frecuentemente queda afónico. Dice que es hiperactivo, que habla fuerte y que grita y llora con frecuencia. Cuando

grita mucho queda disfónico. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Laringitis viral
- b) Nódulos vocales
- c) Reflujo gastroesofágico
- d) Edema de Reinke
- e) Cáncer de Laringe

43) La causa más frecuente de obstrucción intestinal es (son):

- a) Bridas o adherencias
- b) Cáncer
- c) Hernias
- d) Vólvulo
- e) Bezoares

44) Paciente de 22 años, consulta por aparición de pápulas pruriginosas en la fosas cubitales y poplíteas, de larga evolución, pero que se han hecho más intensas en los últimos días. En el examen físico destacan las lesiones descritas y además queratosis pilar en los brazos y lengua geográfica. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto alérgica
- b) Dermatitis seborreica
- c) Dermatitis atópica
- d) Escabiosis
- e) Psoriasis guttata

45) Una paciente de 60 años consulta por cuadro de 2 meses de evolución de escapes de orina frecuentes, de baja cuantía especialmente al toser, reírse o levantar objetos pesados. Los síntomas han comenzado a afectar su vida social. No ha presentado otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer de vejiga
- b) Incontinencia urinaria de esfuerzo
- c) Incontinencia urinaria de urgencia
- d) Infección urinaria
- e) Estenosis uretral por hipoestrogenismo

46) ¿Cuál de las siguientes estructuras se lesiona con mayor frecuencia en una fractura de diáfisis humeral?

- a) Arteria braquial
- b) Nervio axilar
- c) Arteria circunfleja humeral posterior
- d) Nervio mediano
- e) Nervio radial

47) Paciente de 54 años, diabético, consulta por vértigo de 2 días de evolución, que se ha vuelto más intenso y se acompaña de hipacusia y tinitus derecho. Habría sufrido 2 cuadros similares algunos años atrás y presenta tinitus con cierta frecuencia. El examen físico demuestra nistagmo horizontal con fase rápida a izquierda y lateropulsiones a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Vértigo postural paroxístico benigno
- b) Infarto de tronco encefálico
- c) Enfermedad de Meniere
- d) Infarto cerebeloso
- e) Parálisis cocleovestibular súbita

48) Un paciente de 57 años sufre accidente de tránsito, resultando con politrauma y evolucionando con compromiso de conciencia hasta Glasgow 7. La conducta MENOS adecuada para el manejo de la

vía aérea, en este paciente, es:

- a) Retirar objetos de la boca
- b) Hiperextender el cuello
- c) Realizar laringoscopia con hoja curva
- d) Instalar tubo orotraqueal
- e) Ventilar con ambú

49) La frecuencia de una enfermedad en una población se denomina:

- a) Tasa de ataque
- b) Prevalencia
- c) Incidencia
- d) Morbilidad
- e) Importancia relativa

50) Un paciente sufre hemianopsia homónima derecha con escasa congruencia. ¿A qué nivel de la vía óptica se encuentra la lesión con mayor probabilidad?

- a) Retina
- b) Nervio óptico
- c) Quiasma óptico
- d) Cintilla óptica
- e) Lóbulo occipital

51) Las luxaciones que no se reducen, a largo plazo producen clásicamente:

- a) Daño neurovascular
- b) Alto riesgo de cáncer
- c) Alto riesgo de artritis séptica
- d) Artrosis
- e) Osteoporosis

52) ¿Cuál de los siguientes fármaco NO es un inductor anestésico?

- a) Propofol
- b) Tiopental
- c) Midazolam
- d) Morfina
- e) Ketamina

53) Paciente de 35 años, presenta varias denuncias en su contra por violencia intrafamiliar y sus hijos han sido hospitalizados en 3 ocasiones por fracturas. Consume alcohol y pasta base con cierta regularidad. Ha sido detenido en varias oportunidades por robo y ha sido despedido de sus trabajos por problemas con otros empleados. Presenta algún grado de verborrea y una actitud minimizadora respecto a sus actos. No parece sentir culpa respecto a sus acusaciones. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno de personalidad límite
- c) Trastorno de personalidad antisocial
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno delirante crónico

54) La salud pública chilena actualmente se financia principalmente por:

- a) La ley de presupuestos
- b) El aporte de los trabajadores
- c) El aporte de los empleadores
- d) El aporte de los municipios
- e) El copago de los pacientes

55) ¿Cuál de las siguientes corresponde a una herida limpia?

- a) Cirugía a corazón abierto

- b) Mordedura
- c) Cesárea
- d) Laringectomía
- e) Nefrectomía radical

56) Paciente de 35 años, consulta cuadro de 3 semanas de evolución de episodios de disnea, palpitaciones, opresión precordial, sudoración, temblor, angustia, parestesias y náuseas, de instalación en 5 minutos y que demora cerca de 15 minutos en ceder. El primer episodio apareció en relación a un estresor económico. Desde entonces ha presentado 6 episodios similares y en 3 de ellos no ha sido posible identificar un desencadenante claro. Está muy preocupada por su problema, ya que teme sufrir un infarto o un accidente vascular durante otra crisis. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de angustia
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno facticio
- e) Depresión

57) ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico de una dermatitis de contacto alérgica?

- a) Prick test
- b) Test de parches (patch test)
- c) Inmunoglobulina E total
- d) Inmunoglobulina E específica
- e) Biopsia de piel

58) La agorafobia es el miedo irracional a:

- a) Los espacios cerrados
- b) Los espacios abiertos
- c) Situaciones donde no se recibirá ayuda
- d) Perder la razón
- e) El escrutinio de los demás

59) ¿A qué tipo de estudio corresponde el siguiente enunciado?:

Se seleccionan 300 pacientes diagnosticados de artritis reumatoide y se asignan aleatoriamente a dos grupos de 150 pacientes cada uno. El primer grupo es tratado con infliximab y el segundo es tratado con metotrexato. Se comparan las tasas de remisión clínica y los efectos adversos.

- a) Casos y controles
- b) Cohortes
- c) Ensayo clínico controlado
- d) Ensayo de campo
- e) Transversal

60) La clínica típica de la encefaloatía de Wernicke es:

- a) Confusión, ataxia y oftalmoplejia
- b) Convulsiones, desorientación y parestesias
- c) Confusión, debilidad de extremidades inferiores y nistagmo
- d) Nistagmo, parestesias y convulsiones
- e) Inatención, alucinaciones visuales y convulsiones

61) Un paciente de 78 años, con accidente vascular periférico secuelado, semipostrado presenta lesión negra, levemente dolorosa en el glúteo derecho. Al examen se observa paciente enflaquecido, con la

lesión descrita, de 4 cm, con halo eritematoso menor a un centímetro, con costra negra en el centro.

La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar antibióticos orales y cambiar frecuentemente de posición al paciente, protegiendo los puntos de apoyo
- b) Realizar curaciones frecuentes, aplicando debridante químicos, proteger puntos de apoyo y cambiar frecuentemente de posición al paciente
- c) Realizar debridación quirúrgica, con antibióticos endovenosos y protección de los puntos de apoyo
- d) Anticoagular y solicitar angiografía de arterias ilíacas y decidir manejo según hallazgos
- e) Solicitar pletismografía de volumen e indicar medidas antiescaras

62) La institución que fiscaliza el correcto funcionar de los laboratorios privados es:

- a) El instituto médico legal
- b) El instituto de salud pública
- c) La superintendencia de Isapres
- d) El servicio nacional de salud
- e) La secretaría regional ministerial

63) La etiología de la depresión en niños suele ser:

- a) Secundaria a enfermedades médicas
- b) Alteraciones en la migración neuronal
- c) Disfunción familiar
- d) Déficit atencional
- e) Secundaria al mal rendimiento escolar

64) Se compara la frecuencia de hipertensión arterial entre pacientes obesos y pacientes normopeso. La prueba indicada para calcular la significancia estadística es:

- a) "t" de Student
- b) Chi cuadrado
- c) "r" de Pearson
- d) Análisis de varianza
- e) Test exacto de Fisher

65) Paciente de 22 años, con diagnóstico reciente de esquizofrenia, inicia tratamiento hace 5 días con risperidona. Evoluciona con espasmos musculares del cuello y movimientos rápidos de los ojos. El diagnóstico más probable es:

- a) Acatisia
- b) Disquinesia tardía
- c) Disonía
- d) Catatonía
- e) Balismo

66) Un adolescente de 13 años, con sobrepeso consulta por dolor inguinal derecho en relación a la marcha, que le hace cojear. Al examen físico el dolor se reproduce con la abducción y rotación de la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Enfermedad de Perthes
- b) Sarcoma de Ewing
- c) Epifisiolisis de la cabeza femoral
- d) Sinovitis transitoria de la cadera
- e) Artritis séptica

67) Una paciente de 20 años, consulta por dolor perianal, de 2 días de evolución que aumenta al sentarse. Al examen se observa aumento de volumen en la zona perianal derecha, eritematoso, fluctuante y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar analgésicos orales, baños de asiento y un laxante
- b) Realizar trombectomía y administrar AINES
- c) Puncionar con jeringa e iniciar tratamiento antibiótico oral
- d) Enviar a domicilio bajo tratamiento antibiótico oral
- e) Realizar drenaje quirúrgico e iniciar analgésicos orales

68) Se eligen 278 pacientes con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y 332 pacientes, sanos. Se comparan las tasas de exposición previa al humo del cigarrillo. ¿A qué tipo de

estudio corresponde el enunciado anterior?

- a) Caso control
- b) Ensayo clínico
- c) Transversal
- d) Cohortes
- e) Ensayo de campo

69) El tratamiento farmacológico de elección para el trastorno de pánico es:

- a) Benzodiazepinas
- b) Antidepresivos tricíclicos
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- e) Clorpromazina

70) La lesión elemental del acné es:

- a) Pápula
- b) Pseudopápula
- c) Comedón
- d) Pústula
- e) Escoriación

1) Un paciente presenta, desde hace 48 horas, visión de luces en el cuadrante temporal superior del campo visual del ojo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Retinopatía diabética
- c) Desprendimiento de retina
- d) Glaucoma
- e) Trombosis de rama de la vena central de la retina

2) Un paciente de 60 años, consulta por dolor epigástrico urente y baja de peso. Al examen físico se palpa una tumoración epigástrica. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen
- b) Solicitar ecografía de abdomen
- c) Solicitar CPRE
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Solicitar alfafetoproteína, Ca19.9 y antígeno carcinoembrionario

3) Una paciente de 35 años consulta por un cuadro de 35 días de rinorrea purulenta, hiposmia, obstrucción nasal, sensación de presión facial y descarga posterior. Refiere haber tomado paracetamol y antihistamínicos, sin lograr mejoría. ¿Qué aseveración es CORRECTA respecto a este cuadro clínico?

- a) El agente etiológico más probable es el estafilococo áureo
- b) Debe solicitarse una radiografía de cavidades paranasales
- c) Debe iniciarse amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Probablemente tenga una obstrucción del meato inferior
- e) Debe iniciarse una asociación entre antihistamínicos orales y corticoides tópicos

4) La capacidad de un test de catalogar como sana a una persona que efectivamente está sana se denomina:

- a) Sensibilidad
- b) Especificidad
- c) Valor predictivo positivo
- d) Valor predictivo negativo
- e) Exactitud

5) Un paciente de 56 años acude a control urológico, realizándose un tacto rectal que demuestra una tumoración de 1 cm de diámetro en el lóbulo derecho de la próstata, de consistencia dura. Se solicita además antígeno prostático que resulta 0,5 ng/ml (VN: menor a 4 ng/ml). La conducta más adecuada es:

- a) Biopsiar la lesión
- b) Iniciar ciprofloxacino oral y controlar con nuevo tacto rectal y con nuevo APE en 1 mes
- c) Iniciar finasteride oral y controlar con nuevo tacto rectal y con nuevo APE en 1 mes
- d) Controlar con nuevo tacto rectal y con nuevo APE en 6 meses
- e) Controlar con nuevo tacto rectal y con nuevo APE en 1 año

6) Un paciente es muy retraído, no tiene amigos íntimos y evita lugares y actividades en los que tenga que interactuar con otras personas ya que siente miedo a ser rechazado o ser considerado como inferior. Tampoco ha iniciado relaciones amorosas por el mismo motivo. El diagnóstico más probable es:

- a) Agorafobia
- b) Trastorno de ansiedad generalizada
- c) Fobia social
- d) Trastorno de personalidad evitativo
- e) Trastorno de personalidad dependiente

7) Una paciente de 20 años presenta aparición de múltiples lesiones eritematosas en el tronco y en la zona proximal de las extremidades, indoloras. Al examen se aprecian múltiples placas eritematosas,

con fina descamación, que se distribuyen en patrón de árbol de pascua. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis secundaria
- b) Psoriasis guttata
- c) Pityriasis versicolor
- d) Psoriasis
- e) Pityriasis rosada

8) Un paciente de 45 años, operado de una apendicitis hace 8 horas presenta fiebre hasta 38°C. La herida se muestra sin secreción ni eritema, al abdomen es doloroso a la palpación y el examen pulmonar muestra escasos crépitos bibasales. El diagnóstico más probable es:

- a) Pileflebitis
- b) Atelectasias
- c) Neumonía
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Plastrón apendicular

9) Un paciente sufre un asalto en su casa, siendo maniatado por los delincuentes. Inicialmente evoluciona bien, sin embargo 2 meses después presenta pesadillas y recuerdos frecuentes del suceso, que le causan gran ansiedad, insomnio y evita salir de la casa por miedo a ser agredido por delincuentes. Refiere que le es muy difícil expresar lo que siente y no lo ha conversado con sus familiares ni amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Distimia
- c) Depresión
- d) Ansiedad generalizada
- e) Trastorno de estrés postraumático

10) Un paciente sufre un golpe directo de alta energía en el codo izquierdo. Presentando una luxofractura. Además presenta imposibilidad para flexar los 4° y 5° dedos de dicha mano, con anestesia de ambos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Lesión del nervio mediano
- b) Lesión del nervio radial
- c) Lesión del nervio cutáneo antebraquial lateral
- d) Lesión del nervio musculocutáneo
- e) Lesión del nervio cubital

11) Se desea determinar si existe una relación causal entre el uso de las redes sociales (Facebook, Myspace) y el posterior consumo de drogas. ¿Qué tipo de estudio sería el más recomendado para resolver esta interrogante?

- a) Estudio de casos y controles
- b) Estudio de cohortes
- c) Ensayo clínico controlado
- d) Ensayo de campo
- e) Estudio de intervención comunitaria

12) ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para presentar náuseas en el postoperatorio?

- a) Paciente fumador
- b) Paciente de sexo femenino
- c) Paciente con antecedente de náuseas en cirugías previas
- d) Paciente con antecedente de náuseas en otras circunstancias, como viajar en auto, etc
- e) Paciente que recibió opiáceos

13) Un paciente de 40 años sufre la muerte de su esposa, evolucionando con tristeza, falta de concentración, insomnio e ideas de muerte. Refiere que se siente muy solo y que la muerte sería una

buena solución a su sufrimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Depresión psicótica
- c) Depresión melancólica
- d) Depresión doble
- e) Depresión atípica

14) Un paciente consulta por cefalea, vómitos, ojo rojo izquierdo y disminución de la agudeza visual izquierda. Al examen físico se constata ojo rojo periquerático, con dilatación pupilar izquierda que no responde a la luz. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Parálisis del tercer nervio craneal
- c) Síndrome de Horner
- d) Uveítis aguda
- e) Glaucoma agudo

15) Un paciente de 45 años consulta por dolor epigástrico muy intenso, asociado a vómitos alimentarios, ictericia y coluria. Al examen se aprecia de buen aspecto, con signos vitales normales e ictericia marcada. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina: 6,4 mg/dl, bilirrubina directa: 5,6 mg/dl, GGT: 430 UI/l, GOT: 58 UI/l, GPT: 60 UI/l, FA: 402 UI/l, lipasa: 45 UI/l, hematocrito: 40%, blancos: 8.500 por mm³. La ecografía muestra una vía biliar de 9 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Cólico biliar simple
- e) Celédocolitis

16) La asociación de dolor abdominal crónico, esteatorrea y diabetes debe hacer pensar en:

- a) Cáncer de páncreas
- b) Enfermedad celíaca
- c) Colecistitis crónica
- d) Cáncer de vesícula biliar
- e) Pancreatitis crónica

17) Una paciente de 30 años pierde casi por completo la audición del oído izquierdo en pocos minutos, permaneciendo sin cambios desde hace 6 horas. La otoscopia es normal. ¿Cómo esperaría encontrar los test de diapasones?

- a) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a derecha
- b) Rinne (+) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- c) Rinne (-) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- d) Rinne (-) a derecha, (-) a izquierda y Weber lateraliza a izquierda
- e) Rinne (+) a derecha, (+) a izquierda y Weber lateraliza a derecha

18) En un país, cuya población es de 3 millones de habitantes, se han detectado 300 casos de fiebre tifoidea en el último año. Esto quiere decir que:

- a) La prevalencia de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- b) La incidencia de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- c) La tasa de ataque de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- d) La letalidad de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- e) El likelihood ratio de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes

19) Un adolescente de 16 años cae a nivel, apoyando la extremidad superior izquierda en extensión, contra el suelo. Evoluciona con importante dolor en el codo izquierdo, que le impide especialmente la

pronosupinación. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de la apófisis coronoides
- b) Fractura del epicóndilo lateral
- c) Luxación del codo
- d) Fractura de olécranon
- e) Fractura de la cúpula radial

20) Un paciente alcohólico presenta un cuadro de confusión, diplopía y dificultades para caminar. Al examen físico destaca estrabismo divergente. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de privación
- b) Intoxicación por metanol
- c) Déficit de vitamina B1
- d) Alucinosis alcohólica
- e) Encefalopatía hepática

21) Un hombre de 63 años presenta una lesión solevantada en el ala nasal izquierda, de 6 mm de diámetro, con una telangectasia asociada. El diagnóstico más probable es:

- a) Granuloma telangectásico
- b) Melanoma nodular
- c) Rosácea
- d) Queratosis seborreica
- e) Carcinoma basocelular

22) Un paciente de 79 años presenta un cuadro de agitación e ideas paranoides. Al examen físico presenta desorientación temporoespacial y no puede invertir series adecuadamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Demencia por cuerpos de Lewy
- b) Accidente vascular encefálico
- c) Enfermedad de Alzheimer
- d) Síndrome confusional agudo
- e) Esquizofrenia de instalación tardía

23) Un paciente de 63 años se realiza una ecografía abdominal, que muestra como hallazgo, un tumor renal izquierdo de 5 cm de diámetro y de aspecto sólido, ubicado en el lóbulo superior. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar resonancia magnética nuclear abdominal y pelviana
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- c) Solicitar biopsia con aguja fina
- d) Realizar tumorectomía
- e) Realizar nefrectomía izquierda

24) Se realiza un estudio que compara un nuevo antibiótico para la neumonía intrahospitalaria con el tratamiento convencional. Se obtiene como resultado que el riesgo relativo de muerte, al usar el nuevo medicamento es 0,92, con un intervalo de confianza al 95% de 0,86 – 0,99. Con esto se puede afirmar que:

- a) El nuevo tratamiento es significativamente más eficaz que el tradicional
- b) El nuevo tratamiento es significativamente menos eficaz que el tradicional
- c) El nuevo tratamiento es igual de eficaz que el tradicional
- d) Hay un 95% de probabilidad de que el nuevo tratamiento sea mejor que el tradicional
- e) Hay un 92% de probabilidad de que el nuevo tratamiento sea mejor que el tradicional

25) ¿Cuál es el diagnóstico más probable frente a un paciente muy apático, con muy poca iniciativa, que presenta la idea de que es el enviado de Dios en la tierra?

- a) Esquizofrenia
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Manía
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno de personalidad esquizotípica

26) Un paciente de 85 años consulta por dolor abdominal muy intenso, de 1 hora de evolución, que

inició súbitamente y que se asoció a vómitos. Al examen físico presenta FC: 130 x', irregular, FR: 17 x', PA: 130/80 mmHg, se aprecia abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparotomía de urgencia
- b) Solicitar AngioTAC de abdomen
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar radiografía de tórax de pie
- e) Solicitar lipasa pancreática

27) Un paciente sufre una fractura expuesta de fémur izquierdo, producto de un accidente laboral. Es manejada con tutores externos. Días después presenta aumento del dolor, asociado a caída de los vellos distales y a adelgazamiento de la piel. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome compartimental
- b) Atrofia ósea de Sudeck
- c) Trombosis enosa profunda
- d) Pseudoartrosis
- e) Osteomielitis

28) El tratamiento inicial de un trastorno de pánico debe ser:

- a) Diazepam 10 mg cada 12 horas v.o.
- b) Fluoxetina 40 mg al día v.o.
- c) Fluoxetina 10 mg al día v.o. + alprazolam 0,5 mg cada 12 horas
- d) Clonazepam 1 mg cada 8 horas v.o. + risperidona 1 mg al día v.o.
- e) Fluoxetina 40 mg al día v.o. + clonazepam 1 mg cada 8 horas v.o.

29) Un paciente de 35 años consulta por aparición de lesiones muy pruriginosas en ambas muñecas. Al examen físico se aprecian pápulas eritematosas, con descamación muy fina, brillantes y poligonales, ubicadas en las zonas flexoras de ambas muñecas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis atópica
- b) Dermatitis de contacto alérgica
- c) Liquen simple crónico
- d) Liquen plano
- e) Angiomatosis basilar

30) Se realice un estudio que pretende correlacionar los niveles plasmáticos de homocisteinemia con los niveles plasmáticos de vitamina B12. Para esto se registran los valores de 200 pacientes. ¿Qué prueba es más adecuada para determinar la significancia estadística de esta correlación?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) r de Pearson
- d) Análisis de varianza
- e) Test exacto de Fischer

31) Una paciente refiere que en ocasiones presenta la idea de que la van a atropellar y por eso no sale de su casa o bien lo hace pero con ropa roja. Sabe que es ridículo, pero la ansiedad que la idea le causa es muy marcada. Además refiere que en ocasiones también siente que habrá un terremoto si es que no se cambia de ropa 3 veces. El tratamiento de elección es:

- a) Anticonvulsivantes
- b) Antidepresivos
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Litio
- e) Psicoterapia sola

32) El cáncer de colon suele complicarse más frecuentemente con:

- a) Hemorragia
- b) Perforación
- c) Sepsis
- d) Obstrucción
- e) Intususcepción

33) Una paciente de 23 años presenta un cuadro de insomnio, irritabilidad y agresividad con sus familiares. Al examen habla rápido y cambia fácilmente de tema, dejando incompletas algunas ideas que estaba exponiendo. Refiere sentirse bien y no tener ningún problema, más que sus familiares no la dejan tranquila. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad límite
- b) Psicosis aguda
- c) Trastorno por consumo de sustancias
- d) Depresión atípica
- e) Trastorno bipolar

34) Un niño de 2 años presenta retraso del lenguaje y la madre refiere que no escucha bien. A la otoscopia destacan tímpanos opacos y rosados. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar audiometría
- b) Solicitar impedanciometría
- c) Iniciar amoxicilina oral
- d) Iniciar corticoides orales
- e) Realizar punción timpánica

35) Un paciente de 45 años consulta por dolor ocular izquierdo, asociado a imposibilidad de ver por dicho ojo, que inició hace 24 horas y que se instaló en pocas horas. Al examen físico destaca pupila de Marcus Gunn. El diagnóstico más probable es:

- a) Uveítis aguda
- b) Neurosífilis
- c) Neuritis óptica
- d) Edema macular
- e) Glaucoma

36) Se decide implementar un programa de vacunación contra el pneumococo. Se pretende tener una cobertura del 80% en una población de 100.000 individuos. Además se sabe que una enfermera puede poner 10 vacunas por hora en promedio. ¿Cuántas horas-enfermera se necesitarán?

- a) 80.000
- b) 12.500
- c) 8.000
- d) 1.250
- e) 800

37) ¿Cuál de los siguientes es un efecto adverso de los IMAO?

- a) Aumento de peso
- b) Náuseas
- c) Impotencia sexual
- d) Constipación
- e) Hipertensión arterial

38) Un paciente sufre torsión de rodilla izquierda, mientras jugaba fútbol. Evoluciona con dolor importante, que le impide la marcha. Al examen físico se aprecia dolor a la palpación de la interlínea articular y a la compresión con rotación externa de la pierna, sin otras alteraciones. ¿Qué estructura está dañada con mayor probabilidad?

- a) Menisco medial
- b) Menisco lateral
- c) Ligamento cruzado anterior
- d) Ligamento colateral medial
- e) Ligamento colateral lateral

39) El trastorno de angustia se caracteriza principalmente por:

- a) Expectación ansiosa
- b) Crisis de pánico inesperadas y recurrentes
- c) Ansiedad constante
- d) Agorafobia
- e) Conductas evitativas

40) Un paciente sufre un atropello por un automóvil, resultando con fractura de pelvis, la que es adecuadamente manejada. Evoluciona con imposibilidad de orinar y uretrorragia y al examen físico se

aprecia globo vesical. La conducta más adecuada es:

- a) Instalar sonda Foley
- b) Drenar con sonda Nelaton
- c) Solicitar pielografía de eliminación
- d) Solicitar pielotAC
- e) Realizar cistostomía suprapúbica

41) Un paciente diabético, de 50 años, consulta por aparición de una lesión en el brazo izquierdo de lento crecimiento, 5 cm de diámetro, borde solevantado, papular, eritematoso, con tendencia a la curación central, sin compromiso de los fanéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Granuloma telangiectásico
- b) Tiña corporis
- c) Eritema marginado
- d) Eccema numular
- e) Granuloma anular

42) La tasa de natalidad en Chile ha presentado un lento descenso durante la última década, en cambio la tasa de mortalidad general se ha mantenido estable. Con esto se puede afirmar que en la última década, el crecimiento vegetativo:

- a) Se ha mantenido estable
- b) Ha presentado un lento descenso
- c) Ha presentado un leve aumento
- d) Ha presentado un marcado descenso
- e) Ha presentado un marcado aumento

43) Un paciente de 60 años, con cludicación intermitente de la pierna izquierda, desde hace 1 año, consulta por dolor intenso de inicio súbito en la pierna izquierda, asociada a palidez, parestesias y debilidad para la movilización de los ortejos. Al examen físico además se constata ausencia del pulso pedio y tibial posterior. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar pletismografía de volumen
- b) Realizar by-pass arterial femoro-poplíteo
- c) Solicitar ecografía doppler de extremidades inferiores
- d) Mejorar los factores de riesgo cardiovascular e indicar un programa de ejercicios de marcha
- e) Anticoagular con heparina y llamar al cirujano vascular para resolución urgente

44) Calcule el valor predictivo positivo con la siguiente información. Prevalencia: 10%, especificidad: 50%, sensibilidad: 80%.

- a) 15% aprox
- b) 35% aprox
- c) 55% aprox
- d) 75% aprox
- e) 95% aprox

45) Una paciente de 50 años consulta por vértigo intenso, que inició hace algunas horas. Refiere que desde hace 2 días presentaba sensación de oído izquierdo tapado, asociado a un tinitus y que se sentí a insegura en la marcha. Al examen físico se aprecia nistagmo horizontal con fase rápida hacia la izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuronitis vestibular
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Vértigo postural paroxístico benigno
- d) Accidente vascular cerebeloso
- e) Laberintitis aguda

46) Un paciente de 65 años presenta un cambio progresivo en su conducta, caracterizada por lenguaje más grosero, de contenido sexual y además con escaso o nulo insight. El diagnóstico más probable

es:

- a) Delirium
- b) Encefalopatía de Korsakov
- c) Demencia por cuerpos de Lewy
- d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Demencia frontotemporal

47) Un niño de 1 mes de edad presenta ambos testículos en el conducto inguinal, sin embargo es posible descenderlos hasta el escroto, volviendo inmediatamente al conducto inguinal al soltarlos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar descenso testicular y orquidopexia bilateral lo antes posible
- c) Realizar descenso testicular y orquidopexia bilateral durante el segundo año de vida
- d) Solicitar marcadores tumorales anuales
- e) Solicitar cariograma

48) La 1) atención primaria y 2) hospitalaria del sistema público, se financian principalmente a partir de:

- a) El aporte municipal y el 7% de aporte de los trabajadores, respectivamente
- b) El aporte per cápita y aporte fiscal directo, respectivamente
- c) El aporte fiscal directo y el copago de los trabajadores, respectivamente
- d) El aporte per cápita y el 7% de aporte de los trabajadores, respectivamente
- e) El aporte municipal y el aporte fiscal directo, respectivamente

49) Una cocinera consulta por dolor de la muñeca derecha, que aparece cuando realiza mucha actividad y que le impide seguir trabajando. Al examen presenta dolor a la palpación de la cara radial de la muñeca y especialmente al realizar una maniobra de flexión y oposición del pulgar, más cubitalización de la muñeca. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura del apófisis estiloides
- b) Dedo en gatillo
- c) Síndrome de túnel carpiano
- d) Tendinitis de Quervein
- e) Artrosis de muñeca

50) Un paciente de 60 años se palpa una masa pulsátil en el abdomen. Se solicita TAC abdominal que muestra un aneurisma aórtico abdominal de 4,1 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina
- b) Iniciar aspirina y estatinas, mejorar los factores de riesgo cardiovascular y realizar seguimiento ecográfico periódico
- c) Resolver quirúrgicamente mediante resección del segmento comprometido e instalación de una prótesis aórtica
- d) Solicitar angiografía aórtica
- e) Observar evolución, sin necesidad de ninguna medida adicional

51) Una mujer de 50 años presenta, desde hace algunas semanas, aparición de lesiones ampollosas recurrentes en la cara, tronco y extremidades, que se rompen fácilmente ante pequeños roces, dejando zonas de piel expuesta. Al examen físico presenta positividad del signo de Nikolsky. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de piel escaldada
- b) Penfigoide
- c) Pénfigo
- d) Síndrome de Steven Johnson
- e) Epidermolisis bulosa

52) Una paciente ve por televisión como su hijo es arrestado por vandalismo. Reacciona indiferente y

conversa con sus familiares acerca de lo bueno que es su hijo y acerca de que de seguro conseguirá un trabajo en el sur en el que podrá desarrollarse como un profesional exitoso. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipomanía
- b) Trastorno de estrés agudo
- c) Trastorno disociativo
- d) Psicosis reactiva
- e) Amnesia global transitoria

53) Se eligen 2 ciudades distintas y se comparan los índices de mortalidad infantil y las tasas de escolaridad de la población adulta, de modo de encontrar alguna relación entre el nivel de escolaridad de los padres y la tasa de mortalidad infantil. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

- a) Cohortes
- b) Casos y controles
- c) Ecológico
- d) Intervención comunitaria
- e) Ensayo de campo

54) Un paciente de 69 años sufre una caída por la escalera, presentando un golpe en la cabeza. Inicialmente está bien, con algo de dolor, sin embargo el dolor aumenta lentamente, presentado además desorientación al día siguiente. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma extradural
- b) Hematoma subdural
- c) Hemorragia subaracnoidea
- d) Hematoma intraparenquimatoso
- e) Contusión cerebral

55) Un paciente de 78 años presenta disminución progresiva de la agudeza visual de ambos ojos, mayor en el lado izquierdo, que inició hace un año. Además refiere que ve las imágenes distorsionadas. No ha presentado dolor ni otros síntomas y la inspección ocular, así como el rojo pupilar son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Catarata senil
- b) Glaucoma crónico
- c) Retinopatía diabética
- d) Degeneración macular relacionada con la edad
- e) Desprendimiento de retina

56) Un paciente de 40 años, diagnosticado de un trastorno delirante crónico, inicia tratamiento con risperidona. Sin embargo al segundo día presenta contracción tónica y dolorosa del músculo esternocleidomastoideo derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Disonía
- b) Acatisia
- c) Disquinesia
- d) Balismo
- e) Atetosis

57) Un paciente de 23 años consulta por aumento de volumen testicular. Se realiza una ecografía que muestra presencia de un tumor testicular izquierdo, de consistencia sólida y de 3 cm de diámetro. Se realiza orquiectomía radical y se solicitan marcadores tumorales. La biopsia es informada como presencia de seminoma puro y los marcadores muestran elevación marcada de la beta-HCG y de la alfa-fetoproteína. Se solicita un TAC de tórax, abdomen y pelvis que no visualiza metástasis a distancia ni adenopatías comprometidas. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución, controlando con marcadores tumorales cada 6 meses
- b) Iniciar quimioterapia
- c) Realizar radioterapia retroperitoneal profiláctica
- d) Realizar linfadenectomía lumboaórtica
- e) Iniciar hormonoterapia

58) El tratamiento de elección de la depresión en el embarazo es:

- a) Fluoxetina

- b) Venlafaxina
- c) Amitriptilina
- d) Moclobemida
- e) Anticonvulsivantes

59) Un paciente de 18 años consulta por odinofagia muy intensa, asociada a fiebre alta e imposibilidad de mover el cuello. Al examen físico se aprecia faringe eritematosa, con exudado amigdalino bilateral abundante. Al mover el cuello en el sentido antero-posterior se produce mucho dolor, el que no permite mayor movimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso periamigdalino
- b) Angina de Vincent
- c) Angina de Ludwig
- d) Adenitis supurada
- e) Abscesos retrofaríngeo

60) Un paciente presenta un nódulo cervical en la línea media, que asciende con la deglución y que se asocia a 2 adenopatías cervicales anteriores de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer papilar de tiroides
- b) Cáncer medular de tiroides
- c) Cáncer espinocelular de vía aereodigestiva superior
- d) Linfoma
- e) Tiroiditis de Riedel

61) Un paciente de 70 años consulta por dolor en el hombro izquierdo. Se solicita una radiografía que muestra múltiples lesiones líticas en sacabocado en relación a la cabeza y diáfisis humerales. El diagnóstico más probable es:

- a) Displasia fibrosa ósea
- b) Osteosarcoma
- c) Osteoma osteoide
- d) Tumor de células gigantes
- e) Mieloma múltiple

62) La bulimia se diferencia de la anorexia principalmente en que la primera:

- a) Pierde el control sobre la comida
- b) Presenta alteración de la percepción corporal
- c) Presenta obesidad
- d) Se asocia a trastornos de la personalidad
- e) Se asocia a episodios depresivos

63) Una paciente de 25 años consulta por ojo rojo, sensación de arenilla y prurito ocular bilateral, mayor al lado izquierdo. Al examen se aprecia hiperemia conjuntival, con secreción mucosa y presencia de reacción tarsal papilar. El diagnóstico más probable es:

- a) Conjuntivitis alérgica
- b) Conjuntivitis bacteriana
- c) Conjuntivitis viral
- d) Síndrome de Sjögren
- e) Queratitis punctata

64) Calcule el odds ratio con la siguiente información obtenida de un estudio de casos y controles:

	Casos	Controles	Total

Expuestos	20	10	30
No expuestos	80	190	270
Total	100	200	300

- a) 2,25
- b) 4,00
- c) 4,75
- d) 6,67
- e) 9,45

65) Una paciente, cursando una depresión severa, ingiere 50 comprimidos de amitriptilina hace 2 horas, con clara intención suicida. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar naloxona y realizar apoyo ventilatorio
- b) Realizar apoyo ventilatorio y acidificar la orina
- c) Realizar monitorización electrocardiográfica y administrar bicarbonato endovenoso
- d) Realizar lavado gástrico
- e) Administrar carbón activado y N-acetilcisteína

66) Un paciente de 50 años consulta por un cuadro de un día de evolución de aparición de múltiples lesiones eritematosas e intensamente pruriginosas, generalizadas. Al examen físico se aprecian lesiones pseudopapulares generalizadas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis de contacto alérgica aguda
- b) Dermatitis atópica
- c) Prurigo
- d) Urticaria aguda
- e) Eritema multiforme menor

67) Un paciente de 8 años presenta obstrucción nasal intermitente, de larga data, asociada a rinorrea acuosa. Al examen físico se aprecia ojeroso, con la mucosa nasal pálida. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipertrofia adenoidea
- b) Sinusitis crónica
- c) Poliposis nasal
- d) Rinitis alérgica
- e) Rinitis vasomotora

68) Un paciente de 65 años presenta hematuria en 3 oportunidades, sin otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina que muestra más de 100 GR por campo, sin presencia de dismorfia, ni otras alteraciones. El urocultivo es negativo. La conducta diagnóstica más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) Solicitar una uretrocistografía miccional seriada
- b) Solicitar una pielografía de eliminación
- c) Solicitar un pielotAC
- d) Solicitar una ecografía renal y vesical
- e) Solicitar una cistoscopia

69) Una paciente de 24 años se golpea la pierna izquierda. Al examen se aprecia aumento de volumen de 10 cm de diámetro, indoloro, de consistencia similar a las masas musculares. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma
- b) Lipoma
- c) Linfoma
- d) Sarcoma
- e) Quiste de Baker

70) Un paciente de 60 años, operado de una orquiectomía, con anestesia raquídea, presenta cefalea muy intensa al día siguiente de la operación y que aumenta especialmente al sentarse o ponerse de

pie, obligándolo a permanecer en decúbito. Al examen físico no presenta signos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar AINES endovenosos
- b) Solicitar TAC de cerebro
- c) Solicitar punción lumbar
- d) Iniciar anticoagulación con heparina
- e) Realizar parche de sangre

1) Una paciente consulta porque astenia y disestesias de las extremidades inferiores de larga data, que han empeorado en el último tiempo. Además refiere náuseas y dolor abdominal recurrente y en algunas ocasiones disuria y sensación de cuerpo extraño faríngeo (globus). Cuenta con numerosos exámenes que descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno por hipocondría
- b) Trastorno por somatización
- c) Trastorno conversivo
- d) Trastorno disociativo
- e) Trastorno delirante crónico

2) La lesión de la cintilla óptica izquierda se traduce clínicamente es:

- a) Hemianopsia heterónima binasal
- b) Hemianopsia heterónima bitemporal
- c) Hemianopsia homónima derecha
- d) Hemianopsia homónima izquierda
- e) Amaurosis

3) La mastocitosis es una enfermedad muy infrecuente. Se quiere determinar su relación con la exposición a arsénico. ¿Qué tipo de estudio sería el más útil para esto?

- a) Transversal
- b) De cohortes
- c) De casos y controles
- d) Ensayo clínico controlado
- e) Serie de casos clínicos

4) Un paciente de 24 años nota aumento de volumen testicular. Al examen físico se palpa un tumor testicular izquierdo de cerca de 2 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar marcadores tumorales
- b) Observar evolución
- c) Solicitar ecografía testicular
- d) Solicitar biopsia por punción
- e) Realizar orquiectomía radical

5) ¿Qué alteración es más probable de encontrar en un paciente con trastorno de ansiedad generalizada?

- a) Ansiedad anticipatoria
- b) Crisis de pánico recurrentes
- c) Expectación ansiosa
- d) Embotamiento afectivo
- e) Temblor

6) Una paciente de 50 años consulta por vértigo intenso, que inició hace algunas horas. Refiere que desde hace 2 días presentaba sensación de oído izquierdo tapado, asociado a un tinitus y que se sentía insegura en la marcha. Al examen físico se aprecia nistagmo horizontal con fase rápida hacia la izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis vestibular
- b) Enfermedad de Meniere
- c) Vértigo postural paroxístico benigno
- d) Accidente vascular cerebeloso
- e) Laberintitis aguda

7) Un paciente de 23 años presenta una caída a nivel, cayendo sobre la extremidad superior izquierda, en extensión. Al examen físico presenta dolor a la presión de la tabaquera anatómica. El diagnóstico más probable es:

- a) Fractura de trapecio
- b) Fractura de cúpula radial
- c) Fractura de la apófisis estiloides
- d) Fractura de escafoides
- e) Fractura de extremo distal del radio

8) Un paciente de 54 años consulta por vómitos explosivos, frecuentes, que suceden algunos minutos

después de cada comida. Refiere además haber bajado 7 Kg de peso en los últimos 2 meses. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar manometría esofágica
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar pH-metría esofágica de 24 horas
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste

9) Una mujer de 21 años presenta pésimas relaciones familiares con sus padres y con su hermano. Pelean frecuentemente y ella incluso ha llegado a agredir a su madre. Además presenta una relación muy intensa e inestable con su novio, con quien ha terminado y vuelto en reiteradas ocasiones. En 2 oportunidades ha intentado suicidarse, la última de ellas con ingestión de benzodicepinas. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de conducta
- b) Depresión psicótica
- c) Esquizofrenia hebefrénica
- d) Trastorno de personalidad antisocial
- e) Trastorno de personalidad límite

10) Una paciente de 20 años ha presentado en 3 oportunidades un cuadro caracterizado por angustia, disnea, palpitaciones, vértigo, náuseas y sensación de muerte, que inicia y se instala relativamente rápidamente, durando cerca de 15 minutos. Refiere que los episodios inician de manera inesperada y tienen mucho miedo a que se repitan y pueda morir. El tratamiento más adecuado de la patología descrita, es:

- a) Benzodicepinas
- b) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Litio
- d) Antipsicóticos atípicos
- e) Anticonvulsivos

11) ¿Qué examen es útil para la confirmación diagnóstica de la dermatitis de contacto alérgica?

- a) Biopsia cutánea
- b) Prick test
- c) Test de parche
- d) Prueba de respuesta a corticoides
- e) Niveles plasmáticos de IgE específica

12) Un paciente de 78 años presenta disminución progresiva de la agudeza visual de ambos ojos, mayor en el lado izquierdo, que inició hace un año. Además refiere que ve las imágenes distorsionadas. No ha presentado dolor ni otros síntomas y la inspección ocular, así como el fondo pupilar son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Catarata senil
- b) Glaucoma crónico
- c) Retinopatía diabética
- d) Degeneración macular relacionada con la edad
- e) Desprendimiento de retina

13) La capacidad de una intervención de dar resultados favorables a menor costo se denomina:

- a) Eficacia
- b) Efectividad
- c) Utilidad
- d) Eficiencia
- e) Beneficio

14) Se solicita una ecografía abdominal a un paciente, como parte del estudio de una insuficiencia renal crónica, que visualiza como hallazgo, la presencia de 2 lesiones hepáticas redondas, anecogé

nicas, de 3 y 4 cm de diámetro respectivamente, con presencia de una pared hiperecogénica de 2 mm de grosor y refuerzo posterior. El diagnóstico más probable es:

- a) Quistes simples
- b) Quistes hidatídicos
- c) Metástasis
- d) Hemangiomas
- e) Hierplasia nodular

15) Una mujer de 55 años presenta miedo a que la asalten, por lo que ha dejado de salir de su casa. Además no le gusta que su marido ni que su hijo manejen por miedo a que puedan chocar. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Fobia social
- b) Agorafobia
- c) Trastorno de personalidad evitativo
- d) Depresión
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

16) El trastorno delirante crónico se caracteriza principalmente por presentar:

- a) Ideas paranoides
- b) Delirio sistematizado
- c) Alucinaciones visuales
- d) Alucinaciones auditivas
- e) Juicio de la realidad conservado

17) Una paciente de 65 años ha notado algunas dificultades para ver. Al examen físico se aprecia una agudeza visual normal, sin embargo ha perdido gran parte de la visión periférica, manteniendo la visión central. El diagnóstico más probable es:

- a) Degeneración macular relacionada con la edad
- b) Glaucoma crónico
- c) Catarata
- d) Tumor de hipófisis
- e) Edema macular

18) La capacidad de un test de catalogar como enferma a una persona que efectivamente está enferma se denomina:

- a) Sensibilidad
- b) Especificidad
- c) Valor predictivo positivo
- d) Valor predictivo negativo
- e) Exactitud

19) Un paciente presenta placas eritematosas en ambas extremidades inferiores, descamativas, no dolorosas ni pruriginosas, asociadas a lesiones ungueales como pequeños hundimientos. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña
- b) Psoriasis
- c) Dermatomiositis
- d) Liquen plano
- e) Dermatitis de contacto

20) Una paciente de 35 años consulta por un cuadro de 35 días de rinorrea purulenta, hiposmia, obstrucción nasal, sensación de presión facial y descarga posterior. Refiere haber tomado paracetamol y antihistamínicos, sin lograr mejoría. ¿Qué aseveración es CORRECTA respecto a este cuadro clínico?

- a) El agente etiológico más probable es el estafilococo áureo
- b) Debe solicitarse una radiografía de cavidades paranasales
- c) Debe iniciarse amoxicilina más ácido clavulánico
- d) Probablemente tenga una obstrucción del meato inferior
- e) Debe iniciarse una asociación entre antihistamínicos orales y corticoides tópicos

21) Un paciente de 25 años es traído por su madre, ya que desde hace un mes que anda con ideas

extrañas acerca de contactarse con Dios. Refiere que Dios le habla y que le dice que el mundo se está acabando. La madre refiere que ha descuidado su aspecto personal y que se ha retraído bastante. Previo a este episodio, era un hombre muy religioso, poco expresivo y con pocos amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Esquizofrenia
- c) Trastorno esquizoafectivo
- d) Depresión psicótica
- e) Trastorno de personalidad esquizotípica

22) Un paciente con antecedente de hiperplasia benigna de la próstata, en tratamiento con tamsulosina, consulta por imposibilidad de orinar, de 6 horas de evolución, asociado a intenso dolor abdominal. Al examen físico se palpa globo vesical. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar cistostomía suprapúbica
- b) Drenar con sonda Nelaton
- c) Instalar sonda Foley a permanencia
- d) Indicar sondeo vesical intermitente
- e) Administrar anticolinérgicos endovenosos

23) Un paciente de 45 años, operado de una apendicitis hace 8 horas presenta fiebre hasta 38°C. La herida se muestra sin secreción ni eritema, al abdomen es doloroso a la palpación y el examen pulmonar muestra escasos crépitos bibasales. El diagnóstico más probable es:

- a) Pileflebitis
- b) Atelectasias
- c) Neumonía
- d) Tromboembolismo pulmonar
- e) Plastrón apendicular

24) Un hombre de 80 años con antecedente de artrosis, presenta ánimo bajo y tristeza. Refiere que sus dolores articulares en las caderas limitan mucho sus actividades y se siente viejo e inútil, además que sus amigos antiguos han fallecido en su mayoría. Piensa que vivir en esas condiciones no sirve y que debería morir ahora, sin embargo no presenta ideación suicida. Refiere que duerme poco y que se junta menos con sus familiares y amigos. La conducta más adecuada, además de mejorar el tratamiento analgésico de la artrosis, es:

- a) Iniciar psicoterapia
- b) Iniciar psicoterapia y quetiapina
- c) Iniciar psicoterapia y sertralina
- d) Iniciar psicoterapia y amitriptilina
- e) Iniciar psicoterapia y ácido valproico

25) Una paciente de 28 años, sin antecedentes de importancia, consulta por cefalea muy intensa, que inició de manera súbita, hace 30 minutos, presentando además vómitos. Al examen físico no presenta signos focales. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar corticoides endovenosos
- b) Administrar AINES y antieméticos endovenosos y reevaluar en 4 horas
- c) Indicar AINES orales y controlar en 24 horas
- d) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
- e) Solicitar RMN de cerebro

26) Identifique la asociación INCORRECTA entre la condición y el manejo de la vía aérea:

- a) Estómago lleno – máscara laríngea
- b) Vía aérea difícil – intubación vigil
- c) Estómago lleno – intubación en secuencia rápida
- d) Trauma cervical – No hiperextender la columna
- e) Vía aérea difícil – Intubación con guía (boogie)

27) Las actividades que promueven un estilo de vida saludable, con alimentación adecuada y ejercicios habituales corresponde a:

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Prevención específica
- e) Protección de la salud

28) El tratamiento del síndrome compartimental, secundario a una fractura, suele ser:

- a) Analgesia
- b) Anticoagulación
- c) Vendaje compresivo
- d) Inmovilización adecuada
- e) Fasciotomía amplia

29) La asociación de ojo rojo profundo, miosis, hipopion y disminución de la agudeza visual, debe hacer sospechar:

- a) Queratitis
- b) Uveítis
- c) Glaucoma de ángulo abierto
- d) Glaucoma de ángulo estrecho
- e) Coriorretinitis

30) ¿De dónde se obtienen los recursos para el manejo de los accidentes laborales y del trayecto?

- a) Del aporte fiscal directo
- b) Del aporte per cápita
- c) Del aporte de las municipalidades
- d) Del aporte de las mutuales de seguridad
- e) Del aporte de los empleadores

31) En un paciente con una manía aguda se espera encontrar todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Alucinaciones
- b) Verborrea
- c) Aumento de la libido
- d) Insomnio
- e) Ánimo irritable

32) Un paciente presenta, desde hace 48 horas, visión de luces en el cuadrante temporal superior del campo visual del ojo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuritis óptica
- b) Retinopatía diabética
- c) Desprendimiento de retina
- d) Glaucoma
- e) Trombosis de rama de la vena central de la retina

33) Se desea determinar si existe una relación causal entre el uso de las redes sociales (Facebook, Myspace) y el posterior consumo de drogas en niños y adolescentes. Se cuenta con una población en la cual el 40% de los niños y adolescentes utiliza estas redes. ¿Qué tipo de estudio sería el más recomendado para resolver esta interrogante?

- a) Estudio de casos y controles
- b) Estudio de cohortes
- c) Ensayo clínico controlado
- d) Ensayo de campo
- e) Estudio de intervención comunitaria

34) Un hombre de 65 años, presenta hematuria recurrente desde hace 5 días, sin otros síntomas. El examen físico no presenta alteraciones y los exámenes de orina demuestran hematuria de más de 100

glóbulos rojos por campo, sin dismorfia, sin otras alteraciones y con hemocultivos negativos. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
- b) Solicitar ecografía renal y vesical
- c) Solicitar uretrocistografía retrógrada
- d) Solicitar cistoscopia
- e) Solicitar pielografía de eliminación endovenosa

35) En un pueblo africano de 1.000 personas, aparecen 60 casos de ébola durante un año, de los cuales 54 mueren. Calcule la letalidad del ébola:

- a) 90%
- b) 54 por mil
- c) 60 por mil
- d) 90 por mil
- e) 1,1

36) Un paciente de 45 años consulta por dolor epigástrico muy intenso, asociado a vómitos alimentarios, ictericia y coluria. Al examen se aprecia de buen aspecto, con signos vitales normales e ictericia marcada. Se solicitan exámenes que muestran bilirrubina: 6,4 mg/dl, bilirrubina directa: 5,6 mg/dl, GGT: 430 U/l, GOT: 58 U/l, GPT: 60 U/l, FA: 402 U/l, lipasa: 45 U/l, hematocrito: 40%, blancos: 8.500 por mm³. La ecografía muestra una vía biliar de 9 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

- a) Colangitis aguda
- b) Pancreatitis aguda
- c) Colecistitis aguda
- d) Cólico biliar simple
- e) Celédocolitis

37) La asociación de dolor abdominal crónico, esteatorrea y diabetes debe hacer pensar en:

- a) Cáncer de páncreas
- b) Enfermedad celíaca
- c) Colecistitis crónica
- d) Cáncer de vesícula biliar
- e) Pancreatitis crónica

38) Un paciente de 35 años consulta por dolor precordial. Al examen físico está muy agitado, sudoroso, con temperatura 37,8°C, FC: 130 x', PA: 180/110 mmHg y con midriasis bilateral. El resto del examen físico no aporta mayor información. Como antecedente tendría adicción a las drogas. ¿Qué fármaco es más adecuado para el manejo inicial de este paciente?

- a) Propanolol
- b) Bicarbonato
- c) Benzodiazepinas
- d) Haloperidol
- e) Naloxona

39) Un paciente de 35 años consulta por aparición de lesiones muy pruriginosas en ambas muñecas. Al examen físico se aprecian pápulas eritematosas, con descamación muy fina, brillantes y poligonales, ubicadas en las zonas flexoras de ambas muñecas. El diagnóstico más probable es:

- a) Dermatitis atópica
- b) Dermatitis de contacto alérgica
- c) Liquen simple crónico
- d) Liquen plano
- e) Angiomatosis basilar

40) Una paciente presenta hipoacusia derecha que ha aumentado en el último tiempo. La otoscopia no muestra alteraciones por lo que se realizan pruebas de diapasones, que muestran Rinne (+) a izquierda

y (-) a derecha y Weber que lateraliza a derecha. El diagnóstico más probable es:

- a) Presbiacusia
- b) Otitis media fibroadesiva
- c) Otoesclerosis
- d) Sordera súbita
- e) Trauma acústico

41) Un paciente de 59 años, agricultor, presenta lesiones cutáneas ásperas, de hasta 4 mm de diámetro, localizadas en el dorso de ambas manos, en la frente y la nariz, que han crecido lentamente a lo largo de años y que no presentan dolor ni prurito. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratosis seborreica
- b) Léntigos solares
- c) Carcinomas basocelulares
- d) Queratosis actínicas
- e) Rosácea

42) Un paciente de 85 años consulta por dolor abdominal muy intenso, de 1 hora de evolución, que inició súbitamente y que se asoció a vómitos. Al examen físico presenta FC: 130 x', irregular, FR: 17 x', PA: 130/80 mmHg, se aprecia abdomen blando, depresible, sin signos peritoneales. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar laparotomía de urgencia
- b) Solicitar AngioTAC de abdomen
- c) Solicitar ecografía abdominal
- d) Solicitar radiografía de tórax de pie
- e) Solicitar lipasa pancreática

43) En el tratamiento del alcoholismo es útil la naltrexona, ya que actúa:

- a) Como un fármaco aversivo
- b) Como un fármaco desmotivante
- c) Sustituyendo el efecto del alcohol en el sistema nervioso central
- d) Aumentando la metabolización hepática del alcohol
- e) Disminuyendo la metabolización hepática del alcohol

44) Una paciente de 20 años presenta aparición de múltiples lesiones eritematosas en el tronco y en la zona proximal de las extremidades, indoloras. Al examen se aprecian múltiples placas eritematosas, con fina descamación, que se distribuyen en patrón de árbol de pascua. El diagnóstico más probable es:

- a) Sífilis secundaria
- b) Psoriasis guttata
- c) Pitiriasis versicolor
- d) Psoriasis
- e) Pitiriasis rosada

45) Un paciente de 19 años consulta por odinofagia muy intensa, asociada a imposibilidad de abrir la boca. Al examen físico se aprecia eritema faríngeo, con exudado bilateral y abombamiento del pilar amigdalino izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Indicar penicilina benzatina intramuscular y analgésicos orales
- b) Indicar amoxicilina oral
- c) Indicar amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral
- d) Hospitalizar para tratamiento endovenoso con ceftriaxona + clindamicina
- e) Hospitalizar para drenaje quirúrgico y tratamiento antibiótico

46) En un país, cuya población es de 3 millones de habitantes, se han detectado 300 casos de fiebre tifoidea en el último año. Esto quiere decir que:

- a) La prevalencia de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- b) La incidencia de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- c) La tasa de ataque de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- d) La letalidad de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes
- e) El likelihood ratio de fiebre tifoidea es 10 por 100.000 habitantes

47) Un paciente sufre un asalto en su casa, siendo maniatado por los delincuentes. Inicialmente

evoluciona bien, sin embargo 2 meses después presenta pesadillas y recuerdos frecuentes del suceso, que le causan gran ansiedad, insomnio y evita salir de la casa por miedo a ser agredido por delincuentes. Refiere que le es muy difícil expresar lo que siente y no lo ha conversado con sus familiares ni amigos. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Distimia
- c) Depresión
- d) Ansiedad generalizada
- e) Trastorno de estrés postraumático

48) ¿Qué elemento le da una mayor gravedad a una fractura expuesta?

- a) Herida de 5 cm de diámetro
- b) Fractura conminuta
- c) Mala cobertura de partes blandas
- d) Fractura con rasgo intraarticular
- e) Tiempo de evolución de 5 horas antes de atención médica

49) El problema más frecuente del propofol, en la práctica anestésica, es:

- a) Depresión respiratoria
- b) Hipotensión
- c) Convulsiones
- d) Alergias
- e) Hipertermia maligna

50) La lesión del cuarto nervio craneo producirá:

- a) Imposibilidad para mirar hacia arriba
- b) Imposibilidad para mirar hacia lateral
- c) Imposibilidad para mirar hacia inferonasal
- d) Miosis
- e) Midriasis

51) Un hombre de 36 años consulta por disuria y fiebre, asociadas a lesiones en el pene. Al examen físico se constata t° : 38,9°C, adenopatías inguinales bilaterales y se observan múltiples úlceras en el glande, dolorosas, de fondo blanquecino. El diagnóstico más probable es:

- a) Linfogranuloma venéreo
- b) Herpes genital
- c) Sífilis primaria
- d) Chancroide genital
- e) Balanopostitis gonocócica

52) Un paciente de 40 años sufre la muerte de su esposa, evolucionando con tristeza, falta de concentración, insomnio e ideas de muerte. Refiere que se siente muy solo y que la muerte sería una buena solución a su sufrimiento. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno adaptativo
- b) Depresión psicótica
- c) Depresión melancólica
- d) Depresión doble
- e) Depresión atípica

53) Un paciente de 60 años se palpa una masa pulsátil en el abdomen. Se solicita TAC abdominal que muestra un aneurisma aórtico abdominal de 3,8 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar anticoagulación con heparina
- b) Iniciar aspirina y estatinas, mejorar los factores de riesgo cardiovascular y realizar seguimiento ecográfico periódico
- c) Resolver quirúrgicamente mediante resección del segmento comprometido e instalación de una prótesis aórtica
- d) Solicitar angiografía aórtica
- e) Observar evolución, sin necesidad de ninguna medida adicional

54) Calcule el Odds ratio aproximado, utilizando la siguiente información de un estudio de prevalencia. Elija la alternativa que contenga al valor de dicho OR.

	Gastritis antral (+)	Gastritis antral (-)	Total
H. Pylori (+)	600	150	750
H Pylori (-)	50	200	250
Total	650	350	1000

- a) Menor a 1
- b) Entre 1 y 5
- c) Entre 5 y 10
- d) Entre 10 y 15
- e) Mayor a 15

55) ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un paciente con una fractura nasal reciente que presenta un hematoma del tabique?

- a) Solicitar TAC de cavidades paranasales y decidir conducta según resultados
- b) Solicitar RMN de cavidades paranasales y decidir conducta según resultados
- c) Controlar en 7 días para evaluar cirugía
- d) Compresión del tabique nasal
- e) Drenaje quirúrgico de inmediato

56) Un paciente de 65 años presenta hematuria en 3 oportunidades, sin otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina que muestra más de 100 GR por campo, sin presencia de dismorfia, ni otras alteraciones. El urocultivo es negativo. La conducta diagnóstica más adecuada para proseguir el estudio es:

- a) Solicitar una uretrocistografía miccional seriada
- b) Solicitar una pielografía de eliminación
- c) Solicitar un pielotac
- d) Solicitar una ecografía renal y vesical
- e) Solicitar una cistoscopia

57) Una paciente de 68 años, alcohólica, consulta por dolor en la ingle izquierda, que inició el día de ayer y que le dificulta la marcha. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y presenta importante dolor a la movilización del muslo izquierdo, especialmente ante la abducción con rotación externa. El diagnóstico más probable es:

- a) Artritis séptica
- b) Artrosis
- c) Síndrome de pellizcamiento acetabular
- d) Pelviespondiloartropatía
- e) Necrosis avascular de la cabeza femoral

58) Un paciente alcohólico presenta un cuadro de confusión, diplopía y dificultades para caminar. Al examen físico destaca estrabismo divergente. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de privación
- b) Intoxicación por metanol
- c) Encefalopatía de Wernicke
- d) Alucinosis alcohólica
- e) Encefalopatía hepática

59) Un paciente presenta un nódulo cervical en la línea media, que asciende con la deglución y que se asocia a 2 adenopatías cervicales anteriores de consistencia aumentada. El diagnóstico más probable es:

- a) Cáncer papilar de tiroides
- b) Cáncer medular de tiroides
- c) Cáncer espinocelular de vía aereodigestiva superior
- d) Linfoma
- e) Tiroiditis de Riedel

60) Una paciente consulta por sensación de oído tapado y otorrea por el oído izquierdo, de algunas semanas de evolución. Al examen físico se aprecia una perforación timpánica izquierda. El diagnóstico

stico más probable es:

- a) Cáncer de oído
- b) Otitis media crónica
- c) Otitis media con efusión
- d) Otitis externa localizada
- e) Otitis externa maligna

61) Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por constipación de un mes de evolución, que en las últimas horas se ha hecho mucho más marcada, siendo imposible eliminar gases ni deposiciones y presentando dolor abdominal tipo cólico y vómitos alimentarios. Al examen físico se aprecia distensión abdominal, con dolor a la palpación y aumento de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:

- a) Íleo biliar
- b) Vólvulo de sigmoides
- c) Cáncer de colon
- d) Obstrucción intestinal por bridas
- e) Enfermedad diverticular complicada

62) Un niño de 1 mes de edad presenta ambos testículos en el conducto inguinal, sin embargo es posible descenderlos hasta el escroto, volviendo inmediatamente al conducto inguinal al soltarlos. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar descenso testicular y orquidopexia bilateral lo antes posible
- c) Realizar descenso testicular y orquidopexia bilateral durante el segundo año de vida
- d) Solicitar marcadores tumorales anuales
- e) Solicitar cariograma

63) El tratamiento inicial de un trastorno de pánico debe ser:

- a) Diazepam 10 mg cada 12 horas v.o.
- b) Fluoxetina 40 mg al día v.o.
- c) Fluoxetina 10 mg al día v.o. + alprazolam 0,5 mg cada 12 horas
- d) Clonazepam 1 mg cada 8 horas v.o. + risperidona 1 mg al día v.o.
- e) Fluoxetina 40 mg al día v.o. + clonazepam 1 mg cada 8 horas v.o.

64) Un paciente sufre una fractura expuesta de fémur izquierdo, producto de un accidente laboral. Es manejada con tutores externos. Días después presenta aumento del dolor, asociado a caída de los vellos distales y a adelgazamiento de la piel. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome compartimental
- b) Atrofia ósea de Sudeck
- c) Trombosis enosa profunda
- d) Pseudoartrosis
- e) Osteomielitis

65) Una mujer consulta por eritema facial, que compromete el dorso de la nariz y ambas zonas malares, respetando el surco nasolabial. No presenta otras lesiones y refiere astenia. El diagnóstico más probable es:

- a) Rosácea
- b) Dermatomiositis
- c) Lupus
- d) Nevus flammeus
- e) Erisipela

66) Se realiza un estudio que compara un nuevo antibiótico para la neumonía intrahospitalaria con el tratamiento convencional. Se obtiene como resultado que el riesgo relativo de muerte, al usar el nuevo

medicamento es 0,92, con un intervalo de confianza al 95% de 0,86 – 0,99. Con esto se puede afirmar que:

- a) El nuevo tratamiento es significativamente más eficaz que el tradicional
- b) El nuevo tratamiento es significativamente menos eficaz que el tradicional
- c) El nuevo tratamiento es igual de eficaz que el tradicional
- d) Hay un 95% de probabilidad de que el nuevo tratamiento sea mejor que el tradicional
- e) Hay un 92% de probabilidad de que el nuevo tratamiento sea mejor que el tradicional

67) Un paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral, por un golpe directo. ¿Qué estructura estará lesionada con mayor posibilidad?

- a) Nervio cubital
- b) Arteria braquial
- c) Nervio mediano
- d) Vena basilíca
- e) Nervio radial

68) Una paciente de 24 años se golpea la pierna izquierda. Al examen se aprecia aumento de volumen de 10 cm de diámetro, indoloro, de consistencia similar a las masas musculares. El diagnóstico más probable es:

- a) Hematoma
- b) Lipoma
- c) Linfoma
- d) Sarcoma
- e) Quiste de Baker

69) Una paciente refiere que en ocasiones presenta la idea de que la van a atropellar y por eso no sale de su casa o bien lo hace pero con ropa roja. Sabe que es ridículo, pero la ansiedad que la idea le causa es muy marcada. Además refiere que en ocasiones también siente que habrá un terremoto si es que no se cambia de ropa 3 veces. El tratamiento de elección es:

- a) Anticonvulsivantes
- b) Antidepresivos
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Litio
- e) Psicoterapia sola

70) Se realiza un estudio que pretende correlacionar los niveles plasmáticos de homocisteinemia con los niveles plasmáticos de vitamina B12. Para esto se registran los valores de estas dos sustancias en 200 pacientes. ¿Qué prueba es más adecuada para determinar la significancia estadística de esta correlación?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) r de Pearson
- d) Análisis de varianza
- e) Test exacto de Fischer

1) Un paciente de 80 años presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, de manera brusca. Al examen se aprecia amaurosis izquierda, con defecto pupilar aferente ipsilateral y edema de papila en el fondo de ojo. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de hipertensión endocraneana
- b) Glaucoma de ángulo abierto
- c) Glaucoma de ángulo estrecho
- d) Trombosis de la vena central de la retina
- e) Neuritis óptica isquémica anterior

2) Un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón, presenta de manera aguda un cuadro caracterizado por disfonía, con voz bitonal. El diagnóstico más probable es:

- a) Síndrome de vena cava superior
- b) Edema de Reinke
- c) Cáncer de laringe
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Parálisis del nervio laríngeo recurrente

3) Un paciente se ve obligado a rematar su casa, debido a que presenta múltiples deudas y enfrenta la quiebra de su empresa. Su situación económica se estabiliza, sin embargo él y su familia deben disminuir el ritmo de gastos al que estaban acostumbrados, de manera drástica, arrendando un pequeño departamento. El paciente evoluciona con ánimo bajo, muy irritable, con sensación de fracaso e ideas de desesperanza. Refiere que siente mucha vergüenza, duerme gran parte del día y no tiene motivación para reactivar su empresa o buscar un empleo. Además ya no se junta con sus amigos y casi no habla con sus hijos ni esposa. Ella refiere que está muy preocupada, ya que previo a esto, era un hombre muy alegre, buen padre y buen esposo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno bipolar
- b) Trastorno adaptativo
- c) Trastorno depresivo mayor
- d) Esquizofrenia
- e) Trastorno por estrés postraumático

4) Un paciente de 80 años consulta por dolor en la rodilla izquierda, de 1 mes de evolución, que aumenta con la marcha y que cede parcialmente con el reposo. Refiere además dolor nocturno. Al examen físico presenta movilidad indolora, con cierto grado de limitación a la flexión completa, sin signos inflamatorios ni de derrame articular. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar radiografía de rodillas
- b) Indicar reposo relativo y AINEs orales, sin necesidad de estudio
- c) Solicitar ecografía e indicar analgésicos orales
- d) Solicitar artroscopia
- e) Solicitar estudio de líquido sinovial

5) Un estudio diagnóstico presenta sensibilidad: 95%, especificidad: 92%, VPP: 90% y VPN:98%. Un paciente se realiza el examen y resulta negativo. ¿Qué probabilidad tiene de estar enfermo?

- a) 2%
- b) 5%
- c) 8%
- d) 10%
- e) 95%

6) Un paciente sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media izquierda. Se ausculta un soplo carotídeo izquierdo. La conducta más adecuada, para el estudio de la etiología, es:

- a) Solicitar Angio-TAC de cuello
- b) Solicitar ecografi-doppler de carótidas
- c) Solicitar angiografía carotídea
- d) Solicitar pletismografía de volumen
- e) Solicitar angio-RMN de cuello y cerebro

7) Un paciente de 60 años presenta lesiones solewantadas, ásperas e hiperqueratósicas en la frente y nariz, de hasta 5 mm de diámetro, sin dolor ni prurito, que han crecido lentamente en los últimos años.

Respecto a este paciente es VERDADERO que:

- a) Las lesiones descritas deben ser extirpadas inmediatamente, de manera quirúrgica
- b) Las lesiones descritas tienen riesgo de evolucionar a un melanoma
- c) Las lesiones descritas tienen riesgo de evolucionar a un cáncer basocelular
- d) Las lesiones descritas tienen riesgo de evolucionar a un cáncer espinocelular
- e) Las lesiones descritas no presentan un riesgo para el paciente y sólo deben ser tratadas en caso de presentar signos de alarma

8) Un paciente de 25 años refiere escuchar voces de espíritus malignos que lo insultan y lo obligan a autoagredirse. Explica que las voces fueron enviadas por el diablo, para hacerlo sufrir por ser el hijo de Dios. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia paranoide
- b) Trastorno esquizotípico de la personalidad
- c) Trastorno delirante
- d) Epilepsia focal, de ubicación temporal
- e) Delirium

9) Un paciente de 65 años se realiza una ecografía abdominal, que demuéstrala presencia de un tumor renal izquierdo de 7 cm de diámetro. Se solicita TAC de abdomen y pelvis, que visualiza el tumor de carácter sólido, sin presencia de adenopatías. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar nefroureterectomía
- b) Realizar nefrectomía radical
- c) Realizar nefrectomía parcial (tumorectomía)
- d) Solicitar resonancia magnética nuclear
- e) Realizar biopsia por punción de la lesión

10) Un estudio pretende determinar la asociación entre la exposición a arsénico y el desarrollo de cáncer de colon. ¿Qué tipo de estudio sería el más adecuado para obtener evidencia científica de calidad?

- a) Caso control
- b) Cohortes
- c) De corte o transversal
- d) Ensayo clínico
- e) Ecológico

11) Un paciente ingresa a cirugía electiva, debido a una hernia inguinal indirecta, con anestesia general. En la evaluación preoperatoria se constata que el paciente está en ayuno, en buenas condiciones, sin embargo al examen físico se aprecia con Mallampati IV y disminución de la distancia tiromentoniana. ¿Cómo manejaría la vía aérea de este paciente?

- a) Intubación en secuencia rápida
- b) Cánula Mayo
- c) Uso de máscara laríngea
- d) Intubación a 4 manos (6 manos)
- e) Intubación retrógrada por traqueostomía

12) Un hombre de 80 años, hipertenso y dislipidémico, presenta dolor abdominal cólico, intenso, que aparece 15-30 minutos luego de comer, especialmente cuando ingiere grandes cantidades de alimentos, lo que lo obliga a comer fraccionado, resultando en una baja de peso de 5 Kg en 3 meses. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Cáncer gástrico
- b) Cólico biliar
- c) Pancreatitis crónica
- d) Cáncer de páncreas
- e) Angina mesentérica

13) Un paciente de 35 años consulta por epistaxis de 30 minutos de evolución. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y sangrado activo por la fosa

nasal derecha. Se inicia compresión manual por 20 minutos, sin embargo no se logra detener la hemorragia. La conducta más adecuada es:

- a) Administrar ácido tranexánico
- b) Solicitar nasofibroscofia
- c) Realizar taponamiento nasal anterior
- d) Realizar taponamiento nasal posterior
- e) Aplicar adrenalina en solución tópica intranasal

14) Un estudio de prevalencia muestra que de un total de 10.000 pacientes estudiados, 100 padecen de VIH. A su vez, en el grupo de pacientes VIH (+) el 20% presenta hipertensión, mientras que en el grupo de pacientes VIH (-) sólo el 18% padece de hipertensión. ¿Qué prueba utilizaría para determinar la significancia estadística de la asociación entre la portación del VIH y la hipertensión arterial?

- a) t de Student
- b) Chi cuadrado
- c) ANOVA
- d) r de Pearson
- e) Correlación de Spearman

15) Un paciente de 24 años es muy preocupada por el orden y los detalles. Suele invertir gran parte del tiempo en mantener completamente limpia y ordenada su casa y se molesta fácilmente cuando alguien ensucia algo y no lo limpia de inmediato, o cuando las cosas no se hacen como a ella le gusta, por lo que suele tener problemas de convivencia con sus familiares y con sus compañeros de universidad. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de personalidad obsesiva compulsiva
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Manía
- e) Trastorno paranoide de la personalidad

16) Un paciente de 67 años consulta por dolor en el codo izquierdo. Al examen físico se constata aumento de volumen y eritema del codo, con aumento de la temperatura local y signos de derrame articular. Se solicita radiografía de codo que resulta normal y punción articular, que da salida a un líquido turbio, con 80.000 células por mm³, glucosa baja y presencia de escasas células gram positivas, dispuestas en racimo. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar cloxacilina oral y realizar drenaje por punción con aguja gruesa
- b) Administrar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje articular quirúrgico
- c) Administrar vancomicina endovenosa y realizar drenaje articular quirúrgico
- d) Administrar cefazolina endovenosa y realizar drenaje articular quirúrgico
- e) Iniciar flucloxacilina oral y controlar en 48 horas

17) Un paciente de 30 años consulta por fiebre y dolor abdominal intenso. Al examen físico se aprecia FC: 94x', PA: 120/80 mmHg, t°: 38,8°C, abdomen sensible, doloroso en el hemicodo superior, especialmente intenso en el hipocondrio derecho, con RHA (+). El hemograma demuestra leucocitosis y las pruebas hepáticas, así como la lipasa resultan normales. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Pancreatitis aguda
- b) Gastroenteritis aguda
- c) Colangitis aguda
- d) Colédocolitiasis
- e) Colecistitis aguda

18) Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y su lesión elemental:

- a) Píntiriasis rosada – Placa
- b) Vitiligo – Mácula
- c) Pénfigo – Pseudopápula
- d) Acné – Comedón
- e) Líquen plano – Pápula

19) Un paciente de 60 años consulta por dificultad para orinar, con disminución del calibre del chorro miccional, disuria de esfuerzo y latencia de 20 segundos. Se solicita APE, que resulta 3,0 ng/ml. El

tacto rectal constata una próstata aumentada moderadamente de tamaño, sin presencia de nódulos.

Respecto a este paciente es VERDADERO que:

- a) Debe realizarse una biopsia prostática transrectal
- b) Debe realizarse una prostatectomía radical
- c) Debe iniciarse un alfa-antagonista
- d) Debe instalarse una sonda Foley
- e) Deben solicitarse niveles plasmáticos de APE libre y total

20) Un paciente de 40 años, usuario de lentes de contacto, por hipermetropía, presenta intenso dolor ocular izquierdo, asociado a marcada disminución de la agudeza visual y ojo rojo profundo. Al examen físico se constata además midriasis y abolición del reflejo fotomotor del ojo izquierdo. El diagnóstico más probable es:

- a) Queratitis aguda
- b) Endoftalmitis
- c) Uveítis
- d) Neuritis óptica
- e) Glaucoma agudo

21) En un ensayo clínico controlado se pretende evaluar la eficacia de un nuevo antibiótico, para el tratamiento de la endocarditis bacteriana. Para esto se escogen 100 pacientes diagnosticados de endocarditis, de los cuales los 50 pacientes de menor edad reciben el nuevo antibiótico y los 50 pacientes de mayor edad reciben el tratamiento convencional. Se puede afirmar que:

- a) Este estudio carece de validez externa
- b) Este estudio presenta un sesgo por variable de confusión
- c) Para poder interpretar este estudio se debe realizar un ajuste de tasas
- d) Este estudio carece de fiabilidad
- e) Este estudio presenta un sesgo de selección

22) ¿Cuál de las siguientes patologías se puede confundir con un trastorno de pánico?

- a) Hipertiroidismo
- b) Anemia
- c) Trastorno de ansiedad generalizada
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Trastorno por somatización

23) Ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea se debe solicitar como primer examen:

- a) Un TAC de cerebro
- b) Una RMN de cerebro
- c) Una punción lumbar
- d) Un fondo de ojo
- e) Una angiografía carotídea

24) Un paciente de 66 años consulta por cefalea crónica, especialmente molesta en las tardes, asociada a sensación de presión facial “visión cansada”. Refiere que además padece de colon irritable y fibromialgia, con respuesta parcial al tratamiento con trimebutino y alprazolam. También presenta disfagia intermitente y disestesias ocasionales en las extremidades inferiores. El examen físico es normal. Se solicitan exámenes generales, que resultan normales y una endoscopia digestiva alta, que también resulta normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno por hipocondría
- c) Trastorno por somatización
- d) Trastorno disociativo
- e) Depresión

25) Un paciente de 54 años consulta por sensación de oído tapado y tinnitus de 4 días de duración, a lo que se ha agregado vértigo y vómitos en las últimas horas. El vértigo disminuye al fijar la mirada en un

punto, se aprecia nistagmo horizontal a derecha y lateropulsiones a izquierda. El diagnóstico más probable es:

- a) Neuronitis vestibular
- b) Vértigo postural paroxístico benigno
- c) Enfermedad de Meniere
- d) Infarto de troncoencéfalo
- e) Hemorragia cerebelosa

26) La tasa de mortalidad por cáncer de testículo está dada por la relación entre:

- a) Muertes por cáncer de testículo / casos nuevos de cáncer de testículo
- b) Muertes por cáncer de testículo / casos prevalentes de cáncer de testículo
- c) Muertes por cáncer de testículo / muertes totales
- d) Muertes por cáncer de testículo / población masculina
- e) Muertes por cáncer de testículo / población total

27) Un paciente de 60 años consulta por aparición de placas eritematosas y descamativas en las extremidades inferiores. Al examen físico se aprecian placas de hasta 4 cm de diámetro, ubicadas en las rodillas y en la cara anterior de las piernas. Refiere que las lesiones aparecieron hace varios meses, han aumentado de tamaño, y que hasta ahora no han presentado dolor ni otros síntomas. Además se constata onicosis en algunos ortejos. El diagnóstico más probable es:

- a) Tiña
- b) Psoriasis
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Eccema numular
- e) Eccema dishidróico

28) Un paciente de 60 años, hipertenso y diabético, consulta por dolor torácico intenso, lancinante, de una hora de evolución, que inició súbitamente y que ha ido aumentando al pasar el tiempo. Al examen físico está taquicárdico, hipertenso, con auscultación de un soplo diastólico. El diagnóstico más probable es:

- a) IAM con rotura de la pared libre
- b) IAM con rotura del músculo papilar
- c) IAM con rotura del tabique interventricular
- d) IAM con formación de aneurisma ventricular
- e) Disección aórtica

29) Se prueba la tolerabilidad de un nuevo fármaco, comparada con placebo y se aprecia que el 1% de los pacientes que reciben el fármaco presentan algún efecto adverso, mientras que sólo el 0,75% de quienes reciben el placebo los presentan. Calcule el NNH (número needed to harm).

- a) 40
- b) 75
- c) 100
- d) 133
- e) 400

30) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con una fractura cerrada de fémur derecho. A los pocos minutos comienza con desorientación y dificultad para respirar, progresiva, evolucionando con rápido deterioro de la función respiratoria y compromiso de consciencia. El diagnóstico más probable es:

- a) Shock hipovolémico
- b) Contusión pulmonar
- c) Tromboembolismo pulmonar
- d) Embolia grasa
- e) Neumotórax a tensión

31) Respecto a la pancreatitis aguda es FALSO que:

- a) Se diagnostica preferentemente con la determinación de los niveles plasmáticos de lipasa

- b) Su causa más frecuente es la litiasis biliar
- c) Inicialmente debe ser manejada con régimen cero
- d) El tratamiento quirúrgico está indicada en cerca de la mitad de los casos
- e) El TAC es la mejor imagen para evaluarla, sirviendo como factor pronóstico

32) Calcule el riesgo relativo con la siguiente información obtenida de un estudio de cohortes:

	Desarrollo IAM	No desarrolla IAM	Total
LDL aumentado	100	400	500
LDL normal	150	1.350	1.500
Total	250	1.750	2.000

- a) 1,25
- b) 1,5
- c) 1,75
- d) 2,0
- e) 2,25

33) Un paciente de 56 años presenta fotopsias persistentes, localizadas en el cuadrante inferior izquierdo del campo visual del ojo izquierdo, que iniciaron hace 48 horas, sin otras alteraciones. Al examen físico está en buenas condiciones, con agudeza visual y oculomotilidad normal. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar RMN de cerebro
- b) Observar evolución
- c) Solicitar campimetría ocular
- d) Solicitar fondo de ojo de urgencia
- e) Realizar test de Snellen corriente y a través de un agujero estenopeico

34) Una paciente de 67 años presenta vómitos explosivos postprandiales, desde hace 2 meses, que han ido aumentando, asociándose a baja de peso importante. La conducta más adecuada es:

- a) Solicitar ecografía abdominal
- b) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste
- c) Solicitar manometría esofágica
- d) Solicitar endoscopia digestiva alta
- e) Solicitar radiografías baritadas

35) Un paciente presenta una criptorquídea derecha, la que es corregida mediante cirugía a los 18 meses de edad. Respecto a este paciente es FALSO que:

- a) Luego de la cirugía el riesgo de desarrollar un cáncer testicular se iguala al de la población general
- b) Luego de la cirugía la tasa de fertilidad se iguala a la población general
- c) La cirugía se debe realizar antes de los 2 años de edad, para evitar el desarrollo de infertilidad
- d) El sitio más frecuente de ubicación del testículo afectado, es el conducto inguinal
- e) La criptorquídea tiene menor riesgo de desarrollar cáncer que el testículo intraabdominal

36) Un paciente diabético, presenta una lesión indolora, de lento crecimiento en el brazo derecho, caracterizada por una placa de 5 cm de diámetro de borde papular, arciforme, con tendencia a la curación central y sin compromiso de los vellos de la piel afectada. El diagnóstico más probable es:

- a) Lipodermatoesclerosis
- b) Tiña corporis
- c) Placa heráldica (Pitiriasis rosada de Gilbert)
- d) Eritema migratorio
- e) Granuloma anular

37) ¿Cuál de los siguientes corresponde a un estudio ecológico?

- a) Se aplica una campaña de prevención del SIDA en un país y se comparan las tasas de incidencia de VIH con un país en el que no se realizó la campaña.
- b) Se identifican los factores de riesgo cardiovascular de los individuos de todo un pueblo y se siguen en el tiempo, determinando las tasas de incidencia de muerte y eventos cardiovasculares graves
- c) Se analiza si existe correlación entre las tasas de mortalidad infantil y el ingreso familiar promedio de 10 países latinoamericanos
- d) Se administra la vacuna antiinfluenza a todos los habitantes de un país y se comparan la tasa de incidencia de influenza con las de los años anteriores
- e) Se administra la vacuna antineumocócica a todos los habitantes de un país y se compara la tasa de incidencia de infecciones neumocócicas con un país que no ha sido vacunado

38) Un paciente de 29 años ingresa por un cuadro de sopor profundo, vómitos y malestar general, que inició luego de consumir marihuana con unos amigos. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Realizar ventilación con ambú
- b) Administrar benzodiazepinas
- c) Indagar sobre el consumo de otras drogas
- d) Administrar suero fisiológico por vía venosa periférica
- e) Instalar sonda orogástrica y administrar carbón activado

39) Un paciente de 50 años asegura que su mujer lo engaña con un hombre más joven. Ella niega el hecho y se muestra muy preocupada por su marido, quien contrató a un detective privado, para que la siguiera, sin poder obtener ninguna prueba contundente contra ella, sin embargo él refiere estar seguro del engaño, ya que ha encontrado colillas de cigarrillo y boletas de supermercado en su casa, que habría dejado el supuesto amante. Los hijos y la hermana del paciente niegan el engaño. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno delirante crónico
- b) Trastorno obsesivo compulsivo
- c) Trastorno paranoide de la personalidad
- d) Esquizofrenia
- e) Episodio maniaco

40) Un paciente de 6 años consulta por un cuadro de odinofagia intensa, asociada a fiebre hasta 38,5° C, coriza y tos seca. Al examen físico presenta faringe eritematosa, con amígdalas de tamaño aumentado con exudado amigdalino escaso, presencia de 3 vesículas en la úvula y se palpan pequeñas adenopatías cervicales bilaterales. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar ibuprofeno y solicitar hemograma y hemocultivos
- b) Iniciar ibuprofeno y amoxicilina oral
- c) Iniciar ibuprofeno y clindamicina oral
- d) Iniciar ibuprofeno y solicitar cultivo faríngeo
- e) Iniciar ibuprofeno oral

41) El Instituto Médico Legal:

- a) Fiscaliza el cumplimiento de las normas por parte de los prestadores de salud
- b) Fiscaliza el cumplimiento de las normas sanitarias por parte de restaurantes
- c) Confirma los casos de patologías infecciosas de notificación obligatoria
- d) Realiza análisis forenses de interés judicial
- e) Dirime los casos de licencias médicas rechazadas

42) Un paciente de 35 años se aplica un nuevo desodorante, evolucionando al día siguiente con prurito y eritema de la piel de la axila. El diagnóstico más probable es:

- a) Urticaria
- b) Dermatitis de contacto irritativa
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Hidrosadenitis
- e) Intérrigo

43) Un paciente de 26 años sufre “torcedura” de pie mientras jugaba fútbol, evolucionando con

intenso dolor e imposibilidad de pisar. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, dolor y equimosis en la cara medial del tobillo derecho, con dolor en la palpación del maléolo medial, que se reproduce al realizar compresión medio-lateral de la pierna. El diagnóstico más probable es:

- a) Esguince de tobillo
- b) Luxación de tobillo
- c) Fractura de tobillo
- d) Rotura del tendón de Aquiles
- e) Síndrome compartimental

44) Un paciente de 65 años, diabético, presenta de manera súbita diploplía, sin dolor. Al examen físico se aprecia imposibilidad para mirar hacia inferonasal con el ojo izquierdo, sin otras alteraciones en la oculomotilidad. La agudeza visual es normal. El diagnóstico más probable es:

- a) Parálisis del III nervio craneal izquierdo
- b) Parálisis del IV nervio craneal izquierdo
- c) Parálisis del VI nervio craneal izquierdo
- d) Lesión del fascículo longitudinal medial
- e) Lesión del ganglio estrellado

45) Se realiza un estudio en el que se determina que mejora el 80% de los pacientes tratado con el fármaco A (tratamiento convencional) y el 90% de los pacientes tratados con el fármaco B (tratamiento experimental), demostrándose diferencias estadísticamente significativas.

Es costo del tratamiento completo del fármaco A es \$100 por paciente.

Es costo del tratamiento completo del fármaco B es \$200 por paciente.

Calcule cuánto dinero adicional se requiere para obtener un resultado favorable adicional al usar el fármaco B, en lugar del A.

- a) \$100
- b) \$200
- c) \$400
- d) \$1.000
- e) \$2.000

46) Un paciente de 33 años presenta un cuadro de 2 semanas de evolución, caracterizado, por ánimo irritable, agresividad e impulsividad en el gasto de dinero, que ha ido empeorando. Al examen se aprecia muy molesto, habla rápido, cambiando fácilmente de un tema a otro y menciona que tiene pensado postularse para senador de la república, ya que de seguro será electo, pues él cuenta con numerosas influencias en el gobierno. El diagnóstico más probable es:

- a) Psicosis reactiva
- b) Trastorno delirante crónico
- c) Trastorno de personalidad límite
- d) Trastorno bipolar en fase maníaca
- e) Esquizofrenia

47) Un paciente de 68 años, fumador, se realiza una radiografía que muestra un nódulo pulmonar de 2 cm de diámetro, en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia de la lesión
- b) Repetir las radiografías en 6 meses
- c) Revisar las radiografías previas
- d) Realizar tumorectomía
- e) Realizar lobectomía inferior izquierda

48) ¿Cuándo debe iniciarse el Screening de cáncer de próstata en un paciente sano, sin antecedentes de importancia?

- a) A los 40 años el APE y a los 50 años el tacto rectal
- b) A los 50 años el APE y a los 40 años el tacto rectal
- c) A los 50 años el APE y a los 50 años el tacto rectal
- d) A los 40 años el APE y a los 40 años el tacto rectal
- e) A los 40 años el APE, sin necesidad de realizar tacto rectal, a menos que el APE sobrepase el límite máximo establecido

49) Un paciente tiene la sensación de que su auto quedó sin llave, por lo que regresa a verificar que efectivamente lo dejó cerrado. En ocasiones regresa más de una vez, ya que presenta mucha angustia de haber dejado una ventana abierta y que le roben su auto. En ocasiones pierde mucho tiempo e incluso llega tarde al trabajo, debido a esta situación. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

- a) Anticonvulsivantes
- b) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Antipsicóticos atípicos
- d) Benzodiacepinas
- e) Antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa

50) Una paciente de 29 años sufrió una lipotimia en el metro, evolucionando con mucha angustia y llanto incontrolable. Luego de ese episodio persiste con miedo a repetir el cuadro y sufrir algo grave durante él, como un infarto o un accidente cerebral y no recibir ayuda. Por esto, ha dejado de salir de su casa y se preocupa de estar siempre acompañada por algún familiar o amigo. El diagnóstico más probable es:

- a) Fobia social
- b) Trastorno de estrés postraumático
- c) Trastorno de angustia generalizada
- d) Trastorno evitativo de la personalidad
- e) Agorafobia

51) ¿Cuál de los siguientes pacientes puede recibir antidepresivos tricíclicos sin mayor contraindicación?

- a) Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva en CF III
- b) Paciente adulto mayor de 85 años
- c) Paciente con glaucoma de ángulo abierto
- d) Paciente con colon irritable
- e) Paciente con 6 semanas de embarazo

52) Un paciente de 50 años presenta pérdida de la audición del oído izquierdo, de manera súbita, de modo que sólo es capaz de oír ruidos muy intensos por dicho oído. Se solicita una audiometría, que muestra una hipoacusia sensorineural izquierda marcada. El diagnóstico más probable es:

- a) Sordera súbita
- b) Neurinoma del acústico
- c) Accidente vascular de troncoencéfalo
- d) Hidrops vestibular
- e) Enfermedad de Meniere

53) Un paciente presenta tristeza marcada, ideas de muerte, anhedonia e insomnio de despertar precoz de varias semanas de evolución, que ha empeorado en el último tiempo. Refiere que padece de un cáncer que lo “está consumiendo y que pronto acabará con su vida”, sin embargo no cuenta con ningún diagnóstico médico y su examen físico, así como sus exámenes generales, son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Hipocondría
- b) Trastorno somatomorfo
- c) Trastorno delirante crónico
- d) Depresión psicótica
- e) Depresión atípica

54) Una paciente de 30 años ha sufrido crisis de pánico en reiteradas oportunidades, sin lograr identificar un desencadenante claro. El último episodio fue en su trabajo, por lo que no ha querido regresar a su lugar de trabajo, ya que piensa que podría volver a presentar una crisis. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Trastorno facticio
- c) Trastorno de ansiedad
- d) Fobia social
- e) Trastorno de ansiedad generalizada

55) Un niño de 4 meses de edad presenta signos de Ortolani y Barlow, sin otras alteraciones. Ha crecido adecuadamente y se alimenta por lactancia materna exclusiva. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar ecografía de caderas
- c) Solicitar radiografía de cadera y pelvis
- d) Indicar correas de Pavlik
- e) Indicar yeso pelvipedio

56) Una paciente de 30 años, asesora del hogar, sufre un corte profundo en la mano izquierda, mientras cocinaba en su lugar de trabajo, siendo manejado con sutura e indicándole 7 días de licencia médica. Está afiliada a una AFP y a una Isapre y su empleadora la tiene afiliada a la mutual de seguridad. ¿Quién paga los días de licencia médica?

- a) Fonasa
- b) La AFP
- c) La mutual de seguridad
- d) La Isapre
- e) Esos días no se pagan

57) Un paciente consulta por sensación de arenilla ocular y ojo rojo izquierdo de 3 días de evolución. Al examen físico se aprecia ojo rojo superficial y secreción serosa, con reacción tarsal folicular. El diagnóstico más probable es:

- a) Uveítis
- b) Cuerpo extraño tarsal
- c) Conjuntivitis bacteriana
- d) Conjuntivitis viral
- e) Conjuntivitis alérgica

58) Un paciente sufre un traumatismo torácico de alta energía, evolucionando con dificultad respiratoria. Al examen físico está disneico, con FC y PA dentro de rangos normales y se constata matidez y disminución del murmullo pulmonar izquierdo, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Realizar punción del segundo espacio intercostal
- c) Realizar toracocentesis y drenaje del derrame pleural, sin necesidad de cirugía ni pleurostomía
- d) Instalar un tubo pleural con trampa de agua
- e) Resolver quirúrgicamente de inmediato

59) La anorexia nervosa puede presentar todo lo siguiente, EXCEPTO:

- a) Ánimo depresivo
- b) Elevación de las transaminasas
- c) Amenorrea
- d) Autoinducción de vómitos
- e) Atracones

60) Un paciente de 16 años presenta epistaxis izquierda recurrente, asociada a obstrucción nasal progresiva ipsilateral. Al examen físico no se aprecian otros datos de relevancia. El diagnóstico más probable es:

- a) Rinitis alérgica
- b) Hipertrofia adenoidea
- c) Poliposis nasal
- d) Cáncer nasal
- e) Rinofibroangioma

61) Un paciente sufre una caída de altura, resultando con múltiples contusiones, fracturas costales y fractura de pelvis desplazada. Evoluciona con imposibilidad de orinar. Al examen físico se aprecia uretrorragia. El diagnóstico más probable es:

- a) Contusión renal
- b) Laceración renal
- c) Sección de uréter
- d) Lesión de la vejiga urinaria
- e) Lesión de uretra

62) El diseño “cruzado”, en un ensayo clínico, puede utilizarse en un estudio que compare las diferencias entre:

- a) Dos tratamientos antibióticos diferentes, para la peritonitis bacteriana espontánea
- b) El tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico de la pancreatitis crónica
- c) Dos fármacos fibrinolíticos para el tratamiento del infarto agudo al miocardio con supradesnivel de segmento ST
- d) Dos broncodilatadores de larga acción en el manejo sintomático del EPOC
- e) Dos pruebas de screening para cáncer de colon

63) ¿Cuál de los siguiente fármacos produce una relajación muscular de menor duración?

- a) Atracurio
- b) Pancuronio
- c) Vecuronio
- d) Rocuronio
- e) Succinilcolina

64) Un paciente de 26 años reprueba su examen de grado. Evoluciona muy tranquilo asegurando que se trata de un sueño y que en realidad no está pasando. El diagnóstico es:

- a) Trastorno conversivo
- b) Delirio
- c) Síndrome confusional agudo
- d) Psicosis reactiva
- e) Trastorno disociativo

65) Un hombre de 76 años de edad presenta disminución progresiva de la agudeza visual bilateral, mayor a izquierda. Además refiere que en ocasiones ve las imágenes algo distorsionadas. No ha presentado dolor ni otros síntomas y la inspección ocular, oculomotilidad, reflejo fotomotor y rojo pupilar son normales. El diagnóstico más probable es:

- a) Envejecimiento normal
- b) Catarata senil
- c) Glaucoma de ángulo abierto
- d) Desprendimiento de retina
- e) Degeneración macular relacionada con la edad

66) Un paciente de 25 años es poco expresivo, emocionalmente frío, marcadamente ineficiente y con dificultades para realizar trabajos ejecutivos. No ha presentado alucinaciones y el curso formal de su pensamiento está conservado. El diagnóstico más probable es:

- a) Esquizofrenia simple
- b) Trastorno esquizotípico de la personalidad
- c) Trastorno paranoide la personalidad
- d) Trastorno delirante crónico
- e) Distimia

67) El tratamiento de la colangitis aguda se basa en:

- a) Manejo hemodinámico, antibióticos y drenaje endoscópico de la vía biliar
- b) Manejo hemodinámico y antibióticos
- c) Manejo hemodinámico, antibióticos y drenaje quirúrgico de la vía biliar
- d) Manejo hemodinámico y drenaje quirúrgico de la vía biliar
- e) Manejo hemodinámico y drenaje endoscópico de la vía biliar

68) Un paciente sufre una fractura de peroné a nivel proximal. ¿Qué estructura podría verse afectada con mayor probabilidad?

- a) Nervio ciático

- b) Arteria poplítea
- c) Nervio peroneo
- d) Tendón de la pata de ganso
- e) Menisco lateral

69) Una paciente presenta dolor lumbar intenso, asociado a disuria dolorosa y fiebre alta. Al examen físico presenta puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina, que muestra presencia de abundantes piocitos y bacterias, por lo que se inicia ciprofloxacino oral. Se controla a las 48 horas, con urocultivo, que resulta positivo para Klebsiella multisensible y se constata que la paciente permanece con fiebre alta, dolor lumbar y disuria. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar gentamicina e.v.
- b) Iniciar ceftriaxona e.v.
- c) Solicitar nuevo urocultivo
- d) Solicitar ecografía abdominal
- e) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

70) Una paciente de 55 años presenta múltiples lesiones en la cara, caracterizadas por pápulas y pustulas, sobre una base eritematosa en las mejillas, frente y mentón. Refiere que las lesiones aumentan al exponerse al sol y cuando consume alcohol. El diagnóstico más probable es:

- a) Demodicidiosis
- b) Lupus
- c) Dermatomiositis
- d) Rosácea
- e) Acné

PRUEBAS GRANDES CIRUGÍA, ESPECIALIDADES, SALUD PÚBLICA y PSIQUIATRÍA RESPUESTAS

Prueba 1

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

1 B	48 E	20 B	61 C	28 C	65 C
2 D	49 E	21 C	62 D	29 B	66 C
3 E	50 B	22 D	63 C	30 A	67 E
4 A	51 E	23 D	64 D	31 E	68 A
5 A	52 B	24 A	65 A	32 D	69 D
6 A	53 D	25 B	66 D	33 C	70 C
7 D	54 B	26 B	67 B	34 A	
8 A	55 E	27 D	68 C	35 C	Prueba 4
9 B	56 B	28 D	69 B	36 B	1 C
10 E	57 C	29 D	70 C	37 A	2 D
11 C	58 D	30 D	Prueba 3	38 D	3 C
12 B	59 E	31 C	1 D	39 B	4 B
13 E	60 C	32 B	2 D	40 C	5 A
14 A	61 C	33 D	3 C	41 E	6 D
15 C	62 C	34 B	4 C	42 B	7 E
16 E	63 D	35 E	5 B	43 A	8 B
17 E	64 C	36 C	6 A	44 C	9 E
18 E	65 A	37 B	7 B	45 B	10 E
19 C	66 D	38 A	8 C	46 E	11 B
20 A	67 D	39 C	9 C	47 C	12 A
21 C	68 D	40 D	10 B	48 B	13 C
22 B	69 D	41 A	11 B	49 B	14 E
23 C	70 A	42 C	12 A	50 D	15 E
24 D	Prueba 2	43 D	13 A	51 D	16 E
25 D	1 B	44 B	14 C	52 D	17 E
26 B	2 B	45 A	15 A	53 C	18 B
27 D	3 A	46 B	16 C	54 A	19 E
28 D	4 C	47 C	17 E	55 A	20 C
29 B	5 C	48 D	18 E	56 A	21 E
30 E	6 B	49 B	19 A	57 B	22 D
31 E	7 B	50 A	20 B	58 C	23 B
32 C	8 C	51 B	21 D	59 C	24 A
33 D	9 E	52 E	22 D	60 A	25 A
34 B	10 D	53 B	23 B	61 B	26 B
35 A	11 E	54 B	24 B	62 B	27 B
36 D	12 D	55 B	25 D	63 C	28 C
37 C	13 C	56 B	26 A	64 B	29 D
38 D	14 B	57 A	27 A		30 C
39 B	15 D	58 A			31 B
40 D	16 A	59 B			32 D
41 A	17 C	60 D			33 E
42 C	18 E				34 B
43 A	19 D				35 C
44 C					36 C
45 C					37 E
46 C					
47 B					

38 A	68 D	26 A	56 D	14 B	44 B
39 B	69 D	27 A	57 E	15 A	45 D
40 E	70 A	28 E	58 C	16 D	46 D
41 E		29 B	59 A	17 E	47 C
42 B	Prueba 5	30 E	60 B	18 C	48 C
43 E	1 B	31 -	61 C	19 C	49 B
44 A	2 C	32 C	62 A	20 E	50 E
45 B	3 C	33 B	63 C	21 E	51 D
46 E	4 C	34 B	64 B	22 A	52 A
47 A	5 C	35 A	65 C	23 A	53 D
48 B	6 B	36 E	66 A	24 C	54 C
49 D	7 D	37 E	67 E	25 C	55 C
50 B	8 B	38 C	68 D	26 D	56 C
51 C	9 E	39 D	69 B	27 B	57 D
52 C	10 B	40 C	70 C	28 E	58 D
53 C	11 C	41 D		29 E	59 E
54 B	12 D	42 B	Prueba 6	30 D	60 E
55 D	13 D	43 B	1 E	31 D	61 E
56 A	14 B	44 E	2 E	32 D	62 D
57 D	15 E	45 E	3 C	33 D	63 E
58 A	16 B	46 B	4 A	34 D	64 E
59 E	17 B	47 E	5 A	35 A	65 E
60 A	18 A	48 C	6 B	36 E	66 A
61 E	19 B	49 B	7 D	37 C	67 A
62 A	20 -	50 C	8 A	38 C	68 C
63 A	21 B	51 B	9 B	39 A	69 D
64 C	22 C	52 C	10 B	40 E	70 D
65 C	23 B	53 B	11 C	41 D	
66 D	24 C	54 E	12 E	42 C	
67 D	25 D	55 E	13 C	43 C	